

总主编 周丽莎 朱书秀
主编 朱书秀 苏飞

针灸名师
临床笔记丛书

内分泌代谢 病证卷

NEI FEN MI DAI XIE BING ZHENG JUAN

广集临床验案
汇聚特色疗法

中国医药科技出版社

策划编辑/白极
责任编辑/白极
封面设计/白极

针灸名师
临床笔记丛书

内分泌代谢 病证卷

NEI FEN MI DAI XIE BING ZHENG JUAN



上架建议 中医·针灸

ISBN 978-7-5067-3940-5



9 787506 739405 >

定价：33.00元

总主编 周丽莎
主编 朱书秀
苏飞

针灸名师

临床笔记丛书

内分泌代谢 病证卷

NEI FEN MI DAI XIE BING ZHENG JUAN

中国医药科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

针灸名师临床笔记丛书. 内分泌代谢病证卷/朱书秀, 苏飞主编. —
北京: 中国医药科技出版社, 2008. 9

ISBN 978 - 7 - 5067 - 3940 - 5

I. 针... II. ①朱... ②苏... III. ①内分泌病—针灸疗法 ②代谢病—针灸疗法 IV. R245

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 143192 号

美术编辑 陈君杞

责任校对 张学军

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 责编: 010 - 62250159 发行: 010 - 62227427

网址 www.cspyp.com.cn

规格 958 × 650mm¹/₁₆

印张 19¹/₄

字数 282 千字

印数 1—5000

版次 2008 年 9 月第 1 版

印次 2008 年 9 月第 1 次印刷

印刷 北京市通州皇家印刷厂

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 3940 - 5

定价 33.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

《内分泌代谢病证卷》编委会

- 主 编

朱书秀 苏 飞

- 副主编

王 芳 马 利

- 编 委 (以姓氏笔画为序)

马 利 王 芳 刘 键
朱书秀 祁友松 邢燕玲
苏 飞 张 涛

《针灸名师临床笔记丛书》编委会

• 总 主 编

周丽莎 朱书秀

• 副总主编 (以姓氏笔画为序)

马 骏 王维宁 孔立红 付艾妮
苏 飞 吴绪平 张 英 涂 乾
梁 忠

• 编 委 (以姓氏笔画为序)

马 利 马 骏 王小月 王 芳
王维宁 孔立红 付艾妮 付 蕾
冯美果 朱书秀 朱青艳 全国芳
苏 飞 杜艳军 吴绪平 张 英
周丽莎 孟培燕 涂 乾 望庐山
梁 忠 褚 伟

• 主 审

孙国杰

博采众长
拓業岐黃

李维衡

二〇〇七年九月

中国针灸学会会长 李维衡

荟萃數百匠家之經驗

驅除千萬患者之痼疾

石學敏

2007.9.

中國工程院院士 石學敏

孙 序

针灸是中医学中的一颗璀璨明珠，几千年来为我国人民的健康、保健做出了巨大贡献。从公元 6 世纪传到朝鲜、日本以后，又传到了东南亚、欧洲等许多国家。针灸医学已在全球范围内得到了广泛的推广和运用，为世界人民的防病治病做出了卓越贡献。

早在 20 世纪 80 年代，世界卫生组织原总干事中岛宏博士就指出：“中国传统医学能够治疗西洋医学束手无策的许多疾病”，“针灸已成为世界通行的一门新的医学科学”。针灸医学有着悠久的历史，在历史长河中形成了完整的理论体系，积累了丰富的临床经验，发明创造了多种行之有效的操作技术。我坚信它必将成为世界主流医学的一个组成部分。

针灸医学在我国的疾病预防、治疗和康复中，以简、便、验、廉和疗效显著而被广泛运用，每年发表的有关针灸基础研究和临床运用的论文有 2000 篇左右。其中临床报道占了大多数。但不少医家的学术思想、治疗方法、临床经验未能很好地得到发扬和推广。为此，周丽莎教授组织有关专家学者，查阅历代医籍、医学刊物和临床专著，在重视科学性、先进性，注重实用性的同时，将散在各医家宝贵的针灸临床经验精华，编撰成《针灸名师临床笔记丛书》。丛书编写注重于临床，着重总结医家的学术思想、临床特色、治疗方法，并附典型病例加以佐证，是广大医务人员临床工作的重要的案头参考书。

《针灸名师临床笔记丛书》，经过参编专家的艰苦努力，即将付梓问世，这必将能嘉惠医林，启迪后学，造福民众。值该书出版之际，欣然作序、以表祝贺。

中国针灸学会副会长

孙国杰

2007 年 10 月 8 日

前言

针灸是中医学宝库中一门独特的遗产，是中医学的重要组成部分。几千年来，针灸学历代医家不断发展、完善，已成为一门独立的学科，获得国内外医学界的广泛重视和赞誉。近年来，随着高科技手段在针灸领域的运用，扩大了针灸治疗的范围，提高了治疗效果，使这门学科更加丰富、更臻完善。

随着健康保健知识的日益普及，人们对化学合成药品不良反应的担心日渐增加，相反，对针灸外治等自然疗法越来越愿意接受。因此，具有验、便、廉和独特效果的针灸治疗方法，在治疗各种疾病方面不断取得新的突破性发展。

近年来，大量针灸医学的书籍、期刊出版发行，对指导临床研究和推广、普及针灸医学知识起到了积极深远的影响。然而，不少医家的学术思想、新的疗法和宝贵的经验，仍然只是散见于文献刊物之中，且缺乏系统的整理与分类，使学者不易领会，研究者搜寻亦难，难以最大限度地满足广大医务工作者学习和借鉴的需要。有鉴于此，我们组织有关专家，查阅收集了近现代医籍、医学刊物和临床专著，在重视科学性、实用性的同时，将各医家散在的针灸临床治疗方法和经验编撰成《针灸名师临床笔记丛书》。

该套丛书注重于临床，在病种选录上，力求收集针灸科常见、且疗效显著的疾病种类，在内容上，突出每一种病证的独到的针

灸治疗精法验案，同时又百花齐放，竟显各家学说的光彩，并且在每一个治疗经验前，都以一句精炼的标题概括其与众不同的特点，旨在两意：一是尊重各个第一作者的学术成就；二是方便读者理解。丛书分为《妇儿病证卷》、《心脑血管病证卷》、《肺系病证卷》、《筋伤病证卷》、《皮肤病证卷》、《脾胃病证卷》、《肾膀胱病证卷》、《内分泌代谢病证卷》共8个分册。可供针灸教学、临床、科研人员及在校中医专业学生参考使用。

编写该套丛书工作量繁重，由于人员分散，缺乏经验，虽做了极大努力，但限于水平，缺点和疏漏在所难免，恳请读者赐教与指正。

此书在编写过程中，承蒙中国针灸学会会长李维衡教授指点与题词，中国工程院院士石学敏教授题词并提出宝贵意见，中国针灸学会副会长、博士生导师孙国杰教授为本书写序言并赠墨宝，在此一并表示谢意。

《针灸名师临床笔记丛书》编委会
2008年1月

编写说明

本书是《针灸名师临床笔记丛书》中的一个分册。内分泌代谢病证为内科疾病的重要组成部分，临床内分泌代谢病证是一门古老而又年轻的边缘学科，近年来发展迅速，但不少内分泌代谢病证的疗效目前尚不尽人意，针灸医学由于在该领域治疗效果独特、迅速、操作简便、适应症广泛、无不良反应，受到广大患者的欢迎。然因各种客观原因，不少医家的学术思想，新的疗法和宝贵的经验，散在于大量的文献刊物之中，难以为广大医务工作者总结和借鉴，不易于继承和发扬。有鉴于此，我们组织了有关专家学者，收集了诸多有关内分泌代谢病证的文献资料，荟萃了各家的证治经验，在重视科学性、实用性的同时，立足从多方位、多层次来反映中医针灸在内分泌代谢病证方面的经验精华。

本书注重于临床，力求收集针灸科常见的内分泌代谢病证，以各位医家的临床治验或特色治疗为原则。以病证为纲，在内分泌代谢病证下细分为单纯性肥胖、高脂血症、功能性子宫出血、骨质疏松症、黄褐斑、甲状腺功能亢进、经前期紧张综合征、精神分裂症、内分泌失调性不孕、男性更年期综合征、女性更年期综合征等16种疾病。在每种病证之前均有内容提要，简要介绍该病证的病因病机、治疗原则，以及各医家的诊治特点，便于读者选择应用。在每位医家的经验之中，重点介绍个人的辨治方法，经穴配方的运用与具体操作技巧，以求实用，切合临床。每种病证中收录了多种治疗方法，诸如毫针法、头针法、耳针法、梅花针法、电针法、穴位注射法、三棱针等。总之，在治疗方法上，仁者见仁，智者见智，各有千秋，别具特色。

此书虽广集历代学术理论和各名家之诊疗精华，但由于我们的经验不足，加之时间仓促，还有许多好的经验未能收入，致有遗珠之憾，同时在内容的广度和深度方面亦有未尽人意之处，热切期望广大读者批评指正。

本书在编写过程中，得到了许多著名专家教授的悉心指导帮助，在此表示衷心感谢。并向为本书编辑、出版、发行做出了辛勤劳动的人士表示谢忱。

《内分泌代谢病证卷》编委会

2008年1月

目 录

单纯性肥胖症

1 - 35

- 一、电针配耳压 补虚泻实 / 2
- 二、证分四型 辨证用穴 / 3
- 三、耳穴贴压 随症选穴 / 4
- 四、肥三针为主 化脂降浊 / 5
- 五、群针疗法 调理经脉 / 7
- 六、刃针割治 消肥散积 / 8
- 七、透刺闪罐耳压 三法并用 / 9
- 八、随证取穴 穴位埋线 / 11
- 九、电针为主 综合治疗 / 12
- 十、针刺为主 配中药内服 / 14
- 十一、脐周八针 随症加减 / 15
- 十二、针刺配食疗 调和营卫 / 16
- 十三、辨证施针 调整脏腑 / 18
- 十四、整体与局部并重 随证取穴 / 19
- 十五、针刺走罐埋线 三法并用 / 21
- 十六、针药并用 清胃热 / 23
- 十七、多法并用 整体调理 / 24
- 十八、局部取穴 苍龟探穴 / 25
- 十九、腹部取穴为主 电针 / 26
- 二十、快速针刺为主 配合推拿 / 27
- 二十一、辨证分型 体耳针并用 / 29
- 二十二、电针为主 综合治疗 / 31

目

录

高脂血症

36 - 41

- 一、背俞穴埋线 结合耳针 / 37
- 二、立足于脾胃 化痰降脂 / 38
- 三、针刺配耳压 健脾祛痰除湿 / 39
- 四、三阴交为主 辨证施治 / 39

骨质疏松症

42 - 54

- 一、百会长留针 背俞穴速刺 / 43
- 二、理据肾主骨 - 生髓 行耳压治疗 / 43
- 三、腹针疗法 标本兼治 / 44
- 四、骨肽注射液 穴位注射 / 45
- 五、独取神阙 隔药灸 / 45
- 六、针推罐 三法并用 / 46
- 七、补肾为主 温针灸 / 47
- 八、证分两型 针刺配火针 / 48
- 九、足三里 - 三阴交 针药并用 / 49
- 十、背俞穴为主 重手法 / 50
- 十一、针刺穴数 健脾补肾 / 50
- 十二、督脉穴为主 针灸并用 / 51
- 十三、温针为主 配西药口服 / 52

精神分裂症

55 - 65

- 一、穴分两组 水电针并用 / 56
- 二、辨证分型 电针治疗 / 58
- 三、耳针治疗 镇静安神 / 59
- 四、头皮电针为主 配合穴位注射 / 60
- 五、针刺配药物 醒脑安神 / 61
- 六、辨证取穴 镇静安神 / 61
- 七、针药结合 泻火祛痰 / 62

- 八、穴位埋髻 随证选穴 / 63
- 九、独取膻中 刺血拔罐 / 64

糖尿病及其并发症

66 - 84

- 一、电针为主 配经穴按摩 / 67
- 二、揠针配体针 补虚泻实 / 68
- 三、独取胰俞 埋药线 / 69
- 四、背俞穴为主 针刺降血糖 / 70
- 五、针药并用 治肾为主 / 72
- 六、浅刺任督 配药物治疗 / 73
- 七、针药并施 益气养阴 / 74
- 八、电针配艾灸 神经源性膀胱 / 75
- 九、动眼神经麻痹 辨证施针 / 77
- 十、视网膜病变 针药并用 / 77
- 十一、针药结合 治动眼神经麻痹 / 79
- 十二、糖尿病胃轻瘫 芒针为主 / 80
- 十三、背俞穴 辨证治胃轻瘫 / 81

附：糖尿病并发末梢神经炎

85 - 99

- 一、刺络放血 除陈出新 / 85
- 二、电针耳压 祛风止痒 / 86
- 三、针药并用 养血活血 / 87
- 四、络脉扣刺 泻血攻下 / 88
- 五、辨证分型 针药并治 / 89
- 六、头针为主 配合簇针 / 91
- 七、头针为主 配穴位注射 / 92
- 八、穴位注射 益气养血 / 93
- 九、针药穴位注射 综合治疗 / 94
- 十、针药结合 活血化瘀通络 / 96
- 十一、穴位注射 健脾益肾固本 / 97

甲状腺功能亢进及其并发症

100 - 117

- 一、肝俞 - 心俞 埋线治疗 / 100
- 二、挑筋割脂埋线 化痰散结 / 101
- 三、穴位埋线 标本兼治 / 103
- 四、针刺为主 配神经节阻滞 / 104
- 五、辨证分型 针药并用 / 105
- 六、药线点灸 配中药施治 / 106
- 七、壮医挑刺 调气解毒补虚 / 107
- 八、穴位埋线配中药 标本兼治 / 109
- 九、远近配穴 针药并用 / 110
- 十、疏肝理气解郁 针药并用 / 112
- 十一、针药并施 消瘦散结 / 115

甲状腺肿大

118 - 123

- 一、针挑为主 软坚散结 / 118
- 二、主穴三个 重刺法 / 120
- 三、火针为主 标本兼治 / 122

黄褐斑

124 - 154

- 一、取经为主 走罐配刺络放血 / 125
- 二、督脉埋针 调理诸经 / 126
- 三、耳压磁珠 调节全身 / 127
- 四、灵龟八法 按时开穴 / 128
- 五、随证取穴 挂针配直接灸 / 129
- 六、综合疗法 内外兼治 / 130
- 七、走罐加局部围刺 调补五脏 / 131
- 八、背俞穴 刺血拔罐 / 133
- 九、辨证取背俞 推罐配按摩 / 133
- 十、辨证取穴 药物注射 / 135

- 十一、刺络拔罐配耳压 辨证施治 / 136
- 十二、耳穴刺络 调理气血 / 137
- 十三、耳穴刺血配贴压 化瘀消斑 / 138
- 十四、耳穴贴压 刺血拔罐 / 140
- 十五、飞腾八法 配刺血拔罐 / 141
- 十六、辨证分型 割耳敷药 / 142
- 十七、体耳穴并用 埋线为主 / 144
- 十八、局部刮痧为主 行气消斑 / 145
- 十九、辨证取穴 面部浅刺配闪罐 / 147
- 二十、远端取穴为主 辨证施治 / 148
- 二十一、背部走罐 梅花针叩刺 / 149
- 二十二、针刺为主 神阙隔盐灸 / 150
- 二十三、耳穴贴压配刺血 祛瘀除斑 / 151

男性更年期综合征

155 - 159

- 一、耳压为主 配心理治疗 / 156
- 二、针刺配有氧运动 疏肝健脾 / 157
- 三、针推为主 综合治疗 / 158

女性更年期综合征

160 - 183

- 一、既病防变 电针配耳压 / 161
- 二、电针为主 辨证施治 / 162
- 三、耳穴贴压 平衡阴阳 / 163
- 四、耳压配中药 清心平肝滋肾 / 164
- 五、五脏俞加膈俞 调理脏腑 / 166
- 六、穴位埋线 滋补肾气 / 167
- 七、穴位注射 配耳压 / 168
- 八、辨证配穴 针刺配耳压 / 170
- 九、五脏俞为主 针刺配火针 / 171
- 十、辨证分型 针药并用 / 172

- 十一、上下配穴 针用补法 / 173
- 十二、以肝为本 辨证取穴 / 174
- 十三、整体入手 调理冲任 / 175
- 十四、针药结合 滋阴潜阳 / 175
- 十五、针刺配穴位注射 补肾益气养血 / 176
- 十六、俞募配穴 协调阴阳 / 176
- 十七、针灸配耳穴疗法 补肾培元 / 178
- 十八、三穴六针 平补平泻 / 178
- 十九、针药结合 辨证分型 / 179
- 二十、针药配合 疏肝解郁 / 181

经前期紧张综合征

184 - 192

- 一、头针为主 虚补实泻 / 184
- 二、穴位注射配体针 调理冲任 / 185
- 三、针药并用 行气活血 / 186
- 四、调脏腑 理冲任 平阴阳 / 187
- 五、针刺配推拿 通调冲任 / 188
- 六、辨证取穴 耳穴贴压 / 189
- 七、针刺配心理治疗 强调情志 / 190
- 八、辨证施治 调肝与胞宫 / 191

痛 风

193 - 219

- 一、刺络拔罐 活血止痛 / 193
- 二、刺络放血 泻热解毒 / 194
- 三、刺血为主 辅以中药 / 195
- 四、随证取穴 针灸并用 / 196
- 五、电针配穴位注射 消肿止痛 / 197
- 六、浮针疗法 通则不痛 / 198
- 七、腹针为主 配合中药 / 199
- 八、局部取穴 火针点刺放血 / 200

- 九、随症配穴 火针点刺 / 201
- 十、以痛为腧 梅花针叩刺 / 202
- 十一、梅花针配中药 分期治疗 / 203
- 十二、局部取穴 齐刺加隔姜灸 / 205
- 十三、温针灸 清热泄火 / 205
- 十四、针刺配刺络拔罐 清热解毒 / 207
- 十五、针药合用 清热利湿 / 208
- 十六、随症选穴 针药并施 / 209
- 十七、内外合治 针药并用 / 210
- 十八、病分急慢 刺络拔罐为主 / 212
- 十九、泄浊祛邪 泻热化瘀 / 214
- 二十、针药并用 急慢性治法各异 / 216

月经不调

220 - 228

- 一、辨证取穴 腹针为主 / 221
- 二、主穴三个 阴中隐阳 / 222
- 三、独取神阙 药物贴敷 / 222
- 四、调泌穴针刺 平衡内分泌 / 223
- 五、针灸并用 益气补血 / 224
- 六、随证取穴 耳穴压豆 / 224
- 七、药针并用 疏肝补肾 / 225
- 八、取隐白 子午流注施灸 / 226
- 九、针刺调冲任 补肝肾 / 227
- 十、穴位注射 益气摄血 / 227

子宫内膜异位症

229 - 232

- 一、七厘散敷贴 活血化瘀 / 229
- 二、药饼灸配水针 温通经络 / 230
- 三、补肾化浊 针药并用 / 231

内分泌失调性不孕症

233 - 262

- 一、针药结合 调理肝脾肾 / 233
- 二、针刺配中药 分期治疗 / 234
- 三、补肾化浊 药针并用 / 236
- 四、辨证分型 针药合用 / 237
- 五、穴位注射 标本兼顾 / 238
- 六、主穴三个 电针治疗 / 239
- 七、雷火灸 活血化瘀通络 / 240
- 八、灵龟八法配温和灸 通调任脉 / 241
- 九、内外结合 活血化瘀通络 / 243
- 十、三法同用 取长补短 / 244
- 十一、独取子宫 温针灸 / 245
- 十二、分期取穴 药饼灸 / 246
- 十三、针刺配穴位敷药 通胞宫 / 248
- 十四、针灸配耳压 调理冲任 / 250
- 十五、针灸治疗 生血充精 / 251
- 十六、辨证分型 因证施治 / 252
- 十七、针药配合 补肾益精 / 254
- 十八、针药罐灸 综合治疗 / 255
- 十九、针药并举 调理冲任 / 257
- 二十、补益肝肾 佐以活血化瘀 / 258

功能性子宫出血

263 - 278

- 一、独取关元 隔姜灸 / 264
- 二、定宫丹填脐灸 滋阴调经 / 264
- 三、随症选穴 耳穴贴压 / 265
- 四、穴位注射为主 配中药内服 / 266
- 五、中极为主 深刺 / 267
- 六、温针配服中药 调和温补冲任 / 268
- 七、中药内服外用 补肾活血兼施 / 269

- 八、证分三型 治分两期 / 270
- 九、穴分两组 轮流注射 / 272
- 十、太阳灸 冲任督三经并调 / 273
- 十一、针药并用 标本兼治 / 274
- 十二、中药并灸法 培元气止崩漏 / 275
- 十三、壮医药线灸 调摄冲任 / 277

【单纯性肥胖症】

单纯性肥胖症是指无明显内分泌 - 代谢原因，且排除因水钠潴留或肌肉发达等蛋白质增多诸因素引起实际体重超过标准体重 20% 以上的一种疾患。目前，中国“肥胖问题工作组根据 20 世纪 90 年代中国人群有关数据的汇总分析报告，提出了适合我国成人的肥胖标准：正常体重指数 $[\text{体重 (kg)} \div \text{身高}^2 (\text{m}^2)]$ 是 18.5 ~ 23.9，大于或等于 24 为超重；大于或等于 28 为肥胖。男性腰围大于或等 85cm、女性腰围大于或等于 80cm 为腹部肥胖标准。临床上所称的肥胖症大多指单纯性肥胖。

正常成年人的能量摄入和机体的能量消耗长期维持在平衡状态，脂肪量亦维持在一定水平，使体重保持相对稳定。若神经、精神、遗传、饮食等因素使摄入能量过多或消耗能量过少，多余的能量除了以肝糖原、肌糖原形式贮存之外，脂肪就成为多余能量的主要贮存形式。长期能量代谢障碍，可引起肥胖症。按发病年龄和脂肪组织病理可分为体质性肥胖和获得性肥胖两类。体质性肥胖与遗传有关，且营养过度，幼年起即有肥胖，全身脂肪细胞增生肥大；获得性肥胖多自青少年起因营养过度、活动减少等因素而发病，脂肪细胞仅有肥大而无增生。

本病的发生与脾、胃、肾三脏功能失调有

关。脾胃功能失常，肾元虚惫则引起气血偏盛偏衰、阴阳失调，导致肥胖。脾胃虚弱则水湿不化，酿生痰浊；胃肠腑热则食欲偏旺，水谷精微反被炼成浊脂；真元不足则气不行水，凝津成痰，遂致痰湿浊脂滞留肌肤而形成肥胖。

该篇共收录了 22 位针灸医家的临床治验，有的采用电针配耳压；有的采用群针法；有的采用刃针治疗；有的采用穴位埋线；有的采用快速针刺为主。从取穴上有的根据临床表现采用辨证取穴，有的以脐周八针为主，有的以肥三针为主，有的以腹部取穴为主。方法各异，疗效较佳。

针灸治疗单纯性肥胖在取得疗效后应巩固治疗 1~2 个疗程，以防体重回升。在治疗的同时应指导患者改变不良的饮食和生活习惯。食物宜清淡，少食肥甘厚腻及煎炸之品；用餐须细嚼慢咽；限定食量，少吃零食；忌过度睡眠；坚持适度的体力劳动和体育运动。

一、电针配耳压 补虚泻实

金涛在临床工作中，采用针刺加电针配合耳压治疗单纯性肥胖，疗效较佳。

取穴：主穴为梁丘、公孙、上巨虚、天枢；配穴根据辨证分型，胃肠实热型配内庭、曲池，脾胃气虚型配三阴交、气海、足三里，真元不足型配命门、太溪、关元。

操作：用 30 号 1.5~2 寸毫针，针刺得气后，实证用泻法，虚证用补法，然后接 G6805 电针仪，接两组线，任取一个主穴、一个配穴。用连续波，频率为 20 次/s，强度以患者耐受最大值为度。每日治疗 1 次，星期日休息不治疗。

耳压：取穴：口、胃、脾、肺、肾、外鼻、内分泌、皮质下，三焦，交感。每天于三餐前半小时按压，每穴按压 30 次，以酸痛为度。3 天换贴 1 次，两耳交替。

注意事项：在治疗期间，要求患者饮食清淡，多吃蔬菜，少吃荤菜；规律饮食；禁吃甜食、零食、浓茶、咖啡、酒；晚餐吃八分饱，充分咀嚼，睡前 3h 勿进食；每天慢跑或快步走 1h。

中医学认为肥胖可因饮食失调或长期食欲亢盛，偏食膏粱厚味、甘美甜腻之品，且多逸少劳，致营养过剩，蓄积于肌肤而成肥胖。

反之，脾胃气虚，运化失职，湿聚成痰，痰湿流注肌肤，或禀赋不足，真气虚弱，气化不能，物质消耗不足，亦可形成肥胖。故本病发生与脾、胃、肾三脏有关。病机有虚实之分，实者脾胃亢盛，虚者脾胃气虚、真气虚弱。

刘某，女，39岁。1998年5月10日初诊。自诉形体肥胖10年，曾用减肥药、节食、运动等方法减肥，但收效不大，且每次减肥后体重均有反弹。食欲旺盛，喜食巧克力等甜食，常感口干、口渴，饮水量大，大便干结，小便黄。查体：身高165cm，体重82kg，腰围103cm，舌红苔黄，脉滑。诊断：中度单纯性肥胖。辨证分型：胃肠实热型。给予针刺梁丘、公孙、上巨虚、曲池、天枢、内庭，加电针。耳穴取口、胃、脾、肺、肾、外鼻、内分泌、皮质下、三焦，嘱于三餐前半小时按压。治疗期间少吃肉食，多吃蔬菜、水果，禁吃巧克力、甜食，晚餐八分饱，每天快步走1h。治疗2次后，自述食欲已得到控制，不再有饥饿感，体重开始下降。治疗10次后，测体重为74kg，腰围95cm。1个月后测体重68kg，腰围88cm，精神饱满，精力充沛。停止治疗后，嘱仍需保持饮食清淡和坚持锻炼。随访半年，体重又下降4kg，工作、生活一切正常。

二、证分四型 辨证用穴

艾炳蔚采用针刺加电针的疗法对单纯性肥胖病进行了较为系统的临床研究，取得了满意的疗效。

取穴：基本方：中脘、天枢、水道、阴交、足三里。随证加减：脾虚湿阻加水分、阴陵泉；胃热湿阻加内庭、上巨虚；肝瘀气滞加气海、血海、太冲；脾肾两虚加关元、太溪；阴虚内热加水道、三阴交。

操作：穴位常规消毒，取28号1.5寸毫针，针刺深度0.6~1.2寸，主穴进针后，以有麻胀触电感为佳。有针感时停止行针，并提针少许，再予留针。配穴均取双侧，行一定的补泻手法得气。用G6805电针仪置于腹部穴位，选用疏密波脉冲，电流强度以病人能耐受为度。留针30min，每天1次，10次为1个疗程。

中医对肥胖的认识早在《内经》中便有详细记载，《灵枢·逆顺肥瘦》：“广肩腋项，肉薄厚皮而黑色唇临临然，其血黑以浊，其

气涩以迟，其为人贪于取与。”《灵枢·卫气失常》：“膏者多气而皮纵缓，故能纵腹垂腴；肉者身体容大；脂者身体收小……是故膏人纵腹垂腴，肉人者上下容大，脂人者虽脂不能大者。”这是有关肥胖病最早的医学分类方法。中医学认为，肥胖主要是因为脾胃运化功能失调，水谷精微不得输布，脂浊痰湿内聚所致，正如李东垣《脾胃论》所说：“脾胃俱旺，则能食而肥。脾胃俱虚，则不能食而瘦，或少食而肥，虽肥而四肢不举。”故以健脾化痰、消脂降浊之法治之。因大肠小肠皆通于胃，故足太阴脾经、足阳明胃经穴位最为常用。取天枢能疏调肠腑、理气通便；足三里以抑制食欲；胃之募穴中脘以健运中州、调理气机、升清降浊。配合三阴交以健脾胃、助运化、除湿浊；血海以活血；气海以理气、益气；阴交以调经血、温下元、利水；水分以健脾胃、利水湿；太溪以益肾气、清虚热、调经血；太冲以疏肝理气；内庭以降胃火、通腑气等。诸穴合用，可调整胃肠道的蠕动功能，抑制食欲，促进能量代谢。同时腹部任脉穴位和三阴交可调整内分泌。

电针刺激腹部穴位可以加强针感，使腹部穴位得到持续刺激，加强胃肠道的蠕动，促进脂肪代谢。在刺激的时间和刺激量上均较单纯针刺手法强。一般认为，频率快的密波，能降低神经应激功能，常用于止痛、镇静、缓减肌肉和血管痉挛；频率慢的疏波，能引起收缩，提高肌肉韧带的张力。疏波和密波相交替的疏密波，能促进代谢，推动气血循环，改善组织营养，消除炎性水肿。本法选择疏密波，因疏密波刺激可使腹壁内的张力提高，促进肠蠕动加快，从而加快脂肪的分解排出，减少脂肪组织的堆积，并使能量的摄入减少。同时疏密波作用于人体局部肥胖的深部，使肌肉产生各种收缩按摩运动，引起肥胖部位做被动运动，将脂肪转变为热能而消耗掉，使肌肉绷紧。肌肉运动能使血液内游离脂肪酸的消耗量增加，脂肪细胞缩小，从而达到减肥目的。

三、耳穴贴压 随症选穴

丁哲采用耳穴贴压治疗单纯性肥胖，疗效满意。

取穴：主穴：胃、口、饥点、神门、下屏尖。配穴：内分泌、肾上腺、皮质下、缘中、三焦、肺、小肠、肾。如伴有胆囊炎或胆

结石者取胰、胆、肝；伴有大便干燥者取大肠、直肠、肺；伴有神经衰弱、睡眠欠佳者取心、垂前；伴有头晕嗜睡者加脾、枕、额、颈椎；伴有水肿、四肢倦怠乏力者加脾、肾；伴有高血压者加耳背肝、耳背肾、耳背沟；伴有更年期综合征者加肾、内生殖器。

操作：用探棒在所选穴区找出敏感点，用碘伏或 75% 的酒精局部常规消毒后，用 $0.6\text{cm} \times 0.6\text{cm}$ 的胶布将王不留行籽或磁珠贴在敏感点上。嘱患者每日自行按压 5 ~ 7 次，每次按压各穴 20 ~ 30 次，按压强度以感到局部有酸、麻、胀、痛感为佳。每次贴压一侧耳穴，隔 3 ~ 5 日换另一侧耳穴，10 次为 1 个疗程。

现代医学认为，肥胖是由内分泌、遗传或热量摄入超过消耗而引起脂肪过多堆积而致，治疗以饮食疗法最为重要，目的是使热量负平衡。临床观察发现耳穴贴压有明显控制食欲和调节内分泌的作用。对单纯性肥胖患者，治疗关键是控制饮食以及清胃肠之实热。取胃、口、饥点穴可有效地控制食欲；内分泌、皮质下、三焦、肾上腺等穴可调节内分泌，通利水道，消除体内多余的水分；下屏尖、神门、肺、小肠等清利胃肠热。

进行耳穴贴压治疗时嘱患者每次进餐前自行按压各穴 30 ~ 50 次，进餐时要细嚼慢咽，坚持始终。一般经过 3 ~ 5 次贴压后体重开始下降，此时嘱患者再坚持 5 个疗程左右。另外，丁哲在临床观察到有些患者经耳压治疗后食欲控制理想，自觉体重减轻，但实际体重并未减轻，此时正是患者体内脂肪分布变化的关键时期，其体重一旦变化每次就可减少 4 ~ 5kg 以上。

四、肥三针为主 化脂降浊

唐天芬采用针刺肥三针治疗单纯性肥胖患者，疗效较满意。

取穴：肥三针（中脘、带脉、足三里）。

操作：使用 30 号不锈钢毫针，患者取仰卧位，常规消毒进针。中脘、足三里穴选用 1.5 寸毫针，直刺 1.2 寸，得气后行提插泻法和大幅度、快频率捻转，产生较强的针感；带脉穴选用 4 寸针，入针后沿着腹壁向肚脐围刺，即双侧带脉透刺。接通 G6805 - 1 型电针仪，调至疏密波，把微电流接通于针体上，电流强度以患者能耐受为度，留针 40min。隔天治疗 1 次，10 次为 1 个疗程。

中医学认为，饮食不节是肥胖形成的重要原因之一。生活安逸，少动多静亦是诱发肥胖的主要因素。肥胖的直接原因虽为“饮食不节，入多于出”，导致脂肪在体内堆积，但其内在原因多为脏腑功能失调所致，主要与脾胃、肝、肾相关，尤以脾胃运化失常为关键。《脾胃论》说：“脾胃俱旺，则能食而肥”。饮食水谷入胃，须依靠脾胃运化功能健运才能转化为精微物质，若脾胃虚弱则运化失职，水谷肥甘之物无以化生气血津液，转化为脂膏、痰浊积聚体内，导致体态肥胖。《丹溪心法》进一步指出“肥人多湿痰”。故治疗以调理脾胃、升清降浊为大法。

肥三针是广州中医药大学靳瑞教授从临床经验中总结出来的。肥三针之中脘与足三里都是调理胃肠功能的要穴，带脉穴能畅通带脉经气，管束诸经脉，且能加强局部的刺激作用而治疗肥胖之腰腹肥大者。足三里是足阳明胃经的合穴，同时也是胃经的下合穴，针刺足三里可以疏调阳明经气，通调肠胃。中脘属于胃经的募穴，腹部局部取穴，直接调理脾胃的消化功能。针刺中脘穴时，针刺深度比较深，过了皮肤就到脂肪，脂肪层厚，所以中脘穴是根据肥瘦来定深浅。带脉穴位于腰腹部的中部，起于少腹之侧，季肋之下，环身一周，络腰而过，约束诸经脉，如同束带。肥胖的病人，尤其是腹部肥大的病人，起因多与带脉的约束功能下降有关，所以选用带脉穴，加以电流刺激，能疏通带脉经气，管束诸经脉，且能加强局部的刺激作用而治疗肥胖之腰腹肥大者。通过针刺肥三针，可以起调整脾胃功能，化脂降浊作用，而达到减肥目的，使病态机体得到恢复。

王某，女，38岁，2002年7月9日初诊。既往肥胖史12年，身高157cm，体重69kg。患者形体肥胖，多食易饥，脘腹胀满，大便秘结，四肢困倦，舌偏红、苔薄黄，脉滑有力。曾采用药物及运动疗法减肥未见效。经针刺肥三针治疗1个疗程，体重下降3kg，患者进食减少，腹部较治疗前平坦，腹胀减轻。2个疗程后，体重下降8kg，腹胀便秘症状明显改善。3个疗程后，体重下降12kg，自觉身体轻松，纳佳，大便通畅，脘腹胀满消失。随访1年，自觉身轻体健，体重无反弹。

五、群针疗法 调理经脉

顾健华以群针法为主治疗单纯肥胖患者，取得理想疗效。

取穴：主要在腰腹部群取穴位，以足阳明胃经、足太阴脾经、足少阳胆经、足厥阴肝经、任脉 5 条经脉在腰腹部的穴位为主穴。取胃经的梁门、水道、大巨、外陵、天枢、滑肉门、太乙、关门；脾经的腹结、大横、腹哀；胆经的带脉、五枢、维道；肝经的章门；任脉的中脘、建里、下脘、水分、阴交、气海、石门、关元；手臂肥胖加手阳明大肠经、手少阳三焦经经穴，取肩髃、臂臑、肩髃、臑会、曲池、支沟；腿部肥胖加足阳明胃经、足少阳胆经、足太阴脾经、足太阳膀胱经的经穴，取髀关、伏兔、居髃、风市、梁丘、足三里、上巨虚、血海、阴陵泉、承筋、承山、三阴交。以上穴位同时取用。

操作：患者平卧，用 1.5 寸不锈钢毫针直刺约 1~2 寸，小幅提插捻转，以略有酸胀感为度，用 G6805 低频电子脉冲治疗仪接于天枢、章门上，频率 3Hz，强度中度，以耐受为限，连续波，留针 30min，治疗先每天 1 次，连续 5 天，以后每周 3 天，每天 1 次，10 次为 1 个疗程。

单纯性肥胖主要由于机体内热量摄入大于消耗，造成脂肪在体内积聚过多，导致体重超常，临床上多伴有内分泌紊乱的症状。中医对本病也有较详细的论述，《脾胃论》云：“脾胃俱旺，则能食而肥；脾胃俱虚，则不能食而瘦或少食而肥，虽肥而四肢不举，盖脾实而邪气盛也。”脾胃俱旺者由于多食多饮，致膏脂堆积于体内，脾胃气机凝滞，不能运化转输水湿，痰湿内生而成病；或有脾胃俱虚，胃虚则食少，脾虚则失运，中焦生化不足，水谷之精气失于运化，转为痰浊，贮留于皮里膜外，形成肥胖。近年来，对肥胖的治疗方法有很多，然而或不良反应大，或效果不理想。

顾健华用群针法治疗，是采用常规毫针刺法，取体表某区的某经及该穴周围邻近的多个腧穴行针刺，取穴多而群集，故名群针法。脂肪堆积主要地方，以腹部为最，故着重取腹部的经穴，这种取法是重局部而不弃经脉，所取的经穴分属胃经、脾经、胆经、肝经、任脉等不同的经脉，通过经穴本身的作用及众多经脉之间相互协调

作用，来平衡阴阳，调整脏腑功能，以达到减肥的功效。

六、刃针割治 消肥散积

李健采用刃针治疗单纯性肥胖，取得了满意的效果。

取穴：主穴：中脘、天枢、水分、外陵、上巨虚、足三里、三阴交等穴。胃热湿阻者加曲池、合谷、公孙、内庭等穴；脾虚湿阻者加丰隆、阴陵泉、气海、水道等穴；肝郁气滞者加肝俞、期门、行间、太冲等穴。

操作：患者取仰卧位或俯卧位，充分暴露操作部位皮肤，在确定的穴位或脂肪堆积处用龙胆紫做一标记，用安尔碘消毒，医者带无菌手套，根据患者体质的强弱及局部肥厚程度分别选用不同型号的无菌刃针进行操作。以左手拇指、食指捏住刃针套管，针尖对准所取的穴位，其余三指作为支撑，压在进针点附近的皮肤上，使之固定。用右手食指快速拍击刃针尾部，使之进入脂肪层后，取下套管，纵行或横行切割或摆动，即出针，稍加压迫针孔，敷贴创可贴。在脂肪较多的腹部、大腿等部位快速直刺入皮肤后，倒置针身，在脂肪层沿经络向前推切 2~3 针，同时作扇形摆动，还可在脂肪层分层次作推切、摆动；或在脂肪堆积部位每 1cm 左右刺 1 针行密集刺。对脂肪颗粒粗大的或局部形成团块、硬结、条索的可行纵行切割、横行摆动，进行疏通松解，出针后按压针孔 1min，贴创可贴即可。在停滞期时，可不马上起针，适当留针 10min 后再起针以增强疗效。每次选取 4~6 个穴位，每 5 天 1 次，6 次为 1 个疗程，休息 1 周后，再进行第二个疗程治疗。

现代医学认为，单纯性肥胖的病因主要与营养过度、缺乏运动、遗传因素有关。针灸疗法治疗单纯性肥胖疗效显著，且无副作用，已被公认。其机制主要为：通过神经系统调节，刺激外周躯体神经对内脏自主神经进行调节，使交感神经与副交感神经相互协调，纠正异常的食欲；另一方面调节脂质的代谢过程，使血中过氧化脂含量下降，加速其脂肪分解过程。刃针疗法以针刺理论为指导，将“针”与“刃”巧妙地融为一体，在针刺穴位的同时，通过“刃”的切割，扩大了针刺的作用，使经络和穴位经气得以快速激发，产生较强的信息震荡（即得气），通过经络信息通

道传输气血；另一方面，通过切割筋膜，消除过高应力，从而影响其中通过的各种信息传递系统及经络系统，使局部的气血疏通，达到消肥散积的目的。

张某，女，38岁，已婚。身高162cm，体重91.6kg，腰围114cm，臀围116.5cm。近几年来体重一直持续增长，多食易饥，胃脘滞闷，口干舌燥，口渴喜饮，大便秘结，舌红，苔黄，脉滑数。曾自服减肥药无效而来诊。刃针取中脘、天枢、水分、上巨虚、足三里、三阴交、曲池、合谷、公孙、内庭等穴。经刃针治疗1次后即有明显食欲减退的感觉，3次后，便秘、口干症状得到明显改善。3个疗程后，体重为76.2kg，腰围98cm，臀围106cm，自觉身体轻盈，精力充沛。

七、透刺闪罐耳压 三法并用

华云辉经过长期临床观察，认为透刺、闪火罐配合耳穴对单纯性肥胖具有良好的减肥效果。

主穴：体穴：以神阙穴、神阙穴下2寸，神阙穴上2寸为中心，双向旁开3寸分别向任脉方向平直透刺，向上或向下平直透刺，均取双侧。耳针：主穴：内分泌、神门、三焦、饥点；分型：肠腺便秘型加曲池、支沟、梁丘，耳穴加肺、大小肠；脾肾阳虚型加太溪、三阴交、公孙，耳穴加脾、肾、脑点；湿困中焦型加中脘、三阴交、阴陵泉、丰隆、梁丘，耳穴加脾、胃、肺、肾、口、脑点；月经不调型加太溪、血海、三阴交、关元，耳穴加卵巢、肾、肝、脾。

操作：患者仰卧，局部皮肤常规消毒，用3寸30号一次性毫针平透刺至脂肪层，手法小幅度捻转泻法，取得胀感，接通G6805-B型电针仪，选择频率为100Hz，强度以患者耐受度为限的疏密波，配穴均直刺取得酸胀感为度，留针30min。完毕后用中号玻璃火罐，以闪火法刺激以神阙穴为中心，旁开3寸为圆周范围以及脂肪较厚的范围，反复闪罐，直至所刺激部位潮红为度。前4日每天1次，以后隔日1次，10次1个疗程。耳穴用王不留行籽贴压单侧耳廓，嘱患者餐前半小时按压耳穴，每穴1min，以酸胀痛、耳廓微红发热为宜，每3~4日换1次，10次1个疗程。

中医认为肥胖是脾失健运，痰湿中阻，脏腑功能失调和内分泌紊乱影响所致。特别是水液代谢异常，肺的宣降，脾的输布，胃的游溢，肾的气化功能失调，导致水谷精微敷布全身失调，气血津液无从化生而成肥胖，华云辉运用薄氏腹针理论治疗肥胖症，取得可喜成效，经络学说认为：背为阳，腹为阴，腹部为诸阴经之会，除足三阴经外，还有阴中之阴任脉，足阳明胃经和足少阳胆经循行于腹侧，带脉束腰1周与督脉、足太阳膀胱经相连，冲脉，阴跷脉阳维脉亦行于小腹或腹前。脏腑有邪多反映于募穴，募穴是脏腑之气结聚于胸腹的地方。说明腹部是人体气血阴阳汇聚之地，更是体内痰湿易于聚集形成腹型肥胖之处。神阙穴位于腹中，其旁边的气海、关元、天枢、中脘等穴均为调理脏腑气化功能的主要穴位，通过透刺闪火刺激诸穴，起到振奋中阳、升清降浊、水精四布、除湿化痰浊，阴中求阳之妙法，提高健脾降脂之功。外耳与消化系统功能均受迷走神经支配，刺激耳穴产生某种信号沿迷走神经传递，阻断下丘脑饥饿信息，影响胰岛素值，抑制食欲，产生纳呆感，可以拮抗多吃意向，打破促其饮食意向的习惯性反应。对减少饮食的信号建立一个新的条件反应，所以透刺、闪火、配合耳穴治疗，具有取穴少，进针深，得气快，针感强等优势，经此法治疗3天后患者多出现食欲降低，排便次数增多，腹胀消失，精力充沛，易于患者接受。

何某某，女，42岁。2003年5月初诊。近6年来，体重增加明显，身高161cm，体重由过去 $50 \pm 1\text{kg}$ 增至 $70 \pm 1\text{kg}$ ，较正常体重超重16kg。5年前下岗后在家，嗜睡，心烦，喜甜食，月经不规律，舌淡红苔薄白，脉滑，查BMI：27.02，腰围95cm，臀围109cm，为轻度腹型肥胖，考虑为肝郁犯脾所致脾胃功能失调，治疗以疏肝健脾，化痰浊除湿为主。取神阙穴以及其上下各2寸为中心，双侧旁开3寸分别向任脉平透直刺，平向上或向下透直刺至脂肪层，配梁丘、三阴交、足三里，主穴接G6805-B型电针仪疏密波，以患者耐受为度，留针30min后用闪火罐以神阙为中心，旁开3~4寸圆周范围，以及腰臀部脂肪较厚处反复闪罐，直至所刺激部位潮红为度。耳针取肝、脾、内分泌、神门、三焦、饥点、大小肠、卵巢、肾、皮质下，经针体治疗2个疗程，耳针1个疗程后，体重下降8kg，腰围87.1cm，100.2cm，BMI：23.9，随访半年，体重维持在 $59 \pm 1\text{kg}$ 。

八、随证取穴 穴位埋线

张中成根据中医理论,采用穴位埋线治疗单纯性肥胖,疗效满意。

取穴:中脘、天枢、气海、上巨虚。加减:胃肠实热加大横;脾虚湿盛加脾俞;肝郁气滞加肝俞;脾肾阳虚加脾俞、肾俞;阴虚火旺加复溜。

操作:应用一次性32号注射针,将1.5cm左右0号羊肠线从针尖放入注射针芯,用一次性针灸针在注射针柄插入针孔,选取中脘、天枢、气海、上巨虚等,常规消毒后,将注射针插入穴位,用针灸针将羊肠线推入穴位内,拔出注射针,压迫针孔止血。治疗15天1次,3次1个疗程。

中医对肥胖病早有记载。《素问·通评虚实论》曰:“肥贵人则膏粱之疾也。”《素问·奇病论》说“必数食甘美而多肥也。”;又“肥者令人内热,甘者令人中满”。由于贪食甜腻之品,即“膏粱厚味”致使膏脂内生,而发生肥胖。《脾胃论》说:“脾胃为后天之本”。脾主运化水谷,输布精微,运行水液。在生理上,脾将饮食化生的营养,输布全身,充养肌肉四肢。因此食欲与营养的消化吸收与脾有直接关系。脾胃同居中焦,互为表里,胃主受纳腐熟,脾主运化水谷,脾主升,胃主降,二者共同完成饮食摄入、吸收、消化转输的生理功能。如果饮食不节,摄食肥甘,则可使脾胃功能失常,气血偏盛偏衰,阴阳失调,痰湿瘀热积聚,导致肥胖的发生。正如李东垣《脾胃论》所说“脾胃俱旺,则能食而肥,脾胃俱虚,则不能食而瘦或少食而肥,虽肥而四肢不举”。因而无论从脾胃的生理功能或病理变化,脾胃与肥胖的发生发展都有密切的关系。肥胖病病位在脾胃,其发生是由于饮食不节,摄食肥甘等内外因素的作用下,脏腑功能失调,导致水湿、痰浊、瘀热、膏脂等病理产物壅积体内而发生肥胖。中脘为胃之募穴,天枢为大肠募穴,针之可调理胃肠,健运中焦;上巨虚为大肠的下合穴,针之可清本经腑热。正如《素问·水热穴论》有“气街、三里、巨虚上下廉,此八者以泻胃中实热也”。诸穴合用,具有健脾化湿、泻热消脂、轻身减肥的作用。

肥胖是一种慢性代谢性疾病,其治疗周期长,易于反复,很多

病人常常因不能坚持而导致治疗的失败。因而寻找一种有效、作用持续久、病人依从性好的疗法，有着重要的意义。穴位埋线疗法，是根据中医理论，利用羊肠线在穴位内的持久刺激而产生治疗作用的方法。最初通过羊肠线对穴位的机械性刺激，产生针灸效应；随后随着羊肠线的分解、吸收，引起机体相应的物理及生化反应，从而对穴位产生温和持久的治疗作用。因而本疗法可弥补针灸治疗次数多，作用时间短，疗效不稳定，易复发的缺点。

九、电针为主 综合治疗

郑丽静采用以电针为主配合神灯、耳穴贴压等治疗单纯性肥胖，获理想疗效。

电针：以腹部透刺为主，两组穴位交替使用。第一组穴：梁门透中脘，大横透天枢，大巨透四满；第二组穴：腹哀透关门，腰结透外陵。腹部透刺选用3~4寸毫针，刺入主穴待患者出现针感后退针，使针尖位于脂肪层，再透刺到同一平面上的配穴。在透穴针上连接常州英迪电子医疗器械有限公司生产的KWD-808-I型脉冲针灸治疗仪，负极接在向心穴上，正极连在离心穴上，采用疏密波，强度以患者能耐受为度，治疗30min。另在腰腹脂肪堆积处，有穴取穴，无穴守经，双侧对称针刺3~5穴。不强求针感，以刺入脂肪层为度。再根据中医辨证分型，脾虚湿阻加地机、丰隆、阴陵泉；胃肠积热取支沟、曲池、上巨虚、内庭；脾肾阳虚型取三阴交、脾俞、肾俞、太溪；肝气郁结型取太冲、阳陵泉、外关。选用1.5寸毫针，除脾肾阳虚型外，手法均采用捻转泻法，得气后留针30min，隔日1次，10次为1个疗程。

神灯照射：留针期间以神灯照射腹部，以患者产生舒适的温热感为度。

耳穴贴压：主穴取脾、胃、饥点，酌配神门、内分泌、皮质下、大肠、三焦。贴压时，耳穴部位常规消毒，将苏州康升医疗器械有限公司生产的康年牌耳穴定向磁珠贴压在耳穴上，每次取单侧4~6穴，两耳交替，隔3天1次，10次为1个疗程。嘱患者每日3餐前30min及睡前各按压耳穴1次，每次按压2~3min，以局部有发热及酸痛感为度。

饮食指导：治疗期间应禁食高脂肪、高淀粉、高糖食物，适量进食蔬菜、水果；晚餐尽量提前，晚餐后或睡觉前4h不进食任何食物；平时饮食以清淡为主，减少油、盐、糖的摄入。治疗结束后也应长期遵守上述原则以防反弹。

运动指导：晚餐后半小时以中等速度行走30~60min或坚持有氧运动，如慢跑、游泳、打球、跳健身操等。

肥胖症的发生是一个慢性、复杂的过程，与诸多因素有关，中医学古籍中对其病因病机即有一定认识，《素问·通评虚实论》曰：“肥类人，则膏粱之疾也”。又《素问·奇病论》云：“此肥美之所发也，此人必数食甘美而多肥也”。属中医“肥类人”、“肌肤盛”的范畴。医家多认为本病与脾关系密切，因脾主运化，机体内气血津液的运化敷布都有赖于脾，如果嗜食肥甘厚味，多逸少劳，脾失健运则水谷不化精微，机体不能正常吸收利用，而生成痰湿浊脂蓄积体内而成肥胖，其病理机制为本虚标实，本虚主要是指脾胃失调，运化失常，标实主要是指痰、湿、瘀热或肝气郁结。人体为一个有机的整体，脾之功能正常亦有赖于胃之受纳功能，肝之疏泄功能，肾主水之功能正常。治疗中旨在通过刺激相应的穴位，疏通经络，健脾化湿，平调阴阳，保持水液代谢中各个环节的平衡。通过化痰祛湿、利尿、通便等，将滞留于体内的痰湿浊脂排出体外。腰腹是减肥的重点，腹部分布有任脉、脾经、胃经、肾经、肝经，共涉及5条经脉，在治疗中于主穴上直刺得气后再透刺到另一条经脉的穴位，做到一针透多经，多经间同时得气，加上神灯局部照射，其行气通络之功更著。再根据中医辨证分型进行四肢配穴，可使脏腑、经络、腧穴之间的经气交融贯通，气血通畅条达。电针的应用可进一步加强穴位功效，激发腧穴电特性与人体生物电的耦合，对消化系统有明显的良性调节作用。且局部的振动使神经肌肉组织产生兴奋作用，促使腹部肌肉收缩，并随电流变化而运动，增加能量消耗，使腰围减小。另《灵枢·口问》曰：“耳者，宗脉之所聚也”，又《医学真经》说：“十二经脉，上终于耳，其阴阳诸经，适有交并”，可见其与经络、脏腑关系密切。耳穴贴压根据中医辨证取穴，与体针共奏疏通气血、利湿降脂之功，且耳穴贴压可有效维持刺激量，加强疗效。

现代医学研究认为肥胖与遗传、神经精神、物质代谢及内分泌等因素有关,其治疗不外乎两个方面,一是减少摄食,减少营养物质及能量的摄入;二是加强代谢,增大消耗,促进蓄积的脂肪分解。研究证实,针灸可降低胰岛素水平,提高胃泌素分泌量,增加垂体激素、甲状腺素等的合成。调节“下丘脑-垂体-肾上腺皮质”和“交感-肾上腺皮质”两系统的功能,加速脂肪分解,还可调节下丘脑腹内侧核的饱觉中枢和腹外侧核的食饵中枢,抑制饥饿感,减少摄食。可见针灸治疗肥胖病是对多种器官、组织以及各种代谢途径的综合作用,通过调整身体的生理功能,激发机体固有的防御疾病和自我修复能力。其近期疗效可靠,远期疗效稳定。

十、针刺为主 配中药内服

张瑛用针刺配合内服中药治疗肥胖患者,疗效满意。

取穴:天枢、支沟、阴陵泉、丰隆(均双侧)、气海、阴交、水分。

操作:按其所在部位的脂肪深浅不同,选用1.5~3寸的32号针灸针,常规消毒后快速刺入,得气后留针30min,针刺法每日1次,10次为1个疗程,每个疗程治疗后休息2~4天,连续2个疗程为1个治疗阶段,每个治疗阶段可休息1周。

中药:轻身饮(自拟名):制半夏10g,炒苍术10g,云苓10g,白芥子10g,山楂15g,内金12g,陈皮10g,荷叶10g,川朴10g,苡仁30g。将上述10位中药用清水浸泡1h,然后用大火煮开,改为小火煮沸20min,将药汁150ml倒入碗中;再把清水放入药罐中第2次煮沸后,改小火煎20min,将此药液150ml与第一次药液混合(共300ml),每日分2次服(间隔6h)。

中医学认为肥胖形成的原因与过食肥甘厚味以及与先天禀赋有关。其病机无外胃强脾弱。正如《素问·奇病论》“必数食甘美而多肥也”。《素问·通评虚实论》“肥贵人,则膏粱之疾也。”在临床上,取天枢、支沟疏调肠腑,理气通便;阴陵泉、丰隆健脾祛痰;气海益气消积化脂;配以任脉之阴交、水分以分清泌浊,温运水湿。同时内服轻身饮加强健脾理气,化积祛痰之功效。从现代医学理论看,针刺配合内服轻身饮,可以使胃活动水平降低,餐后胃排空时

间延长,既能抑制患者过亢的食欲,抑制亢进的胃肠消化吸收功能,从而减少能量的摄入。另外,适当控制饮食,特别是限制脂肪,糖类食物,并结合活动锻炼以消耗多余的脂肪。

张某某,女,49岁,教师,无肥胖家族史。检查:身高160cm,体重86kg,血压正常,无其他病史,属单纯性肥胖,按上述方法治疗1个疗程体重减轻6kg,腰围缩小5cm;休息1周后连续治疗1个疗程,则体重减轻8kg,腰围缩小9cm。

十一、脐周八针 随症加减

王红玉采用针刺治疗单纯性肥胖,获得了满意效果。

主穴:取脐周八针(天枢、滑肉门、外陵均取双侧,下脘、石门);配穴取曲池、支沟、血海、伏兔、梁丘、足三里、丰隆、阴陵泉、三阴交均双侧取穴。

操作:脐周八针用毫针直刺1.5~2寸左右,施平补平泻手法,以患者自觉腹肌向脐中心收缩及有明显肠蠕动感为佳;余穴均施以平补平泻法,以穴位局部有酸胀感为度。得气后留针30min,隔日1次,15次(30天)为1个疗程。

中医认为,本病多因脏腑功能失调,运化失健,水液代谢失常,痰湿内阻,气机不畅,日久经络闭阻,冲任不调,形成肥胖。生活安逸,过食肥甘厚味之品,且久坐久卧,活动过少亦是诱发肥胖的主要原因。

现代医学认为,肥胖与遗传、饮食及精神因素有关,肥胖患者交感神经功能低下,迷走神经功能亢进,且内分泌功能失调,其下丘脑-垂体-肾上腺系统功能偏低,多数患者物质代谢异常,尤其是脂质代谢障碍。

治疗中所选诸穴相互配伍,有调节脏腑功能,通调上、中、下三焦气机,使得肺气宣发,气机调畅,脾胃健运,水湿得以正常气化排泄,从而恢复正常的水液代谢功能及大肠传导功能,达到减肥的目的。多数患者经1~2次治疗后普遍感觉食欲下降,无饥饿感,大便通畅,体重开始下降,半个月后月经失调的女性患者即开始恢复。说明针刺治疗可以调节内分泌功能,抑制兴奋的迷走神经,加强脂肪分解,促进新陈代谢,而获得减肥目的。

患者于某，女性，35岁，大学讲师。因形体肥胖9年余，于1999年4月29日来针灸科门诊求治。患者9年前生产后补养过度，形体日渐肥胖，体重最高达86kg，伴见乏力，多寐；下肢微肿，月经不调等症，做妇科检查未见异常，曾做过药物减肥，饥饿疗法，运动减肥，辣椒减肥等多种治疗方法，但疗效均不满意，且反弹明显，减肥后乏力，气短，面色少华等现象出现，月经不调无改善。就诊时查体血压120/80mmHg，身高174cm，体重84kg，腰围83cm，体重指数为27.7，舌暗淡，苔黄微腻，脉细滑。诊为单纯性肥胖。采用针刺治疗1个疗程后体重减轻8kg，2个疗程后减轻12kg，3个疗程后减轻15kg，体重达到69kg，腰围减至73cm，月经恢复正常，且减肥期间未严格要求病人节食，但针刺后饥饿感明显减轻，进食量渐渐减少，而无气短乏力，下肢肿等不良反应，面色红润光泽，精神饱满，精力充沛，疗效满意，停止治疗，随访半年，体重未出现反弹。

十二、针刺配食疗 调和营卫

黄瑾采用中医针灸疗法结合饮食调配治疗单纯性肥胖，获得了较为满意的疗效。

(1) 体针疗法

主穴：大横、天枢、三阴交、足三里、曲池、关元、血海、梁丘。胃肠蕴热甚者加内庭、上巨虚、丰隆；脾虚痰湿者加内关、水分、三阴交、支沟；脾肾气虚者加肺俞、脾俞、气海、太溪；肝郁气滞者加肝俞、合谷、太冲；男性腰围大于90cm，女性腰围大于80cm为腹性肥胖，加中脘、气海、滑肉门、带脉、大巨；大腿肥胖加髀关、伏兔；小腿肥胖加阳陵泉、下巨虚；局部过于肥胖者可加阿是穴。行提插捻转手法，留针30min，隔日1次，15次为1个疗程，休息15天后继续下1个疗程。

(2) 饮食疗法

首先保证正常的一日三餐及规律的进食时间，早餐必须吃，午餐在下午2点钟以前进食，入睡前2h不要进食。

早餐：1~2个鸡蛋或其他禽蛋，1杯无糖豆浆或脱脂牛奶；或少量燕麦粥、全麦面包、玉米、红薯等。午餐：蒸、煮、熏、酱的

瘦肉制品，或豆制品，配合可以生吃的蔬菜。晚餐：可以生吃的蔬菜、苹果。

禁任何零食、饮料、油炸食品。阻止脂肪吸收的食物如高纤维的碳水化合物，在脂肪被身体储存之前，帮助其进入消化系统，如苹果、杏、梨、菠萝、芦笋、绿豆、小扁豆、红薯、燕麦粥、面包（最好全麦面包）、荞麦、玉米，和帮助脂肪燃烧的食物，如鸡蛋或蛋制品、瘦肉、脱脂牛奶、去皮鸡肉或火鸡、脱脂或低脂奶酪、豆腐或豆制品、脱脂或低脂的酸奶酪。

（3）巩固治疗

穴位埋线治疗。脾虚湿阻型：天枢、脾俞、丰隆、足三里、阴陵泉、三阴交、中脘、水分、大横、滑肉门；胃肠实热型：胃俞、足三里、内庭、曲池、中脘、下脘、公孙、上巨虚、下巨虚、关元；脾肾阳虚型：脾俞、肾俞、三阴交、气海、足三里、关元、天枢、阴陵泉、水分。每次依辨证取5~6个穴位进行穴位埋线，并根据患者不同情况加埋阿是穴，2周埋线1次，4次为1个疗程。

单纯性肥胖其直接原因大多为饮食不节，消耗能量少，导致入多出少，因此脂肪在体内堆积，钠水潴留。而中医认为，肥胖的发生多因胃、肠、肝、脾等脏腑功能失调所致，而肥胖症多为本虚标实，本虚主要以气虚为主，兼见阴虚、阳虚，病位以脾为主，标实以痰浊为主，可兼气滞、血瘀。因此，黄瑾应用针刺减肥取足阳明胃经、足太阴脾经、足太阳膀胱经、任脉等经脉之穴位，以健脾除湿、调和营卫、通利三焦，使水湿得以正常排泄，从而恢复正常的水液代谢功能及大肠传导功能而获得满意疗效。

黄瑾还通过临床发现，在针灸治疗疗程结束后进行穴位埋线治疗，可以有效地巩固治疗效果，并使体重继续缓慢下降。而且有些没有时间或惧怕疼痛的患者，也可以直接采用这种治疗方法。

李某某，女，16岁，于2005年7月4日就诊。体重74.5kg，身高163cm，中度肥胖，舌淡，苔白腻。经过2个疗程的治疗，疗效显著，2005年12月10日体重下降为65kg，继续巩固治疗，穴位埋线4次，体重仍有下降，2006年9月体重下降为62.5kg，随访至今未见反弹。

十三、辨证施针 调整脏腑

许慧艳在临床针对单纯性肥胖，使用针灸方法辨证施针，在减轻体重的同时，调整脏腑功能，改善亚健康状态，取得满意的疗效。

取穴：主穴：脐周 8 穴：中脘、阴交、水分、关元、天枢（双）、大横（双）。辨证取穴：胃肠腑热型：曲池、梁丘、上巨虚、内庭；脾虚湿阻型：阴陵泉、太白、丰隆、三阴交；肝郁气滞型：肝俞、太冲、曲泉、期门；真元不足型：太溪、照海、肾俞、关元。临证加减：多食善饥、口渴体穴加足三里、梁丘，耳穴加渴点、饥点；嗜睡体穴加气海，耳穴加丘脑；便秘体穴加曲池、支沟，耳穴加肺、直肠下段；多汗体穴加合谷、复溜，耳穴加交感；月经不调体穴加血海、三阴交，耳穴加内分泌；产后肥胖体穴加石门、曲泉，耳穴加内分泌；自幼肥胖体穴加肾俞、三阴交，耳穴加肾；下肢水肿体穴加水道，耳穴加三焦。

操作：皮肤常规消毒后取 30 号 1.5 ~ 2.0 寸毫针，快速进针得气后，虚则补之，实则泻之，每日 1 次或隔日 1 次，留针 30min，15 次为 1 个疗程。耳穴取单侧或两耳交替使用，行王不留行贴压法，嘱患者于餐前和饥饿时按压耳穴 3 ~ 5min，以耳部酸痛发热为宜，每 3 天换 1 次，5 次为 1 个疗程。

单纯性肥胖的直接原因是饮食不节，导致脂肪在体内堆积而成，其内在因素主要是脏腑功能失调所致。正如《素问·奇病论篇》曰：“此肥美之所发也，此人必数食其美而多肥也”，张景岳提出：“肥人多有气虚之证”，朱丹溪提出“肥白人多湿”。单纯性肥胖多为本虚标实之证，病初以实证为主，后期以虚证为主，本虚以气虚居多，兼有阴虚或阳虚，标实以实热、痰浊、水湿为主。兼有气滞血瘀；病位多在中焦脾胃，其次为肝肺肾，因此肥胖是由于多脏腑、多器官功能失调引起的一种综合性疾病。临床治疗时必须四诊合参，根据病因病机进行辨证施针，以调整脏腑功能，达到“阴平阳秘，精神乃至”的平衡状态，方能取得显著的疗效。

针刺减肥的关键是依据病因、病机辨证取穴，通过调整气血，使紊乱的物质、水、盐、能量的代谢重新恢复平衡。同时加强机体的新陈代谢，促进脂肪的分解，消耗积存的脂肪，从而维持人体正

常的生理平衡，消除肥胖患者临床症状、减轻体重。

由于导致单纯性肥胖的原因是饮食不节和久坐不动，使脂肪在体内大量堆积所致。因此，制定合理的膳食结构，控制脂肪和碳水化合物的摄入量，参加一定量的体能锻炼，是增加治疗效果的必要手段。尤其是在体重恢复正常后，更应养成良好的饮食和生活习惯，从而防止体重的反弹。

王某，女，38岁。全身肥胖6年，身高162cm，体重84kg，BMI32.4，腰围109cm，臀围76cm，为Ⅱ级肥胖。伴食欲亢进、口干、饮水不多、大便秘结、气短乏力、嗜睡、时有头晕、舌淡苔腻脉沉滑，血清总胆固醇6.1mmol/L、甘油三酯1.74mmol/L，诊断为脾虚湿阻兼胃热型肥胖。体穴选脐周8穴阴陵泉、丰隆、上巨虚、足三里、内庭、曲池，耳穴选渴点、饥点、丘脑、三焦。经过2个疗程治疗后，体重下降16.5kg，腰围由109cm减至89cm，生化指标均降至正常范围内，伴随症状消失。半年后随访，病情稳定未反弹。

十四、整体与局部并重 随证取穴

曾洪玉在临床上采用针灸治疗单纯性肥胖症具有较好的疗效。

（一）针灸毫针电脉冲整体疗法

主穴：中脘、气海、滑肉门、大横、梁丘。

轻度肥胖：天枢、丰隆、足三里、梁丘、血海、水分、三阴交、阴陵泉等穴，以足阳明、手阳明、足太阴经穴为主；中度肥胖：加滑肉门、外陵、大巨、上巨虚、曲池、合谷；重度肥胖：加滑肉门、外陵、大巨、中脘、梁门、水道、公孙、太冲、上巨虚。

辨证配穴：脾虚湿阻型配水分、足三里、阴陵泉、丰隆、三阴交、公孙、脾俞；胃热湿阻型配足三里、天枢、合谷、支沟、曲池、丰隆、上巨虚、内庭；肝郁气滞型配膻中、期门、阳陵泉、太冲、支沟、三阴交、曲泉、行间、肝俞等；脾肾阳虚型配关元、足三里、三阴交、照海；阴虚内热型配内关、足三里、三阴交、太溪、食欲亢进明显配上脘、手三里、足三里、下巨虚；便秘配腹结、支沟、上巨虚；月经不凋配合谷、关元、带脉、子宫、血海、三阴交；浮肿配上脘、水分、天枢、太渊、阴陵泉、阴谷、复溜；伴高血压病

者配风池、太冲；伴冠心病者配内关、膻中、三阴交；伴糖尿病患者配阳池、足三里、三阴交。

操作：常规消毒后，选用30号1~3寸毫针，常规刺法快速进针并得气。将针灸减肥仪每一输出导线的两个电极分别连接在主穴两支毫针柄上，中脘气海连接；双滑肉门连接；同侧大横与梁丘连接，全部正、负极相同而不相邻。确定调制和脉冲时，要根据患者的肥胖程度和接受治疗的次数及前次使用脉冲形式等灵活选用。每日或隔日1次1个小疗程，30次1个大疗程。

注意事项：妇女经期，孕期哺乳期或醉、劳、饥、饱等暂不用本法，带起搏器、换有金属瓣膜、体内有钢钉等禁用本法，有严重晕针反应、身体极度虚弱者慎用本法。一般情况下应连续治疗3个小疗程，若治疗期间减肥效果停滞不前，则可在疗程间休息5~7天，若经1个疗程或2个疗程已经取得了满意的疗效，也应坚持治完1个疗程，以便巩固疗效。

（二）针灸毫针电脉冲局部疗法

（1）腹部肥胖

取穴：主穴取阿是穴、梁丘。配穴：脐以上肥胖明显配中脘、下脘、水分、滑肉门；脐以下肥胖明显配三阴交、关元、外陵、腹结；全腹肥胖配建里、气海、大横。

操作：患者取仰卧位，在左、右腹部各确定1个最高点做阿是穴。选用30号1~2.5寸毫针，直刺进针，到达常规深度。针灸减肥仪输出电极连接方法：阿是穴与同侧梁丘相连接，配穴的2个任脉穴相连接，另一对（左右）配穴相连接。逐渐调高每一对输出的脉冲强度，在患者能耐受前提下，尽量加大电流，留针30min，出针时宜快速用力拔出毫针，不按压针孔。

注意事项：腹部最高点恰在要取的穴位或相距很近时，可将此穴作为阿是穴，配穴重新选择稍远一些的腹部穴位，腹部穴位进针达到常规深度即可，以免通电后毫针震动时损伤内脏。

（2）腰部肥胖

取穴：主穴取带脉、风市。配穴：伴有腹部肥胖者配天枢；后腰部肥胖者配志室。

操作：选用30号1~2.5寸毫针，穴区常规消毒后，直刺进针，到达常规深度后向外提针0.2寸左右。针灸减肥输出电极连接方法：带脉与同侧相风市相连接，每一对配穴相连接。

(3) 臀部肥胖

取穴：主穴取白环俞、环跳。配穴：臀部下垂配会阳、承扶；臀部配阿是穴、巨髎；上臀部肥胖突出配髂棘下。

操作：选用30号1.5~3寸毫针，先刺主穴，穴区常规消毒后，直刺进针，至局部有酸胀感后，行轻插重提泻法，每穴约1min左右，然后将针提至皮下，改为平刺；配穴刺法同主穴，阿是穴为仰卧位时臀两侧最宽的部位，髂棘为髂棘最高点下1寸左右处最丰满处的两点。针灸减肥仪输出电极连接方法：同侧主穴相连接；同侧配穴相连接。

注意事项：主穴直刺后改为平刺时，针尖方向最好朝向脂肪堆积明显的部位，每次治疗可在方向上有所变化，尽量避免每次在同一部位皮下组织中刺激。肥胖症患者除了通过辨证采用针灸整体与局部相结合的方法治疗以外，还可配合食疗，药膳（如：薏苡仁粥，荷叶粥，冬瓜粥）、耳穴、刮痧、熏蒸、运动、气功、按摩等项目进行综合治疗，从而取得有效且持久的疗效。

金某，女，35岁，于2003年8月19日就诊，体重102.5kg，身高168.5cm，舌淡苔白腻。既往有肾上腺瘤史。经过2个疗程的治疗，疗效显著，2003年10月19日体重下降为87kg。继续巩固治疗，体重仍有下降，未见反弹。

刘某，女，42岁，于2003年8月19日就诊，体重62.5kg，身高164cm，经过2个疗程的治疗，2003年11月27日体重恢复到58.6kg，体形完全正常，且未见反弹。

十五、针刺走罐埋线 三法并用

涂玲采用针刺、走罐、埋线为一体的综合疗法治疗单纯性肥胖，收到了较满意的效果。

(1) 针刺

取穴：主穴：足三里、内庭、关元、中脘；配穴：“胃热易饥型”配天枢；“脾虚水停型”配三阴交、阴陵泉、水分。

操作：选用华佗牌 30 号，1.5 寸不锈钢毫针，患者仰卧，常规消毒后进针。手法：“胃热易饥型”采用泻法，“脾虚水停型”采用补法，得气后将 G6805 - A 型电针仪接于针柄上，施以连续波。“胃热易饥型”通电频率 120 次/min 以上，通电时间 30min，再留针 5min。“脾虚水停型”通电频率 40 ~ 60 次/min，通电时间 15min，留针 20min。

（2）走罐

选用中号玻璃火罐，拔罐时先在所拔部位皮肤上涂上一层石蜡液，再将罐拔住，然后医者用右手握住罐子，向上、下或左、右需要拔的部位，往返推动致所拔部位皮肤红润、充血，瘀血时将罐取下。

（3）埋线

取穴：关元、气海、天枢、足三里，随证加减。

器材准备：自制埋线消毒包 1 个（弯盘 1 个、剪刀 1 把、镊子 2 把、12 号腰穿针 1 个、孔巾 1 张、纱布若干、一次性手套一副、1 号医用外科羊肠线 1 根、注射用水 5ml、生理盐水 500ml 备用）。

操作：患者取仰卧或俯卧位，暴露手术区部位，选取穴位，进行常规消毒，打开消毒埋线包，向弯盘中倒入少许生理盐水，把羊肠线置于其中浸泡变软，将羊肠线剪成长 0.5 ~ 1cm 若干段备用，铺洞巾，将备用羊肠线放入针芯，刺入穴位，有针感后将线送入穴位点，然后将针拔出，盖消毒纱布，胶布固定即可。

先行针刺 30 天，连续针刺 5 天停针 2 天，30 次为 1 个疗程，同时每周 2 次腹部走罐，而后行埋线，每月 1 次，连续 3 个月。

根据临床症状进行辨证分型，分为“胃热易饥型”和“脾虚水停型”两型。“胃热易饥型”表现为多食易饥，口舌干燥，多有便秘，舌红，苔黄，脉滑，治拟清泻胃肠实热。《灵枢·经脉》记载，“盛则泻之”选足阳明胃经穴为主，采用泻法，针刺“足三里”、“内庭”对下丘脑摄食中枢的影响，能降低饥饿中枢的兴奋性，提高饱食中枢的兴奋，从而控制其食欲，减少热卡的摄入，调整胃肠运动和吸收功能，促使体内堆积的脂肪被消耗利用。“脾虚水停”型，患者均感肢体困重，纳少乏力，腹胀便溏，腰膝酸软，月经不调，舌边多齿痕，脉沉或细。治法健脾益气，以利水湿，脾为后天之本，

气血生化之源。《灵枢·经脉》虚则补之，选足太阴脾经穴为主，采用补法，针刺“三阴交”，对肝、肾、脾均有调节作用，针刺“阴陵泉”、“水分”，有利水湿作用，针刺“关元”，有调节月经作用，据临床表现可随症加减。针刺后胃纳减退，饥饿感降低，还可影响糖代谢，内分泌及消化液分泌过程。穴位埋线起到针刺后穴位的持续刺激作用。走罐可使局部的脂肪颗粒破碎，局部缩小。三者相结合治疗，患者体重、体重指数、腰围均有显著下降。

十六、针药并用 清胃热

夏茗琦采用针刺、中药、耳穴刺激疗法对单纯性肥胖进行治疗，取得较好的效果。

(1) 针刺

取穴：水道、中脘、天枢、气海、腹结、足三里、丰隆、内庭、上巨虚、梁丘、曲池。

操作：局部皮肤消毒，右手持针、针尖抵触穴位，进针深度适宜，用提插泻法。得气后主穴接中频治疗仪，采用连续减肥波、频率80~120次/min，电流强度以肌肉抽动、病人感舒适为佳，留针30min，前6天每日1次，以后每隔2天针1次，共30天为1个疗程。

(2) 中药 大黄10g，泽泻30g，桃仁10g，山楂15g，黄芪10g，防己5g，枳实5g，厚朴5g。煎药内服，每日2次，口服15天为1个疗程。

(3) 耳穴疗法

取穴：胃、大肠、肺、三焦、内分泌、皮质下、饥点、渴点、口、食道、神门等穴。

操作：75%酒精常规消毒耳廓，王不留行粒置于0.5cm×0.5cm胶布上，贴于上述穴位，每次全部穴位均贴，左右耳隔3~4天替换，嘱患者饭前30min按诸穴5min，以耳穴发热为度。

《素问·奇病论》曰：“肥者令人中满，此肥点之所发、其人必数食其美而多肥也”。肥胖的主要原因为过食肥甘、醇酒厚味，而致湿热渐积，脾失健运，水精不布，脂膏内瘀。脾胃功能失调、脾胃偏盛，饮食过盛，吸收过盛。夏茗琦在治疗过程中用泻法，取足阳

明胃经、足太阴脾经上的穴位，以清胃热、节食欲、健脾运、祛痰湿、疏通脾胃经气、调理脾胃功能，再辅以健脾祛湿、和胃理气运脾的中药，耳穴调整内分泌和自主神经，抑制亢进的胃肠功能，促进代谢物质的排泄和消化吸收，内分泌和全身各系统功能的调节，从而健身减肥。

十七、多法并用 整体调理

李道平采用耳穴贴压、刮痧、饮食、运动等疗法治疗单纯性肥胖，取得较满意疗效。

(1) 耳穴贴压

取穴：外鼻、脾、胃、肺、肾、神门、内分泌、三焦。

操作：所取耳穴局部皮肤用 75% 酒精棉球消毒，固定耳廓，右手用镊子夹取粘有王不留行籽的方形小胶布，对准所选好的耳穴贴敷，并按压，每次取 3~5 穴，嘱患者每天自行按压 5 次以上，特别在饭前或感觉饥饿时必须按压。每次贴一侧耳穴，5 天换贴另一侧耳穴，6 次为 1 个疗程。

(2) 刮痧

刮试经脉：主要为督脉、任脉、足太阳、足阳明、足太阴、足厥阴、足少阴等经络。

选穴：膻中、中脘、气海、关元、三阴交、脾俞、胃俞、肾俞、肺俞、公孙、太溪、梁门、天枢、水道、大横、尺泽、鱼际、足三里、丰隆、大椎等。

操作：①首先让患者摆好合适体位，便于施术。其次在要刮痧部位涂上自制刮痧介质。②用泻法刮拭督脉（由上而下）、足太阳经（由下而上）一、二侧线。重点刮拭大椎、T₅~T₁₂及其两侧、腰骶部。③用泻法刮拭任脉（由上而下）、足阳明（由下而上）、足太阴（由上而下）的腹部经脉。重点刮拭膻中、中脘、气海、关元、梁门、天枢、水道、大横等穴，刮拭腹部以刮至肠鸣辘辘、矢气胀消为佳。④用泻法由上而下刮拭足三阴经的足内侧处，重点刮拭三阴交、太溪、公孙等穴。⑤用泻法点状刮拭尺泽、鱼际、足三里、丰隆等穴。⑥施术初期以刮出的痧消退后，方可进行下一次刮拭，一般 2 次刮痧间隔 2~3 天，等施术后期不再出痧时，可每天刮拭 1

次,1个月为1个疗程。

(3) 饮食疗法

饮食疗法应在医生和营养师的指导下,科学地、有计划地改变患者不合理的膳食结构,根据患者的肥胖度适当控制其饮食量,做到低热能平衡饮食,在限制热能的基础上,多吃高蛋白、低糖、低脂肪食物,但三者配比要适宜,无机盐、维生素供给充足,以满足机体需要。还要让患者养成良好的饮食习惯,三餐定点吃饭,不要为节食而减少三餐中的任何一餐,晚餐宜少吃,不吃零食、甜食、夜宵,吃饭时要细嚼慢咽,不要暴饮暴食等。

(4) 运动疗法

众所周知,生命在于运动。就是说运动不仅使肌体各系统功能增强,提高人体抗病能力,达到健康长寿的目的,同时运动可以增加热量消耗,而体内脂肪只有通过氧化成二氧化碳才能被消耗,故在低热能饮食条件下,多运动以增加热量消耗,就可以减轻体重了。但必须在医生的指导下,根据患者自身的爱好和身体状况选择合适的运动,如体操、步行、慢跑、骑自行车、游泳、哑铃、太极拳、球类运动、仰卧起坐、鱼跃式运动等。不论何种运动,都要循序渐进,持之以恒,才能达到减肥的目的。

十八、局部取穴 苍龟探穴

王兵采用苍龟探穴针刺法为主治疗单纯性肥胖,取得显著疗效。

取穴:主穴为上脘、中脘、水分、阴交、中极、大横(双)、不容(双)、天枢(双)、外陵(双)、水道(双)。配穴:双侧章门、日月、三阴交。

操作:患者取仰卧位。先在主穴中选出4个穴位(以脐为中点,上下左右各象限均应有1穴为佳),常规消毒后,使用30号1寸不锈钢毫针先针刺脐上穴位。采用苍龟探穴法进行针刺:先将针进至地部,复将针提至天部,以拇指、食指扳倒针身,依照先上后下、自左而右的次序斜刺进针,变换针尖方向。向每一方向针刺都必须由浅入深,分三部徐徐而进,待针刺得到新的感应时,则退至穴位浅层,然后改换方向,依上法再刺。手法完毕后,出针(不需留针)再行针刺下1个穴位(按照脐左、右、下的顺序)。待4个主穴的苍

龟探穴针刺法全部完毕后，再消毒其他穴位，用30号1.5寸不锈钢毫针，按照常规进行针刺，手法刺激得气后反复轻插重提，大幅度高频率捻转，产生较强的针感后，将G6805-Ⅱ型电针仪接于腹部脂肪较为肥厚穴位处的针柄上，采用连续波，强度以患者耐受为度。配穴采用华佗牌30号1寸不锈钢毫针，按照常规针刺，平补平泻法。留针30min。起针后，用4号火罐在腹部和大腿处拔罐，留罐期间，嘱患者自行摇晃腹部火罐罐底，带动肌肉的运动，10min后起罐。取耳穴饥点、渴点、口、胃、脾、内分泌、神门、大肠、脑点，脱敏胶布剪成5mm×5mm，中间放王不留行籽，贴上述穴位。每次贴一侧，两耳交替贴压。嘱患者每日按压至少3次，每次均按至耳朵发热为止。每周治疗3次，10次为1个疗程。

治疗期间，患者应限制淀粉类食物的摄入量，提倡高纤维素饮食；适当增加运动量以增加热量消耗，减少脂肪积聚。

苍龟探穴针刺法始见于《金针赋》：“苍龟探穴，如入土之象，一退三进，钻剔四方。”该针法属于平补平泻法，有较强的行气作用，原本适用于治疗顽麻冷痹、瘫痪痿软、肢体麻木、癥瘕积聚等一切气滞血瘀证。但由于该手法进针的深浅层次不同，针刺方向上更具有多样性，应用于腹部穴位时，可直接破坏皮下脂肪细胞，加速脂肪细胞的分解。因此，可将该法用于治疗肥胖症。使用1寸针可以使操作灵活、快捷；因为行针时针体完全在脂肪层，故患者无明显的疼痛等不适感。腹部是脂肪堆积最多的部位，因此选取腹部穴位应用该法往往特别有效。中医学认为本病的病机为脾胃失和，脾虚胃盛，痰湿壅滞，所以临床选用足太阴脾经和足阳明胃经及任脉的腹部腧穴为主穴，以达健脾和胃、化痰利湿之效。配合胆经募穴日月、脾经募穴章门、足三阴之交会穴三阴交，可起到疏肝利胆、行气、健脾和胃之效。针刺结束后在腹部拔罐并摇罐底也可起到破坏脂肪细胞，加速脂肪细胞分解的作用。

十九、腹部取穴为主 电针

乔子虹采用腹部电针治疗单纯性肥胖，取得了较显著的疗效。

取穴：主穴：府舍、腹结、大横、归来、大巨、天枢、滑肉门、梁门、承满。配穴：脾虚湿阻型加脾俞、足三里、厉兑、丰隆；胃

肠实热型加足三里、阳陵泉、支沟；脾肾阳虚型加脾俞、肾俞。

操作：使用 G6805 - II A 型或 G6805 - I A 型电针治疗仪。治疗前将治疗仪上的 A 频调至中间位置，B 频调至中间稍偏右边位置，呈疏密波型，4 个输出电极强度调至 3 ~ 5 刻度之间。治疗时用 75% 酒精棉球对针刺穴位皮肤由内向外消毒，取 30 号，1.5 寸毫针，一只手提起腹部脂肪组织，另一只手持针直刺进入主穴，穿过表皮后，针尖指向头部方向，沿皮下逆脾胃两经在脂肪层内平刺，一针连一针，将刺入脾经的毫针自上而下依次连上治疗仪的电极，将刺入胃经的毫针自下而上依次连上治疗仪的电极，使电流方向与针刺方向一致。取出腹部毫针时，用消毒干棉球轻按穴位，握针柄将针取出；对足三里、厉兑、丰隆、阳陵泉、支沟等穴直刺进针，快进慢出，取针时不需按压穴位；脾俞、肾俞穴则慢入快出，取针时按压穴位。治疗以患者自觉腹部发热、发痒或由内向外收紧感为宜。每日针刺 1 次，每次 30min，针刺 5 次休息 2 天，针刺 15 次为 1 个疗程。

祖国医学称单纯性肥胖者为“肥人”。引起肥胖的原因有饮食不节，过食肥甘厚味；好静恶动，静而不动，气血不畅，脾胃气滞，运化失调，水谷之精微输布障碍，化为膏脂和痰浊，滞于肌肤、脏腑，导致肥胖；七情变化超过人体正常生理功能调节，影响饮食起居，引起脾胃运化障碍而发病。肥胖的病机主要是脾胃功能失常。针刺的主要穴位在脾胃二经上，以腹部穴位为主，让针体直接与脂肪组织接触，以穴为点，以点带线，接通电极，再以线带面，震动整个腹部，从而达到治疗目的。有患者诉针刺后有明显饥饿感，此时应忌暴饮暴食；还有患者针刺后有大小便急迫感，大便较以往通畅，便软成形，但无腹痛、腹泻、厌食等不适。需要强调的是掌握好针刺方向及针法补泻，调节脾胃功能，泻其过亢，补其不足，是针灸减肥的一个重要环节。

二十、快速针刺为主 配合推拿

宋少军采用快速针刺加推拿方法对单纯性肥胖患者进行减肥治疗，效果较好。

取穴：足三里、中脘、气海、丰隆、天枢、三阴交、上巨虚、

阴陵泉、梁丘、太白、公孙、水道、归来、曲池、内关、阴交。

操作：针刺：选用 28 号 2 寸一次性无菌针灸针，中脘、气海、阴交、天枢、水道、归来、足三里、上巨虚、阴陵泉诸穴直刺 1 ~ 1.5 寸，丰隆、三阴交、太白、公孙、曲池、内关、梁丘直刺 1 ~ 1.5 寸，腹部诸穴快速进针到位后即出针，其余穴针后施捻转泻法 2s 内出针，视病者肥胖程度及全身情况交替配穴，每次选 15 ~ 20 个穴，20 次为 1 个疗程。第一个疗程每天 1 次，第二个疗程前 10 次隔天 1 次，后 10 次隔 2 天 1 次，2 个疗程间隔 7 ~ 10 天。

推拿：中脘、气海、阴交、天枢、水道、归来主要施用掌摩法及运八卦法，足三里、丰隆、三阴交、阴陵泉、梁丘、太白、公孙、曲池、内关、上巨虚主要施用一指禅法，要求手法要由轻至重，以病人能耐受为度，以推拿部位皮肤微热微红为佳，每次推拿 15 ~ 20min。

临证加减：易饥饿者重泻足三里；产后肥胖重泻气海；肠燥便秘者重泻天枢；自幼肥胖者重泻丰隆；月经不调者加地机、血海；气滞湿阻者加水分、关元；腰背部肥胖者配合捏脊及推背法治疗。

注意事项：除针刺推拿一般注意事项外，其一是饮食控制，建议在减肥期间多食蔬菜及粗纤维食物，适量控制零食及高脂肪、高糖类饮食以及醇酒辛辣食品，特别应控制晚餐的数量和质量。其二是运动，建议每日至少要完成 1000m 步行或慢跑或等量的其他有氧运动，但不主张做较大强度的仰卧起坐运动。

中医学认为，脾主运化升清，当脾运化水谷精微的功能减退，则机体消化吸收功能失常，导致水谷在体内停滞，不能化生机体所需要的精微物质，而产生痰湿饮等病理产物，这些产物在体内蓄积而造成肥胖。因此，脾失健运、痰湿内聚是引起肥胖的最基本病机。针刺推拿的配穴原则，一是调节脾胃两经为主，达到标本兼治之功。足三里、中脘、天枢能补益脾胃，清热利湿化痰。二是丰隆化痰，气海、阴交、水道、归来、阴陵泉、三阴交为化湿利水要穴，对通便利水促使痰湿饮排空有益。上述诸穴大多是脂肪组织集中聚集的部位，刺激上述诸穴，可使局部血循环加速，而局部血运障碍改善又促使脂肪转化为可代谢产物，从而被机体排出体外。

二十一、辨证分型 体耳针并用

单纯性肥胖是指由于机体摄入热量大于消耗热量，或摄入热量正常而消耗热量过少，以致体内脂肪堆积过多、体重增加或脂肪分布异常的病症。现代社会随着生活条件的改善，患肥胖病的人越来越多，不仅影响美观，加重全身各系统的负担，更可伴有血糖、血脂等代谢及内分泌系统功能异常，诱发或加重心脑血管病症，从而严重危害人类的健康。魏立新运用体针配合耳穴贴压治疗本病，取得较好疗效。

(1) 辨证分型

①胃肠实热型：形体肥胖，面色红润，消谷善饥，脘腹胀满，口干口苦，大便秘结，舌红，苔黄腻，脉滑数。②脾虚湿盛型：肥胖臃肿，面色苍白，身体困重，胸脘痞满，纳少便溏，嗜睡肢肿，舌淡胖有齿痕，苔薄白或白腻，脉细滑。③气滞血瘀型：形体丰满，面色黯红，胸闷肋胀，烦躁易怒，舌黯红或有瘀斑、瘀点，苔薄白，脉弦涩。

(2) 体针

取穴：曲池、梁门、腹哀、天枢、大横、水道、腹结、足三里、三阴交、丰隆、局部（肥胖部位）。胃肠实热型加支沟、上巨虚、内庭；脾虚湿盛型加脾俞、阴陵泉、水分；气滞血瘀型加气海、膈俞、太冲。

操作：常规消毒后，腹部穴位采用2寸或3寸毫针，从腹部两侧向腹中线方向斜刺，强刺激，使局部有明显酸胀感；肥胖局部亦以深刺为宜，并力求有针感；其余穴位按常规刺法针刺。除脾俞平补平泻外，其余穴均以泻法为主。留针30min，留针期间每隔10min行针1次。每天1次，5次后改为隔天1次。女性月经期间暂停治疗。

(3) 耳穴贴压

取穴：神门、皮质下、内分泌、交感、三焦、口、饥点、渴点。胃肠实热型加胃、大肠；脾虚湿盛型加脾、肺；气滞血瘀型加肝、胆。

操作：常规消毒，先在穴区内探寻敏感点，再用脱敏胶布贴以

王不留行籽。每次取一侧耳穴，3天后换另一侧，两耳交替。嘱患者每天三餐前及睡觉前自行按压，每次5~10min，至耳部有发热感为宜。食欲旺盛者可于有饥饿感时增加按压次数。

(4) 注意事项

①严格控制饮食量，但不主张饥饿疗法。饮食结构宜低糖、低脂、低盐、多纤维，适当补充蛋白质和维生素，忌吃零食，晚餐清淡少食；②增加运动，使热量摄入与消耗排泄平衡。根据自身情况，选择散步、快走、慢跑、骑车、爬楼、家务劳动等适当运动，每天坚持锻炼。③每天睡眠时间控制在7h以内。④作息时间要规律。

中医认为，肥胖多与先天禀赋、恣食肥甘、久坐久卧有密切关系，而胃肠实热、脾虚湿盛及气滞血瘀是发病的主要内在因素。针刺腧穴可通过疏通经络气血而调整脏腑的功能，祛除瘀积在体内的湿热、痰浊及多余膏脂，从而达到减肥的目的。取穴以足阳明经、足太阴经为主，其中梁门、腹哀、天枢、大横、水道、腹结可调理脾胃气血，助大肠传导以通便；曲池为大肠经合穴，泄热通腑；足三里、三阴交可健脾胃以运化输布水湿；丰隆为祛痰要穴，可杜绝生痰之源；局部穴位可疏通肥胖部位之气血以祛除多余膏脂。胃肠实热型配支沟以泻三焦相火而通便，上巨虚以疏通肠腑，内庭为胃经荥穴而清泄胃火；脾虚湿盛型配脾俞以健脾益气，阴陵泉以健脾利湿，水分助小肠泌别清浊以利水通小便；气滞血瘀型配气海以益气行气，膈俞以活血化瘀，太冲以疏肝理气。针刺以泻法为主，以祛除实邪。针刺深度较常规要深，并力求得气，以达到一定的刺激量。留针期间的间断行针亦必不可少，使有效的刺激量得以维持。

耳穴贴压作为体针的辅助治疗措施，可有效地维持针刺的刺激量。除此之外，患者于进餐或饥饿时及时按压耳穴，可适时地提醒患者控制饮食量及进食种类，是非常必要的行为干预。

在减肥治疗过程中，魏立新体会如下：①中医辨证分型中胃肠实热型疗效最佳，此型以消谷善饥为主要症状，而如上所述，针刺不仅可抑制亢进的食欲，减少能量的摄入和吸收，还可促进能量的代谢，故治疗效果明显优于其他两型。②肥胖前期的患者疗效较差。因针刺是通过激发机体自身的调节系统起作用的，对于代谢功能正常的调节能力有限。而此类患者的代谢功能可能亦属正常或接近正

常,因而效果欠佳。③中外患者的疗效对比虽无明显差异,但治疗初始阶段国外患者的体重变化却明显优于国内患者。可能与其初次接触针灸,因而比较敏感有关。④有些患者体重虽无明显减轻,但在穿衣时却可感觉体形的变化,尤其腰围明显减小。提示针刺可使脂肪的分布向良性发展,可起到美体的作用。⑤家族性肥胖、运动员型肥胖减肥效果不理想,前者因遗传因素而难以减重;后者多属肌肉发达而非脂肪堆积。⑥减肥治疗必须集治疗、饮食、运动、生活规律于一体,方能奏效。单纯依赖治疗无法取得并维持良好的疗效。⑦减肥治疗应以不降低患者的体力和抵抗力为基本标准。

患者,男性,36岁,孟加拉国人,身高1.70m,职员。因近1年来体重明显增加而于2002年6月10日就诊。就诊时体重87kg,形体肥胖,腹部臃肿,食欲旺盛,嗜食肥甘,口渴喜冷饮,大便干燥,两日一行,舌红,苔薄黄,脉数有力。诊断:Ⅱ°肥胖。辨证分型:胃肠实热型。治疗:同治疗方法中的胃肠实热型,并嘱其控制肉类及甜食的摄入,增加运动量。结果:治疗1次,减重1kg,4次后减重3kg,15次后减重7kg,取得显著疗效。

二十二、电针为主 综合治疗

郑斌在临床上以针刺为主,配合耳压穴、电脑中频治疗仪、饮食调配综合治疗单纯性肥胖,疗效较佳。

(1) 辨证分型

单纯性肥胖症的临床表现可见于任何年龄,幼年型者自幼肥胖,成年型者多起病于25岁,但临床以40~50岁中年女性为多。男性脂肪分布以颈项部、躯干部为主,而女性以腹部、下腹部、胸部乳房及臀部为主。轻度肥胖者常无症状,中重度肥胖者按以下情况辨证分型。

胃热炽盛型:患者表现为消谷善饥,饮食量大,喜冷恶热,大便秘结,小便色黄,舌苔黄偏干,脉大有力。

痰浊中阻型:患者表现为素喜肥甘厚味,头重如裹,肢体沉重,纳呆,舌胖大,苔白腻,脉滑。

气滞血瘀型:患者表现为胁肋胀满,心烦易怒,口苦口干,失眠多梦,或长期精神紧张,情绪失控,舌质偏黯,苔白,脉弦。

脾肾阳虚型：患者表现为面色苍白，畏寒喜暖，体重乏力，口淡纳呆，腰膝酸软，便溏，夜尿多，舌胖大有齿痕，苔白腻，脉濡滑。

（2）电针

以肚脐为中心划十字，每隔2寸刺入1针，脐上、脐下各2针，脐两旁各3针，共计10针，简称腹十针。用2寸毫针，先直刺后斜刺，针尖指向下。再任取两穴加上电极，共取2组。再根据辨证取下面的辅穴：胃热加内庭、曲池、支沟；痰浊加内关、足三里；气滞血瘀加太冲、阳陵泉、血海；脾肾虚加太溪、三阴交、阴陵泉。实证针刺用泻法，虚证针刺用补法，留针30min。每日治疗1次，10次为1个疗程。连续2个疗程后休息3天，继续下1个疗程。

（3）耳压

取神门、内分泌、饥点、渴点为主，胃热配胃、大小肠、肛门、口；痰浊配脾、胃、三焦；气滞配肝、心、脑；脾肾虚配脾、肾、膀胱。用王不留行籽按压，两耳交替贴，每日三餐前揉按，以耳廓发热为度。每周换药2次，10次为1个疗程。

（4）电疗

采用TL900型电脑中频治疗仪，每机分A、B两组，每组有两个极板。毫针刺入后，将两个极板分别放在腹部或腰背部肌肉丰厚的部位，调整电量的大小，以患者可以耐受为度。仪器自动设置为20min，每日治疗1次，10次为1个疗程，与针刺同步。

（5）饮食调配

肥胖患者在进行综合治疗的同时，必须进行相应的饮食控制，才能取得较好的疗效，而且治疗停止后体重不易反弹。一般建议患者早餐以谷类为主，配合煮鸡蛋及水果，一定要吃饱；中餐主食适量，配合肉食（以鸡肉、鱼肉为好）及蔬菜，进食七八成饱最佳；晚上6点以后不吃主食，以水煮菜为主，不吃含糖量高的水果，如香蕉、甜橙、甜瓜等，睡前若觉得饿可喝杯脱脂酸奶。郑斌认为饮食控制应适度，过于严格的节食会损害人的肝肾功能，甚至是不可逆的，而且也很难坚持下去。

针灸通过对肥胖者神经及内分泌功能的调整，一方面抑制食欲，减少进食量，同时抑制亢进的胃肠消化吸收功能，控制机体对营养

物质的吸收；另一方面，可促进能量代谢，增加消耗，促进体内脂肪分解，最终实现减肥效果。在中医脏腑辨证上，肥胖主要与肝脾肾三脏的功能失调有关，因此，清胃健脾、疏肝理气温肾，使气血通畅是基本治则。临床肥胖症患者以胃热炽盛型和痰浊中阻型最为多见，因此，清胃健脾是主要治则，兼以理气活血温肾。

“腹十针”为郑斌在临床实践中摸索总结出的个人经验用穴法。脐周十穴多为奇经和足阳明胃经、足太阴脾经循行经过，与人体的气血充盛，饮食摄入后的腐熟运化、水液调节有直接关联。辅以电疗，具有见效快、安全性高、痛苦小、疗效巩固的特点，不产生厌食、腹泻、体力下降等不良反应。

从临床实践和观察中体会到，体重越重或者体重波动大的患者，疗效越明显。从整体看，腹部脂肪较其他部位脂肪消减快，即使体重减的不多，相应症状也会好转，对高血压、高血脂、高血糖均有辅助治疗作用。但是在减肥的认识上需注意一点，减肥过程中体重不会直线下降，需经过治疗期→稳定与调整期→巩固期3个阶段，是一个长期过程，不能一蹴而就，甚至急功近利，造成对身体的不可逆损伤。

患者，女，41岁，已婚，2004年5月11日初诊。患者体重68kg，身高163cm，饮食量大，易饥易渴，喜冷饮，大便干，两日一行，小便黄，量少，舌尖红，苔黄干，脉数有力。有家族肥胖史，除外其他疾病和药物作用。诊断：单纯性肥胖症（胃热炽盛型）。取“腹十针”配内庭、曲池、合谷、支沟、下巨虚。任选2组腧穴加电，再将中频极板放在患者臀部，留针30min。起针后贴耳压豆于一侧，再嘱咐患者饮食调配。结果：1个疗程后体重下降2kg，3个疗程后下降4.5kg，5个疗程后下降6kg。自觉食欲减退，渴感适度，胃中不再嘈杂，身轻，大便每日一行，小便淡黄，舌尖略红，苔薄黄，脉弦。随访5个月以上，自觉身体无任何不适，体重无反弹。

参 考 文 献

- [1] 金涛. 电针结合耳压治疗单纯性肥胖 30 例. 江苏中医药, 2002, 23 (11): 45
- [2] 艾炳蔚. 电针治疗单纯性肥胖 30 例临床观察. 江苏中医药, 2004, 25 (11): 44~45
- [3] 丁哲, 丁岩. 耳穴贴压治疗单纯性肥胖 112 例. 中国民间疗法, 2005, 13 (9): 13~14
- [4] 唐庆芬, 邓倩萍, 徐秋玉. 肥三针治疗单纯性肥胖 50 例疗效观察. 新中医, 2004, 36 (10): 50~51
- [5] 顾健华. 群针法治疗女性单纯性肥胖的疗效观察. 广西中医药, 2006, 29 (4): 30~31
- [6] 李健. 刃针治疗单纯性肥胖 43 例. 湖南中医杂志, 2007, 23 (2): 57~58
- [7] 华云辉. 透刺闪罐与耳穴治疗单纯性肥胖的临床观察. 针灸临床杂志, 2005, 21 (5): 29~30
- [8] 张中成, 符文彬. 穴位埋线治疗单纯性肥胖 30 例. 陕西中医, 2006, 26 (9): 1122~1124
- [9] 郑丽静, 叶国传. 以电针为主综合治疗单纯性肥胖 43 例. 针灸临床杂志, 2007, 23 (4): 29~30
- [10] 张瑛, 吴芳蕙. 针刺配合中药治疗单纯性肥胖 58 例. 上海针灸杂志, 2007, 23 (4): 16
- [11] 王红玉. 针刺治疗单纯性肥胖 60 例临床疗效观察. 针灸临床杂志, 2001, 17 (4): 27~28
- [12] 黄瑾. 针灸结合饮食治疗单纯性肥胖 219 例. 中医外治杂志, 2007, 16 (3): 30~31
- [13] 许慧艳, 马金. 针灸治疗单纯性肥胖 138 例. 辽宁中医药大学学报, 2007, 9 (4): 137~138
- [14] 曾洪玉. 针灸治疗单纯性肥胖的体会. 针灸临床杂志, 2005, 21 (3): 26~27
- [15] 涂玲, 蒋晓莉, 袁婉丽. 针疗法治疗单纯性肥胖疗效观察. 泸州医学院学报, 2004, 27 (6): 529~530
- [16] 夏茗琦, 夏一波, 尚弘光. 针药并用治疗单纯性肥胖 62 例. 实用中医内科杂志, 2002, 16 (2): 112~113

- [17] 李道平, 孙丽云, 宫化丽, 等. 综合疗法治疗单纯性肥胖 67 例. 针灸临床杂志, 2001, 17 (9): 11~12
- [18] 王兵, 刘家瑛. 苍龟探穴针刺法为主治疗单纯性肥胖 40 例. 中医杂志, 2005, 46 (10): 768~769
- [19] 乔子虹, 雷红. 腹部电针治疗单纯性肥胖 47 例. 中国针灸, 2005, 25 (1): 67
- [20] 宋少军, 宫美英, 殷丽红, 等. 快速针刺加推拿治疗单纯性肥胖 261 例. 中国民间疗法, 2007, 15 (9): 55~56
- [21] 魏立新. 体针配合耳穴贴压治疗单纯性肥胖 53 例. 中国中医药信息杂志, 2006, 13 (3): 66~67
- [22] 郑斌, 陈红. 以电针为主综合治疗单纯性肥胖 55 例临床观察. 中国中医药信息杂志, 2007, 14 (1): 57~58

【高脂血症】

高脂血症属于中医“痰湿”、“浊阻”、“肥胖”范畴。古人虽然不知道血脂增高，但已经注意到它的存在与危害，尤其对过食肥甘引起高脂血症的危害性早有认识。如《素问·生气通天论篇》：“高粱之变、足生大疔”。《三因方》：“饮食饥饱，生冷甜腻聚结不散或作痞块、膨胀满闷”。中医在治疗上特别重视节制饮食，如《医学心悟》提出养身之道：“人身之贵，父母遗体，食欲非常，疾病蝉起，外邪乘此，缠绵靡已，浸淫经络，凝寒腠理，变证百端，不可胜纪”。已经注意到饮食与疾病的关系。

对该病的病因病机的论述还见于《素问·经脉别论篇》：“食气入胃，散精于脉，淫气于筋。食气入胃，浊气归心，淫精于脉，脉气流注，经气归于肺……”强调了饮食对人体的重要意义。但是脏腑功能失常，则可影响这一过程而发生各种疾病，在高脂血症形成和发展过程中与脾、肾、肝、心等脏器关系尤为密切。脾气不足，运化功能失常，湿浊内生阻遏经脉，或肝气瘀结，肝阳上亢，木旺乘土，使脾胃蕴热，运化失司，痰热内聚而使水谷精微不能正常输布，久之阻塞经脉而发生胸痹中风。所以《金匱要略》治疗胸痹用“瓜蒌薤白半夏汤主之”以祛痰浊。《医学心悟》指出：“凡人嗜食

肥甘，或醇酒乳酪，内湿从内受……湿生痰，痰生热，热生风，故卒然昏倒无知也”。

本篇共收录了4位针灸医家的临床治疗经验，有的以背俞穴埋线为主，结合耳针治疗；有的立足于脾胃二经进行治疗；有的采用针刺配耳压；有的以三阴交为主，辨证施治。均取得了一定疗效。

一、背俞穴埋线 结合耳针

肖俊芳采用背俞穴埋线结合耳针治疗高脂血症，疗效满意。

取穴：脾俞、肝俞、胆俞、胃俞。随证配穴：痰瘀阻滞型配三焦俞；痰浊中阻型配膀胱俞；脾肾阳虚型配肾俞。

器械材料：准备无菌医用埋线针、无菌镊子、5ml一次性注射器各1个，0.25%利多卡因注射液10ml，2号无菌羊肠线数根（长约2cm）和碘伏与酒精棉球适量。

操作：埋线患者洗干净背部皮肤，患者取俯卧位，充分暴露背部，由助手根据骨度选准穴位。在一侧的穴位皮肤常规消毒，助手在已消毒的穴位皮肤上注射利多卡因约2ml。局麻后，施术者左手持无菌镊子夹紧备用的羊肠线，右手持无菌埋线针，针尖穿过皮肤后与脊柱呈45°角，将羊肠线埋入穴位，待线头见不到时，针再进入1.5分，然后快速拔针，用酒精棉球按压针孔数分钟以防止针孔出血，最后再常规消毒埋线部位皮肤1次。同时嘱患者当天晚上勿洗澡，保持针孔清洁，治疗期内不喝酒、不吃辛辣刺激性食物。在第1次埋线后的第16天于对侧的相应背俞穴进行第二次埋线，两侧穴位交替使用。

耳针：取内分泌、胰、胆、脾、交感。患者取端坐位，选用经过高压消毒过的0.5寸不锈钢毫针，耳穴皮肤严格消毒，施术者右手持针，左手抵着被施针耳廓的背部，针尖进入皮下与耳软骨之间，用捻转平补平泻手法，每隔5min行针1次，留针25min。两侧耳穴交替使用，每天治疗1次，12次为1个疗程，间隔3天再进行第二个疗程。

祖国医学认为，高脂血症与脾失健运、痰瘀阻滞有关。脾失运化，水谷不化精微而生痰浊，痰浊滞留阻塞经络，气血运行不畅，血脂黏附血管壁致血管硬化。气虚血运不畅而生血瘀，瘀血阻络，

肝失疏泄，脂质沉积于血管、肝脏而发病。若从病因来说，不外是内外两端，多属本虚标实之证。内因脾肾不足为本，外因嗜食肥甘厚味，瘀血痰浊为标。治疗应当培土补肾固本，活血化瘀，标本同治。据此，背俞穴埋线治疗高脂血症获得明显疗效。脾俞、肝俞、肾俞埋线的良好刺激，能固本补肝肾，使阴液阳气得充，阴阳相济，瘀血难生，痰浊难成；胃俞、三焦俞埋线，能健脾益气，使脾胃之气健旺，运化正常，水谷精微输布正常，痰湿消去，血脉畅通而治本；肾俞、膀胱俞埋线，具有活血化瘀的作用，可使痰浊消散，气血和顺，经脉畅通以治本。以上多个脏腑的背俞穴合用，加上穴位埋入羊肠线，对穴位形成长期刺激，埋线与耳针并施，达到标本兼治的目的。全息耳穴有协调各脏腑功能、调节阴阳平衡、畅通全身脉络的作用，有升降浊功能，祛痰湿力强。故临床上背俞穴埋线加耳针治疗高脂血症能取得比较满意的疗效。

二、立足于脾胃 化痰降脂

从中医五脏的功能看，脾主运化水谷精微和水湿，是与人体脂质代谢最为密切的脏腑，因此治疗上立足于脾胃二经，达到补脾、健脾、化湿的目的。周喜燕在临床运用针灸治疗痰浊血瘀型高脂血症，取得一定疗效。

取穴：足三里、丰隆、阴陵泉、三阴交、阳陵泉、内关。

操作：穴位常规消毒，取28号1.5寸毫针，针刺深度0.6~1.2寸，有针感时停止行针，并提针少许，再予留针30min。每日1次，10次为1个疗程。

足三里为胃之下合穴，有补益脾胃、升发脾阳、消脂助运动等功能；丰隆为足阳明络穴，功能化痰降浊、运脾通腑，可宣通脾胃二经之气机，其化痰浊作用显著；阴陵泉、三阴交均为脾经要穴，分别为足三阴经的交会穴及脾经合穴配合内关穴有调理脾胃、化湿利水、活血通络的作用。针刺足三里有促进胃肠蠕动及胆汁分泌与排出作用；针刺胆经穴可以促进肝脏中酶的活性，使脂肪更快的转化、利用并促进肝肠循环。

三、针刺配耳压，健脾祛痰除湿

中医学认为高脂血症是由于过食肥甘厚腻，少劳、久卧、久坐和先天禀赋等因素导致脾虚痰浊偏盛为主的一类病症。黄伟贞运用针刺配合耳穴贴压，取得良好效果。

取穴：神门、内分泌、饥点、口、食道、肺、胃、三焦、大肠，每次选用3~5个穴；体穴：内关、丰隆、关元、足三里、天枢、梁丘、公孙、曲池、三阴交、内庭、太溪、太冲中的4~6个穴位。

操作：常规消毒耳廓后，左手固定耳廓，绷紧皮肤，右手用血管钳或镊子夹住皮肤针的针柄，轻快刺入所选耳穴皮内，再用胶布固定；或在所选耳穴皮内压入王不留行籽，再用胶布固定，然后嘱患者每天按压所选耳穴3~5次，每次3~5min；隔天再在患者另一侧耳廓上进行以上操作；在所选体穴位上，常规消毒后，用常用毫针进行针刺，得气后用电针治疗仪加电（使用连续波），每次20min，交替使用，10次为1个疗程。

从中医五脏的功能来看，脾主运化水谷精微和运化水湿，所以人体水谷精微的运输及代谢靠脾来完成，其中自然也包括了现代医学所言的脂质代谢。由此可见肥胖症和高脂血症的共同病因病机就是脾虚痰浊偏盛。因此，选择足阳明胃经及足太阴脾经的足三里、内庭等穴位即可健脾胃、促运化，又能祛痰除湿，从而消除停聚在体内的痰浊及脂膏。

四、三阴交为主 辨证施治

高脂血症是人体的脂质代谢异常，是血浆类脂质，如胆固醇、甘油三酯等一种或多种成分的浓度超过正常含量时的一种病变。它是导致动脉血管粥样硬化、高血压、冠心病和脑血管疾病的重要因素之一，所以要积极防治高脂血症。陈太福在临床上针刺治疗单纯性高脂血症，取得满意效果。

（1）痰浊阻络型

高脂血症的发生，常与饮食因素有关。胃主受纳，脾主运化，过食肥甘厚味，内伤脾胃，运化失司，致饮食不化精微，浊脂内生。

临床表现为形体多肥胖，头晕头重，胸脘痞闷，肢麻沉重，苔

白腻，脉弦滑。

治以健脾祛痰降浊。处方：三阴交、足三里、公孙、丰隆。手法：三阴交、足三里、公孙平补平泻，丰隆泻法。

(2) 气滞血瘀型

高脂血症的发生，又与情志有关。七情五志过极，肝气郁结，疏泄失职，气郁日久，气滞血瘀，阻塞脉络，浊脂内生。

临床表现为头晕头痛，胁肋胀痛，心胸刺痛，时痛时止，舌紫黯或有瘀点，脉弦涩。

治以行气活血化瘀。处方：三阴交、膈俞、内关。手法：三阴交平补平泻，膈俞、内关泻法。

(3) 肝肾阴虚型

高脂血症的发生，还与禀赋有关。肾为先天之本，五脏之根，藏精，主生长发育。先天禀赋不足，肾气亏虚，致肝肾不足而出现眩晕。肾主水，司气化，肾虚则气化失常，致水湿阻滞，浊脂内生。

临床表现为眩晕耳鸣，头痛肢麻，口干咽燥，恶心烦热，腰膝酸软，健忘少寐，舌红苔少，脉细数。

治疗滋养肝肾。处方：三阴交、肝俞、肾俞、太溪。手法：三阴交平补平泻；肝俞、肾俞、太溪补法。

所有证型采用毫针治疗，1个月为1个疗程，疗程之间间歇3~5天。

张某，男，27岁，1997年2月就诊。临床表现为头晕，形体肥胖，肢体沉重，乏力，恶心纳差，苔白腻，脉滑。

经生化分析仪检查：血清总脂6.31g/L，血清胆固醇7.98mmol/L，血清甘油三酯2.44mmol/L，高密度脂蛋白胆固醇0.73mmol/L。检查心电图，B超，X线片均无异常。中医诊断：眩晕（痰浊阻络型）；西医：单纯性高脂血症。治以化痰降浊，处方：三阴交、足三里、丰隆、风池。手法：三阴交、足三里、风池平补平泻；丰隆泻法。治疗1个月复查血三脂均正常。

祖国医学中没有高脂血症这一病名，从高脂血症的临床表现看，属于痰浊、血瘀范畴。高脂血症的认识，古代医学文献中就有类似讨论。如《素问·通评虚实论》：“凡治消瘴，仆击，偏枯痿厥，气满发逆，甘肥贵人，则高粱之疾也”。高脂血症的发生，或由于外源

性脂质摄入过多,或由于体内代谢紊乱,如合成增多、分解降低、排出减少等。其中痰浊、血瘀为标,肝脾肾功能失调为本。由于病因病机不同,临床表现各异,故对本病的治疗如《素问·至真要大论》:“谨守病机,各司其属;有者求之,无者求之,盛者责之,虚者责之”的辨证施治原则。三阴交为足太阴、厥阴、少阴之会,主治肝脾肾三经病变,为治疗高脂血症主穴。研究证实三阴交可以增强胆固醇的分解和排泄,减少其合成和吸收,改变其在血浆和组织中的分布,从而降低血液中胆固醇的含量。足三里、公孙健脾化痰,丰隆化痰降浊,可共同抑制胆固醇在肠道的吸收,促进其排泄,改变脂蛋白的结构和影响脂蛋白的代谢。膈俞为血之会穴,内关为手厥阴与阴维脉交会穴,二者理气活血化瘀,可以改善微循环,抑制血小板聚集,降低血液中脂类水平,改善血液黏稠度。肝俞、肾俞、太溪滋养肝肾,起到固本之功。

参 考 文 献

- [1] 肖俊芳.背俞穴埋线加耳针治疗高脂血症临床研究.中国针灸,2004,24(7):468~470
- [2] 周喜燕.针灸治疗痰浊血瘀型高脂血症50例.吉林中医药,2005,25(6):39
- [3] 黄伟贞.针刺对高脂血症血脂水平的影响.安徽中医临床杂志,2003,15(2):10
- [4] 陈太福.三阴交为主针刺治疗单纯性高脂血症.黑龙江中医药,2003,(1):43~44

【骨质疏松症】

骨质疏松症是老年人的常见病之一，是以骨量减少，骨组织纤维结构受损以及随之而来的骨折危险性增加的一种疾患。无论是原发性或继发性骨质疏松症，其共同特点都是骨量的减少，各个年龄段的骨量正常值是由该年龄段的骨量峰值决定的。骨量峰值大约 80% 是由遗传因素决定的。其他的因素还包括环境因素、运动、饮食和年龄。

中医学无此病名，中医典籍中类似本病的名称有骨痿、骨枯、骨极、骨痹等，其中定性、定位比较准确的当属“骨痿”，并被大多数临床中医学家的所认同。《内经·素问》对该病的病因病机有较为详尽的认识，认为骨痿的病因有肾气热、远行劳倦、逢大热而渴。晋代王叔和在《脉经》里将骨枯的病因归于“足少阴气绝”。明代张景岳认为痿证的发病与脏腑热证关系密切。本病以脏腑失调为本，以痰瘀阻络为标。

这篇共收录了 13 位针灸临床医家的治疗经验，有的采用百会长留针为主治疗；有的依据“肾主骨，生髓”，采用耳压治疗；有的采用腹针治疗；有的采用穴位注射；有的独取神阙，隔药灸；有的针推罐，三法并用；有的针药并用，治法不一，但疗效显著。

一、百会长留针 背俞穴速刺

李树成采用百会长时间留针并间歇行针配合速刺背俞穴的方法治疗骨质疏松性骨痛，取效满意。

取穴：百会、膈俞、肝俞、脾俞、肾俞。

操作：百会以平刺刺入，得气后将针尖的方向沿督脉向脊柱病所方向导气，并按头针的行针方法快速捻转 3min，留针 6h 后拔针，其间每隔 2h 按上法得气后再快速捻转 3min；背俞穴则用稍转身侧卧位而进针，得气后即拔针的速刺法针刺，每天 1 次，10 次为 1 个疗程。

李树成从临床实践中认为：按经络学的观点，骨质疏松的骨痛主要是因精血不能荣润经脉所致；而督脉以及腰背部经络失荣或受损则出现腰背痛，取百会穴是因为督脉“侠脊抵腰中，入循膂络肾”，所以针百会穴既可通调经脉，又可补肾、壮腰脊诸骨，治腰脊诸病；更因此穴在巅顶为诸阳经之会，调一身之气血，精血调而使老年人腰背乏力、四肢酸麻等衰老症状得以改善；另外，在百会穴上长时间留针而不影响患者的起居活动，并因间歇多次行针得气，加强了治疗作用。

临床上骨质疏松骨痛患者中以局限性腰背疼痛为多见，从现代医学的角度分析，其疼痛多由脊椎宏观或微观骨折而引起，其导致局部血液循环不畅，以及骨折后脊柱变形可引致腰背肌、脊柱韧带、椎间关节的紧张增强而使疼痛加重。局部速刺膈俞、肝俞、脾俞、肾俞诸穴而不留针，取其“气至而效”之意，达到改善局部血液循环，加速骨折愈合的作用，并可缓解肌肉、韧带、椎间关节的紧张，减轻疼痛。

二、理据肾主骨 - 生髓 行耳压治疗

骨质疏松症是中老年妇女常见的骨代谢疾病，熊芳丽从“肾主骨，生髓”及肾精化生肾气，以促进肾脏藏肾精的功能等有关理论，结合临床病例治疗，取得了较明显的疗效。

取穴：子宫、肾、内分泌、卵巢、脾。

操作：以埋针法为宜。每次埋针上述五穴，每日自行按压 5~6

次，每次10min左右，留针2天，两耳交替埋针治疗。30天为1个疗程，休息5天后再进行第二疗程。

祖国医学认为：此症的根本原因在于肾虚，再加上后天的各种因素，出现脏腑经气逐渐衰退，肾精也随之衰减。其表现为精神萎靡，腰膝酸软，头晕耳鸣，失眠多梦，发脱齿摇，纳差便溏。由此看出，骨质疏松症与脾肾虚衰关系最为密切。肾为先天之本，脾为后天之本。脾之健运，有赖于肾阳之温煦；而肾气之充沛，又需脾之补养，补脾益肾，相得益彰。埋针内分泌、子宫、卵巢穴，对绝经后妇女的生殖腺有刺激和调节作用，能提高血清中雌激素的含量，达到改善钙的平衡、促进骨质重建、预防骨量的丢失，从而最终达到提高临床治愈率，降低病残率的目的。

三、腹针疗法 标本兼治

莫晓枫采用薄氏腹针治疗原发性骨质疏松症，获理想疗效。

取穴：主穴：中脘、下脘、气海、关元。配穴：滑肉门、外陵、气穴（双）。

操作：常规消毒后，中脘、下脘、气海、关元深刺，滑肉门、外陵、气穴中刺。留针30min，其间行针导气1次。隔日1次。

原发性骨质疏松症是以骨量减少，骨组织显微结构退化为特征，以致骨的脆性增高而骨折危险性增加的一种全身性骨病。中医学认为，老年性骨质疏松症属骨痿范畴。而“肾主骨生髓”，肾虚则骨不坚；“脾主肌肉、四肢”，脾虚则四肢与肌肉不养。故本病主要与肾亏、脾虚有关，当肾阳不足以温煦脾阳，而脾气虚弱进而使运化乏力，先天之精无以充养，势必精亏髓空而百骸痿废。那么通过补先天以促后天，养后天以滋先天，脾肾两脏互相促进，则气血盛、阳气复、筋骨壮。

腹针理论以神阙调控系统为核心，通过调节内脏的平衡，来使机体逐渐地趋于稳态。它的治疗正是从调理脏腑的主层次到疏通经脉的辅层次，再到治疗局部的层次，从而使疾病得到整体的调整。其中中脘、下脘、气海、关元深刺调理脾胃、培肾固本；滑肉门、外陵中刺通调气血、疏理经气，使之上输下达肢体末端；气穴位于足少阴肾经上，中刺也能增强补益脾肾之经气。诸穴合用脏腑和调，

气血生化调节有度，标本兼治，对原发性骨质疏松症有很好的防治作用。

四、骨肽注射液 穴位注射

骨质疏松症是一种常见的老年疾患，随着人均寿命增高及老年型社会的到来，其发病已呈增高趋势，值得临床重视。周道高采用水针治疗该病，疗效显著。

取穴：大杼、膈俞、肾俞以及此类穴附近的夹脊穴、足三里、悬钟。并注意随证选穴，如腰痛加腰阳关；膝痛加阴陵泉，阳陵泉或酌用阿是穴。

药物：骨肽注射液，主要成分为有机钙、磷、无机盐、微量元素、氨基酸等。

操作：每次轮取6~8穴，取骨肽注射液4ml，对穴位常规消毒后，用7号针头，以持笔式持针，垂直刺入穴位，深约0.3~0.8寸（视病人的胖瘦而定），原地捻转，得气后，抽吸针筒，无回血，即将药物注入约0.5ml，然后快速出针，并用棉球轻揉注射部位，让病人休息数分钟后离开，以防晕针。其余注意事项同针灸和注射的注意事项。每日1次，视病症轻重，5~10次1个疗程，治疗结束后，休息3天，可再行第二疗程。

骨质疏松症，中医典籍中无记载，但根据其多发于中老年患者，其病位在骨，表现以腰膝酸软，疼痛，动则加重等肾精虚衰，骨髓失充，骨骼失养症状为主，因此多数医家将其归入“骨痹、骨痿、虚损”等疾病范畴，以补肾为主要治法，也取得了肯定疗效，水针治疗，所选穴位，为八会穴中的骨会大杼，血会膈俞，髓会悬中，肾俞又为肾的背俞穴，足三里为胃经合穴，这类穴位，用补法针刺，即可起到强肾健骨的作用。骨肽注射液中，所含有机钙、磷、氨基酸等人体必须物质，其注入穴位后，既可因局部刺激而产生针刺样作用，又可因上述药物的营养作用而旺盛该经络，脏器的功能，而起到“补正”作用，因此行此法收效较速。

五、独取神阙 隔药灸

李芳莉采用神阙穴隔药灸治疗骨质疏松症，疗效较佳。

取穴：神阙。

操作：将骨碎补、肉苁蓉、淫羊藿、吴茱萸、田三七各等分共碾为末，加入等量食盐备用。将药盐填脐，填平后再填成厚 0.5cm 左右、长宽约 3cm × 3cm 的范围，以高 1cm、直径 0.8cm、重 0.1g 艾炷点燃置于药盐上灸至局部皮肤出现潮红为度。每日 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 3 天。

根据中医“肾主骨”的理论，肾藏精，精生髓；肾精不足，肾气虚衰是导致绝经后骨质疏松症的重要原因。神阙穴位于脐中，为任脉主穴之一，任脉与冲、督脉“一源三歧”，与其他经脉也有着密切联系。熏脐一点而贯发全身的特点完全体现出经络的全息特性。淫羊藿、肉苁蓉、骨碎补、吴茱萸、田三七具有调补肾之阴阳的作用。穴位对药物有着特殊的亲和力，药物熏脐后，药物分子通过热力，药物的性味很易透入穴内，有选择性地归经，引起穴位和经络产生一系列生理变化，从而补肾壮骨。

六、针推罐 三法并用

熊周清采用推拿配合针罐疗法治疗骨质疏松症，疗效尚可。

(1) 推拿

①患者俯卧位，解去腰带，袒露背腰部，先在肾俞穴处轻揉 1min，然后用掌振法在背腰部推拿 10min。旨在放松腰部肌肉。

②医者两手指交叉，指尖向上，用双掌根对挤对按、交替缓揉，左右慢拨两侧背腰部 5min。

③按压经穴，取穴肾俞、志室、膈俞、腰阳关、太溪、涌泉等穴各按压 1min。

④双手掌各放于背部，大拇指腹从督脉向膀胱经方向推，自上向下推 5min。

⑤双手掌擦膈俞、肾俞、八髎各 3min，以热透腹胸部。

手法必须轻柔、缓和持久，切忌用力过猛，每次手法治疗需 25min 左右。

(2) 针刺

取穴：肾俞、志室、腰阳关、膈俞、腰眼、太溪、三阴交。

操作：以毫针先刺肾俞、志室、太溪。弱刺激，行补法，腰阳

关、膈俞、三阴交强刺激，行泻法，留针 20min，中间行针 2 次。

(3) 火罐 起针后各穴立即拔火罐，留罐 10min 后起罐，再行按摩局部数分钟。

要求整个手法结束，患者顿感腰背部轻松，疼痛减轻。

有专家认为：骨质疏松症是一种骨量减少和骨组织显微结构受损、继而引起骨骼脆性增加和骨折危险性增高的系统性骨骼疾病，临床表现为脊椎和骨盆的疼痛，并由腰向臀部和下肢放散，亦可由背部向肋骨腹部放散，静卧休息减轻，弯腰活动剧痛、咳嗽、喷嚏也能引起胸痛或腰腿痛。有的由于椎骨塌陷、驼背逐渐增加，自己感觉身长逐渐变矮，造成短身，圆背和不相称的长臂。

骨质疏松症属中医学中带脉型腰痛范畴，王叔和《脉经》云：“诊得带脉，左右绕脐腹、腰脊痛阴股”。《张氏医通·诸痛门》谓“腰痛如以带束，引带，此属带脉为病”。《石室秘录》曰“此乃肾经与带脉不利……法当峻补肾水，而兼补带脉”。

本疗法采用推拿手法来舒筋活络，针刺肾俞、太溪、志室、命门等补肾要穴调补肾气并升命门火，火罐温通带脉，可能对抑制骨吸收和骨细胞的活性，防止骨矿物质的丢失有一定作用。

七、补肾为主 温针灸

杨莉采用温针灸治疗骨质疏松症腰背痛，收到一定疗效。

取穴：大杼、膈俞、肝俞、肾俞、脾俞、命门、足三里、绝骨、阳陵泉、太溪、关元。

操作：根据病痛部位，每次选 3~4 个主穴，2 个配穴，用 1.5 寸毫针快速进针，缓慢捻转得气后，将 3cm 长的艾段头朝下套入主穴针柄点燃。艾段下方垫薄纸皮，以防烫伤。每次起针均以皮肤潮红微痛为宜，每日 1 次，7 次为 1 个疗程，休息 2 天进行下 1 个疗程。

另用钙尔奇 D 片 1500mg，每日 1 次；或壮骨关节丸 6g，每日 2 次。

骨质疏松症腰背痛属中医“骨痿”范畴，多因年高肾衰，调养失宜或久病体虚，肝肾精血不足或脏腑功能紊乱或精血枯耗，不能生髓养骨，髓空无充，骨质稀疏所致。治疗当以补肾为主，结合补

肝健脾。针刺、艾灸施于皮肤、俞穴可直达病所，通过经络调节气血及脏腑生理功能，促进钙在肠道的吸收，提高骨密度、增强骨的韧性从而防止骨折。同时对骨质疏松及腰背痛等症状有很好的防治作用。

黎某，女，72岁，2001年5月10日初诊。反复腰背痛数年，加重10余天，腰脊不举，四肢怕冷，畏寒喜暖，小便频繁，面黄，苔淡舌白腻，脉沉细弦。查脊柱后凸，呈圆形驼背，胸12腰1压痛明显，腰背肌肉紧张，X线片示脊柱各椎体骨质疏松，胸12腰1陈旧性压缩性骨折。西医诊断：①老年性骨质疏松症；②陈旧性胸12腰1压缩性骨折。中医诊断：腰背痛（肾阳虚损型）。采用上述方法进行治疗1个疗程后腰背痛明显缓解，治疗4个疗程后腰背痛及症状消失，生活自理，1年后随访无复发。

八、证分两型 针刺配火针

潘文字以针刺加火针治疗绝经后骨质疏松症，收到较好疗效。

取穴：肾阴虚型取大椎、关元俞、肾俞、太溪、三阴交、太白；肾阳虚型取大椎、关元俞、命门、腰阳关、百会、足三里、脾俞。

操作：①选用28号1.5寸毫针，针刺上述穴位，在行针得气基础上运针以紧按慢提、小角度捻转后留针。留针期间每10min重复上述手法1次，留针30min后出针，隔日1次。②每次针刺出针后，以火针点刺背部俞穴，每周2次。上述方法操作，8周为1个疗程。

妇女绝经后骨质疏松症是绝经后妇女的高发病症，由于本病引起的骨折率增加是影响老年妇女健康和寿命的严重问题。为了改善和提高更年期妇女的生活质量，防治骨质疏松症成为医务工作者急需解决的问题。中医学认为骨质疏松症属“骨痿”范畴。肾藏精、主骨、生髓，藏真阴而寓元阳，为先天之本，肾在骨的生长发育，骨的强壮及其发生病变等方面都起主要作用。女过“七七”后，即绝经后意味着步入老年，肾精逐渐衰少，肾阳衰微，不能充骨生髓，便出现骨髓脆弱无力等一系列衰老症状。由于脾为后天之本，肾脾二者相互滋生，相互为用，故本病亦与脾虚关系密切。故治疗上宜补肾壮骨，温阳健脾，活血止痛。取肾俞、关元俞、大椎、命门等以补肾气，壮筋骨；足三里、脾俞健脾补气。所有穴位均应用复式

补法，同时配合火针起热疗作用，以加强温补脾肾、强筋壮骨之功。

李某，女，53岁。2000年1月25日初诊。主诉反复腰背痛3年余。患者绝经8年，时有腰背痛，神疲乏力，夜尿多，舌淡苔白，脉细。以单光子骨密度仪测定前臂骨密度 $20.9\text{mg}/\text{cm}^3$ ，按骨质疏松症综合评分为8分，西医诊断为绝经骨质疏松症。中医诊断为骨痿，属脾肾两虚型，治宜补肾壮骨，温阳健脾，活血止痛。取穴：①针刺百会、大椎、肾俞（双）、足三里（双）；火针关元、气海。②针刺天枢（双）、关元、气海；火针命门、腰阳关、脾俞（双）。以上两组穴位交替进行，针刺时行上述手法。经治疗后，腰背痛症状逐渐减轻至消失，治疗6个月后复查，前臂骨密度 $27.6\text{mg}/\text{cm}^3$ ，骨矿含量 $83.9\text{mg}/\text{cm}^3$ 。综合分析诊断评分指数减少3分，疗效评定为显效。

九、足三里 - 三阴交 针药并用

卓铁军采用针刺加药物对绝经后骨质疏松症治疗，在临床上收到了很好的效果。

取穴：足三里、三阴交。

操作：令患者呼气时将30号2寸不锈钢毫针缓慢刺入，得气后行重插轻提手法1min，而后留针30min，其间行针1次，出针时令患者吸气，将针疾速提至皮下，出针后揉按针孔。隔日1次，3个月为1个疗程，休息10天后继续下1个疗程。

药物：钙尔奇D。用法：每日1次，每次1粒，连续服用6个月。

原发性骨质疏松症属于中医骨痿之范畴，《灵枢·阴阳二十五人》：“足阳明之下，……血气皆少则无毛，有则稀，枯悴，善痿厥”，说明气血亏虚是痿证发生的重要原因之一。卓铁军根据《素问·痿论篇》“治痿独取阳明”的理论，选用足阳明胃经之足三里，足太阴脾经、足厥阴肝经、足少阴肾经三经之交会穴三阴交，脾胃为后天之本，气血生化之源，二穴合用能补脾健胃，益气养血，气血充足，骨髓充盈，则骨有所养，从而达到治疗骨痿的目的。

十、背俞穴为主 重手法

骨质疏松症是临床上常见的老年性疾病之一，随着人均寿命的不断延长，其发病率呈逐年上升的趋势。目前西医治疗骨质疏松症的药物虽然较多。有的效果也不错，但长期服用不良反应大。王东岩根据中医理论，应用补肾健脾法，选用背部俞穴针刺治疗原发性骨质疏松症，在临床上收到了较好的效果。

取穴：脾俞、胃俞、肾俞、气海俞。

操作：令患者呼气时，将30号1.5寸不锈钢毫针缓慢刺入，得气后行重插轻提手法1min而后留针30min，其间行针1次。出针时令患者吸气，将针疾提至皮下，出针后按压针孔，隔日1次，3个月为1个疗程，休息10天后继续下1个疗程。

骨质疏松症隶属于中医“肾虚腰痛”，“肾虚骨痿”之范畴。祖国医学认为，肾为先天之本，主藏精气，脾为后天之本，主运化水谷，先天之精需赖后天脾胃运化之水谷精微不断充养。若先天本虚，加之后天不济，则骨髓生化无源而发生骨枯。因此骨质疏松症的发生除与肾有关外，还与脾虚密切相关。基于此，在穴位的选择上，既选用具有补肾壮骨作用的肾俞、气海俞，又选用了具有健脾和胃作用的脾俞、胃俞，四穴合用，能补肾填髓，髓满则骨自健，从而达到治疗骨质疏松症的目的。

十一、针刺穴敷 健脾补肾

原发性骨质疏松症是一种以骨量减少、骨组织微结构破坏为特征，导致骨骼的脆性增加、易发生骨折的全身性骨骼疾病。随着人们寿命的延长，社会的老龄化，其发生率逐渐上升。徐亚莉采用健脾补肾、温阳通脉的穴位，配合中药穴位贴敷治疗本病，疗效独特。

取穴：神阙、关元、气海、命门、肾俞、脾俞。

操作：局部消毒，先针刺，行捻转补法，得气后取针（神阙穴不针刺），将密骨丹穴位透皮贴剂贴敷穴位，6~8h将透皮贴剂取下，耐受性好的患者可以延长敷贴时间至8~12h，每周3次。

穴位敷贴：密骨丹穴位透皮贴剂由甘肃中医学院附属医院中药制剂室提供，密骨丹药物组成：补骨脂、骨碎补、续断、川芎、制

川乌、透骨草、牛膝、细辛等。透皮贴剂直径约 1.5cm、厚 0.5cm，每贴含药量相当于生药 10g。

中医学中尚无骨质疏松症之病名，就临床表现和体征而言，应当归属中医骨痹、骨痿范畴。就其临床病因、病机特点、病理性质等，历代医籍鲜见。中医认为，骨质疏松症的病因病机为肾虚精亏，其病位在骨，所涉及脏腑为肾。肾与脾胃关系密切；其病性为本虚标实，虚实相间，以肾脾两虚、骨枯髓弱为本，气血不行、闭阻经络为标。徐亚莉选择神阙、关元、气海、命门、肾俞、脾俞。肾俞扶助正气，培元固本；脾俞培补脾胃。现代研究脾俞能增强胃肠的吸收功能，促进蛋白质，氨基酸，微量元素如钙、磷、镁等营养物质的吸收；而且还有提高性激素水平、增强人体免疫力等作用。密骨丹由补骨脂、骨碎补、续断、川芎、制川乌、透骨草、牛膝、细辛等中药组成，方中补骨脂补肾固精，温脾止泻；骨碎补补肾强骨，续伤止痛；续断补肝肾，强筋骨，疗骨伤；川芎活血行气，祛风止痛；制川乌祛风除湿，温经止痛；透骨草祛风除湿，活血止痛；牛膝补肝肾，强筋骨，活血祛瘀；细辛祛风散寒，止痛通窍，通利血脉。诸药合用，达到补益肝肾、强筋壮骨、通络止痛的目的。针刺健脾补肾、温阳通脉的穴位配合应用补益肝肾、强筋壮骨、通络止痛的中药密骨丹穴位贴敷，使骨骼得以滋养，疼痛消失。

十二、督脉穴为主 针灸并用

刘广霞用针灸督脉为主治疗老年性骨质疏松症取得较满意的疗效。

取穴：主穴：百会、大椎、至阳、腰阳天、命门。配穴：关元、气海、肾俞、脾俞、悬钟、太溪、足三里、三阴交、上髁、次髁。每次治疗时，主穴必取，酌加 4~6 个配穴轮换交替使用。

操作：针刺得气后留针 40min，间隔 10min 行针 1 次，以补法为主。留针时用艾条温和灸 2~3 穴，每穴灸 15min，以局部皮肤温热潮红为度。局部疼痛较甚者，可加用皮肤针轻叩痛处，而后用艾盒温灸，每次灸 30min。每日治疗 1 次，10 次为 1 个疗程。休息 2~3 天，再进行下 1 个疗程。

本病属痿、痹范畴。《素问·痿论篇第四十四》说：“肾主身之

骨髓，……肾热，则腰脊不举，骨枯而髓减，发为骨痿”，《灵枢·海论第三十三》又说：“脑为髓之海，……髓海有余，则轻劲多力，自过其度。髓海不足，则脑转耳鸣胫酸眩冒，目无所见，懈怠安卧”。肾主骨，骨生髓，髓聚为脑，故称脑为髓海，髓海充足，可使肢体骨骼强壮有力，足则肢体骨骼菱弱甚则废用。督脉循行于脊里，入络于脑，与脑和脊髓有着密切的联系，督脉的第二、三支又分别属于肾，和联络于肾。张锡纯《医学衷中参西录》中说：“肾虚者，其督脉必虚，是以腰疼”，故老年性骨质疏松症主要责之于肾虚、髓减、骨枯，采用针灸督脉为主，配以肾、脾、胃经等穴位为辅，通过针刺和艾灸达到养骨增髓，补益脾肾的功效治疗骨质疏松症。

十三、温针为主 配西药口服

陈丽仪以温针为主配合口服西药钙尔奇 D 片治疗妇女绝经后骨质疏松症，收到较好疗效。

取穴：大椎、肾俞（双）、足三里（双）、关元俞（双）。

操作：选用 28 号 1.5 寸毫针，针刺上述穴位，在行针得气基础上运针以紧按慢提、小角度捻转后留针，继而将预先切好的 2cm 左右艾灸段穿套在针柄上，点燃艾条，使之缓缓燃烧，待艾条完全燃尽即出针，隔日 1 次，每周 3 次，8 周为 1 个疗程，治疗期间每天加服西药钙尔奇 D 1 片。

妇女绝经后骨质疏松症是目前临床上常见多发病，中医学认为骨质疏松属“骨痿”范畴。肾藏精、主骨、生髓，藏真阴而寓元阳，为先天之本，肾在骨的生长发育，骨的强壮与发生病变等方面都起主要作用。女子过“七七”后，即绝经后，意味步入老年，肾精逐渐衰少，肾阳衰微，不能充骨生髓，便出现骨髓脆弱无力及一系列衰老症状。由于脾为后天之本，肾脾二者相互资生，相互为用，故本病与脾虚关系密切。治宜补肾壮骨，温阳健脾，活血止痛。取肾俞、关元俞、大椎以补肾气壮筋骨，足三里健脾补气。应用温针以加强补肾壮骨，温阳止痛之功。针与灸并用，两种作用相辅相成。另由于中国人平均每天饮食摄入的钙普遍不足，而治疗骨质疏松不管采用何种治疗，补充足够的钙及维生素 D 是必要的。因此应用温针加口服西药钙尔奇 D 片治疗本病取得较好疗效。

周某,女,56岁,1998年3月26日初诊,主诉反复腰背痛3年余。患者绝经8年,时有腰背痛,神疲乏力,夜尿多,舌淡苔白,脉细。以单光子骨密度仪测定前臂骨密度 $20.9\text{mg}/\text{cm}^3$,骨矿含量 $81.1\text{mg}/\text{cm}^3$,按骨质疏松综合评分为8分,西医诊断为绝经后骨质疏松症。中医诊断为骨痿,属脾肾两虚型,治宜补肾壮骨,温阳健脾,活血止痛。取大椎、肾俞、关元俞、足三里穴行温针治疗,隔日1次,每天加服西药钙尔奇D1片,经治疗,腰背痛症状逐渐减轻至消失,治疗6个月后复查,前臂骨密度 $27.6\text{mg}/\text{cm}^3$,骨矿含量 $83.9\text{mg}/\text{cm}^3$ 。综合分析诊断评分指数减少3分,疗效评定为显效。

参 考 文 献

- [1] 李树成,老锦雄,袁训林,等.百会穴长时间留针配合速刺背俞穴治疗骨质疏松性骨痛101例疗效观察.现代康复,2001,5(6):107
- [2] 熊芳丽,肖亚平.耳针治疗中老年妇女骨质疏松症60例临床观察.贵阳中医学院学报,2000,22(2):33~34
- [3] 莫晓枫,梁若茄.腹针治疗原发性骨质疏松症的临床观察.中国中医药科技,2007,14(5):315
- [4] 周道高.骨质疏松症的水针治疗体会.光明中医,2001,21(6):22
- [5] 李芳莉,吴昊.神阙穴隔药灸治疗绝经后妇女骨质疏松症34例.中国针灸,2005,25(7):448
- [6] 熊周清.推拿配合针罐疗法治疗骨质疏松症的临床观察.按摩与导引,1996,(4):18~19
- [7] 杨莉.温针灸为主治疗骨质疏松症腰背痛43例.实用中医药杂志,2005,21(1):28
- [8] 潘文字,李艳慧.针刺加火针治疗绝经后骨质疏松56例.中医药学刊,2003,21(5):811~812
- [9] 卓铁军,欧阳钢,申志祥,等.针药结合对绝经后骨质疏松症骨密度的影响.针灸临床杂志,2000,16(11):1~2
- [10] 王东岩,蔡红.针刺背俞穴对原发性骨质疏松症腰椎骨密度的影响.安徽中医临床杂志,2001,13(1):26
- [11] 徐亚莉,金建军.针刺加穴位贴敷对原发性骨质疏松症患者骨密度及疼痛的影响.中国针灸,2006,26(2):87
- [12] 刘广霞,张道宗.针灸督脉为主治疗老年性骨质疏松症28例临床报道.

中国针灸, 2000, 9: 529

- [13] 陈丽仪, 郭元琦. 温针为主治疗绝经后骨质疏松症临床观察. 针灸临床杂志, 2000, 16 (8): 35 ~ 36

【精神分裂症】

精神分裂症表现为特征性的思维和知觉障碍，情感不协调、平淡以及意志活动缺乏等，绝大多数病人没有意识及智能障碍。属于中医学癫狂病的范畴。本证在《内经》中早有记载。如《素问·至真要大论篇》说：“诸躁狂越，皆属于火。”《素问·病能论篇》又说：“有病狂怒者，此病安生？岐伯曰：生于阳也。……治之奈何？岐伯曰：夺其食即已。……使之服生铁落为饮。”对癫狂证的病因、治法和处方，都作了详细的论述。《河间六书·狂越》认为是“心火旺，肾阳衰，乃失志而狂越。”《丹溪心法·癫狂》篇说：“癫属阴，狂属阳，……大率多因痰结于心胸间”，提出了癫狂与痰有密切的关系。本证多见于青壮年。

本病的发生是以阴阳失调，七情内伤，痰气上扰，气血凝滞为主要因素。①阴阳失调：历代医家认为阴阳的盛衰是癫狂证的主要原因。如《素问·生气通天论篇》说：“阴不胜其阳，则脉流薄疾，并乃狂”。《素问·宣明五气论篇》说：“邪入于阳则狂，邪入于阴则痹，搏阳则为巅疾。”《难经·二十难》说：“重阳者狂，重阴者癫”。《诸病源候论·风狂病候》说：“气并于阳则为狂发。”这说明癫狂主要是由于机体阴阳平衡失调，不能互相维系，以致阴虚

于下，阳亢于上，心神被扰，神明逆乱而发。②情志抑郁：恼怒惊恐，损伤肝肾，或喜怒无常，心阴亏耗，肝肾阴液不足，木失濡润，屈而不伸，则默默寡言痴呆，语无伦次；或心阴不足，心火暴涨，则狂言狂语，骂詈不休，逾垣上屋；或所欲不遂，思虑过度，损伤心脾，心虚则神耗，脾虚则不能生化气血，心神失养，神无所主；或脾胃阴伤，胃热炽盛，则心肝之火上扰，神明逆乱，如此等等，都能发为癫狂。如《景岳全书·癫狂痴呆》说：“凡狂病多因于火，此或以谋为失志，或以思虑郁结，屈无所伸，怒无所泄，以致肝胆气逆”，都是指情志而言。③痰气上扰：由于痰气上扰清窍，以致蒙蔽心神，神志逆乱，狂燥不宁，歌笑骂詈，逾垣上屋为癫狂。如《证治要诀·癫狂》说：“癫狂由七情所郁，遂生痰涎，迷塞心窍。”《临证指南医案·癲癩》说：“狂由大惊大恐，病在肝胆胃经，三阳并而上升，故火炽则痰涌，心窍为之闭塞。癲由积忧积郁，病在心脾胞络，三阴蔽而不宣，故气郁则痰迷，神志为之混淆。”④气血凝滞：脑气与脏腑之气不连接而发狂。如清《医林改错·癫狂梦醒汤》说：“癫狂一症，哭笑不休，骂詈歌唱，不避亲疏，许多恶态，乃气血凝滞脑气，与脏腑气不接，如同作梦一样。”此外，癫狂证与先天禀赋和体质强弱亦有密切关系，如禀赋素足，体质健壮，阴平阳秘，虽受七情刺激亦只有短暂的情志失畅，并不为病。反之，遇有惊骇悲恐，意志不遂，则往往七情内伤，阴阳失调而发病。禀赋不足往往是家族性的，故癫狂证患者的家族往往亦有类似病史。

该篇收录了9位针灸医家的临床治验，有的采用辨证分型，电针治疗；有的采用耳针治疗；有的采用头皮电针为主，配合穴位注射；有的采用穴位埋鬚治疗等，各种治疗方法均可缓解其症状。

一、穴分两组 水电针并用

精神分裂症是常见病，祖国医学称之为癫狂。孙志刚采用四神聪电针配水针治疗方法，取得独特的疗效。

(1) 电针

取穴：①四神聪、神门（双）。②百会（留针不通电）、神庭、印堂、太阳（双）、内关（双）、合谷（双）。

操作：患者仰卧，用75%酒精皮肤作常规消毒，呈15°斜刺前聪透

右聪、右聪透后聪、后聪透左聪、左聪透前聪，常规刺神门（双）、神庭、印堂、太阳（双）、内关（双）、合谷（双）。得气后接 G6805-1 治疗仪输出五组线：前聪与右聪为一组，后聪与左聪为一组，神门（双）为一组，神庭与印堂为一组，太阳（双）为一组，内关（双）为一组，神门（双）为一组。用连续波，频率 130 ~ 200 次/min 为补，200 ~ 310 次/min 为平补平泻，310 ~ 400 次/min 为泻。频率由小至大，每次通电 20min。

（2）水针

取穴：①取大椎、陶道、身柱、神道、灵台、一光（经外奇穴。位于项部正中线，第 5 ~ 6 颈椎棘突之间。针斜向下刺 1 ~ 1.5 寸，针感局部麻、胀）。②取足三里（双）、丰隆（双）。

操作：患者俯卧或仰卧，不合作者护理人员协助。胸前垫一枕头，用手指甲按压标明穴位，做皮肤常规消毒，然后用 10ml 注射器接上 7 号针头抽 5% 当归液 10ml，氟哌利多 50mg 组成混合液，刺入穴位找到针感后得气，回抽无脑脊液或血即将药液快速注入，每穴 1.5ml。全过程约 2min 左右。

治疗同时，鼓励患者就餐，长期拒绝进食者强行补充液体和能量，防止电解质紊乱。电针组①配水针组①为第一治疗组；电针组②配水针组②为第二治疗组。每天治疗 1 次，两组交替使用，10 天为 1 个疗程，疗程间隔 3 天。

电针与穴位注射结合治疗精神分裂症的疗效与既往史、发病时间长短、是否服过抗精神病药物、初发与复发等因素有关。督脉为阳脉之海，总督一身之阳，循行脊里，入络于脑。《本草纲目》中注“脑为元神之府”。临床观察，在督脉或阳明胃经穴注射 5% 当归注射液氟哌啶混合液，有利于调整阴阳平衡，营养和改善脑神经，四神聪有清头明目，开窍提神，镇静安神之功效，从而达到治疗疾病的目的。

陶某，男，19 岁，未婚，高中学生，1991 年 10 月 6 日入院。因行为反常 5 天而入院。国庆节前几天为排练游行甚感疲劳，节后出现失眠。继而出现话多、唱歌、幼稚愚蠢行为、妄想、幻觉等精神分裂症状。

幼年生长发育良好，既往体健聪明伶俐，语文成绩好，数学成

绩差。个性较倔强，急躁。家族无精神病遗传史。

入院精神检查：衣冠不整，油腔滑调，见女病员盯住不放，抢别人的食品及香烟。情绪兴奋，行为忙乱不停，言语显著增多而凌乱，脱离现实，无法理解。

采用四神聪电针与穴位药物注射治疗法。治疗 10 次后睡眠好转，不骂人。治疗 20 次精神症状开始好转。针治 30 次精神症状完全消失，痊愈。出院后门诊治疗 30 次，巩固疗效。一年后随访未复发。

二、辨证分型 电针治疗

幻听属于知觉障碍中幻觉的一种表现形式，在精神科临床上最为常见，幻听内容是多种多样的，可听到不同种类和不同性质的声音。精神分裂症、器质性精神障碍、酒精中毒性精神障碍的患者可出现这一症状。林虹采用电针治疗幻听取得了满意的疗效。

主穴：耳门、听宫、听会、翳风。用 28 号 2 寸毫针直刺耳门、听宫、听会、翳风；用捻转泻法，使针感向耳内放散，得气后在耳门、听宫、听会穴接通 G6805 治疗仪，采用连续波，电流强度以患者耐受为度。

配穴：根据辨证论治原则，痰火郁结者取百会、丰隆、间使、膻中、神门；心脾两虚者取足三里、三阴交、内关；痰火上扰者取人中、大椎、风府、大陵、曲池、丰隆；阴虚火旺者取涌泉、太冲、三阴交、神门。

采用提插捻转补泻法。治疗 10 次为 1 个疗程。

幻听症为精神科临床常见症状，尤其以精神分裂症患者为多见，发病初期由于幻听的出现可继发思维、行为障碍，如妄想内容、冲动行为。部分精神分裂症患者在治疗恢复期常残留幻听，可达数年，为复发的一大隐患。因此消除幻听症状一直为精神科临床所重视。目前，西医未见单一消除此症状的有效疗法，临床效果不显著。中医学认为幻听与脏腑功能密切相关。《灵枢·邪气脏腑病形篇》载“十二经脉，其别气走于耳而为听”，其中听力与肝、胆、肾、脾的关系最为密切。因而幻听的治疗采用了整体辨证与局部治疗相结合的治疗方法，并配合电针取得了满意疗效。林虹认为电针能够提高

疗效，主要由于电针的穴位在耳部附近，在治疗中采用深刺重手法，并加上不间断的电流刺激，使耳部肌肉有节律地收缩，加快了耳部的血液循环，均提高了局部针刺的治疗结果。同时配合辨证取穴，故效果明显，可广泛用于精神科临床。

三、耳针治疗 镇静安神

黄庆元采用耳针治疗精神分裂症幻听症状，取得了较为满意的效果。

取穴：幻听穴：为经验穴，位于外耳道口后下缘。神门穴：位于耳廓三角窝外1/3处、对耳轮上下脚交叉之前。心穴：位于耳甲腔中心最凹陷处。脑干穴：又名皮质下，位于对耳屏内侧面。

操作：因耳廓组织结构主要为皮肤及软骨组织，易于感染常导致软骨炎，所以行耳部针刺治疗前，耳廓及耳背皮肤和术者手指均以2%碘酒及75%酒精消毒。选用短毫针，左手固定耳廓及耳背，右手持针快速进行捻转进针，深度以穿入软骨但不透对侧皮肤为度。患者可有针刺局部疼痛，或热感或酸麻感，以及有感觉循经络路线的放射传导，此为得气。得气后留针2h，留针期间可间歇捻针。每日针刺1次，左右耳交替进行治疗，每周针5次，10次为1个疗程，两个疗程之间休息3~7天。

耳针治疗是在耳部穴位用针刺等刺激防治疾病的一种治疗方法，治疗范围较广，操作方便，无副作用，易被病人接受。《灵枢·口问》篇有“耳为宗脉之所聚”，可见耳与全身经脉的联系相当密切。同时耳与脏腑联系也很密切，因分布耳的经脉均与脏腑有联系。作为脏腑之一的大脑，耳与大脑在生理、病理方面息息相关，说明耳不单纯是邻近大脑的听觉器官，更是人体整体的一部分，因此分布在耳廓上的某些穴位，可以作为针灸的刺激点治疗精神疾病。本法中幻听穴为经验穴，专用以治疗幻听症状；神门穴具有镇静、镇痛作用，主治失眠、烦躁等；心穴主治急惊风、心血管系统疾病；脑干穴主治失眠多梦、疼痛性病症、智能发育不全等。诸穴合用，共奏镇静、安神之功。

李某，女，患精神分裂症13年。此次复发主要症状为言语性幻听、幻视及被害妄想。脉沉细，舌红无苔。耳针治疗后第5天，幻

听次数开始减少，内容听不清楚。第1个疗程结束时，幻听症状基本消失，但无自知力。后又巩固1个疗程治疗，病人幻听症状再未出现。考虑病人由于肾阴虚，而心血不足，血少不能濡养心脉，心血虚而神不宁，以致引起幻听和被害妄想症状。

张某，男，患精神分裂症妄想症20年。此次复发，主要症状为评论性幻听、嫉妒妄想和被害妄想。脉弦滑，舌质淡红、苔微黄。耳针治疗1个疗程后，幻听症状无明显变化，但脉弦滑转沉数。休息3天后又转为弦滑，于第二个疗程调整穴位，常规穴加耳部肝穴，治疗第2天幻听内容比前欠清晰，为继续观察及争取进一步疗效，坚持治疗3个疗程后无进步，因病人不甚合作，即停耳针治疗。考虑此病人为肝气郁结，兼痰涎聚结。

四、头皮电针为主 配合穴位注射

舒德海采用头皮电针配合穴位注射治疗难治性精神分裂症，取得一定疗效。

取穴：印堂、百会、太阳。

操作：印堂穴横刺，针尖从下向上刺入0.8寸；百会穴是朝后枕部横刺，刺入0.5~1.0寸；双侧太阳穴是向耳垂后部横刺透安眠穴。然后连接多频波电麻治疗仪。连接方法是双侧太阳穴一组，印堂穴和百会穴一组。电量调至病人感到舒适而穴位局部皮肤肌肉轻微抽动为限，频率为80~100次/min，每治疗15min增加电量1次，每次结束前将电量调至最大量，连续强刺激冲击3~5次，每次1~3s。每日治疗1次，每次1h，30天为1个疗程。从第三十一天开始用2ml注射器、6号针头代替针灸针，在电针治疗半小时后将氯丙嗪5~15mg推注印堂穴中，一旦精神症状得到控制或发生感染就停止此种治疗。

毕某，男，28岁，就诊日期：1990年3月22日。病史：患者第三次住院，诊断为精神分裂症，曾用过氯丙嗪、三氟拉嗪、氟奋乃静、氯普噻吨、氟呱啉醇、氟奋乃静癸酸酯、五氟利多等药治疗，均无明显疗效。本次住院92天，表现兴奋话多，痴笑，自语，对空漫骂，被控制感以及行为怪异等症状。初用氯丙嗪（最大量800mg）合并碳酸锂（最大量15mg）无效，换氯氮平（最大量500mg）合并

碳酸锂仍无效，改头皮电针印堂穴、百会穴、太阳穴，每天1次，治疗第二十八天，患者表现安静，话少，第三十一天开始从印堂穴注射氯丙嗪10mg，每天注射1次，共3次，患者出现发烧（体温38.5℃）、面部肿胀、印堂穴局部红肿疼痛，考虑感染而停止电针治疗。精神检查，患者幻觉妄想等精神症状均消失，自知力恢复，观察2周痊愈出院，随访5年未见复发。

五、针刺配药物 醒脑安神

精神分裂症是临床上常见病，多发病。且前多以单纯药物治疗。但均不令人满意。陈忠容采用针刺加药物并用治疗，取得良好效果。

针刺：选穴以百会、人中、内关、神门、涌泉针平补平泻。操作取28号毫针，根据穴位深浅在常规消毒后进针适当深度。行针必求得气，留针2h，每日1次。针刺3次为1个疗程。

药物疗法：氯丙嗪75mg 配伍50%葡萄糖40ml 静脉推注，治疗第一日用量，以后停用药物治疗。

“头为诸阳之会，清阳之府。五脏精华之血，六腑清阳之气，皆上注于头。”古人有“诸经皆通于脑”的论述，百会穴可治头中百病，又能升清阳以醒脑，平肝安神；人中醒脑开窍安神，并能解除情感淡漠和某些精神症状；涌泉在急诊抢救中确有斩将夺关之效。内关神门以养心安神，神安则思睡，宣通气机，宽胸利膈，降气溶痰。氯丙嗪为治精神病首选药，久用可产生椎体系不良反应。本法适用于精神分裂症患者的临床治疗。且避免了抗精神病药物引起的不良反应。

马某，女，34岁，农民。神志失常20余天，加重10余天来诊，症见精神烦躁，面色红，哭笑无常，昼夜不眠，不知饥饱，服氯丙嗪片100mg、1天2次，治疗无效，症状逐渐加剧，登高而歌，弃衣而走，不知羞耻，被他人带入针灸科。查血压120/60mmHg，精神错乱，对答不切题，注意力涣散。心肺听诊（-）。诊断：癲狂病。治疗采用前述方法，4h后醒来如常人，巩固治疗两天而告愈。

六、辨证取穴 镇静安神

马霞根据祖国传统医学的理论，采用针药结合的方法治疗精神

分裂症缓解期失眠，取得较好疗效。

取穴：主穴选用百会、四神聪、内关、神门、足三里、三阴交，同时根据中医辨证选用不同的配穴治疗。①痰火内扰：配太冲、太阳；②痰湿内阻：配丰隆；③阴虚火旺：配太溪；④气滞血瘀：配血海、行间；⑤阳虚亏损：配心俞、脾俞。

操作：患者卧位，宽衣松带，全身放松，用30号毫针针刺得气后留针30min，手法除太冲用泻法外均为平补平泻法，期间行针1~2次，每天1次，10天为1个疗程，疗程间隔1天。

中医认为失眠主要由七情所伤，思虑太过，或暴受惊恐，亦有禀赋不足，年迈体弱所致，其病是由气血阴阳失和，脏腑功能不调，以致心神疲劳，神不守舍而不得安眠。

百会为督脉之要穴，百脉之会，其穴总督一身正气，针刺百会有平衡阴阳，镇静安神之功。四神聪乃经外奇穴，其前后两穴均在督脉的循行线路上，左右两穴则紧靠膀胱经，膀胱经络肾，督脉贯脊属肾，络肾贯心，其气通于元神之府，故此穴能安神定志，醒脑益智有疏通局部气血的作用。同时神门为手少阴心经原穴，心主神志，针刺神门能养心安神，使心有所主。内关为手厥阴心包经络穴，通过阴维脉，可治心、胸、胃疾患，与神门穴相配，为原络配穴，可奏和胃安神之功；足三里是足阳明胃经合穴，有调气血、补虚的作用，是全身强壮穴之一；三阴交是足太阴脾经络穴，又是足三阴经交会穴，能调节三阴经经气，也是全身强壮穴之一，两穴相配有调整阴阳气血、理脾胃、补虚弱的功能。配太阳，健脑开窍，通络止痛；配太冲能清降肝阳，安神定志；配丰隆，可祛湿除痰，清利头目；配太溪滋阴降火宁神；配血海、行间二穴能调肝脾之气，奏行瘀化滞之功；配心俞、脾俞，可调和气血，养心安神。以上诸穴相配，共同发挥镇静安神，改善睡眠的目的。

另外，还应重视精神调护，劳逸结合，合理安排生活，养成良好规律的生活习惯，以提高疗效。

七、针药结合 泻火祛痰

精神疾病所致听幻觉症是指患者自觉听到辱骂、威胁、议论、命令等声音，常引起患者出现明显的情绪反应，并可引起逃避、自

伤、自杀或暴力攻击行为，应优先处理。乌云对常见的精神分裂症所致听幻觉症，采用针刺配合舒必利静脉滴注的方法治疗，收到明显疗效。

针刺：选穴以听宫、支正、小海为主穴，配穴取太渊、列缺；偏历、温溜；隐白、公孙；足三里、解溪；太冲、行间；百会、上星；中脘、膻中（依据辨证酌取），针以泻法。操作取28号毫针，根据穴位深浅在常规消毒后进针适当深度。行针必求得气，留针30min。每天1次。

药物疗法：舒必利注射液100~600mg/天配伍生理盐水250ml静脉滴注，每日1次。注意：抗精神病药物药量应从低量渐增至治疗量。

治疗10次为1个疗程，休息3天后，继续第二疗程。

听幻觉可出现于多种疾病的精神障碍症状，祖国医学称“耳妄闻”，归属“癫狂”范畴，其病因病机为痰火气郁，阴阳失调，致心气衰而神明无主。乌云参照《针灸甲乙经》治疗“耳妄闻”相关内容。采用手足少阳、手太阳之会听宫穴，手太阳络穴支正穴，合穴小海穴为主以复心气，辅以手太阴、手阳明、足太阴、足阳明、足厥阴、任脉、督脉诸经腧穴，共调阴阳气血、泻火祛痰。痰火祛除，阴阳气血平复，心神复明，诸症渐愈。再应用有较好抗幻觉作用的舒必利共奏良效。而且应用本法尚可根据病情需要有计划减低药量至最少维持量，以减轻抗精神病药物的毒性及不良反应，缩短疗程，防止病情进一步恶化，近期疗效满意。

张某，女，56岁。神志失常总病程30年余，加重1周来诊。症见精神差，面色黑，心烦易怒，时常日夜怒骂不休，夜间尤甚，睡眠差，舌质红苔黄，脉沉弦。证属肝阳化火，炼液为痰，病久痰火郁结，阻碍气机，致心气衰而神明无主，故见幻听及怒骂不休。治疗采用前述方法，针刺得气后，头脑立刻清亮，精神转佳，怒骂声减少，随即静脉滴注舒必利，1周后夜间睡眠转佳，诸症悉除。

八、穴位埋鬃 随证选穴

精神分裂症是由脑部疾病引起的精神障碍，属中医学“癫狂”范畴。郝斌采用穴位埋鬃治疗本症取得了较好疗效。

将健壮成年猪鬃浸泡于 84 消毒液中 30min 后取出清洗干净，剪成长 1cm 左右的若干小段，取一段置于 9 号腰穿针针腔前端，经高压消毒备用。取穴：抑郁型取百会、神门、内关、心俞、肝俞、脾俞、足三里等；狂燥型取百会、神门、中脘、上脘、丰隆、大椎、长强等。每次取 2 ~ 3 穴，每 3 天施术 1 次，直至所取俞穴埋完结束。

患者暴露穴位后，局部消毒以 2% 利多卡因局麻，将装有消毒猪鬃的腰穿针准确地刺入穴位肌层，得气后将针芯插入腰穿针内、边插边退，以保证猪鬃埋入穴位肌层，出针后以消毒纱布盖之，胶布固定。

难经谓“重阴者癫，重阳者狂”。本病多为七情所伤。癫表现为精神抑郁；狂表现为精神狂躁。治癫以理气解郁、健脾固本为主；治狂以清火涤痰、安神定志为主。取督脉穴、任脉穴有泻火镇静、调气血、祛痰开窍作用；神门穴可开郁、宁神；足三里、丰隆健脾化痰；内关宽胸利气；心俞、肝俞、脾俞可调治心肝脾之气血及其功能。

猪鬃这一异种蛋白埋入穴位后，具有集多种方法（针刺、局麻、放血、埋针、封闭）效应于一体的治疗作用。能起长期的持续柔和的刺激经气作用。

胥某，女，32 岁。患者于 3 个月前因家庭发生矛盾，精神和情绪受到压抑和刺激，初起头晕失眠，终日不语，继而有时哭笑，语无伦次，思维联想障碍，行为异常，曾经某精神病院诊断为精神分裂症。诊见神情淡漠，嘻笑无常，纳呆脘痞，舌质淡，苔白腻，脉细弦。证属痰气郁结，神志被蒙。按上法治疗 1 个月后，思维、情感、言行均恢复正常，能从事正常劳动，一年后随访未复发。

九、独取膻中 刺血拔罐

精神分裂症是最常见的精神病，郭健民采用膻中穴刺血拔罐治疗，取得较满意的疗效。

取穴：膻中穴。

操作：嘱患者仰卧位，选准膻中穴，行常规消毒，用三棱针点刺出血少许，用中号玻璃罐闪火拔之，留罐 10 ~ 15min，每周拔 2

次，8次为1个疗程。

精神分裂症是最常见的精神病，在病理方面，如《证治要诀》云：“癫狂者由七情所郁”。精神分裂症主要由思虑太过、肝气郁结引起。膻中穴是八会穴中气会之穴，乃宗气会聚之所，为任脉、手足少阴经、手足太阴经的交会处，又是心包经的募穴，可宽胸利膈、理气通络，以治神志病为佳。如《引针指要》所言：“或针气，膻中一穴分明记”。刺血疗法有较强的祛邪作用，能使闭阻的经脉和气血得以畅通，从而达到治病目的。

患者，女，25岁。5个月前因精神刺激，之后沉默不语，神态呆板，表情淡漠，继而喃喃自语，或语无伦次，答非所问，不思饮食，夜间少眠或不能入睡。诊断为精神分裂症。治疗：取膻中穴，用三棱针点刺出少量血，闪火拔罐，留罐10min，每周2次，共治疗8次，诸症消失，恢复正常工作，半年后随访未复发。

参 考 文 献

- [1] 孙志刚，吴红英，孙元林．电针与穴位注射治疗精神分裂症350例疗效观察．中国针灸，1994，增刊：53～55
- [2] 林虹，李成．电针治疗幻听症30例疗效观察．天津中医药，2003，20（3）：39
- [3] 黄庆元，李建国．耳针治疗精神分裂症幻听34例．甘肃中医学院学报，2005，22（1）：36～38
- [4] 舒德海，周桂芝，何华，等．头皮电针配合穴位注射治疗难治性精神分裂症．中国针灸，1996，（7）：13～14
- [5] 陈忠容．针药合用治疗精神分裂症．针灸临床治疗，2001，17（2）：29
- [6] 马霞．针药结合治疗精神分裂症缓解期失眠30例．河南中医，2006，26（3）：57～58
- [7] 乌云，毕树安．针药结合治疗精神分裂症所致听幻觉症．针灸临床杂志，2000，16（2）：12
- [8] 郝斌．穴位埋鬃治疗精神分裂症33例．中国民间疗法，1996，（5）：14
- [9] 郭健民，徐春军．膻中穴刺血拔罐治疗精神分裂症．山东中医杂志，1997，16（2）：74～75

【糖尿病及其并发症】

糖尿病属于中医学消渴病的范畴，中医中药治疗消渴病有着悠久的历史，经过数千年的医疗实践，积累了丰富的临床经验。中医治疗糖尿病不只是着眼于降低血糖，而是强调辨证论治，结合辨病用药，并注重整体调控。《黄帝内经》中即有“消渴”的记载，并用“苦渴数饮”、“热中善饥”、“善食而瘦”等症状的描述。还提出，其发病是由于“五脏皆柔弱者，善病消瘵”的体质因素和“此肥美之所发也”的饮食因素及“怒则气上逆……热则消肌肤”的情志因素等共同作用的结果。汉代《金匮要略》中立消渴专篇，指出：“男子消渴，小便反多，以饮一斗，小便一斗，肾气丸主之。”开创了温补肾阳辨治糖尿病之先河，对后世产生了深远的影响。宋代《圣济总录》中始有“三消”之说，提出消渴病“原其本则一，推其标有三；一曰消渴，以渴而不利，引饮过甚而言之；二曰消中，以不渴而利，热气内消言之；三曰肾消，以渴而复利，肾燥不能制约言之。此久不愈，能为水肿痼疽之病”。金元时期，朱丹溪明确提出三消是指部位而言。后世医家在上述基础上，根据本病的“三多”症状的孰轻孰重，均将本病分上、中、下三消。

中医认为，糖尿病的产生系由先天禀赋不

足、脏腑柔弱的体质因素，后天饮食失调、情志不遂、房劳过度等致病因素共同作用的结果。其基本病机是阴虚燥热，阴虚为本，燥热为标，二者互为因果。燥热甚则阴愈虚，阴虚虚则燥热愈甚。病变脏腑在肺、脾、肾。三者之中可各有侧重，互相影响。上焦肺燥阴虚，津液失于输布，则胃失濡润，肾乏资助；中焦胃热炽盛，灼伤津液，则上灼肺津，下耗肾阴；下焦肾阴不足，虚火上炎肺胃，致使肺燥、胃热、肾虚三焦同病。早期阴虚火旺，中期伤气出现气阴两虚，晚期阴损及阳导致阴阳双亏。由于气虚不能帅血而行、阴虚寒凝血滞、阴虚火旺煎灼津液，均可导致瘀血痰浊的形成。气阴双亏、痰浊瘀血痹阻脉络是消渴病发生并发病的病理基础。

该篇共收录了13位针灸医家的临床经验，对该病的治疗有的以电针为主，配以经穴按摩；有的采用揠针配体针，补虚泻实；有的独取胰俞，埋药线；有的以背俞穴为主针刺治疗；有的以针药并用，治肾为主；有的浅刺任督二脉为主，配药物治疗等，治法及取穴各异，对早、中期患者及轻型患者效果较好。若病程长而病重者应积极配合药物治疗。糖尿病患者的皮肤极易并发感染，在针刺过程中应注意严格消毒。严格控制饮食，限制碳水化合物的摄入，饮食增加蔬菜、蛋白质和脂肪类食物。

一、电针为主 配经穴按摩

消渴，以多饮、多食、多尿、体重减轻等症状为表现，多见于中老年人。张戈采用电针结合经穴按摩治疗消渴病患者，取得满意疗效。

电针法：患者仰卧位，首取关元、天枢，然后根据辨证分型分别取穴：阴虚燥热取曲池、复溜；气阴两虚取列缺、地机；肾阴亏虚取双太溪；阴阳两虚取委中、阴谷。针刺补泻得气后，接电子脉冲针灸治疗仪，用连续疏密波20~30min，电针频率60Hz。

经穴按摩法：取针后以黄氏补法，即以顺时针摩腹72次，逆时针摩腹36次，摩腹取中脘、天枢、关元三穴范围；以三进一退的按法取梁门、天枢、中极三穴，掌握好患者呼吸以行之；然后俯卧位以推背部足太阳膀胱经5~6min，并行按法取脾俞、肺俞、胃俞、三焦俞、肾俞、膀胱俞1~2min。

消渴病，《灵枢·相应篇》：“心脆，则善病消瘵热中，肺脆肝脆脾脆肾脆，则但善病消渴易伤。”故该病临床损害诸多脏器，但主要以肺、胃、肾三脏多见。论其治疗，《医学心悟》言：“大法治上消者，宣润其肺，兼清其胃；治中消者，宣清其胃，兼滋其肾；治下消者，宜滋其肾，兼补其肺。”说明治疗重点在肺胃肾三脏。临床中医辨证分型治之以养阴清热润燥，益气养阴生津，滋阴益肾润燥，滋阴温阳益肾。首用电针以疏密波刺激天枢、关元穴，以健脾养胃，益气归元；对阴虚燥热取曲池以清热生津，复溜为肾之合以益气养阴；气阴两虚取列缺为肺之络以宣肺益气，地机为脾之郄以养阴生津；肾阴亏虚取肾之俞，原穴太溪以滋阴益肾；阴阳两虚膀胱之合，血郄穴委中以补肾壮阳，肾之俞阴谷以滋阴益肾。并以传统黄氏经穴按摩法摩腹补其元气，推按背部足太阳膀胱经及腧穴以通脏腑经络之气，协调阴阳平衡，调整内分泌失调及代谢紊乱。

二、揠针配体针 补虚泻实

周潮采用揠针及体针并用治疗 2 型糖尿病，获理想疗效。

体针：取穴：大椎、合谷、足三里、三阴交、复溜、肾俞、脾俞、肝俞。手法：平补平泻，针刺得气后留针 30min，每隔 15min 行针 1 次。每日或隔日针灸 1 次。

揠针：取一侧耳穴胰、肝、内分泌、脾、渴点、心、口、肾、下屏尖。合并高血压者加降压沟；合并腹泻或便秘加直肠下段；合并有两目干涩者加眼穴。方法：耳部常规消毒，将揠针每次按在 6~9 个穴位上，用麝香壮骨膏固定，每 1 周换针 1 次，两耳交替。

病情属轻度者，可停止原有治疗，单纯针灸。对病情属中度以上者，可酌情减少或维持原有药物治疗。揠针及体针均以 30 天为 1 个疗程。

糖尿病属中医的消渴病范围，其病机为本虚标实，故治以补虚泻实。针刺肾俞、脾俞、肝俞乃为背阳之穴，从阳引阴，使阴生而燥热除。足三里、三阴交、复溜健脾滋肝，益肾活血。大椎、合谷泻热理气。揠针耳压诸穴可调节脾胃，益肾生津，清热除烦。用麝香壮骨膏固定，可增强穴位的刺激，两耳交替可持续刺激调节机体的内分泌、以补充体针停针时之不足。长期临床观察，针灸治疗 2

型糖尿病（特别是轻型），对降低血糖、尿糖及改善症状、减缓并发症方面疗效较为明显，且无毒性及不良反应，可为轻型糖尿病人的首选疗法。中型、重型病人可配合中西药共同治疗。

李某，女，工人，1994年4月30日初诊。主诉：口干渴，多饮，多尿，多食易饥3年。周身无力，动则汗出，心慌失眠易怒，近3月体重明显减轻。糖尿病史3年。现服用消渴丸5粒，每日3次，降糖灵25mg，每日3次。查：血糖195mg/dl，尿糖（+++）。舌红，苔薄黄，脉细数。辨证当属气阴两虚并内热。治以益气养阴清热。体针取大椎、合谷、足三里、三阴交、复溜、肾俞、肝俞，每日1次，平补平泻手法。耳穴取神门、心、肝、胰、内分泌、渴点、肾。揸针按刺后用麝香壮骨膏固定，每周换针1次。两耳交替。15天后查血糖105mg/dl，尿糖（-），症状基本消失，令其停药降糖药，针灸治疗2个月，血糖持续正常，病情稳定。以后病人每感有周身不适，便来针灸1个疗程。随访2年，疗效巩固。

三、独取胰俞 埋药线

随着人们生活水平的提高和社会人口老龄化的到来，2型糖尿病的发病率近年来呈不断上升趋势。张中新在临床工作中，采用胰俞埋药线治疗2型糖尿病，效果较好。

操作：将3号医用羊肠线剪成1cm长的线段，放入黄芪注射液中浸泡4~6h后，用时取出，将药线从高压消毒后的备用9号腰穿针的尾部放入，用针芯推至针尖部，备用。取双侧胰俞穴，用0.5%碘伏常规皮肤消毒后，双手持针，快速刺入皮内，针尖向内下斜刺，右手持针，行提插捻转补法，待患者有酸胀感时，停止手法，左手持腰穿针向外提，右手将针芯向里推，使药线停留在体内。左手用无菌棉球按针孔，右手将针退出。针眼敷创可贴，3天后取下。15天埋药线1次，4次为1个疗程（以上均须无菌操作，戴无菌手套）。

注意事项：埋线3天内不可饮酒、进食牛、羊肉、鱼、虾等物，局部皮肤有破溃者不宜埋，体温升高者不宜埋。

针灸疗法治疗糖尿病，早在2000多年前的《史记·扁鹊仓公列传》即载：“肺消瘵也……灸其足少阳脉口。”晋代《针灸甲乙经》，

最早提出糖尿病针灸所用 6 穴，说明古人对糖尿病针灸诊治早有认识，胰俞穴曾称胃脘下俞，最早出于《龙衔素针经》，别名胃下俞，胃管下俞。《千金翼方》：“消渴咽喉干，灸胃管下俞三穴各百壮”。

胰俞穴首见于《常用新医疗法手册》，该穴属经外奇穴，却位于足太阳膀胱经第一条侧线上，在第 8 胸椎棘突下旁开 1.5 寸，左右共计 2 穴。背俞穴是脏腑器官生理、病理状态在体表功能的感应点，针刺不同的背俞穴，机体在正常情况下，对所属脏腑功能有促进和调整作用。当机体患病后，它对脏腑功能有良性调节和修复作用。通过现代神经解剖学研究已证实：胰俞穴深层主要由 T_8 神经分布，而胰腺传入神经是 T_8 ，说明胰俞与胰腺有着高度的对应性，这一点与背俞穴的特性相吻合，只是由于历史的局限性，古代医家没有认识到胰腺，故无胰俞穴。现有人建议，应将此穴归于经穴以应脏腑。

张中新认为本疗法是将黄芪注射液的药性与肠线异体蛋白的作用相结合。集药物、针刺、埋线、穴位注射于一体，通过经络、穴位的作用，达到调整脏腑、疏通经络之目的。药线在体内被软化、分解、液化、吸收的过程，对穴位起到了缓慢、持续的“长效针感”效应。

四、背俞穴为主 针刺降血糖

2 型糖尿病即非胰岛素依赖型糖尿病，目前国内主要靠控制饮食结合运动疗法或服用降糖药物来控制血糖。刘晓峰运用针刺背俞穴为主治疗 2 型糖尿病，疗效满意。

取穴：主穴取胰俞、肺俞、脾俞、肾俞，配穴取公孙、太渊、太溪、血海、足三里、地机、三阴交、曲池。每次治疗必取主穴，配穴可选用 2~3 个。

操作：定准穴位后，局部常规消毒，用 1.5 或 2 寸 30 号毫针快速刺入皮下，背俞穴向脊柱方向斜刺，得气后施捻转补法，以针感向内脏深处放散为度，不留针，出针后局部拔火罐 10min。配穴针刺除血海施行捻转泻法外，其余穴位均施以平补平泻手法、留针 30min，每隔 10min 行针 1 次。每日或隔日 1 次，10 次为 1 个疗程，每疗程间隔 3~5 天，连续治疗 3~4 个疗程。

本病在祖国医学中属消渴病范畴，其病因多为素体阴虚，肥甘

无节，饮酒过度，情志失调引起，从而形成阴虚燥热的病机。金元时期朱丹溪论述：“消渴，乃三焦受病也，上消者，肺也，其燥在上焦；中消者，胃也；下消者，肾也。肺为水之上源，脾为气血水谷生化之源，肾为主水之脏，当三脏受病，气机不畅，水液失去正常的代谢而致病，故只在肺、脾、肾元气充足，三焦气化通畅，则病自愈。背俞穴是脏腑经气输注于背腰部的腧穴，《类经》曰：“十二俞皆通于脏气”，故针刺肺、脾、肾俞穴，可疏通三脏之气机，恢复脏腑正常功能。胰俞穴之应用，在《备急千金要方》中有记载：消渴咽喉干，灸胃管下输三穴……穴在背第八椎下，横三寸间寸灸之。再配以具有清热、养阴、活血作用之穴，则疾病可愈。

根据现代医学的研究，2型糖尿病的病理中，既有胰岛素分泌不足或缺乏，亦有胰岛素抵抗，两者同时存在。其发病原因为多种因素（包括遗传、环境因素及生活方式）综合作用破坏胰岛素 β 细胞及导致周围组织对胰岛素的利用障碍。根据解剖学特点，背俞穴与交感神经链的体表投影区基本重合，同一节段的躯体神经与支配内脏的交感神经受同一脊髓节段支配，故针刺胰俞穴可通过刺激冲动、中枢神经调节有效地改善局部微循环，促进胰 β 细胞的修复及胰岛素的合成、分泌。针刺脾俞、肾俞、足三里等穴，可提高外周组织对胰岛素的利用，改善胰岛素抵抗。在两者共同作用下，使患者血糖得到有效调节。

吴某，女，70岁，于1996年5月16日初诊，自述发现糖尿病已5年。既往服用优降糖，血糖控制良好，近数月因觉口干烦渴，日渐消瘦，诊断为2型糖尿病，选用消渴丸及二甲双胍治疗，然而症状一直未能缓解，经实验室检查：空腹血糖 11.3mmol/L ，餐后2h血糖 19.3mmol/L ，尿糖（+++）。取背俞穴针刺，要求针感向内脏深入放射，行捻转补法，不留针，针后局部拔火罐10min，10天为1个疗程，2个疗程后复查空腹血糖为 8.4mmol/L ，餐后2h血糖 13.2mmol/L ，嘱患者减少降糖药用量直至停药，经4个疗程治疗后，症状消失，复查空腹血糖为 6.5mmol/L ，餐后2h血糖 9.2mmol/L 。随访至今，空腹血糖波动在 $6.5\sim 7.8\text{mmol/L}$ 之间。

五、针药并用 治肾为主

吴维平采取针刺与药物相结合的方法治疗糖尿病，取得了较为满意的疗效。

取穴：主穴：膈穴，脾穴，足三里，三阴交。配穴：上消，渴而多饮者，加肺俞、少商、意舍、承浆；中消消谷善饮者，加胃俞、中脘、丰隆；下消小便频数者，加肾俞、命门、关元、复溜、水泉。

操作：主穴每次必用，临床酌加配穴。针刺以得气为指标，待患者对针刺有较强反应时，留针 20min，出针前重复运针 1 次，手法为平补平泻，每日针刺 1 次，14 天为 1 个疗程。

中药：以合治汤为主方，其组成有熟地 150g，麦冬 100g，山茱萸 100g，人参 50g，车前子 20g（单包）。按常规中药煎法制成汤剂，每日 1 付，150ml，每日 3 次，口服。

受《石室秘录》“消渴之证，虽分上中下，而肾虚以致渴，则无不同也。故治消渴之法，以治肾为主，不必问其上中下之消也。吾有一方最奇，名合治汤，熟地 3 两，山茱萸、麦冬各 2 两，车前子 5 钱，人参 1 两，水煎服，日日饮之，三消自愈。”的启迪，临床中针药结合，辨证施治，确有实效。

中医治疗糖尿病，是以调节机体生理功能为主，大体上以滋肾阴为治本，以清肺、胃为治标。合治汤即是以滋补肾阴为主，配合针刺相关穴位，调节胰腺的功能。

姜某，男性，40 岁，干部。糖尿病，高血压病史 2 年。主症口干、微渴、乏力、头晕。血压 130/100mmHg。实验室检查：空腹血糖 8.7mmol/L，餐后 2h 血糖 13.1mmol/L，尿糖（++）。继续服用复方降压片 2 片，每天 3 次，口服；停用消渴丸 8 粒，每天 3 次，口服。按本治疗方法服用汤剂，针刺主穴及肺俞、少商、意舍、承浆配穴。1 个疗程后，病人诸症好转，血压 125/95mmHg，空腹血糖 7.8mmol/L，餐后 2h 血糖 9.3mmol/L，尿糖（+）。第二个疗程后，病人诸症消失，空腹血糖 5.9mmol/L，餐后 2h 血糖 7.3mmol/L，尿糖（-）。经合理控制饮食，坚持服用合治汤（汤剂制成散剂）半年后，血、尿糖一直在正常范围。随访 1 年，未见血、尿糖升高。

六、浅刺任督 配药物治疗

糖尿病属于中医学消渴范围，其病多见于阴虚燥热之体，根据病机特点，岳玉烈采用毫针浅刺任督二脉穴治疗 2 型糖尿病，经临床观察获得比较理想的效果。

取穴：取任督二脉穴，补百会、泻廉泉。配四神聪、风池、头维。加减：多饮、烦渴加太渊、后溪、太溪、神门、上星，清热生津；多尿、头晕耳鸣，腰膝酸软加气海、关元、中极、太冲、申脉；多饮易饥、便结者加丰隆、中脘、水分、天枢、水道，润肠通便；身乏懒言，便溏，口渴，下肢浮肿、肌肤瘙痒者配三阴交、足三里、阴陵泉、肾俞、复溜健脾益胃。

操作：让患者采用仰卧位，双腿平伸，暴露头部，取穴常规消毒，择 0.5~1mm 长毫针，采用快速无痛浅刺进针，进针后患者得气为度，一般留针 30~40min，中间不用行针，每日 1 次，15 次 1 个疗程，休息 5~7 天再行第二疗程。手法：补百会、泻廉泉。其余穴均平补平泻。

药物：月见草、肠溶阿司匹林、六味地黄丸口服。静脉滴注丹参液 20ml，每日 1 次，2~3 个疗程期间药量减半或口服 1~2 种药维持。

糖尿病为三大顽疾之一，病在肺、脾、肾三脏，阴虚为本，燥热为标，治疗上以养阴清热为主。因为经络是一个有机的整体，它能沟通内外，贯穿上下，内连脏腑，外络肢节，同时经络的作用能运行气血、调理阴阳，能使人体各部脏腑功能活动维持相对平衡，所以取任督二脉经穴（百会、廉泉）能清肝明目，加速头部循环，清脑安神，使脑部血脉流畅，血液循环加速，降低血脂，血糖恢复正常。头为诸阳之首，百会为巅顶，属于督脉穴，别名三阳五会，阳脉之海，行于人身之后，并于脊里，上风府，入于脑，能统领一身，四神聪邻近四穴，加强百会之功能，加速头部之循环；廉泉任脉之经穴，行于人身之前，为阴脉之海，起于中极之下，上之咽喉，能治口干舌燥，生津液。头维、风池穴属少阳、是阳明二脉交会穴，能清头目，调通脑部之络，任督二脉相配用，达到标本兼固，扶正祛邪，恢复脏腑功能。配太溪、内关、太渊、神门起到清热生津；

关元、中极、气海、后溪滋养肝肾；配天枢、水道、中脘、丰隆润肠通便，使腑气得通、阴阳得平。三阴交、足三里、阴陵泉、复溜健脾益胃。配合中草药治疗，口服月见草油丸、六味地黄丸，静脉点滴复方丹参液，起到疏通血脉、加强微循环改善，降低血脂。针药相配、燥而不烈、滋而不腻、刚柔相济、阴中有阳、降中有升、不伤正气，改善糖尿病并发症，达到降血糖的作用。

患者王某某，男性。70岁，干部，本市劳动局退休干部，患糖尿病10余年，加重1个月，伴有高血压，心脏病，在本院内科住院治疗有1个多月，采用静脉点滴丹参液，灯盏花，饭前口服糖适平，饭后口服消渴丸、六味地黄丸。入院时查空腹血糖14.14mmol/L，尿糖（++++），经治疗1月余后复查空腹血糖2次，分别是12.32mmol/L和12.1mmol/L，尿糖（++++）。患者心情急躁，精神极差，伴头晕、耳鸣、口干舌燥，五心烦热，腰膝酸软纳差，夜寐不安，多梦遗尿，夜尿5~6次，24h尿次13次以上，舌暗红，苔腻燥，脉沉细而弱，采用针灸浅刺治疗1次，次日自述，夜尿1次，无遗尿，睡眠大有好转，共治疗11次，查血糖5.3mmol/L，尿糖转阴，患者精神良好，纳正、寐安，二便调而停止治疗。半年随访，自述平时口服消渴丸、六味地黄丸，尿糖空腹血糖，均在正常值范围内。

七、针药并施 益气养阴

糖尿病为内科学常见病、多发病。并发症多难以治疗，张瑞杰在临床上采用针灸与中药结合治疗该病，疗效尚可。

取穴：主要取关元、足三里（双）、三阴交（双）、曲池（双）、脾俞、肺俞、肾俞、气海，口渴甚加支沟，善食易饥加中脘配天枢。

手法：采取轻幅度的捻转，达到酸、麻、胀、痛感觉后留针30min，每天1次，10天1个疗程。

中药：天花粉50g，生地20g，山萸肉75g，沙参25g，玄参15g，苍术15g，枸杞35g，麦冬15g，五味子15g，丹皮15g，石斛25g，王不留行15g，丹参15g。胃热炽盛上方加知母、生石膏、黄连；尿多而浑浊者加益智仁、桑螵蛸、若气阴两虚加党参、黄芪。上方随症加减，水煎日1剂，早晚分服。

糖尿病在中医属消渴范畴，有上、中、下之分。其发病机制，主要有以下几个特点：阴虚为本，燥热为标；气阴两伤、阴阳俱虚；阴虚燥热，常见变证百出。①肺热津亏，肾阴亏虚：取足三里、关元、三阴交、曲池、肺俞、肾俞、气海。补肺固肾为治疗根本。②气滞血瘀：取井穴或十宣点刺放血，上肢取合谷、曲池、下肢取足三里、内关。放血以去瘀生新，取阳明经以活血通络助气血生化之源。③湿热浸淫型：取大椎、曲池、后溪、养老，前二穴用深法，以泻湿热。2型糖尿病多为中老年发病，肾气亏损为根本，故取穴主要以固摄肾气为主，选肾俞穴，配以脾俞、肺俞、三阴交为主穴，以固摄肾气，培元补金；配足三里，调节脾胃，以生津液的功能。曲池配气海具有旺盛全身之功能，取气海穴主一身之气，固摄肾气，中脘疏通胃气配支沟穴生津润肠。同时配合中药辨证施治。《医学心悟》论“三消之治，不必专执本位。但滋其化源则病易全矣。”张瑞杰在中药治疗上，依照肺为水之上源，故首先清肺热、滋肺阴、润肺燥为主，以滋其化源兼清胃热，使胃火不伤肺兼滋肾阴者，即可使相火不得中攻胃，又可利于肾之封藏约束，使精微不随尿排出，故予益气养阴、清热生津为主，中药汤剂与针灸相互结合治疗，疗效显著。

王某，46岁，女性，烦渴多饮半月，1日饮水4暖瓶，伴口干舌燥，尿频量多，头晕，腰膝酸软，形体消瘦，面色无华，皮肤松弛，舌生芒刺，脉沉细数，血糖16.8mmol/L。尿糖（++++）。证属肺热津伤、肾阴亏虚，中药治宜滋阴清热、生津止渴、补肾固摄。

处方上基础方加知母、石膏、黄精服药10剂，取穴足三里、三阴交、曲池、脾俞、肺俞、肾俞、支沟、中脘1个疗程后血糖为14.8mol/L，尿糖为（++），继续针灸2个疗程，同时服用中药，基础方加菟丝子、党参以巩固疗效，治疗3个疗程，自觉症状消失，血糖5.8mol/L，尿糖阴性，半年后随诊，病人未复发。

八、电针配艾灸 神经源性膀胱

糖尿病神经源性膀胱是糖尿病慢性并发症之一，临床较为常见，给病人带来较大痛苦。何乐中采用电针配合艾灸法治疗本病，取得

了不错的疗效。

取穴：第1组：肾俞、气海俞、次髂、秩边、委阳；第2组：气海、中极、横骨、大赫、阴陵泉、三阴交。

2组轮流交替使用，1日取1组。穴位常规消毒后垂直进针，均采用提插补法。秩边、次髂要求有触电样针感向小腹部膀胱处放射。得气后用G6805-2型电针仪，1组穴位肾俞接正极，次髂接负极。2组穴位横骨接负极，大赫接正极，使用疏密波，以肌肉轻微跳动，病人可耐受为度。电针使用20min后起针，用艾条悬灸以上穴位15min，以皮肤潮红，病人感觉温热舒适为度。每日针刺1次，10次为1个疗程。每个疗程间隔3天。

糖尿病神经源性膀胱是糖尿病周围神经病变的一种，西医认为本病的发生是由于长期的高血糖而致支配膀胱逼尿肌及尿道括约肌的交感、副交感神经损害，膀胱收缩功能下降，膀胱逼尿肌功能异常，排尿功能减弱，残余尿增多，临床表现为尿频，尿急，排尿困难，尿无力，甚至尿潴留等症状。

本病属中医学癃闭范畴，其病位在肾、膀胱。多因患者年事渐高，久病体虚，肾气虚衰，气失统摄，膀胱失约，三焦气化失司而致。故取肾俞，气海俞以培补肾气，肾气得补则气化有司。中极、气海为任脉经穴，中极为膀胱“募穴”，为治疗小便不利的主穴。气海为先天元气之海，可补气行气。两穴合用能调畅水道。调整膀胱气化功能，次髂、秩边为膀胱经穴位，其深部为腰骶部神经丛，深刺激能直接促进腰骶神经功能而治疗尿失禁。横骨、大赫为何乐中治疗小便不利的经验穴，两穴为肾经穴位，其下深处即为膀胱，针刺两穴能直接刺激腹壁下神经丛，增强膀胱逼尿肌的收缩力。委阳为三焦的下合穴，针之可使三焦气化有司，水道得调。三阴交为肝脾肾三经的交会穴，阴陵泉为脾经的下合穴，五行属水，两穴合用功能益气利水渗湿，为治疗小便不利的常用穴。而加用电针可以增加膀胱的最大容量，减轻尿道及膀胱颈痉挛，降低尿道压力，减轻阻力，协调逼尿肌-尿道平滑肌，抑制膀胱的过度活动，而有利于排尿。在电针基础上再加用艾灸可以温补肾气，温热下焦，使气化有司，三焦得培而使膀胱功能恢复。

九、动眼神经麻痹 辨证施针

刘靖用电针配合针刺治疗糖尿病性动眼神经麻痹，获得较满意的疗效。

取穴：主穴取视区、风池、阳白、鱼腰、丝竹空、太阳。脾气不足型配足三里、三阴交、血海、脾俞；肝肾亏损型配太溪、太冲、光明、照海、肝俞、肾俞；外感风邪型配风池、四白、合谷、阳谷、外关。

操作：嘱患者取坐位，穴位常规消毒，选长0.5寸针灸针，先针刺视区及风池，得气后，快速捻针5min；再嘱患者仰卧，选取病灶近端阳白、鱼腰、丝竹空、太阳，采用平补平泻手法，接通电脉冲选用断续波，电流强度以见眼睑肌肉轻度抽动为度，依辨证分型远端选取配穴，得气后近端与远端腧穴均留针30min。每天治疗1次，10天为1个疗程，每疗程结束后休息2天，继续第二个疗程。

糖尿病性动眼神经麻痹属中医“上睑下垂”、“睑废”、“视一为二”等范畴，多由于脾虚气陷，或肝肾亏损，气血不足，风邪乘虚而入，经络阻滞、经筋失养，肌肉纵缓不收所致。西医对此病主要以控制血糖、营养神经、扩张血管等方法来治疗。而运用本治疗方法重要的是辨证准确，选取眼部周围阳白、太阳、鱼腰、丝竹空4个主穴，针刺得气后，每2个穴位接通电针仪刺激，再依据辨证分型选取远端的腧穴结合治疗，来调节神经、疏通气血、改善循环、兴奋眼肌神经、促进局部组织细胞的新陈代谢，进而达到恢复眼肌功能、眼球活动自如的目的。

十、视网膜病变 针药并用

糖尿病视网膜病变是并发症中最常见且早期看到的重要疾病，晚期可致盲。呼永河采用针刺及口服中药结合治疗本病，取得了满意效果。

严格控制饮食，口服降糖药物或皮下注射胰岛素控制血糖，临床控制标准为空腹血糖 $<8.33\text{mmol/L}$ ，餐后2h血糖 $<10.0\text{mmol/L}$ ，每周复查2次。

取穴：主穴：太阳、阳白透鱼腰、攒竹。辅穴：太溪、太冲、

光明透蠡沟。

操作：太阳穴，向后斜刺 0.5 寸，得气时局部有酸胀感，出针后刺皮静脉微出血即可；从阳白穴向鱼腰穴直刺 0.5 ~ 1 寸，进针后强刺激出现闪电样针感传至眼球为佳；攒竹穴，针入 1 分，徐徐出针，微出血即可；太溪穴，直刺 0.5 ~ 1 寸，提插捻转补法；太冲穴，直刺 0.5 ~ 1 寸，提插捻转补法；从光明穴针尖向内下透刺蠡沟穴 1 ~ 1.5 寸，捻转平补平泻法。每日针刺 1 次，留针 30min，中间行针 2 次，10 天为 1 个疗程。

中药：自拟“明目五子汤”。药物选用：决明子 25g，青箱子 15g，车前子 15g，蔓荆子 10g，菟丝子 15g。兼血瘀加用黄芪 15g、桃仁 10g、红花 10g；兼实热加用生蒲黄 12g，栀子 10g，赤芍 12g。煎服法：水煎温服，每次 150ml，每日 2 次，10 天为 1 个疗程。

糖尿病引起的视网膜病变，一般在 5 年以上约 30% 出现眼底变化，其发病程度在于病史、糖尿病控制情况和视网膜变化范围。发病病机由于血管内皮细胞的损害，失去了溶解纤维蛋白的作用而引起微血管的阻塞，使血 - 视网膜屏障受损。

本病属于祖国医学中的视瞻昏渺、暴盲、云雾移睛等范畴，大多可分为阴虚热盛、气阴两虚、阴阳两虚 3 型，或兼血瘀和痰湿证等。依“逸者行之、结者散之”，立治法为行血散血、凉血止血。穴位选取太阳、攒竹点刺少量出血以泄热消肿；阳白透鱼腰以宣热泄气；太冲、太溪以填精养目；光明透蠡沟，肝胆表里二经络穴以平肝兼调理气血。药物选用决明子清肝益肾；青箱子清肝明目兼凉血；蔓荆子疏散风热、清利头目；菟丝子滋补肝肾兼明目以扶正祛瘀；车前子利水清热、除湿消肿可使补而不滞。全方泻中有补，升降得宜，共呈明目益精的作用。若兼血瘀甚者加黄芪益气行血、桃仁红花活血化瘀以奏气行血行、祛瘀生新之功，若兼热甚者加生蒲黄凉血止血、赤芍凉血化瘀、栀子泻火凉血以达凉而不涩、止而不瘀之效。

田某，女，60 岁。既往有糖尿病史 13 年，于 2000 年 7 月 16 日收住院。2 周前，发现双眼视物较前模糊。刻诊：双眼无充血，角膜透明，前房正常深浅，房水清，小瞳孔晶体未见混浊。眼底检查：视盘边界可，血管走行及管径可，视网膜可见散在微小血管瘤，小

出血点，硬性渗出及灰白色棉絮斑，中心光反射弥散。测血糖 12.9mmol/L，尿糖（++++）。现口服美吡达 5mg，每天 3 次，盐酸二甲双胍 0.25mg，每天 3 次。诊断：糖尿病视网膜病变Ⅲ期。中医辨证属肝肾阴虚兼虚火上炎，治以滋水涵木，兼以凉血止血。予上述针刺及口服明目五子汤酌加生蒲黄、栀子、赤芍等，并改用皮下注射胰岛素随时调控血糖。治疗 20 天后，患者自觉视力有所恢复。复查血糖 7.8mmol/L。眼底检查：出血点基本吸收，渗出有所吸收，微血管瘤较前减少，中心光反射敏锐。继续治疗 10 天后出院，随访 3 个月未复发。

十一、针药结合 治动眼神经麻痹

动眼神经麻痹以患眼出现复视，上睑下垂，眼球活动受限，重则患眼不能睁开为主要症状，是糖尿病的一个并发症。杨锦国采用自拟动眼汤内服，配合针刺治疗，疗效较好。

针刺：四白、阳白、太阳、瞳子髎、风池、合谷。每日 1 次，用平补平泻手法，留针 30min。10 次为 1 个疗程，休息 2 天后，再行下 1 个疗程。

动眼汤：组方：熟地 24g，山萸肉 12g，青箱子 12g，茺蔚子 12g，白蒺藜 12g，勾藤 15g（后下），生石决明 30g（先煎），珍珠母 30g（先煎），枸杞 9g，菟丝子 9g，蔓荆子 9g，赤芍 9g，橘络 6g。每日 1 剂，水煎分服，12 天为 1 个疗程。

动眼神经麻痹，中医认为本病多由风热邪毒，上犯于目，袭其经络；或脾失健运，痰湿内生，复感风邪，风痰上犯，络脉痹阻；或因气血不足，肝肾阴虚，虚风内动，筋脉失荣，目失所养，眼带弛缓，约束乏力。故临床可见，目斜视而睑下垂，眼球转动不灵而复视。动眼汤组方紧扣病机，具有滋肝补肾、平肝熄风、养肝明目、化痰通络、活血散瘀之功。方中：熟地、山萸肉、枸杞、菟丝子滋补肝肾，养肝明目；石决明、珍珠母、白蒺藜、勾藤平肝潜阳、熄风明目；青箱子、茺蔚子镇肝明目；蔓荆子清利头目，橘络化痰通络，赤芍活血散瘀。肝开窍于目，足厥阴肝经连接于目系属肝络胆，胆经经脉又循于眼周，故针刺取穴以眼周穴位为主，取足少阳胆经阳白、瞳子髎以通络明目，平肝熄风，阳白又为阳维之会，主目视

不明诸疾。配足少阳胆经风池、手阳明大肠经合谷以通经活络，疏风。四白为足阳明胃经穴，具有祛风明目之用，太阳为经外奇穴，又有清利头目之功。针药并用具有协同作用，以直达病所，提高疗效之目的。

患者，男，74岁，于2003年10月30日突然右眼出现复视，继而右眼不能睁开，有轻微头痛。既往有高血压及糖尿病史10余年。神经系统检查：右上睑下垂，遮盖瞳孔及眼球，右侧瞳孔5.5mm，光感差，左侧瞳孔3.5mm，对光灵敏。右眼球呈外斜视，向内、向外、向上、向下活动受限。右眼球呈外斜并复视。眼底：呈糖尿病眼底表现。脑膜刺激征：阴性，病理反射未引出。血压148/106mmHg，空腹血糖8.9mmol/L。服用中药动眼汤加针刺2周后右上睑即能抬起，前后共服中药24剂，针刺2个疗程，复视消失，完全恢复正常，至今未见复发。

十二、糖尿病胃轻瘫 芒针为主

胃轻瘫是糖尿病常见的慢性并发症之一，是由于自主神经功能紊乱、胃肠道激素分泌异常、血糖控制不佳、微血管病变等因素引起的胃动力障碍，排空延迟，但不伴随机械性梗阻的一组临床综合征。薛银萍应用芒针深刺中脘穴为主治疗该病，临床疗效显著。

操作：行常规糖尿病的治疗方法，如饮食控制、运动疗法、口服降糖药、胰岛素注射等。取中脘为主穴，选择直径0.4mm、长6寸的芒针，常规消毒后施用夹持进针法，垂直缓慢进针，当患者自感针感向小腹或者两胁走窜时即为得气。得气后不行针，缓慢捻转出针。进针过程中，一旦针下搏动感明显则立即停止治疗，防止伤及腹主动脉。气血不足者加刺足三里（双侧）、三阴交（双侧）、气海，施用补法；肝郁克脾者加刺太冲（双侧），施用泻法；腑气不通者加刺天枢（双侧）、关元，施平补平泻法。15天为1个疗程。

胃轻瘫属于糖尿病神经病变，属于中医痞满、胃脘痛、呕吐等范畴。其病位在脾胃，虚实夹杂以虚为主，病性总归本虚（气阴两虚、阴阳两虚）标实（气滞寒凝、痰瘀阻滞），病机关键在中焦气机失调，升降清浊功能紊乱。

芒针细长如麦芒，由古代九针之一长针发展而来。杨兆刚教授

《中国实用芒针治疗》将中脘穴列为芒针治疗的重要穴，主治胃肠疾病。芒针以其深刺有关穴位，直达病所的独特刺法而显示出卓越的治疗效果。中脘为腑之会，正当中焦部位，是三焦气机升降的枢纽，又为胃之募穴，乃胃经经气聚集之所，募治本腑。胃为水谷之海，以通为用，以降为顺，深刺该穴既能通降胃气，升清降浊，又能健中补虚。其健运脾胃通中有降，降中有升，补而不滞，有扶土抑木、健中行气之功效。配合针刺胃经合穴足三里，健运脾胃，调畅三焦尤其中焦气机，恢复脾胃升清降浊之功能。气海为元气之根，深刺可以培本固源；三阴交为足太阴、少阴、厥阴经交会穴，深刺可健运脾胃、消除胀满；配大肠募穴天枢、小肠募穴关元通调肠胃气机，恢复其正常的生理功能。临床观察，芒针治疗后排气增多，肠鸣音明显增强，促进食欲，大便次数增多，恶心、饱胀明显缓解。

李某，男性，54岁，2002年5月19日收入院。主诉：持续性上腹胀满伴间断恶心1个半月，大便已经5日未行。既往糖尿病史4年，空腹血糖控制在7.8~10.2mmol/L之间，餐后2h血糖在9.3~16.9mmol/L之间。一直服用二甲双胍及拜糖苹。经上消化道钡餐造影检查发现钡剂于幽门处通过迟缓，诊断为糖尿病胃轻瘫。治疗：芒针深刺中脘穴，选择直径0.4mm、长6寸的芒针，常规消毒后施用夹持进针法，垂直缓慢进针，当患者自感针感向小腹或者两胁走窜时即为得气。得气后不行针，缓慢捻转出针。再加刺天枢（双侧）、关元，施平补平泻法。经治疗1个疗程，上腹胀满及恶心消失；大便通畅，每日1次。继续巩固治疗1个疗程。随访半年未复发。

十三、背俞穴 辨证治胃轻瘫

糖尿病胃轻瘫的发病与自主神经病变、高血糖、胃肠激素分泌或调节紊乱、外周血管病变有关。胃幽门、十二指肠动力障碍是糖尿病胃轻瘫发病的重要病理基础。临床主要表现为胃排空延迟、腹泻、便秘等胃肠功能失调，属于中医消渴、痞满等范畴。张新成采取西医辨病与中医辨证相结合的方法选用背俞穴穴位注射治疗糖尿病胃轻瘫，取得较好疗效。

辨证分型：脾胃气虚型：纳食减少，懒言气短，四肢乏力，肠

鸣腹胀，大便溏薄，舌淡，苔薄白，脉缓或濡细；肝胃不和型：胃脘胀满，时有隐痛，两胁不适，乳房作胀，嗳气频作，偶泛酸水，情绪欠佳，夜寐不安，舌苔多薄白，脉弦；胃中积热型：多食易饥，形体消瘦，大便干燥，苔黄，脉滑实有力；痰浊中阻型：胃脘食后饱胀，纳呆，恶心，呕吐，嗳气酸臭，大便不畅，形胖，舌苔多厚腻，脉滑；脾胃虚寒型：胃脘胀满不适，喜温喜按，纳少，恶心，时吐清水，口中乏味，大便偏溏，平素怕冷，神疲肢软，舌质多淡胖，脉细；胃阴不足型：胃脘痞闷不适，口干咽燥，时有恶心，大便偏干，形瘦，舌质多红，脉弦细。

取穴：单侧脾、胃、胰俞穴。随证配伍：肝胃不和加肝俞，脾胃虚寒加肾俞，痰浊中阻加丰隆，脾胃气虚者加足三里，胃中积热加上巨虚，胃阴不足加太溪，平补平泻法。

操作：局部皮肤常规消毒后，用10ml注射器5号针头抽取黄芪注射液在所选的穴位刺入皮肤，边进针边提插，当患者得气后，推注黄芪注射液，每穴1ml，每次选3~4穴，隔天1次，15次1个疗程，间隔3天后进行下1个疗程。双侧两组穴交替使用。

穴位注射可使气感增强，作用时间延长，用药量小，有效减少了药物的积蓄和毒性及不良反应，又可反复使用。穴位注射是综合针、穴、药之作用，以加强疗效的一种治疗手段，因此辨证选穴、用药是获取疗效的关键。

张新成选用背俞穴穴位注射治疗糖尿病胃轻瘫，现代医学认为糖尿病胃轻瘫是糖尿病自主神经病变而导致的胃排空延迟。背俞穴：为五脏六腑之气输注于背腰部的腧穴，其位于足太阳膀胱经第1侧线，距脊柱两侧各1寸半，循行：“上额交巅；其支者从巅入络脑，还出别下项，循肩膊内，夹脊抵腰中……。”《素问·长刺节论》：“迫藏刺背，背俞也。”背俞穴部位接近内脏，对相关脏腑具有相对特异性，最能反映五脏六腑的虚实盛衰。

临床上糖尿病累及自主神经病变较常见，且出现较早，影响胃肠、心血管、泌尿系等，表现为排汗异常（无汗、少汗或多汗）；胃排空延迟、腹泻、便秘等胃肠功能失调；直立性低血压等心血管自主神经功能紊乱表现；泌尿系统早期表现排尿无力致膀胱残余尿量增加，后期膀胱瘫痪，出现尿失禁和尿潴留。黄芪为中药的补气药，

具有补气升阳，益卫固表，托毒生肌，利水消肿的作用。其固表止汗的作用可用于自汗、盗汗；其补脾益肺，可治清气下陷导致的头晕、腹胀腹泻，气虚无力运化导致的便秘；利水消肿，可用于水湿潴留导致的水肿尿少；托毒排脓，可治糖尿病患者皮肤感染所致的痈疮不溃或溃后久不收口。

选用黄芪注射液穴位注射治疗，可同时发挥药物和穴位的两方面作用，一方面加强穴位的刺激作用，另一方面强化了黄芪药物的作用，易于使胃肠功能紊乱恢复正常。

参 考 文 献

- [1] 张戈. 电针结合经穴按摩治疗消渴病 36 例. 四川中医, 1995, (9): 52~53
- [2] 周潮, 李晓哲, 常宝中, 等. 揠针及体针并用治疗 2 型糖尿病 178 例. 中国针灸, 1998, (1): 38
- [3] 张中新, 刘建玉, 李民兰. 胰俞穴埋药线治疗 2 型糖尿病临床报道. 针灸临床杂志, 2005, 21 (6): 40~41
- [4] 刘晓峰. 针刺背俞穴为主治疗 2 型糖尿病 30 例. 针灸临床杂志, 2001, 17 (1): 37~38
- [5] 吴维平. 针药结合治疗糖尿病的临床疗效观察. 针灸临床杂志, 2001, 17 (11): 7
- [6] 岳玉烈. 针药治疗 2 型糖尿病临床观察. 针灸临床杂志, 2005, 21 (2): 16~18
- [7] 张瑞杰, 周亚杰. 针药治疗糖尿病 50 例疗效观察. 针灸临床杂志, 2007, 23 (8): 34~35
- [8] 何乐中. 电针配合艾灸治疗糖尿病神经源性膀胱 28 例. 针灸临床杂志, 2007, 23 (5): 26
- [9] 刘靖, 汤艳娟, 王春丽, 等. 电针治疗糖尿病性动眼神经麻痹 33 例. 中国针灸, 2007, 27 (6): 470
- [10] 呼永河, 吴深涛, 李静. 针药结合治疗糖尿病视网膜病变 40 例临床观察. 中国针灸, 2003, 23 (5): 259~260
- [11] 杨锦国, 梁文智, 张永平. 针药结合治疗糖尿病性动眼神经麻痹 3 例. 中国临床医生, 2006, 34 (12): 57
- [12] 薛银萍, 高彤. 芒针为主治疗糖尿病胃轻瘫疗效观察. 四川中医, 2006,

24 (4): 99 ~ 100

- [13] 张新成, 张学莲. 背俞穴穴位注射治疗糖尿病胃轻瘫 45 例. 云南中医学院学报, 2007, 30 (3): 48 ~ 49

【附：糖尿病并发末梢神经炎】

该篇收录了 11 位针灸医家的临床治验，有的采用刺络放血，除陈出新；有的采用电针配耳压，祛风止痒；有的采用针药并用，养血活血；有的取络脉扣刺，泻血攻下；有的根据临床症状辨证分型，针药并治；有的采用头针为主，配合簇针；有的采用针药穴位注射，综合治疗等，对末梢神经炎均有一定疗效，但在治疗时应严格消毒。

一、刺络放血 除陈出新

李佩芳在采用西药控制血糖的前提下，运用刺络放血疗法治疗 2 型糖尿病伴有周围神经病变，取得了一些经验。

取穴：曲池、委中、三阴交、十二井。

操作：每次选用 2~3 穴，穴位局部皮肤用碘酊棉球、酒精棉球常规消毒。用右手拇指、食指和中指持针，中指在前以控制进针的深度，进针时针尖向上，针尾向下，这样既不易刺穿血管壁发生血肿，又可使血液顺势自然流出。拔罐：待针刺出血自然停止后再拔罐，一般用闪火法，既能控制出血量，又可以拔出针刺局部瘀血，减轻疼痛。根据病人体质及病情，每次出血量在 15~30ml，但总量不超过 50ml。每周治疗 1 次，8 周为 1 个疗程。

刺络放血疗法在中医学中源远流长，早在石器时代就有砭石放血记载。《史记》中有“病在血脉，针石所及也”之说。金元四大家李东垣亦有刺血调整营卫气血平衡的论述。明清著名针灸大师杨继洲认为：“病有三因，皆从气血”，“盖针砭所通经脉，均气血，蠲邪扶正，故曰捷法最奇者哉。”生命的基础代谢是新陈代谢，人体内进行的新陈代谢有赖于健全的血液循环，如果经络气血运行的功能发生障碍，就会产生气滞血瘀而导致一系列的病理变化，如局部的疼痛、肿胀或肢体麻木不仁，肌肉萎缩、功能减退等。刺络放血可以疏通经络中壅滞气血、协调虚实、调整脏腑功能紊乱，使气滞血瘀的病理变化恢复正常。另外刺络放血除陈出新，达到内环境新的整合平衡，新生血液会携带更充分的营养物质和氧气，有利末梢神经的修复，改善其功能。

二、电针耳压 祛风止痒

皮肤瘙痒是皮肤科常见病证，可见于多种疾病。由于痒感剧烈，猛烈搔抓引起皮肤抓痕，潮红结痂，日久可有色素沉着、皮肤开裂及苔藓湿疹样变等各种继发性皮损，部分患者还可伴有头昏、失眠、精神忧郁等神经衰弱症状，严重影响患者工作、学习及睡眠。宋广军采用电针配合耳穴贴压治疗糖尿病皮肤瘙痒，获得较理想的效果。

电针：取曲池、合谷、血海、足三里、三阴交、太溪、太冲。采用30号1.5寸毫针针刺上述穴位（双侧），手法为平补平泻，针刺得气后，接通电针电麻仪，留针30min，每日1次，10次为1个疗程。维生素B₁100mg、维生素B₁₂500mg，穴位注射曲池。双侧曲池交替使用，隔日1次。

耳穴：耳部贴压取肺、大肠、肾上腺、内分泌、神门配以相应部位，病久可加心、脾。操作以75%乙醇消毒耳廓，用王不留行籽贴压，每次取一侧耳穴贴压，视气候冷暖每2~5天换1次，贴压后嘱患者用手按压贴压的耳穴，以耳廓发热、胀痛为宜，每日按3~5次，每次2min，两耳交替使用，10天为1个疗程。治疗期间嘱患者洗澡时禁用肥皂、香皂、洗浴液等，忌食海鲜，如鱼、虾、蟹等，忌饮酒及辛辣食物，保持心情舒畅。

糖尿病皮肤瘙痒症是糖尿病的一种特殊并发症，主要病因为糖

尿病患者免疫力减低，皮肤营养不良所致。临床实践证明，针灸治疗该病有良好效果。太溪、血海滋阴润燥、养血祛风，三阴交补肝益气血，足三里养血润燥，合谷、曲池祛风养血，诸穴配合，达到祛风止痒的效果。治疗同时都接上电针，电针具有镇静、安神、止痒、促进血液循环的作用并可增加针刺的针感效应，提高针刺疗效。维生素 B₁、维生素 B₁₂ 维持神经细胞生长，并参与机体代谢，穴位注射曲池穴能充分发挥穴位与药物的作用。耳穴取肺、大肠、可宣肺疏风止痒，肾上腺穴可祛风止痒，内分泌调节全身内分泌功能以止痒，神门起到镇静、安眠作用，相应部位耳穴可疏通局部气血，日久血虚可加心、脾以益气养血。洗澡时忌用香皂、洗浴液等主要是因为皮肤受到碱性等化学成分的刺激易诱发皮肤瘙痒，忌食海鲜及生冷、辛辣刺激食物以防止皮肤瘙痒复发。

三、针药并用 养血活血

糖尿病周围神经病变是糖尿病最常见的慢性并发症，是糖尿病致残的重要原因。任昌伟采用黄芪桂枝五物汤配合穴位注射治疗该病，取得较好疗效。

严格饮食控制，使用降糖药将空腹血糖控制在 $<8.0\text{mmol/L}$ 、餐后 2h 血糖 $<10\text{mmol/L}$ 。在此基础上，进行以下治疗：

取穴：上肢者，选内关透外关，后溪透劳宫，尺泽透曲泽；下肢者，选太冲透涌泉，三阴交透悬钟，阴陵泉透阳陵泉。

操作：取 10ml 注射器，用 5 号牙科长针头，抽取氢溴酸加兰他敏注射液，然后穴位区皮肤消毒，按进针透穴先后，分步将 0.5ml 药液注射到穴位中（得气之后，且回抽无血再注射药物）。2 天 1 次，7 次为 1 个疗程。

中药：黄芪 30g，白芍 20g，桂枝 10g，生姜 15g，大枣 5 枚。每日 1 剂，水煎早晚 2 次分服。加减：疼痛明显者，加延胡索 10g，全蝎（冲）2g，蜈蚣（冲）2 条；麻木明显者，加木瓜 20g，丝瓜络 20g；上肢重者，加姜黄 10g；下肢重者，加川牛膝 20g。

本病在祖国医学属消渴、血痹和痿证的范畴。其主要病因病机为消渴日久，气血（阴）两虚，气虚脉络瘀阻，血瘀不能达于四肢，血（阴）虚肌肉筋脉失于荣养，出现肢体麻木不仁、疼痛。久则阴

损及阳，温煦不足，故见四肢逆冷。黄芪桂枝五物汤即桂枝汤去甘草、倍生姜、加黄芪组成。方中黄芪补气，合桂枝益气通阳、活血通络；佐白芍养血和营、润养血脉；生姜、大枣调营卫、和脾胃，重用生姜能助黄芪桂枝振奋阳气，使气血通、津液布。全方合用共奏补气温阳、养血活血、通络除痹之功。分步注射透穴法，以透穴为主，循经取穴，使药物在2个或2个以上穴位产生较强烈的刺激区，达到调整中枢神经系统及自主神经系统功能，疏通经络，调节气血，气血得旺，经脉得养，筋脉坚强。与中药配合使用相得益彰，故能收到较好疗效。

四、络脉扣刺 泻血攻下

糖尿病周围神经病变是糖尿病常见并发症之一，其发生率为25%~90%，神经病变可累及感觉神经、运动神经及自主神经，产生疼痛、麻木、运动障碍及自主神经功能障碍。糖尿病神经病变随病程延长有累积作用。中医认为糖尿病周围神经病变多与久病入络、络脉空虚、络失濡养有关，因此络病与糖尿病周围神经病变有很好的相关性。胥林波通过络脉扣刺加用维生素B₁、维生素B₁₂的方法治疗糖尿病周围神经病变取得了比较满意的临床效果。

糖尿病常规治疗：包括药物、饮食等。全部患者均在饮食治疗基础上，根据患者具体情况在专科医生的指导下继续服用降糖药，使血糖稳定控制在空腹正常范围。不再服用改善微循环和改善营养神经功能的药物，亦不用其他方法治疗糖尿病周围神经病变。

络脉扣刺：扣刺操作在消毒治疗室进行，充分暴露患者病变部位（疼痛、麻木的部位），先用2%的碘酒消毒，然后用75%的酒精脱碘，用消毒的皮肤针沿经脉叩刺患部的络脉至微红或出血后将维生素B₁、维生素B₁₂倒在消毒的干棉球上，反复擦在皮肤针扣刺过的部位；阴络和阳络交替进行，2天1次，10次为1个疗程。

络脉是由经脉分出的行于浅表的支脉，《灵枢》称之为血络。它具有经脉共有的作用，还可输送营卫气血、渗灌濡养周身。中医认为糖尿病周围神经病变多与久病入络、络脉瘀滞、空虚有关，故胥林波从张从正刺络泻血攻下法中得到启示，用皮肤针扣刺病变局部来改善局部的血液供应状况，虽然《千金方》认为“凡消渴病百日

以上者，不得灸刺”，胥林波经临床观察认为此可能由于当时的医疗条件有限、消毒不严所致。有学者认为刺络实际上刺激了微血管壁上小神经，所谓“刺络出血，与之相逢而得气。”胥林波认为刺络能输送营卫气血，渗灌濡养周身，改善了糖尿病周围神经病变的微血管功能，起到了活血作用，从而对糖尿病周围神经病变受累神经的缺血、缺氧状态起到良性的调节作用。使神经和血管的功能得到改善。

维生素 B₁、维生素 B₁₂ 均参与体内糖代谢，其缺乏时可致糖代谢发生障碍，能量供应减少，从而影响神经功能，在糖尿病周围神经病变的发生中具有一定作用，故胥林波将 2 种方法合用，在临床上取得了明显的疗效。

五、辨证分型 针药并治

糖尿病周围神经炎是糖尿病常见并发症，临床表现往往呈进行性加剧，是糖尿病重要致残致死原因。代国平采用针灸治标（周围神经炎）为主，结合中药治本（糖尿病）收效良好。

（1）辨证分型

据临床症状体征分为三型：

气虚血瘀，营卫不达：见肢体麻木刺痛、入夜尤剧，局部触压痛，皮肤发紫，兼头晕头痛乏力，或胸腹胁肋疼痛、渴饮，面色晄白或有瘀斑。舌质瘀黯或有瘀点、苔薄白，脉沉涩或虚大。

肾阳亏耗，血虚寒凝：见肢端冷痛、遇寒痛重，腰膝酸软，足跟痛，或感觉消失，肢体浮肿，面色黧黑，阳事不举，小便清冷频数，或饮一溲一，尿如脂膏，舌质淡，苔白或水滑，脉沉细缓涩。

气阴两虚，湿热浸淫：见肢体麻木酸痛或闪电样剧痛，兼见五心烦热、渴饮、失眠多梦，自汗盗汗，倦怠乏力，心慌气短，头晕耳鸣，口干尿黄，大便或干或溏，舌质红，舌体胖大有齿痕，苔黄腻或苔少花剥，脉沉细或濡数。

（2）针灸治疗

取穴以疼痛、麻木所涉及的经络循经取穴，并辨证配穴。基本处方：肝俞、脾俞、膈俞、阳陵泉、足三里、曲池。井穴或八风、八邪点刺放血。气虚血瘀，营卫不达者加井穴或十宣点刺放血、外

关、合谷、支沟、内庭、气海、血海。肾阳亏耗，血虚寒凝者加肾俞、关元、气海，可加灸，麻木沉重加悬钟、复溜、八风、八邪。气阴两虚，湿热浸淫针肺俞、胃俞、气海、大椎、太溪、养老。进针得气后，先补而后泻，留针 30min，每日 1 次，每月为 1 个疗程。

(3) 中药

气虚血瘀，营卫不达者，治以补气行瘀，通达营卫，方选补阳还五汤加减。方药：黄芪 60g，当归 15g，川芎 6g，赤芍、红花、地龙、五味子各 10g，生熟地黄、丹参、山药各 30g，全蝎 10g。

肾阳亏耗、血虚寒凝者，温补命门，养营通络，方选金匱肾气丸合二仙汤加减。方药：熟地黄、山药、仙茅、仙灵脾各 30g，菟丝子、山茱萸、巴戟天、覆盆子各 15g，茯苓、牡丹皮、附子、五味子各 10g，泽泻 6g，木通 15g，酌加鹿茸。

气阴两虚、湿热浸淫者，治以益气养阴清热，方选六味地黄汤加减。方药：熟地黄 30g，山茱萸 15g，茯苓、蝉蜕各 15g，山药 30g，牡丹皮 20g，泽泻 6g，白芍 15g，枸杞子 15g，天花粉 15g，麦冬 6g，薏苡仁 30g，黄柏 6g，牛膝 18g。

官某，女，35 岁，农民，1990 年 4 月 3 日就诊。6 年前发现糖尿病，经饮食治疗、口服优降糖、消渴丸等，症状控制。6 年间病情多次反复。1 年来日渐肢体麻木，时有刺痛，呈放射性，常有手指拘挛及腓肠肌痉挛。伴见头晕、乏力、胸胁刺痛、渴饮、烦躁失眠多梦、自汗盗汗，苔薄白，脉细涩。查体：心肺肝脾无异常，四肢肌张力、肌力正常，双跟腱反射消失、浅感觉迟钝。实验室检查：空腹血糖 17.8mmol/L，尿糖定性（+++）。诊为血痹、消渴（尿病周围神经炎），证属气虚血瘀、营卫不达，治以滋阴养血活血，通达营卫。针灸取四肢末端井穴点刺放血，上肢取合谷、曲池，下肢配足三里、内庭，加前述基本针灸处方。每日针灸 1 次。中药选用补阳还五汤加减：黄芪 80g，山药 30g，生熟地黄、鸡血藤各 30g，白芍、花粉、川楝子、佛手各 15g，当归、红花、地龙、木瓜各 12g，川芎、甘草各 6g，全蝎 3g。水煎服，每日 1 剂。治疗 1 个疗程上述症状明显减轻，又治 1 个疗程，痛、麻等及兼见症状消失，指趾感觉正常，跟腱反射适中，空腹血糖 6.1mmol/L，尿糖（+），继以前方去川楝子、佛手水泛为丸，每服 12g，每天 2 次，巩固治疗半年，

随防3年未复发。

六、头针为主 配合簇针

糖尿病周围神经病变是糖尿病患者常见的慢性并发症之一。临床主要表现为肢体的感觉和运动神经障碍，其发病率约占糖尿病患者的半数以上。张玉莲采用头针加簇针疗法治疗该证，取得理想疗效。

取穴：头针取穴：调感三针，从百会穴后2cm处向前下约45°夹角线上，共三穴。调运三针，从百会穴后0.5cm处向前下约45°夹角线上，共三穴。体针取穴：上肢取肩髃、曲池、手三里、内关、合谷、八邪。下肢取血海、足三里、阴陵泉、丰隆、三阴交、绝骨、解溪、八风、涌泉。

操作：头针每穴进针约1.5寸左右。进针后及出针前每穴均采用快速捻转手法捻针30s，约200转/min，幅度前后各约360°。簇针疗法每穴进针2~3颗，施九六提插补泻法，以病情轻重行重按慢提手法9次（初）、27次（少）、81次（老），未得气者，再以上法行针，直至得气。得气后留针30min。每天1次，5天为1个疗程，疗程间隔2天。

糖尿病周围神经病变属消渴证的变证，因消渴日久所致。其病理机制为阴虚燥热，气阴两虚。阴虚火旺，煎熬津液，故而血液黏稠，运行不畅，血脉瘀滞；气虚则血运无力，脉络痹阻，肢体筋脉失于濡养，故而出现四肢麻木无力、感觉减退或消失、自发性疼痛等症。

调感三针和调运三针分别位于大脑皮层感觉及运动功能投影区，针刺该穴可调整中枢神经功能，改善病人的感觉及运动功能。糖尿病周围神经病变病人四肢神经传导功能减退，一般针刺和手法病人针感出现较慢或不明显。簇针可加强针刺强度，加快得气速度。本法治疗关键是第一次针刺就要达到每穴必须得气，这亦是保证临床疗效的关键。究其原因，可能是强烈针感刺激唤醒并兴奋了各级感觉、运动神经元，进而提高了感觉及运动神经的兴奋性；同时加速了血液循环，改善了周围组织缺血缺氧状态。

七、头针为主 配穴位注射

糖尿病伴发的肢体麻木是临床最为常见的一种症状。陈天韵采用头针配合穴位注射治疗糖尿病性肢体麻木，效果满意。

头针治疗：取穴为头针感觉区上 1/5，中 2/5。选用双侧穴位。病人采取坐位或卧位。局部常规消毒后用 26~28 号的长 1.5 寸不锈钢毫针刺入头皮穴位，针与头皮呈 30°左右夹角，用夹持进针法刺入帽状腱膜下，达到该区的应有深度后再接 G6805-1 型治疗机通电 30min，强度以病人可耐受为宜。每日 1 次，10 次为 1 个疗程。每个疗程后休息 2 天，再进行下 1 个疗程。

穴位注射：取中脘、太溪、三阴交、足三里、关元。用药为维生素 B₁100mg、维生素 B₁₂0.1mg，将两药混合备注。局部常规消毒后，取 5ml 注射器套上 6 号针头抽取上述药液在选定穴位处垂直刺入，上下缓慢提插，待有酸、麻、胀等针感，回抽无血即可缓慢注入药液。每穴注入 0.5ml，每次取穴位 2~3 个，上述穴位交替使用。每天 1 次，10 次为 1 个疗程，每个疗程后休息 2 天，再进行下 1 个疗程。

糖尿病属于祖国医学消渴范畴。祖国医学对消渴的认识已有二千多年的历史，而且在防治本病上积累了丰富的临床经验。糖尿病性肢体麻木是消渴病常见的并发症之一，其病因病机为阴虚燥热，气阴两虚或阴阳两虚。本病以阴虚为本，燥热为标。日久则气阴两虚，累及阴阳气血，筋脉失养而致脏腑功能失调。阴虚火旺，煎熬津液，故而引起血液黏稠，运行不畅，血脉瘀滞。阴虚气无所附而致气虚，气虚则血运无力，脉络痹阻，肢体筋脉失于濡养则出现肢体麻木。陈天韵用头针感觉区可治疗四肢的麻木疼痛，并且头针具有兴奋调节神经系统，改善脑血液循环的作用。用足三里、三阴交、中脘、关元、太溪，分属胃经、脾经、任脉、肾经，可疏通胃气、调理脾胃、生津液、补肾气，对改善胃肠道症状，减轻末梢神经炎症状，从而对治疗本病，改善肾功能有一定效果。用维生素 B₁、维生素 B₁₂可促进神经细胞内兴奋和传导，影响神经体液因素。而两药合用穴位注射不但有以上药物作用，还可提高穴位的兴奋性和传导性，具备了穴位与药物的双重治疗作用，可使穴位气感增强作用时

间延长。

王某，男，48岁，干部，1992年8月7日初诊。主诉：患非胰岛素依赖型糖尿病4年，伴四肢麻木2个月。见四肢麻木、乏力、口干、阵发性烘热、心烦易怒、失眠、多梦、小便频多。舌淡红，苔薄少津，脉细微数。检查血糖10.3mmol/L。曾服用消渴丸、谷维素未见好转。查体：神清合作，颅神经（-），四肢肌力正常，巴彬斯基征（-）。西医诊断：糖尿病性周围神经病变。中医诊断：消渴，证属阴虚燥热，脉络瘀阻。治则：补气滋阴，活血化瘀。用头针治疗，取感觉区上1/5、中2/5，双侧穴位。每日1次，每次留针30min。用G6805-1型治疗机，通电30min，10次为1个疗程。配合维生素B₁100mg、维生素B₁₂0.1mg注射中脘、太溪、三阴交、足三里、关元。每个穴位注射药液0.5ml，每次选上述穴位2~3个。每天1次，10次为1个疗程。经头针及穴位注射1个疗程后，四肢麻木、乏力、口干、阵发性烘热、心烦易怒症状减轻。经上述治疗2个疗程后诸症消失，行走自如，恢复正常，复查血糖6.1mmol/L。随访半年未复发。

八、穴位注射 益气养血

糖尿病性末梢神经炎是2型糖尿病的常见并发症和致残因素之一，蔡德锋采用穴位注射和针刺治疗该病，疗效显著。

取穴：曲池、外关、足三里、委中、悬钟。

操作：在严格无菌操作下，选5ml注射器接5.5号针头两具，其一抽取复方丹参注射液2ml，其二抽取维生素B₁₂1ml、辅酶A2ml备用。每次选一侧肢体，穴区常规消毒，在曲池、足三里进针得气，回抽无血后注入复方丹参注射液各1ml，在外关、委中、悬钟如法注入维生素B₁₂、辅酶A的混合液各1ml，出针后用消毒棉球按压针孔以防出血，每日治疗1次，左右交替，10次为1个疗程，间隔3天，进行下1个疗程。

糖尿病性末梢神经炎属中医消渴、痿证范畴，多因消渴之病日久不愈，累及五脏，致精血耗伤、气血亏虚、经脉瘀阻，不能濡养肢体筋骨而成痿证。主要表现为：四肢末梢麻木刺痛、瘦削无力或牵掣拘挛，呈缓慢发病，渐进性加重的特点。若失治、误治，则其

四肢有瘫痪废用之虞。

鉴于糖尿病性末梢神经炎发病机制的复杂性，通常在使用降糖药物治疗的同时，配合维生素 B 族口服，难以取得满意效果，故蔡德锋试从中西医结合的角度，选用降糖药物（如糖适平、降糖灵、达美康）1~2 联，维持血糖基本平稳以控制原发病；结合中医、针灸理论，以益气养血、化瘀通络为治则，治疗其并发症末梢神经炎，穴取多气多血的阳明经之合穴曲池、足三里为主，辅以外关、委中、悬钟等穴，以复方丹参液穴位注射曲池、足三里以振奋气血、活血化瘀；维生素 B₁₂、辅酶 A 的混合液穴位注射外关、委中、悬钟以濡养四肢经脉。通过降低血脂、改善末梢循环，增进神经的营养和代谢，从而达到使神经末梢变性恢复的目的。

徐某，男，65 岁，本市轻工公司退休，1995 年 6 月 13 日初诊，主诉：双侧手指、足趾麻木、刺痛 5 年。患者十年前因口渴、多饮、体重下降半年经北京某医院诊断为 2 型糖尿病，先后服用 D860、达美康等治疗，血糖波动在 7.2~8.5mmol/L 之间，5 年前始起双侧肢体乏力，手指、足趾轻度麻木、刺痛，并逐渐加重，自服维生素 B₁₂、维生素 C 治疗，症状无明显改善而来诊。查：血压 15/12kPa，四肢关节无畸形，双侧肘、膝关节以下肌肉松弛，并轻度萎缩，皮肤痛觉减退，双侧肱二头肌腱反射减退，双侧膝、跟腱反射消失，电生理测定示双侧正中神经、胫后神经传导速度延迟。诊断为：2 型糖尿病并发末梢神经炎，即按上述方法施以穴位注射治疗，经 1 个疗程的治疗，双侧肢体末梢的麻木、刺痛感明显减轻，活动功能较前灵活，至第三疗程结束，上述症状基本消失，肢体活动自如。电生理测定示双侧正中神经、胫后神经传导速度接近正常，予服复方丹参片 3 片，每天 3 次，施尔康 1 片，每天 2 次，以巩固疗效，随访 2 个月，病情稳定。

九、针药穴位注射 综合治疗

糖尿病神经病变是糖尿病致残的并发症之一，发病率高，可出现于糖尿病患者的任何时期，常导致感觉、运动、自主神经功能障碍，是糖尿病致死的主要原因。王前琼采用针刺、穴位注射、药灸疗法进行治疗，收到了满意效果。

(1) 针刺疗法

以足三里、三阴交、太溪、肾俞、脾俞、胰俞为基础方。善食易饥加天枢；口渴加支沟；心率快加内关；腹痛腹泻加上巨虚；尿频尿痛，排尿不尽加中极；大汗淋漓加合谷、复溜；眼睑下垂加攒竹、丝竹空；阳痿加关元；头痛加太阳、百会；垂足加解溪、昆仑、丘墟；垂腕加外关、阳溪、养老、阳池；膝关节站立不稳加鹤顶、膝眼；病变以上肢为主加肩髃、肩髃、曲池、手三里；病变以下肢为主加环跳、风市、伏兔、阳陵泉、悬钟。以上穴位除任督二经穴位外，均取双侧，根据不同病症，拟定2~3组穴位，每组穴位3~5个交替选用。用平补平泻手法，捻转进针，留针30min，每天1次；7天为1个疗程，休息3天后继续第二疗程。

(2) 穴位注射

用维生素B₁₂、维生素B₁、利多卡因针剂进行穴位注射，取穴与针刺选穴相同。操作：用5号注射针头，每次注射维生素B₁₂1支(1ml；0.5mg)，维生素B₁1支(2ml)混合使用，每次3~5个穴位注射，每穴注射0.5~1ml。疼痛剧烈可加利多卡因2ml。缓慢进针，得气后将药液注入穴位，出针时闭针孔，每次每穴注射完后，再用自配方药做成的丸药灸此穴位，以使药液被尽快吸收，减轻穴位胀痛。每天注射1次，7天为1个疗程。

(3) 药灸疗法

自制丸药为灸料，将麝香、樟脑、川芎、当归、川乌、草乌等多味中药研成粉末，做成丸药，将丸药用纱布包裹，置于酒精灯上炙烤一会儿，速又置于所灸穴位上，温度以患者能够承受为宜，药灸取穴与针刺选穴相同。还可加灸一些不宜针刺的穴位，如涌泉、神阙、阿是穴等。

治疗程序：先针刺，取针后，再穴位注射，最后实施药灸。

糖尿病并发神经病变属中医血痹证的范畴，病机为气血亏虚，感受风邪，入于血络，瘀血阻滞，脉络不通，从而导致神经系统的功能障碍。因此，在针刺、药丸灸医治上应根据不同的证型，辨证施治而采用了不同的治疗原则，气血亏虚以调补气血，气滞血瘀以行气活血通络，肝肾亏虚以补肝益肾、宣痹活络。

现代医学观点认为：糖尿病神经病变引起的多种病变与神经营

养因子缺乏、维生素缺乏有关，故而选用营养神经的维生素 B₁ 和抗贫血的维生素 B₁₂，混合进行穴位注射，这样既有药物的作用，又有针刺穴位和药丸灸的治疗，协同治疗糖尿病神经病变达到了满意效果。

患者吴某，女，52岁，干部。2001年2月，患者因春节期间忙碌，忌食不好，近一星期双下肢无力麻木，痉挛性疼痛发作频繁，有时电闪、刀割样痛。检查空腹血糖 10mmol/L，尿糖（++）。肌电检查：神经传导速度迟缓，肌束颤动，异常肌电图。患者已患糖尿病 10 年，从未中断过药物治疗，但此次服药疗效不佳，疼痛、麻木、无力等自觉症状不缓解。采用了针刺、穴位注射、药丸灸的综合疗法，仅治疗 2 次疼痛明显减轻。7 天后（1 个疗程）自觉不良症状及体征进一步减轻，继续治疗 2 个疗程复查：尿糖（-），血糖 7.6mmol/L，肌电图正常。再续治 2 个疗程，配合饮食疗法、运动疗法，3 个月后随访，各项指标及体征均正常。

十、针药结合，活血化瘀通络

糖尿病末梢神经病变是糖尿病最常见并发症，张少云采用中药自拟方益活通络汤与针灸并用治疗 2 型糖尿病末梢病变，取得良好疗效。

（1）针灸

采用针刺与穴位注射疗法治疗。针刺取穴：足三里、太冲、阳陵泉、三阴交、肾俞、太溪、曲池、胰俞、脾俞、支沟、天沟、关元。进针得气后留针 30min 加 TDP 穴位照射。穴位注射液采用复方丹参注射液 2ml、黄芪注射液 2ml，分别进针于双侧足三里或曲池，得气后注射。

（2）中药

益活通络汤：熟地 10g，山药 30g，枣皮 6g，当归 15g，生黄芪 30g，地龙 10g，丹参 10g，丝瓜络 10g，甘草 6g。肝肾阴虚明显者加枸杞 10g，旱莲草 10g，黄精 10g；气虚明显者加党参 15g，土炒白术 10g；血虚明显者加白芍 10g，鸡血藤 15g；病变偏于上肢加桑枝 15g，葛根 15g；病变偏于下肢加牛膝 10g，焦黄柏 6g；瘀血明显者加桃仁 6g，川芎 10g；肢体麻木疼痛剧烈者加炮甲珠 6g，红花 6g；

肢端发凉加桂枝 10g, 仙茅 10g; 血虚燥热者加生地 15g, 赤芍 10g; 肢体灼热者加玄参 10g, 忍冬藤 15g; 肢体蚁行感明显者加蝉蜕 6g, 天麻 10g; 兼见痰浊者加僵蚕 10g, 全蝎 3g; 兼见气滞者加苏梗 10g, 佛手 10g。开水煎煮后 100ml, 餐后 30min 服用, 每日 1 剂, 20 天为 1 个疗程。

糖尿病末梢神经病变是糖尿病常见的慢性并发症之一, 临床以四肢末端麻木疼痛、灼热感或发凉、呈手套或袜套型感觉、手足痛温觉减退甚至消失等为主要表现, 部分患者表现为肢体无力或肌肉萎缩。现代医家对其病名认识不同, 有血痹、痹证、痿证等, 张少云根据多年对此病临床诊疗与研究, 认为其发病根源在于消渴, 故应专门命名为消渴痹及消渴痿, 以区别于其他疾病所导致的痹证及痿证, 从病机看为虚实夹杂、本虚标实之证, 重点在肝脾肾气血的不足, 导致瘀血阻滞络脉, 络脉失养, 功能失调而出现诸多临床表现。且糖尿病末梢神经病变早期中医辨证以实证为主, 中医病名为“消渴痹”, 随着病程的发展呈现虚实并见, 最后以虚证为主, 从而中医病名为消渴痿。

糖尿病末梢神经病变既与原发病相关, 又与患者体质相关, 即先天秉赋薄弱, 肝肾阴虚、气血不足者更易发展成为消渴痹及消渴痿, 使瘀血内生阻滞于络脉而出现诸种临床表现。据此设立中药益活通络汤, 方中熟地、枣皮、山药补脾益肝肾, 当归、黄芪益气补血, 地龙、丹参、丝瓜络活血化瘀通络, 甘草止痛调和诸药, 共取补益肝肾气血、活血化瘀通络之功。现代药理研究表明, 熟地、山药、黄芪降血糖, 当归、丹参、地龙、丝瓜络改善微循环、镇痛、镇静, 甘草降血脂、镇静。在针灸组方中抓住“虚、瘀”病机关键, 以足三里、脾俞、三阴交、曲池益气养阴, 肝俞、肾俞、太冲、支沟、胰俞、关元补益肝肾, 复方丹参注射液与黄芪注射液益气活血化瘀, 在足三里或曲池穴位注射使其通络作用增强。由于中药与针灸同用, 使整体与局部同调, 脏腑与经络同治, 瘀血去除、经络通达而发挥治疗作用。

十一、穴位注射 健脾益肾固本

奚道杰应用穴位注射治疗糖尿病性周围神经病变, 疗效显著。

取穴：①组：胸8夹脊穴、关元俞；②组：关元、三阴交。上肢症状重加曲池，下肢症状重加足三里，两组穴交替使用，每日取1组，10次为1个疗程，疗程间休息5天，根据病情可连续治疗3~5个疗程。如需治疗较长时间，穴位注射50次后应停留两个月，再行治疗。

操作：穴位常规消毒后用5ml的一次性注射器抽取硝酸土的宁注射液1ml（1mg）加维生素B₁₂1mg（2ml）快速刺入所取的穴位，回抽无血时将药液缓缓推入穴内，每穴约0.5ml药液，然后用酒精棉球压迫针孔。

糖尿病性周围神经病变属于中医学的消渴、痹证、痿证范畴。作为糖尿病的并发症，奚道杰认为主要病机为脾肾阴虚、精亏血瘀、脉络瘀阻、肌肤失养。基于这一特点，治疗上应标本兼顾，以补益脾肾、益气活血、通经活络为治则，选取胸8夹脊穴、关元俞、关元、三阴交、曲池、上星等穴，以健脾益肾固其本，调气活血治其标，诸穴相合，标本兼治。

现代医学对本病病因的论述虽未明析，但一般认为主要与患者的微血管障碍和代谢障碍有关。注射药物采用小剂量的硝酸土的宁，对脊神经有高度选择的兴奋作用，并通过脊髓兴奋性的提高以增强骨骼，提高内脏平滑肌的紧张度，同时对胰岛素分泌的调节也有促进作用。

赵某，男，46岁，工人，1997年10月20日初诊。主诉：四肢麻木，夜间为甚，近二日加重、伴神疲乏力、腰膝酸软、口渴咽干，曾服达美康、消渴丸等药物治疗，血糖一般控制在8.0~9.0mmol/L之间，症状未见明显减轻。查：四肢末梢痛觉减退，位置觉差，跟腱反射消失，肱二、肱三头肌腱反射明显减弱。实验室检查：空腹血糖8mmol/L，甘油三酯42mmol/L，胆固醇8.1mmol/L，尿素氮12.12mmol/L。诊断：糖尿病性周围神经病变。经穴位注射治疗2个疗程，四肢麻木刺痛、神倦乏力等症状明显改善，上肢腱反射较前增强，继续治疗2个疗程，自觉症状基本消失，上肢腱反射恢复正常，跟腱反射出现但稍弱，四肢末梢痛觉、位置觉均有明显提高。查：血糖：7.8mmol/L，甘油三酯2.8mmol/L，胆固醇6.7mmol/L。为了巩固疗效，又继续针刺1个疗程，半年后随访未复发。

参 考 文 献

- [1] 李佩芳, 曹奕, 王二争. 刺络放血对 2 型糖尿病周围神经病变和血液流变学的影响. 针灸临床杂志, 2004, 20 (12): 38 ~ 40
- [2] 宋广军, 李红霞. 电针、耳穴贴压并用治疗糖尿病皮肤瘙痒症 20 例. 针灸临床杂志, 2007, 23 (7): 35
- [3] 任昌伟, 田玉生. 黄芪桂枝五物汤配合穴位注射治疗糖尿病周围神经病变 52 例. 中医研究, 2005, 18 (3): 38 ~ 39
- [4] 胥林波, 龙绍疆, 陈晓莉. 络脉扣刺治疗糖尿病周围神经病变的疗效观察. 现代中西医结合杂志, 2003, 12 (6): 586 ~ 587
- [5] 代国平, 王冬梅, 马留德. 糖尿病并周围神经炎针药并治 56 例. 河南中医, 1998, 18 (4): 232 ~ 233
- [6] 张玉莲, 张坤, 赵淑华. 头针加簇针治疗糖尿病周围神经病变的临床研究. 河南中医学院学报, 2003, 18 (5): 39 ~ 40
- [7] 陈天韵. 头针配合穴位注射治疗糖尿病肢体麻木. 中国针灸, 2001, 21 (4): 207 ~ 208
- [8] 蔡德锋. 穴位注射治疗糖尿病性末梢神经炎. 针灸临床杂志, 2000, 16 (11): 18 ~ 20
- [9] 王前琼. 针刺、穴位注射、药灸治疗糖尿病神经病变. 四川中医, 2003, 21 (12): 87 ~ 88
- [10] 张少云, 宋一惠, 李博一. 针药结合治疗 2 型糖尿病末梢神经病变 60 例临床观察. 云南中医中药杂志, 2006, 27 (2): 33 ~ 35
- [11] 奚道杰. 穴位注射治疗糖尿病性周围神经病变 30 例. 中医外治杂志, 2000, 9 (4): 19

【甲状腺功能亢进及其并发症】

甲状腺功能亢进症是以情绪不稳、倦怠乏力、纳差腹胀、腰酸背痛、多尿、夜尿、口渴等为主要表现的临床疑难病。中医虽无此病名，但历代典籍中对其中的症状有很多类似描述，多属于“郁证”、“腰痛”、“消渴”等病证。

中医认为本病病因或由先天不足、肾阴亏损或肾阳虚弱，或由情志不畅、肝郁化热、横逆犯胃，或由气滞不顺、血滞于内，或由湿热内盛、下注阴分。本病辨证首分虚实，虚者多见肾虚，实证者多见于血瘀、血热、湿热之证。治疗以攻邪为主，血瘀者活血化瘀，血热者清热凉血，湿热者清热化湿，而对其虚者则可补益肾阴或肾阳。总之，本病病证复杂，临床辨证应斟酌病机，量虚实之轻重给药。

本篇共收录了 11 位针灸医家的临床治验，有的取肝俞、心俞埋线；有的采用挑筋割脂埋线；有的以针刺为主，配神经节阻滞；有的以药线点灸为主；有的以疏肝理气解郁为大法，针药并用等，均取得了一定的临床疗效。

一、肝俞 - 心俞 埋线治疗

甲状腺功能亢进症是一种自身免疫性疾病，因其具有服药周期长、易复发的特点，病情常缠绵难愈。曹金梅采用背俞穴埋线配合口服小

剂量他巴唑治疗，疗效显著。

取穴：双侧肝俞、心俞。

操作：常规消毒后局麻，用 12 号腰椎穿刺针穿入羊肠线 1.5 ~ 2cm，刺入穴位得气后埋入羊肠线，以无菌干棉球按压片刻，外敷创可贴，2 周 1 次，4 次后，间隔 2 个月再埋线 4 次。同时口服甲硫咪唑片，每次 1 片，每天 2 次，45 天后减为每日 1 片，连续服用 12 ~ 18 个月。

采用埋线疗法配合化学药物治疗甲状腺功能亢进，在减少西药服药量的同时，也减轻了毒性及不良反应，因此认为该疗法是一种安全有效的治疗甲状腺功能亢进的辅助方法。

郑某，女，39 岁，干部。2001 年 4 月 24 日以胸闷、心慌 2 月余为主诉来诊。患者母亲有甲状腺功能亢进病史，5 年前因心脏病死亡。现患者因为过度劳累引起胸闷心慌，活动气短，全身乏力，病情逐渐加重，伴多食消瘦，烦躁多汗，手心潮湿，多动手颤。查：心率 128 次/min，心律不齐，血压 140/70mmHg，体重 45kg，甲状腺不肿大，甲状腺区无杂音，无突眼，手抖。心电图示：窦性心动过速，室性早搏。甲状腺功能测定：FT₃23.26pmol/L，FT₄76.21 pmol/L，TSH0.08mmol/L。诊断：甲状腺功能亢进。给予背部双侧心俞、肝俞埋线，2 周 1 次，4 次后间隔 2 个月再埋线 4 次。同时配合口服他巴唑 1 片，日 2 次；心得安 1 片，日 2 次。治疗 3 天后患者胸闷心慌明显减轻，睡眠好，情绪稳定。治疗 45 天后病情基本控制，心慌、气短消失，体重增加，全身有力，饮食正常，无烦躁多汗及多动手颤。检查：心率 84 次/min，律齐，血压 110/70mmHg，体重 48kg。心电图示：窦性心律。甲状腺功能测定：FT₃4.02pmol/L，FT₄12.46pmol/L，TSH1.21mmol/L。心电图及甲状腺功能均恢复正常。医嘱甲硫咪唑减为每日晨服 1 片，停药普萘洛尔。维持量巩固治疗至 2002 年 4 月 24 日停药，随访观察至今 1 年余未见复发。

二、挑筋割脂埋线 化瘀散结

黄柳和运用挑筋割脂埋线疗法治疗甲状腺功能亢进症，效果较好。

取穴：主穴：颈部肿块阿是、喉 2 ~ 4、喉 6 ~ 7（甲状软骨结节

上的凹陷正中为起点，至胸骨柄上切迹正中上1寸处为止点，共分三等分，每一等分点为1点，连同起止点共4点，从上而下命名为喉1、喉2、喉3、喉4。再在喉1旁开至人迎穴前为喉5，再向下与喉2、喉3、喉4相平各定1点，为喉6、喉7、喉8左右相同)、肝俞、鸠尾。配穴：心悸者加膻中、巨阙；消谷善饥者加中脘；突眼者加眼睑挑点（上睑1在上睑中部正对瞳孔，上睑2和上睑3分别是上睑1内、外侧约3分处，上睑4在上睑1与上睑2上方，适与这二点构成等边三角形，上睑5在上睑1与上睑3的上方，亦适与此二点构成等边三角形。下睑1~5挑点是上睑1~5挑点在下睑的水平对称点）。

操作：挑筋法：患者仰卧，穴位常规消毒，以2%普鲁卡因在穴位皮下注射皮丘后，医者用已消毒之大号缝衣针，右手持针，横刺表皮，翘高针尖，提高针体做左右摇摆动作，把挑起的表皮拉断，再挑出一些稍具黏性的皮下纤维，直至把针孔周围的纤维挑完为止。挑毕，创口涂上红汞，外贴无菌小纱垫。割脂埋线法：患者取仰卧位（选鸠尾）或俯卧位（选肝俞），穴位常规消毒局麻铺巾后，医者用手术刀于矢状方向切开穴位皮肤约1cm，以弯止血钳分离刀口周围皮下组织，范围2~3cm，再以止血钳钳起穴位下皮下脂肪少许，切除，然后将准备好的无菌2号羊肠线4~5cm捆扎成小结放入穴位皮下，刀口缝合1针，酒精消毒刀口，外贴无菌纱块，5天后拆线。

每次挑筋1~2个主穴或配穴，开始每日挑1次，待常规点挑完后，可隔3~5天挑1次，10次为1个疗程，第一及第二疗程结束时，即分别于鸠尾及肝俞做割脂埋线疗法1次。1个疗程未愈者，休息10天再行下1个疗程。

针挑疗法是祖国医学宝贵遗产之一。挑筋疗法为其较有代表性的一种，实践证明，挑筋疗法可通过对筋癭局部病灶或相应经穴之皮部产生良性、持久的刺激，引动脏腑气机而起到疏肝理气，平肝潜阳，化瘀散结等作用，故对筋癭有良好的治疗效果。

鸠尾、肝俞二穴上割脂埋线，能对穴位之皮部产生良性刺激，引动脏腑气机而起上述作用。因所割小脂团的修复及羊肠线的溶解、吸收有一段过程，其作用持续时间可长达3~4周之久。故于前2个

挑筋疗程结束时，分别在肝俞、鸠尾进行割脂埋线，能延续作用时间，提高疗效。

三、穴位埋线 标本兼治

甲状腺功能亢进简称甲亢，属中医瘰病的气瘰范畴。本病好发于青年人，女性多于男性。张德基采取穴位埋线结合服用小剂量他巴唑的治疗方法治疗，效果显著。

取穴：气瘰（人迎与水突连线的中点）、间使、手三里、足三里、三阴交、肾俞、肝俞、太溪。气瘰、间使、三阴交每次均取双侧，其他穴位可取单侧。

操作：选准穴位后用紫药水做好标记，常规皮肤消毒。在标记处用利多卡因约0.5~1.0ml做皮下局部麻醉，使之成1cm左右的皮丘，取消毒备用的1号羊肠线约1~1.5cm装入埋线针，右手持埋线针，左手绷紧穴位皮丘处。针尖以45°左右斜刺入内，当埋线针进入皮下需要深度，羊肠线已完全埋入穴内时，把针退出，见无线头留在皮肤外后，用酒精棉球压迫针孔片刻，再敷上创可贴保护创口2~3天即可。每次埋线前都应检查血清 T_3 、 T_4 的情况变化。1个月后再进行第二次埋线。

药物：他巴唑每天10mg，早晚各5mg，连服2~5个月。第三个月开始，根据 T_3 、 T_4 检查情况，已接近正常值可以停药。已经按常规量（30mg/天）服用他巴唑较长时间的患者，应在埋线半个月后逐步减少服用药量。

甲状腺功能亢进属于中医的气瘰范畴，本病的发生与精神因素有关。主要是由于情志不舒，肝气郁滞，肝郁脾虚，水湿不化，聚湿生痰，痰气交结所致。取气瘰、肝俞，旨在疏导局部经气，并疏肝理气，消瘰散结，治其脖粗眼突，肝郁易怒；取手三里、足三里、三阴交，旨在健脾胃、化痰湿、扶正祛邪、协调阴阳、标本兼治，治其消谷善饥之痰饮；取间使、肾俞、太溪，旨在补肾清心、畅通气机，提高机体免疫功能，治其怕热、心悸等全身症状。羊肠线是一种异体蛋白，埋入穴内，可长期激发经气，疏通经络，调整阴阳，扶正祛邪，提高机体免疫能力，强身健体，从而有效地改善甲状腺功能的亢进状态。他巴唑是治疗甲亢的有效药物，长期多量服用可

引起副作用，而少量的药物与穴位刺激相结合，能激发增效机制，促使气瘕尽快痊愈。

胡某，男，农民，32岁，2000年1月初诊。病史：自1998年底开始手颤、心慌，1999年5月出现眼突，食欲增多，失眠烦躁，体重减轻，经医院检查，确诊为甲状腺功能亢进，曾服用他巴唑、心得安3个多月，症状未见减轻，反见脖子增粗。按照上法给予埋线治疗，并从第一次埋线15天后逐渐减少药物用量。埋线2次后症状明显减轻，体重稍增加，他巴唑用量定为每日口服10mg，早晚各服5mg，埋线3次后症状完全消失，体重增加7kg。属于正常值，为巩固疗效又埋线1次，随访1年多未见复发。

四、针刺为主 配神经节阻滞

甲状腺功能亢进症，是一种常见的内分泌旺盛性疾病。方针采用针刺浮白穴合星状神经节阻滞治疗甲状腺功能亢进症，疗效较佳。

取穴：浮白穴（双），位于耳后乳突的后上方，天冲与完骨的弧形连线的中三分之一与上三分之一折点处。

操作：患者正坐位，穴位皮肤常规消毒后，取1.5寸毫针，往天冲穴方向平刺0.5~1寸，行泻法，得气后，留针30min，每隔5min行针1次。每日1次，10次为1个疗程。

星状神经节阻滞：患者取仰卧位，头向所拟阻滞的对侧转45°角。采用侧入穿刺法，在胸锁乳突肌的后缘，C₆椎体横突投影点进针，直刺到C₆横突骨质后，再将针退至皮下，针体倒向耳后，平行于枕后水平，斜向下向内向星状神经节所在处进针0.5~1寸，注入1%利多卡因10ml加地塞米松注射液2.5mg（分次缓慢地注药，每次注药1~2ml，观察1~2min无异常后，再注药1~2ml，隔日1次，每次阻滞一侧星状神经节，左右交替，5次为1个疗程。

甲状腺功能亢进是以甲状腺肿大和突眼症为主要特征的一种疾病，属中医学“瘕气”、“郁结”范畴。多为情志不舒，肝气郁结所致。浮白穴属足少阳胆经，也是胆经与足太阳膀胱经的会穴。它通过经络的循行路线，影响到眼区及颈部，从而消除颈肿、目突等症状。不仅如此，在胆经的耳后诸穴中，浮白穴另有一个特点，据有人研究“患热性病，高血压或相反之低血压时，此穴常有压痛，

或有充血性不快感或冷感”。这也说明了针泻该穴时，特别具有清热散结、凉血镇静之功效。对于颈项肿大的瘰气证，自可起到疏通肝胆，调和气血而消肿的作用。

现代医学认为，甲亢系内分泌代谢紊乱所致。与精神因素和自身免疫有关。星状神经节阻滞能阻断交感神经节后纤维释放的去甲肾上腺素，改善局部机体组织的血液循环，增加丘脑下部血运，同时使交感神经过度兴奋引起的一系列症状很快改善，降低患者紧张情绪，使机体的内分泌功能和免疫功能保持正常，从而达到抑制甲状腺功能亢进之目的。

患者，女，31岁，2004年4月5日就诊。情绪焦躁易怒，心悸多汗1年余。患者自2003年2月始怕热多汗，心悸气促，多食易饥，甲状腺肿大。经本市某医院诊断为甲状腺功能亢进。予“他巴唑”治疗6个月，症状改善，自行停药。近半年来，症状加剧，结喉两旁腺体肿大日甚，胁肋时有胀痛。就诊时患者心情焦虑，形体消瘦，面色潮红，眼球突出。舌红苔薄，脉弦数。实验室检查：血清总 T_3 及 T_4 数值明显高于正常，血清TSH偏低。依上述方法治疗1个疗程，诸症基本消除，复查 T_3 、 T_4 、TSH均恢复正常。继续巩固1个疗程，病告痊愈。随访1年余未见复发。

五、辨证分型 针药并用

李晔针药并用治疗甲状腺功能亢进，疗效较佳。

针刺：气瘕（相当于水突穴位置，视甲状腺肿大程度稍有出入）、内关、间使、足三里、丰隆、三阴交。气瘕用斜刺，采用拇指后退为主的捻转泻法；内关、间使用泻法；足三里、丰隆、三阴交用补法。留针30min，隔日针刺1次。

中药：

肝气郁积：主证为咽梗，心烦易怒，脉细弦，舌淡红苔薄或薄腻。治宜疏肝理气，化痰消瘕，稍佐清火。方用柴胡6g，黄芩9g，半夏6g，党参15g，苏梗6g，川朴9g，莱菔子9g，陈皮6g，郁金9g，苦丁茶6g，生甘草3g。

肝火内动：主证为咽梗，心悸失眠，眼珠突出，四肢颤抖，易饥善食，形体消瘦，脉弦数或细数，舌红苔黄。治宜平肝熄风，清

泻肝火，佐以和血养阴。方用珍珠母 60g，钩藤 9g，炒栀子 9g，黄芩 9g，夏枯草 12g，玉竹 15g，丹参 15g，赤芍 9g，夜交藤 5g，碧玉散 24g。

肝肾阴亏，气阴两虚：除上述症状外，尚见腰膝酸楚，形神倦怠，头晕心悸，视物昏花，甚至低热不退，脉虚数，舌红苔薄或光剥。治宜双补气阴，滋肝补肾。方用太子参 15g，麦冬 15g，五味子 9g，枸杞子 15g，黄芪 15g，首乌 15g，山药 15g，珍珠母 30g，玉竹 15g，橐豆 24g，白薇 9g，赤芍 9g，甘草 5g。

上述分型处方，在临床具体运用时须灵活加减，如颈肿较大者加鳖甲、浙贝或昆布、海藻、半夏；突眼加大贝母、胆南星、车前子、泽泻等。

甲状腺功能亢进症是一种自身免疫性疾病，临床采用抗甲状腺药治疗，虽见效快，但停药后复发率高。李晔针刺选内关、间使以清心火，熄内热；足三里、丰隆补中益脾祛痰；三阴交滋肾养阴，济水涵木；配以颈部气瘰穴以化痰散结消瘰。选方用药初期以疏肝为主，兼顾双补气阴，佐清余热。临床加减海藻、昆布能暂时改善和控制症状，但不宜久用，因有复发之虞。针药并用达到调谐机体脏腑功能，疏导痰瘀气滞之瘰，平复阴阳气血虚实的目的，并起到相辅相成，提高疗效的作用。

六、药线点灸 配中药施治

甲状腺功能亢进症系甲状腺分泌过旺所引起的内分泌—代谢疾病，也是大脑皮层—内脏疾病之一。中医归属于瘰瘤、心悸、内消等范畴。其特征为甲状腺肿大，目突，基础代谢增加和自主神经系统失常。李洪采用药线点灸穴位配合中草药辨证治疗本病，取效满意。

取穴：廉泉、曲池、内关、足三里、天柱、攒竹、鱼腰、水突、膻中、合谷、大椎。行瘀散结取腺体穴；突眼加丝竹空、睛明、风池、四枢；心悸配神门；易饥、消瘦、多汗加三阴交。每日施灸 1 次，15 天为 1 个疗程。

操作：采用广西中医学院壮医药推广中心精制的壮医药线，成人用Ⅱ号药线，儿童用Ⅲ号药线。医者右手食指和拇指持线端，并

露出线头 1~2cm, 将此线头在酒精灯上点燃, 轻轻甩灭火焰, 使之形成圆珠状炭火, 随即此火星对准穴位, 顺应腕和拇指的屈曲动作, 拇指指腹稳重而敏捷地将有火星的线头直接点按于穴位上, 一按火灭为 1 壮, 一般每个穴位点灸 1 壮即可。

中药: 消瘿汤。药用: 龙胆草 15g, 栀子 8g, 柴胡、玄参各 10g, 龙骨 8g, 牡蛎 10g, 僵蚕 6g, 葛根 15g, 海藻 10g, 昆布 8g。肝阴虚明显, 眩晕、目糊、形瘦加枸杞 9g, 炙首乌 12g; 心虚较甚加熟枣仁 15g, 五味子 45g, 煅龙骨 21g; 肝风内动, 手指震颤加生石决明 31g, 钩藤 15g (后下); 日久瘀血壅结, 肿块有结节, 布有青筋酌加桃仁 9g, 红花 4.5g 或三棱、莪术各 9g, 每日服 3 次, 1 个月为 1 个疗程。

本病多由长期忿郁恼怒使肝阳偏亢, 肝旺克土, 或忧思、饮食及水土失宜等因素, 损伤脾胃气机, 脾失健运, 不能运化水湿, 聚而生痰或气血运行不畅, 血脉瘀阻, 导致痰气瘀结颈前发为瘿病。

甲状腺功能亢进是慢性复发性内分泌系统疾病, 病程较长, 症状反复, 故在临床治疗中, 应根据病情发展的不同阶段和证候表现正确地施予点灸治疗和辨证施治。壮医药线点灸之所以能够治病, 就是根据人体某些穴位经络能自动调节, 产生抵抗力, 减少疾病的侵袭而产生的。它能够强烈刺激人体穴位, 通过经络传导, 调整气血归于平衡, 使人体各部恢复正常的功能。

七、壮医挑刺 调气解毒补虚

甲状腺功能亢进症简称甲亢。临床分为原发性甲亢、继发性甲亢和高功能腺瘤三类。其中原发性甲亢又名毒性弥漫性甲状腺肿, 在临床中最为常见。乐小燕采用壮医针挑术加雀啄灸治疗原发性甲亢, 取得良好效果。

针具: 采用自制的长 12cm, 直径 0.4cm, 尖端锐利的不锈钢针挑针具。

针挑点的选择及定位: 选用背正中线及背侧线上针挑点。背正中线上针挑点在每一脊椎棘突下, 选取从平第 7 颈椎到平第 11 胸椎每一棘突下的针挑点共 12 个点; 背侧线上针挑点分别平背正中线上针挑点, 距背正中线旁开两横指, 选取从第二胸椎棘突下到第 11 胸

椎棘突下的针挑点，左右共 20 个。总共采用 32 个点。

针挑顺序：每次治疗选 3 个点针挑，按三角形顺序往下挑。如先挑第 7 颈椎棘突下针挑点，然后再分别挑左右背侧线上平第二胸椎棘突下的针挑点，3 个点呈一等腰三角形。

操作：穴位用碘酒、酒精常规消毒，用 2% 利多卡因 2ml 加 0.75% 布比卡因 0.5ml，用生理盐水稀释至 4ml 局部麻醉。局麻时注射针轻轻刺入穴位皮肤真皮，在真皮层注射至皮丘隆起如橘皮状，直径约 1.5cm 大小，然后开始针挑。

先用针尖将穴位中心点皮肤挑破 2mm，将针尖刺入缺口皮下，挑出白色皮下纤维，将纤维挑断并挑出。刚开始挑出的纤维较短，挑出后用无菌棉签拭去。逐渐可挑出较长的纤维，旋转针柄使之缠绕在针尖上，慢慢将其完全拉出、挑断。先反复挑刺针口局部，至针口皮下纤维彻底挑尽，再扩大挑刺范围。

将针沿皮下平行探入 0.5cm，用腕力逆时针方向往回挑，带出纤维，将纤维完全拉出，拉断。挑刺手法要轻柔，手腕回旋灵巧，不要伤及深层组织。重复以上动作直至局部皮下纤维挑空，然后按逆时针方向将针眼周围直径 1cm 范围内皮下纤维逐一挑空。挑刺完毕时以见到局部皮肤微微下陷为度。如果不按照此顺序挑刺，就会挑乱，纤维不能陆续挑出或挑不干净，从而影响疗效。

挑刺过程中可有 1~2 次渗血，血量大约 1~2ml，不需止血，用无菌棉球吸拭，待其自动停止后再继续挑。挑刺完毕，针口行雀啄灸 15min。针口用 2% 络合碘消毒，外贴创可贴保护针口。1 周治疗 2 次。

注意事项：治疗期间，忌食辛辣燥热及烟酒、海产品等，注意休息。针口 2 天内不用水洗，防止感染。每日更换创可贴直至针口愈合。一般针口完全愈合需 4~6 天。

壮医针挑疗法是流传于广西壮族自治区民间的一种古老治疗方法。它通过对不同穴位皮肤浅层的轻微损伤刺激来治疗疾病，是古代针灸皮部理论在民间疗法中的发挥运用。

甲状腺功能亢进以汗多怕热、易怒、多食易饥等症状为特点，壮医认为是毒邪亢盛；其症多食但反消瘦乏力，心悸气短，是毒邪致病。人体背部为阳气汇聚之处，针挑加雀啄灸可通龙路与火路，

泻其亢盛之阳气，调整阴阳；还可行气活血，调理脏腑，达到调气、解毒、补虚的目的。

患者，女，22岁。烦躁易怒，多汗怕热，多食消瘦半年余，加重1月余。伴心慌手抖，乏力。半年来体重减少5kg。未经治疗，近一个月来上症加重而来就诊。查：心率106次/min。双侧甲状腺Ⅱ°大，质软，未扪及结节，无震颤，未闻及血管杂音。双眼凝视，眼球稍突。B超示：右甲状腺2.7cm×1.9cm，左甲状腺2.6cm×1.9cm，甲状腺峡部厚1.0cm，轮廓清晰，内部回声均匀，血流丰富。诊断为：原发性甲亢。针挑2次后，汗出减少，燥热感明显减轻，情绪稳定，心率86次/min，体重增加0.5kg，甲状腺较原缩小。针挑8次后，汗出正常，不烦躁，手不抖，食量减少，体重继续增加2kg。继续巩固治疗，疗程结束，所有症状消失，体重共增加5kg，总体重恢复到发病前水平。随访3年无复发。

八、穴位埋线配中药 标本兼治

甲状腺功能亢进症简称甲亢，女性多于男性。近年来，该病的发病率呈上升趋势。黄洁选用穴位埋线配服甲亢宁汤治疗本病，疗效满意。

穴位埋线：取双侧足三里、三阴交、肝俞、肾俞、心俞、脾俞；每次选3个穴位，常规消毒、局麻（利多卡因）后，用12号腰椎穿刺针穿入1号羊肠约1~1.5cm，刺入穴位得气后埋入羊肠线，用酒精棉球压迫针孔片刻，再外敷创口贴2~3天即可。2周1次。

中药：口服甲亢宁汤，处方组成：太子参15g，麦冬10g，五味子6g，玄参15g，浙贝10g，生牡蛎10g，香附10g，夏枯草15g，丹参15g，炙甘草5g。由本院制剂室运用中药浓煎机煎成，每包约150ml的浓缩液，每日2包，分早晚两次服用；待症状控制后，减为每日1包，晨顿服，连续服用6~12个月。

甲状腺功能亢进症属祖国医学瘰气范畴。本病病位在咽喉，与肝、心、胃、肾关系密切。其病变机制多因七情怫郁而致阴阳失调，气血不和，肝郁化火，瘀热内遏而致阴虚火旺，灼津耗气，多为本虚标实之证。故黄洁采用益气养阴、柔肝理气、散结消瘰法治疗本病。穴位埋线取足三里、三阴交、脾俞等穴，旨在健脾胃，化痰湿，

扶正祛邪，协调阴阳，标本兼治。取肝俞、肾俞、心俞等穴，旨在清心火，涵肝木，济肾水，调整脏腑生理功能，平复阴阳气血之虚实。羊肠线是一种异体蛋白，埋入穴位，可长期激发经气，疏通经络，调整阴阳，扶正祛邪，提高机体免疫能力，强身健脾，从而有效地改善甲状腺功能的亢进状态。而甲亢宁方中太子参补正气，使阳升阴长，阴复阳平；麦冬、玄参、五味子养阴清热生津宁心；浙贝化痰散结；生牡蛎敛阴潜阳，止汗涩精，化痰软坚；夏枯草清肝散结；丹参、香附行气疏肝活血；炙甘草调和诸药。

九、远近配穴 针药并用

甲状腺功能亢进症简称甲亢，指甲状腺的高功能状态，其特征有甲状腺肿大、突眼症、基础代谢增加和自主神经系统的失常，是一种常见的内分泌疾病。刘公望对于该病多采用针药并治，在短时间内能起到明显效果。

针灸多采用远近配穴，近取以颈部穴位为主，如天容穴，同时甲状腺周围采用局部透皮浅刺法，以加强甲状腺局部血液循环，远端多采用肝胆经为主，如丘墟、阳陵泉。由于甲亢患者多心悸，故选神门以宁心安神；另可加阴陵泉、丰隆以化痰，并加用八脉交会穴列缺与照海，两者相配主治咽喉部疾患。病例2患者眼部症状明显，故随症选取眼周穴位。刘公望对于该类阴虚、气郁、痰结型甲亢患者，采用解郁、化痰、散结、滋阴为主施以中药治疗。方用小柴胡汤合桂枝加龙骨牡蛎汤加减，小柴胡汤和解少阳以解郁，同时针对甲亢患者往往出现心悸、失眠、汗出等精神神经症状，故常合桂枝加龙骨牡蛎汤以调和阴阳、重镇安神。病例1患者自觉周身烘热、按常理不应使用桂枝，但《本经》云：“桂枝可降逆气”，故桂枝汤临床常具镇静作用，“有是证用是方”，故针对其心悸等精神症状而加用桂枝。另选用麦门冬、天门冬、玄参、生地等以滋阴降火；橘核、佛手等理气解郁；气滞则血瘀，用丹参以活血化瘀；夏枯草、川贝母以软坚散结。病例2患者眼部症状比较明显，故加用潼白蒺藜、苍术。同时由于患者病久，急躁易怒，耳鸣如蝉，故选用旱莲草、女贞子、石决明、龙胆草、鳖甲、青蒿等以滋补肝肾之阴、祛肝胆之热。

病例1 患者，女，34岁，教师，2006年2月8日初诊。患者于2005年12月11日出现乏力、头晕、心悸、手颤、急躁易怒、多食等症，于某医院检查发现，游离甲状腺素（FT₄）：99.24pmol/L、游离三碘甲状腺原氨酸（FT₃）：30.8pmol/L、超敏甲状腺激素（sTSH）<0.01mmol/L、门冬氨酸氨基转移酶（AST）：53U/L，粒细胞：45.2%、中间细胞：16.8%；B超示：双叶甲状腺肿大；心电图示：窦性心动过速、偶发室性早搏。诊断为甲状腺功能亢进。因服西药症状控制不明显，遂来求诊，症见：消瘦、自觉周身烘热、畏热亦畏冷、恶心、心悸、汗出、手颤、急躁易怒、咳痰多、无突眼症。舌红苔薄白腻，脉沉细涩。心率：120次/min。舌红苔白腻，脉沉细涩。诊断为瘰病（甲状腺功能亢进），证属气阴两虚、气郁痰结型。拟解郁化痰、软坚散结之法针药并治。针灸治疗以远近配穴相结合，近取天容，甲状腺周围采用局部透皮浅刺法，远端以厥阴经、少阳经为主，下肢取太冲、丘墟、阳陵泉、照海；上肢取神门、列缺、外关、养老等穴。留针20min/次，隔日1次。方用小柴胡汤合桂枝加龙骨牡蛎汤加减，具体方药为柴胡、黄芪、炙甘草、白芍、川贝母、玄参、生地、夏枯草、猫爪草、天门冬、麦门冬、橘核、佛手各15g，半夏、桂枝、橘叶各10g，生龙骨、生牡蛎、丹参各30g。每天1剂。服药1周后，患者自觉汗出减少，心悸偶作，于前方随症加炙黄芪15g，鳖甲15g。继服1周后，症状大减，治疗3周后在医大总医院复查甲功，FT₄：27.96pmol/L，FT₃：9.28pmol/L，sTSH<0.01mmol/L。现继续服药，密切观察病情。

病例2 患者，女，49岁，实验员，2006年3月4日初诊。患者于2002年在某医院诊断为甲状腺功能亢进。遂来门诊请求中医治疗。现嗜睡乏力，双眼畏光，泪多，迎风流泪；眼突，双目有异物感，眼睑充血，脂肪沉着，急躁易怒，汗出，手颤，畏热，耳鸣如蝉，多食。心率：66次/min。舌淡红苔白腻，脉弦细。诊断为瘰病（甲状腺功能亢进），证属肝肾阴虚、气郁痰凝。拟用针药并治，针灸近取天容，甲状腺周围采用局部透皮浅刺法；眼周穴位，如睛明、瞳子髎、球后等穴，远取头临泣、光明、丘墟、足临泣、阳陵泉、三阴交等穴。留针20min/次，隔日1次。方用柴胡9g，黄芪15g，半夏9g，石斛30g，玄参15g，女贞子15g，青蒿9g，鳖甲15g，

煅龙骨、煅牡蛎各 15g, 川贝母 12g, 夏枯草 9g, 苍术 9g, 炙黄芪 15g, 石决明 30g, 白僵蚕 12g, 白芍 15g, 龙胆草 6g, 潼白蒺藜各 15g, 旱莲草 30g, 胆南星 6g, 山药 15g, 郁金 9g。每天 1 剂。治疗 2 个月后患者自感体力增加, 眼睛状况改变很多, 目干改善, 手颤消失, 饮食恢复正常。现继续服药观察。

十、疏肝理气解郁 针药并用

孙六合采用针药并用治疗甲亢, 取得了较好疗效。

(1) 详辨病因病机

甲状腺功能亢进属中医瘰瘤、瘰气范畴, 其病因与情志有密切联系。所思不遂, 肝失疏泄则情志抑郁, 气郁日久, 气滞及血, 气血壅滞颈前则颈项肿大; 肝气不舒, 郁久化火, 则消烁脏腑阴精。心阴被耗, 心失所养则心悸失眠; 肝阴受耗, 阴不制阳, 则肝阳上亢, 见烦躁易怒; 肝胃不和, 郁而化火, 胃热偏盛, 则消谷善饥; 肝失疏泄, 脾失运化, 不能化生精微, 加之虚火消灼体内阴液, 则肌肉失其所养而消瘦; 五脏皆开窍于目, 五脏阴亏, 虚火上迫目系, 则眼球突出。总之, 甲状腺功能亢进为情志不舒, 肝气郁结所致。病初在肝, 久则延及心、肾、脾、肺而见五脏病变。正如沈金鳌所云: “瘰之为病其症皆隶属五脏, 其源皆由肝火”。

(2) 审证求因 分型辨治 针药并用

对本病的治疗, 应在疏肝理气解郁同时, 注意祛瘀散结, 滋阴清热。根据临床经验, 孙师认为本病多见以下两种类型:

气滞血瘀型: 见精神抑郁, 性情急躁, 胸闷胁痛, 多食善饥而消瘦, 口干, 妇女月经不调, 结喉两旁腺体多肿大, 舌质紫黯, 或有瘀斑, 瘀点, 脉弦或涩。治以疏肝理气, 祛瘀散结。中药方用逍遥散合海藻玉壶汤化裁。针灸取穴: 支沟、膻中、阳陵泉、太冲、血海、章门, 局部配以天突、扶突、水突。

某女, 29 岁, 幼儿教师。自诉: 性情急躁, 多食善饥而消瘦, 身困乏力已 2 年。近半年来症状加剧, 结喉两旁腺体肿大日甚, 肋肋时有胀痛, 月经不调, 且有血块, 婚后 3 年不孕, 曾服西药未效 (具体不详)。就诊时患者心情焦虑, 形体消瘦, 结喉两旁明显肿大, 质软, 舌质紫黯, 有瘀斑, 脉弦涩。实验室检查: FT_3 、 FT_4 明显高

于正常，TSH 偏低。辨证为气滞血瘀型。治以疏肝理气、祛瘀散结。针灸取穴同上，针用泻法，每日1次，7次为1个疗程。药用：柴胡、当归、赤芍、云苓、白术、海藻、昆布、半夏、青陈皮、川芎、浙贝、连翘、三棱、莪术等。针药并用，并嘱病人调畅情志。3个月后，诸症基本消除，复查 FT_3 、 FT_4 、TSH恢复正常，继续巩固1个疗程，病告痊愈。随访多年未见复发，现已育男婴，2岁，身健智灵。

支沟为三焦经经穴，可疏调三焦之经气；膻中为气之会穴，针之可宽胸利膈，理气化痰；阳陵泉为胆经合穴，能疏通肝胆，调理气血；太冲为肝经原穴，可疏肝理气，活血通经；血海为活血化瘀要穴；章门为脏之会穴，可软坚散结；天突为任脉经穴，善理气化痰；扶突为手阳明大肠经穴；水突为足阳明胃经穴，阳明乃多气多血之经，故二穴可理气活血；天突、扶突、水突三穴合用能软坚散结，消癭化积，直达病所。

阴虚火旺型：症见性情暴躁，胸闷心悸，失眠多梦，消谷善饥，形体消瘦，两手颤动，面色潮红，五心烦热，口干少津，眼球突出，结喉两旁腺体肿大不明显，舌红，或有裂纹，少苔或无苔，脉多弦数。治以滋阴清热，疏肝理气。中药方用一贯煎合逍遥散、栀子豉汤化裁。针灸取穴：复溜、照海、支沟、膻中、阳陵泉、太冲，局部配以天突、扶突、水突。

某女，50岁。自诉：情绪焦躁易怒，心悸多汗1年。近几月来症状加剧，食欲亢进，身体消瘦，两眼干涩，口干少津，曾服龙胆泻肝汤等未效。就诊时患者面色潮红，眼球突出，结喉两旁未见肿大，小便短赤，大便干结，舌红乏津，苔薄，脉弦数。经某医院检查确诊为甲状腺功能亢进。辨证为阴虚火旺，治以疏肝理气，滋阴降火。针灸取穴同上，其中复溜、照海用补法；支沟、膻中、阳陵泉、太冲用泻法；天突、扶突、水突平补平泻。每日1次，7次为1个疗程。药用：沙参、生地、元胡、川楝子、枸杞、当归、麦冬、栀子、淡豆豉、柴胡、赤芍、云苓、白术、甘草等。针药并用，并嘱病人调畅情志。2个月后，诸症基本解除，继续巩固2个疗程直至痊愈，随访多年未见复发。

复溜为肾经经穴，善补肾滋阴；照海为八脉交会穴，能滋补真

阴；配以上述诸穴而使病愈。

(3) 中西互参 博古出新 继承发扬

中医古代文献对瘰病病因病机的认识，认为与地理环境及七情内伤有关，由气郁、痰凝到血瘀，以气、痰、瘀壅结于颈前为基本病理，多属实证。如隋·巢元方《诸病源候论·瘰候》所云：“瘰者，由忧恚气结所生”。宋·严用和《济生方·瘰瘤论治》中云：“调摄失宜，气凝血滞，为瘰为瘤”。明·陈实功《外科正宗·瘰病论》云：“夫人生瘰瘤之症，非阴阳正气结肿，乃五脏瘀血、浊气、痰滞而成”。目前认为甲状腺功能亢进多属器官特异性的自身免疫性疾病，并和遗传、精神刺激等因素有密切的关系。该病的临床表现几乎可累及全身各个系统，一般以高代谢引起心血管，神经和消化系统病变的表现较为突出。多数病人甲状腺呈弥漫性肿大，血清中 FT_3 、 FT_4 增高，TSH降低。西医治疗本病主要采用抗甲状腺药物，放射性碘及手术治疗。抗甲状腺药物是在不同的环节抑制甲状腺激素的合成和释放，虽然对控制病情有较好的疗效，但用药时间较长，不良反应较大，而且停药后容易复发。放射性碘和手术治疗虽然复发率较低，但又容易造成甲状腺功能减退，使病情更为复杂。

孙师在学术上倡导要精究经典，博及医源，极为重视经络理论指导临床辨证施治的研究，临证强调辨证审因，中西互参，注重针药并用，即所谓“汤药攻其内，针灸攻其外”，充分体现理法方穴的针灸治疗特色，辨证清，治则明，注重经络辨证，体现《灵枢·九针十二原》指示：“为刺之要，气至而有效”，临证时总是根据经脉分布部位和所联系脏腑生理病理特点，详细分析各种临床表现，确定病在何经、何脏、何腑而后予以循经治疗。因甲状腺位于颈前，喉结两侧，足厥阴经循喉咙入颊颞，连目系；足少阴经沿喉咙上舌根；任脉达喉咙上颊部，经面部入双目；颈前还是手足阳明经的分野，因此在治疗甲状腺疾病时，根据其临床表现选取相应经脉的穴位为主穴，在处方选穴时根据疾病的病因病机特点，以五腧穴、八会穴、八脉交会穴相结合以及局部和远端穴位相结合为主，在注重调理脏腑功能的同时，注意调理经络气血，以求达到阴阳调、经络通、气血和、痰瘀消之目的。

孙老认为，针刺治疗过程是医患双方共同参与的施治过程，因

此, 仅凭一方的努力是难以取得满意疗效的。正如《素问·汤液醪醴论篇》所云: “病为工, 工为标, 标本不得, 邪气不服”。因甲亢症的发生与情志因素密切相关, 故做好病人的思想工作, 调理其精神情绪, 排除与疾病发生有关的因素, 使其树立战胜疾病的信心, 对于取得疗效是非常重要的。

十一、针药并施 消瘦散结

慢性甲状腺功能亢进肌病是内分泌系统常见病, 多发于中年人, 临床表现除主要甲亢高代谢体征外并发肌炎, 本病最常见为累及肩胛带肌, 以致影响肩关节的活动, 肿胀疼痛等, 痛点多在肩胛冈肩峰、斜方肌、冈下肌, 常误诊为肩周炎, 赵立明采用针药结合治疗取得满意疗效。

穴位注射: 当归注射液穴位注射, 取穴人迎, $C_3 \sim C_5$ 、曲池、肩井、天宗、肩贞、足三里, 随证加减, 眼球突出加上天柱, 风池; 手抖加大陵、少海; 多食易饥加中脘、梁门; 失眠多梦加神门、三阴交; 心肝阴虚加心俞、肝俞; 肝火胃热加合谷、阳陵泉, 每次取 2~4 穴, 每穴注射 0.5~1.0ml, 隔 2 天 1 次。

中药: 以疏肝理气, 软坚散结为主, 基本方: 柴胡 15g, 枳壳 10g, 陈皮 10g, 夏枯草 12g, 浙贝 9g, 昆布 20g, 海藻 20g, 牡蛎 25g (先下), 随证加减, 肩背肌肉痛加当归 12g, 莪术 12g, 天花粉 10g, 三七粉 10g (包), 活血行气, 通络止痛, 汗多加生龙骨 20g (先煎), 五味子 10g, 浮小麦 13g; 心烦失眠加酸枣仁 9g, 丹皮 10g; 病久加黄芪 30g, 党参 20g; 眼球突出, 手抖加钩藤 10g, 白蒺藜 9g, 白芍 10g; 腹泻加怀山药 15g, 薏苡仁 15g, 每日 1 剂, 水煎分 3 次服。

慢性甲状腺功能亢进肌病是由于甲状腺激素分泌过多, 作用于肌细胞线粒体, 直接影响能量代谢, 致使肌肉发生肿胀, 变性萎缩引起肌病。本病多见累及近端肌群的肩背肌群疼痛, 外展、外旋活动受限, 活动后加重, 体重减轻。中医认为“正气存内, 邪不可干, 邪之所凑, 其气必虚”, 现代医学认为, 甲状腺功能亢进是一种自身免疫性疾病, 甲状腺功的亢进肌病的发生与人体的抵抗力下降有关, 中药专方随证加减治疗, 以疏肝理气, 消瘦散结, 随证加减治疗,

中药夏枯草、海藻、昆布、陈皮、木香、柴胡、当归、天花粉、黄芪、党参、五味子、浮小麦、酸枣仁、丹皮、白芍、怀山药、薏苡仁等具有提高免疫功能的调节作用，同时又具有调节细胞免疫功能与体液免疫功能的双相调节作用，还具有抑制能量代谢、抑制甲状腺素的分泌作用。当归注射液穴位注射大椎、肩井、天宗、足三里等穴，具有增加抗体，提高细胞免疫作用，增强身体抵抗力。当归穴位注射吸收好，改善局部血液循环，能迅速消除局部的炎症水肿，以缓解疼痛。

唐某某，女，36岁，工人，2003年1月13日初诊。主诉：患甲状腺功能亢进半年，在抗甲状腺药物治疗中逐渐出现左肩部疼痛，无外伤史，左臂活动时加重，夜间尤重，曾按肩周炎治疗，症状减轻，但夜间疼痛明显加重。查体：甲状腺肿大Ⅱ°弥漫型，突眼Ⅰ°（双），消瘦，心率96次/min，心律齐，左肩峰肿胀，压痛，左臂上举120°时局部疼痛，后伸有疼痛感，血压130/60mmHg，基础代谢率+55%，血清 FT_3 5.1pmol/L， FT_4 2.9pmol/L。TSH0.6mmol/L，诊断甲状腺功能亢进肌病。治疗用基本方随证加当归12g，莪术12g，天花粉10g，三七粉10g（包）水煎服，配当归注射液取曲池、天宗、肩贞、足三里，每次取2~3个穴位交替注射，每穴0.5~1.0ml，隔2日1次。治疗6~9天，穴位注射18次，甲状腺功能亢进肌病症状与体征消失，基础代谢率正常，血清 FT_3 ， FT_4 值恢复正常。至今上班工作1年半未复发。

参考文献

- [1] 曹金梅，门艳丽，范军铭．肝俞、心俞埋线为主治疗甲亢262例临床观察．中国针灸，2003，23（9）：515~517
- [2] 黄柳和．挑筋割脂埋线疗法治疗甲亢．中国针灸，1995，（1）：28
- [3] 张德基，张俊，张莺．穴位埋线结合小剂量药物治疗甲亢35例．中国针灸，2002，22（10）：674
- [4] 方针．针刺浮白穴合星状神经节阻滞治疗甲亢症33例．上海针灸杂志，2006，25（7）：34
- [5] 李晔．针药并用治疗甲状腺功能亢进症60例．上海针灸杂志，2007，26

(4): 40

- [6] 李洪, 朱红梅. 壮医药线点灸配合消瘿汤治疗甲亢 50 例疗效观察. 辽宁中医杂志, 2000, 27 (7): 317 ~ 318
- [7] 乐小燕, 陈日兰, 汤献忠, 等. 壮医针挑疗法治疗原发性甲状腺功能亢进症 66 例. 广西中医药, 2004, 27 (1): 29 ~ 30
- [8] 黄洁, 常小荣, 王超, 等. 穴位埋线配服甲亢宁汤治疗甲状腺功能亢进症 36 例. 湖南中医杂志, 2004, 20 (2): 28 ~ 29
- [9] 刘公望. 甲状腺功能亢进的中医辨证施治. 天津中医药, 2006, 23 (3): 255 ~ 257
- [10] 孙国胜, 张京峰. 孙六合教授针药并用治疗甲亢的经验. 中医药学刊, 2005, 23 (11): 1948 ~ 1949
- [11] 赵立明. 针药结合治疗慢性甲亢肌病. 针灸临床杂志, 2005, 21 (7): 30 ~ 31

【甲状腺肿大】

甲状腺肿大是我国常见病、多发病之一。它以甲状腺肿大，颈前出现包块为主要症状。祖国医学认为本病属瘰病、气瘰范畴。远在晋代《肘后方》一书中就记载有用海藻、昆布治瘰的方法，认为其产生与气滞痰凝、血瘀有关，而与肝经气郁尤为密切。《内经》说：“肝足厥之脉，起于大趾丛毛之际，上循足跗上廉，……过阴器，抵少腹，……至胁肋，循喉咙之后……。”说明了甲状腺为肝经循行之部位。《诸病源候论》说：“瘰者，由忧恚气郁所生。”说明情志刺激与本病有关。

本病多由于正气不足，外邪入侵，结聚于经络、脏腑，导致气滞、血瘀、痰凝等病理变化，形成瘰瘤。其本在心、肝、脾等脏，其标因气、血、瘀等。据“郁者发之，结者散之”的理论，故中医辨证论治常以理气解郁，活血化瘀，化痰软坚之法。

该篇收录了3位针灸医家的临床治验，有的采用针挑为主，软坚散结；有的取主穴三个，重刺法；有的以火针为主等，对甲状腺肿大均有一定的缓解作用。

一、针挑为主 软坚散结

瘰瘤是中医外科疾病，植兰英采用针挑疗

法治疗本病，取得可喜疗效。

取穴：针挑穴：①肩井（双）、瘰瘤中心点。②心俞（双）、瘰瘤中上缘点。③膈俞（双）、瘰瘤中下缘点。④肝俞（双）、瘰瘤左侧缘点。⑤脾俞（双）、瘰瘤右侧缘点。

针刺穴：内关、合谷、足三里、三阴交，均双侧。

操作：针挑穴按顺序选用，针刺穴每次均用。先针后挑，每3天1次。针挑后每穴施以温和灸5~10min，再敷以创可贴保护创口。5次为1个疗程。

瘰瘤一病，盖痰气郁结于足太阳、足阳明之筋而致。因足太阳之筋，其支者，别人络舌本；另一支者，出缺盆斜上出于颧部。足阳明之筋，上颈，上挟口。皆经过颈部。故治疗以取此两经穴为主。用足太阳经心、肝、脾等背俞穴，一则疏通足太阳经气，二则调节相应脏腑之功能，以治心悸、烦躁、倦怠等兼证；取阳明经合谷、足三里疏通阳明经气，还可协同肩井、脾俞、膈俞加强化痰散结，佐以内关、三阴交宽胸理气，养血安神。

针挑疗法是一种以针挑皮部治病的疗法。挑刺的深度只限于皮部，刺激手法是以横刺挑提，牵拉摇摆为主；或者在皮层取出一些组织、体液，并留下1个小小的创口。具有疏通经络，活血祛瘀，软坚散结，健脾祛痰，调理脏腑，调和阴阳等疗效。本病以针挑疗法为主，充分发挥了此疗法刺激量大，疗效快捷等优点，故疗效尤为显著。

患者，女，50岁，1998年4月4日初诊。

患甲状腺功能亢进5年余。曾经中西药治疗好转。1997年下半年起，瘰瘤逐渐增大，伴心悸，胸闷不舒，烦躁不宁，倦怠乏力，多汗。因服药无效而经他人介绍来诊。查颈部瘰瘤左右各一，大如拇指，质硬，触之滑动，苔薄略滑腻，脉细弦。证系肝失疏泄，气血郁滞，痰气相结，经络阻塞，搏于颈下。治拟疏通经气，化痰散结。取穴、治法如上。

首次治疗后，心悸、身倦明显减轻。治完第一疗程，心悸、胸闷、倦怠基本消失，瘰瘤缩小过半。自诉上楼脚步轻松，心情平静不再易激。舌苔薄白，脉濡缓。仍按原法治疗1个疗程，诸症安恙，瘰瘤基本平复。嘱其停止治疗，慎起居，调情志，避劳累，每月复

查1次，以防复发。

二、主穴三个 重刺法

单纯性甲状腺肿大是甲状腺疾病中常见的病证，属于中医学中瘰癧之气瘰，具有颈部漫肿或有结块，皮色不变，随吞咽而上下移动，逐渐增大，缠绵难消，且不溃破的特点。邵素菊运用针灸治疗，疗效满意。

取穴：主穴：阿是穴、合谷、足三里。配穴：胸闷、气短、泛恶者配内关；吞咽不适配天突；胸胁胀满配太冲，其他随症加减。

操作：患者采取仰卧位（勿用枕头），合谷、内关、足三里、太冲等穴可按常规针刺。针刺天突穴时，针尖不要斜向两侧，将针尖刺入皮下0.2寸后，沿胸骨柄后斜向下方，勿伤气管。阿是穴在针刺时可根据不同病情采取不同的针刺方法，若颈部无明显结节肿块，可在相当于人迎穴上、下各0.5寸处，双侧共刺4针；若结节性肿块较大者可采用围刺法——中心刺1针，沿肿块周围呈45°角斜刺3~4针，均使针尖刺入肿块，如肿块通过针刺治疗明显缩小，仍需继续治疗，以消失为度。如遇弥漫性肿大者，也可用围刺法治疗，但在进针时应避开气管及大血管进针，斜刺0.5~0.8寸，留针30min，中间行针2次，采用捻转运气法。每日或隔日针治1次，10次为1个疗程，若肿块尚未消失，可继续按前法治疗。

单纯性甲状腺肿大属中医瘰癧范畴。中医认为本病的发生多与精神因素、饮食习惯和地理环境有关。一般认为其发生主要是忧思恼怒，情志抑郁以致肝失条达，气结不化，逆乘脾胃，脾失健运，聚湿生痰，痰气互结，循经上结咽喉；或由外感六淫之邪，经络阻滞，气血凝滞，搏于颈部而成；或因水土不适，所致地方性疾患。邵素菊应用家父邵经明老先生多年的经验，以阿是穴、合谷、足三里为主治疗本病效果较为满意。邵素菊认为本病取用阿是穴有宣通局部经气，疏导壅滞，消肿散结之作用；合谷是手阳明经原穴，阳明为多气多血之经，颈部又属阳明经之分野，合谷为循经远取，具有疏通经络，调理气血，散结消瘰之功；足三里是足阳明胃经的合穴、下合穴，具有调节整体功能，健脾和胃，通经活络，调理气血的作用；治疗本病，三主穴远近相配，功效相得益彰。内关是心包

经络穴，又为八脉交会穴，通于阴维脉，具有清泄包络，通利三焦，宽胸和胃，行滞降逆等功；天突是任脉穴，位居胸腔之上，气管之前，其气以通为顺，有降气祛痰，利咽开音之功；太冲是肝经原穴，有疏肝解郁，理气消胀的作用。治疗本病，主配结合，标本兼顾，共奏祛邪扶正，疏经通络，调理气血，消癭散结之功效。但临证时还应注意：①由于患者的精神状态与病情有密切关系，保证心情舒畅，有助于治疗效果的取得。所以患者一定要注意调畅情志。②要经常食用海带及其他海产品，尤其是妊娠期及哺乳期更为重要。忌食辛辣等刺激性食物。③医者在针刺阿是穴时应注意角度、深度，防止刺伤气管、喉头或大血管，出血后应用消毒棉球按压针孔片刻，以防止出血而形成血肿。④还必须指出，若甲状腺显著肿大，出现压迫症状，而针刺、药物不能迅速取效者，应考虑手术。

另外，根据临床观察本法治疗甲状腺肿大，其疗效对于单发性、囊性结节者较多发性、实性结节者为好；肿大越小，疗效越好。因此提示本病以早期治疗为宜。

刘某，女，29岁。1999年6月3日初诊。颈前肿块伴咽部堵塞感一年余，加重2月。患者1年前发现颈部出现1肿块，遂在当地医院用中药治疗，效果不甚明显，且觉肿块有增无减，尤其是近2个月，有咽部堵塞感，进食时似有轻微阻挡感，遇到精神刺激则症状加重。患者不愿再服中药，故要求针灸治疗。视其体质一般，颈部正前方肿块，超过胸锁乳突肌之前缘，触之不痛，质地较软，表面光滑，边缘清楚，并可随吞咽上下移动。舌淡红苔薄，脉弦数。血 T_3 、 T_4 及基础代谢率检查均正常。B超检查：双侧甲状腺呈中度均匀性肿大，约 $4.3\text{cm} \times 2.6\text{cm} \times 2.1\text{cm}$ 内见有斑状强回声。诊断：双侧甲状腺中度肿大。此乃性情急躁，肝失条达，痰气搏结于颈部所致。治宜理气化痰。针取阿是穴（采用围刺法，以1寸毫针，在肿块中心刺入1针，进针0.5寸，周围4针，进针均为0.8寸），合谷、足三里穴按常规操作。每日针治1次，连针1个疗程。肿块明显缩小，休息3天后，改为隔日针治1次，治疗2个疗程，肿块明显减小，其他症状基本消失。后因生气病有反复，继按前法隔日针治1次，连针2个疗程，肿块完全消失。B超提示甲状腺大小形态均正常。病愈回家。随访1年，病无复发。

三、火针为主 标本兼治

瘰癧俗称“大脖子”病，其病因主要为缺碘所致，多见于高原山区，唐永瑞近年来在当地以火针为主治疗该病，疗效显著。

取穴：主穴：局部取穴（瘰癧肿大处）；配穴（毫针）：肝气郁滞加行间、膻中；痰湿盛者加丰隆、中脘；肝火盛者加太冲、太溪；心悸加内关、神门；目睛外突加丝竹空、攒竹、风池；心肝阴虚加心俞、复溜、三阴交。

操作：用较粗大针先从肿物中心用速刺法点刺、进针深度达肿物三分之二以上，然后于肿物四周取4点点刺、深度达肿物三分之一即可，之后配穴用毫针，留针半小时，隔日1次，10次1个疗程，休息5天，继续针治。

《巢氏病源》说：“诸山水黑土地，出泉水者，不可久居，常饮食令人作瘰癧”，故本病的发生主要原因是由于地理、环境因素或由恼怒忧思、情感抑郁以致气结不化，津液凝聚成痰，痰瘀互结导致气、痰、血瘀，凝于颈部而成，其治疗原则在于疏通经络、调整气血、散结消肿、驱除病邪，以达到“气血流行不失其常，形体和节，无或余赘（《圣济总录》）”的正常生理状况。《针灸聚英》“破瘤坚积结瘤等，皆经火针猛热可用”，临床实验表明，火针确有很强的化痰软坚、散结消瘤、通经活血的作用，随症配穴，标本兼治，病疾渐去。现代实践研究，针刺能促使甲状腺对碘的吸收，这也是针刺治疗该病取得较好疗效的机制所在。

患者，女，38岁，农民。左颈部有一甲状腺包块如苹果大小，一年前发现时仅有2cm×2cm大，包块逐渐增大，影响吞咽。情绪烦躁，舌红、脉滑，用以上方法治疗5天，肿物明显缩小，1个疗程结束，肿块完全消失，吞咽正常，情绪稳定，随访2年未复发。

参 考 文 献

- [1] 植兰英. 针挑疗法为主治疗癭瘤 12 例. 上海针灸杂志, 2002, 21 (1): 35
- [2] 邵素菊, 邵素霞. 针刺治疗单纯性甲状腺肿大 31 例. 针灸临床杂志, 2004, 20 (12): 24 ~ 25
- [3] 唐永瑞, 唐生盛. 火针为主治疗癭瘤 46 例临床观察. 青海医药杂志, 2000, 30 (12): 7

【黄褐斑】

黄褐斑是一种临床常见的以面部发生黄褐色斑片为特征的色素沉着性皮肤病。俗称“蝴蝶斑”、“孕斑”，属中医黧黑斑范畴。《普济方》曰：“夫风邪入于经络，血气凝滞，肌肉弗泽，发为疣目。肝肾阴血亏虚，水不制火，血弱不能外荣于肌肤，火燥结成黧斑。”《神巧万全方》云：“头面者，诸阳之会，血气既衰，则风邪易伤，故头病则或生恶疮、或生秃疮，面则有黯、疮痣、粉刺、酒渣之属。”《外科大成》指出：“黧黑斑多生女子之面，由血热不华，火燥结成。”本病主要发生于中青年女性，影响美容。

本病诱发因素为日晒、妊娠、劣质化妆品、遗传、某些慢性疾病、口服避孕药、皮肤微生态失衡及情志失调等，但真正的病因尚不清楚。中医认为本病多因肾阴不足，肾水不能上承，或忧思抑郁，肝失条达，郁久化热，火燥结滞于面，或气滞血瘀，胃中郁热，阳明经络阻滞，或汗出当风，肌肤营养失职，或冲任失调，妊娠血已养胎而面部失养发病。

本篇共收录了 23 位针灸医家的临床治验，有的采用背部走罐加局部围刺；有的取背俞穴刺血拔罐；有的根据临床症状辨证取穴，药物注射；有的采用灵龟八法针刺，有的采用耳穴

刺络法；有的采用飞腾八法针刺，配合刺血拔罐；有的以埋线为主；有的以局部刮痧为主，行气消斑等，治法各异，疗效显著。

一、取经为主 走罐配刺络放血

黄褐斑是一种好发于中青年女性颜面部的常见色素沉着性皮肤病，俗称蝴蝶斑。王萍采用背部走罐配合刺络放血治疗黄褐斑取得较好的疗效。

取穴：督脉（大椎穴至长强穴）；足太阳膀胱经第一侧线（大杼穴至膀胱俞，双侧）。

操作：患者取俯卧位，皮肤常规消毒后，将凡士林均匀涂于所取的经络上，根据患者的形体及体质选取适当玻璃火罐，将火罐拔于大椎穴穴位上，双手握住火罐循经自上而下缓缓用力往返推罐，同法再施术于膀胱经，每条经络走5~9次（历时约10min），至皮肤紫红为度。然后再于肝俞穴、膈俞穴（均双侧）常规消毒，用三棱针点刺（2~3下），出血后加拔火罐3~5min，出血量约1~3ml。隔日治疗1次，10次为1个疗程。

西医学认为黄褐斑发病与紫外线照射、滥用化妆品、祛斑方法不正确（包括光子嫩肤等）、雌激素和孕激素水平紊乱、服用避孕药、精神因素、遗传因素及某些慢性疾病等有关。中医学无黄褐斑之名称，根据其临床症状可归属于面尘、黧黑黻黯、黧黑斑等范畴，认为肾阳（气）亏虚、肝郁气滞、脾胃虚弱、冲任失调等均可致气血失和，经脉不畅，瘀血阻滞，气血不能上荣于面而发病。针灸治疗黄褐斑古代少有记载，近年来针灸疗法已日益引起重视。王萍认为黄褐斑是脏腑功能失调，气血不能运行于面的外在表现。气血乃人体生命活动之物质基础，气行则血行，气滞则血凝，气血的产生、运行与脏腑经络紧密相关。督脉为人体诸阳经之会，对人体气血阴阳有重要的调节作用。膀胱经第一侧线上分布的背俞穴是脏腑精气汇聚之处，故刺激背俞穴可调整脏腑功能。采用背部督脉、足太阳膀胱经走罐的方法，可有效地刺激穴位，达到调和阴阳，疏通经络，调理脏腑之功效。根据《灵枢·九针十二原》篇所载“凡用针者，虚则实之，满则泄之，苑陈则除之”的原则，选用肝俞、膈俞放血疗法，可起到疏肝理气，活血祛瘀之功效，而令气血上承于面，色

斑自消。故走罐配合刺络放血疗法，可扶助人体正气，理气化瘀，标本兼治，效果显著，是治疗黄褐斑的一种有效方法。

董某，女，39岁，干部，2005年4月21日就诊。主诉：5年前无明显诱因，面颊及唇周出现淡褐色斑，并逐渐加重，尤以近2个月明显。曾自做面部按摩、面膜美容及口服中成药治疗后减轻，一段时间后又复发。症见：面部无光泽，双颊及额下部呈片状黄褐斑，边界清楚，伴有月经延期，量少、色暗黑有瘀块，经前乳房胀痛，舌暗红，其上可见散在的瘀点，少苔，脉沉弦涩。诊断：黄褐斑。采用上述方法治疗1个疗程后，面部斑块色泽明显变浅，面积变小，面色较前红润。治疗2个疗程后，患者大部分色斑消退，尤以双颊部消退明显，但口周色斑仍较重。治疗3个疗程后，患者面部色斑面积消退>90%，颜面皮肤红润光泽，基本治愈。继续巩固治疗1个疗程，色斑完全消退而告痊愈，伴随症状均消失。随访1年未复发。

二、督脉埋针 调理诸经

黄褐斑是一种色素代谢障碍引起的面部色素沉着性皮肤病，皮损多见于面部，以颊部、颧部及鼻、前额和颞部为主。皮损通常为淡棕色、灰色、棕灰色、棕黑色、甚至深蓝色的斑疹，大小不一，可相互融合成片状，皮损多数境界清楚，当色素沉着较淡时，其边缘也可不清楚。肖平运用督脉埋针法治疗女性黄褐斑，疗效显著。

取穴：灵台透至阳。

操作：患者俯卧位，皮肤常规消毒后，用圆利针由灵台透至阳，沿皮横刺入皮内，然后用胶布将留在皮外的针柄固定。埋针期间，每隔4h左右用手按压埋针处1~2min，以增强刺激和疗效。埋针处不可沾水，避免感染。每治疗1次埋针时间为3天，间隔两天再进行第2次治疗，18次为1个疗程，共治疗1个疗程。

中医学认为，黄褐斑的发生与肝、脾、肾的关系密切，气滞血瘀、肝肾不足、脾胃虚弱等致气血不能上荣于面会导致色斑的发生。肖平以整体观念为指导，疏通经络、调和脏腑气血为治则，采取在背部的督脉由灵台透至阳进行埋针治疗。至阳能健脾和中、除湿退黄，灵台具有宣肺理气、通经利络的功效，二穴配合可使经络之气

运行正常，并通过肺的宣发功能将脾所运化的水谷精微布散到全身，使气血上行于颜面。督脉为“督领经脉之海”，与肝、脾胃、肾、膀胱经的关系密切，刺激督脉可促进脾胃运化水谷精微，使肾精充盈，精血之间的相互滋生与转化正常，肝血充足。埋针能有有效的刺激穴位，振奋这些经络、腧穴的功能。透穴刺法具有疏通经络，增强针感，提高疗效的作用。本方法安全有效，有以针代药的作用。

三、耳压磁珠 调节全身

黄褐斑是对称性发生于面部的淡褐色或深褐色色素斑，多发于中青年妇女，常无自觉症状。刘剑梅采用耳压磁珠治疗，效果满意。

取穴：肺、面颊、内分泌、肾、神门。前额为主者加脾；以颧颊为主者加肝。

操作：治疗前选用探针压耳区找出穴位敏感点，常规酒精消毒后以 $0.6\text{cm} \times 0.6\text{cm}$ 方块医用胶布将50GS小磁珠贴压在敏感穴位上，每次选耳穴4~6穴，每日按压3~5次，每次2~3min，以感觉所压部位烧痛或酸麻能耐受为佳。两耳轮换，3天更换1次，10次为1个疗程，每疗程间隔休息5~7天。

中医认为耳与经络，脏腑有密切联系，《灵枢·口问》篇说“耳为宗脉之所聚”，分布于耳部的经脉均与脏腑关系密切，说明耳与脏腑在生理、病理方面息息相关，故耳穴可以作为针灸的刺激点治疗各部病证。面部黄褐斑祖国医学称为“肝斑”、“黧黑斑”，常与肺、肝、脾、肾四脏有关，证有虚实之分。实者常因肝郁气滞，血瘀孙络，导致颜面色素沉着明显；虚则系脾肾阳虚，痰浊挟风上循于面，导致面部肤色灰暗甚则黧黑。肺主皮毛，为五脏六腑之华盖，无论虚实均与肺有关联，故取穴肺、肝、脾、肾，意在疏肝解郁，壮阳益精，健脾益气；从肾论治又可调整内分泌功能，配面颊相应部位，从而达到气血中和，肤色复常的目的。本疗法效果明显，经济简便，易于推广。

李某，女，35岁。产后2个月开始颧部出现淡褐色色素斑6年，逐渐加重为深褐色3年。近1年来月经周期紊乱，经前乳房胀痛，腰骶部酸困，白带多色黄有味，经西医妇科治疗3个月，黄带明显减少，腰骶部酸困减轻，余症无明显改善。于1995年7月，刘剑梅

采用耳压治疗，1个疗程后面部色素变浅，范围稍有缩小，连续治疗2个疗程，面部色斑基本消退，肤色接近正常，月经期少腹胀痛，下坠，乳房胀痛随之改善。随访2年再未出现色斑，月经期恢复正常。

四、灵龟八法 按时开穴

黄褐斑多由于气滞血瘀、脾胃气虚或肝肾亏虚所致。张学丽采取按时取穴法中的灵龟八法配合耳穴压丸法治疗黄褐斑，取得了满意的疗效。

灵龟八法针法：即时开穴为主穴，以后溪配申脉，列缺配照海，外关配临泣的八脉交会穴相配法取穴处方，根据不同的治疗时间选取不同的主穴及配穴。每日1次，10次为1个疗程，每1个疗程之间休息1~2天，继续下1个疗程。

耳穴压丸法：取穴：内分泌、皮质下、肺、肝、脾、心、肾、肾上腺、卵巢、内生殖器、面颊、眼、口、额、颞，其中肺、内分泌、卵巢、面颊为主穴，并根据具体辨证所涉及的经络和脏腑及色斑部位选取耳穴，内分泌、皮质下、内生殖器可交换选用。以王不留行籽贴压，并嘱患者每日轻揉3次，夏日3~4天更换1次，其他季节5~6天，更换1次，两耳交替治疗。

灵龟八法是传统医学中的按时取穴针法之一，是古人以天人合一的观点在临床上的应用。根据大自然的变化规律，结合人体各经脉气血周流盛衰不断变化的情况，张学丽以八脉交会穴为基础，配合九宫八卦逐日按时开穴的方法。运用此种针法既可调节十二经脉气血及与之相络属的脏腑功能，又可调理奇经八脉的阴阳虚实。从而达到脏腑气血调和，经脉通畅，化瘀生新的目的。

李某，女性，62岁，退休工人，初诊日期：2000年11月2日。患者面部黄褐斑两年多。面色晦黯，色斑主要分布于颧部、鼻梁，上眼睑，并有散在的老年斑，曾外用多种品牌祛斑霜，均未奏效。患者纳后胃脘胀满，畏寒乏力，双膝酸软，眠佳，二便调。舌质胖大，边有齿痕，色淡，脉沉。诊为脾肾双亏，气血不能上荣于面所致。张学丽依据患者来诊的时间选取灵龟八法的即时开穴，配以相对应的八脉交会穴，每日1次，耳穴取肺、脾、肾、内分泌、面颊、眼、鼻。治疗1个疗程后，颧部色斑面积缩小20%，老年斑颜色变

浅。第二疗程后，颧部色斑呈散在小片状分布，老年斑颜色与正常皮肤一样，鼻梁上黄褐斑颜色变浅。再经过约2个疗程的治疗，黄褐斑消失，面部皮肤亦有光泽，饭后腹胀不再出现，其他症状也有改善。半年后随诊，黄褐斑未现。

五、随证取穴 挂针配直接灸

黄褐斑又名蝴蝶斑，是一种常见的发生于面部的后天性色素过度沉着性皮肤病。李子勇按中医辨证，将患者分为肝郁气滞型、胃肠积滞型、脾肾两虚型论治，故采用面部挂针加直接灸治疗黄褐斑，取得较满意的疗效。

取穴：

面部挂针：黄褐斑较明显的部位。

体针：主穴：曲池、血海、三阴交、足三里、肺俞。配穴：肝郁气滞型加合谷、太冲、肝俞；胃肠积滞型加天枢、中脘、上巨虚；脾肾两虚型加关元、脾俞、肾俞；失眠加安眠、神门、照海。

操作：常规消毒后，面部选用36号，1寸的环球牌不锈钢毫针，在黄褐斑较明显的部位浅刺1分，毫针数以遍及黄褐斑范围为宜，毫针间距最小为1分。体针选用31号，1.5寸的毫针，直刺进针，得气后，留针30min。出针后，在面部选取斑片较明显的部位涂少许陈渭良伤科油（广东省佛山市中医院陈渭良教授研制的一种伤科外用药，具有解毒消炎、防治烫伤的作用），并行小麦粒直接灸，3壮/穴。每周治疗2次，8次为1个疗程，治疗3个疗程。

黄褐斑在祖国医学中又称面尘、黧黑斑、肝斑。《医林改错》分析本病属“血瘀皮里”而成。《医宗金鉴·外科心法》认为“原于忧思抑郁，血弱不华，火燥结滞，生于面上。”其病虽在外，实因内而发，治宜外病内治而求其本。故李子勇认为针刺治疗以疏肝解郁、行气活血、健脾消滞、滋肾养阴为主。脾胃为后天之本，气血生化之源，故取脾经之血海以调血补血；气为血之帅，肺俞与血海共奏补气理血之功；曲池、足三里分别为手足阳明经之合穴，阳明为多气多血之经，故两穴合用共奏行气活血之效；三阴交乃足三阴经之会，具有调理肝脾肾三经气机之功。面部黄褐斑为气血郁滞于表，

针之可疏通气血。《本草从新》记载：“艾叶苦辛，生温，熟热，纯阳之性，能回垂绝之阳，通十二经，走三阴，理气血，逐寒湿，暖子宫……以之灸火，能透诸经而除百病。”《本草再新》称艾叶可调经开郁，理气行血。面部挂针与直接灸属外治和局部治疗，配合体针的内治调节，能够达到内外兼治、表里贯通、气血畅达之效。面部挂针加直接灸对黄褐斑是一种安全方便、疗效显著的治疗方法。

患者，女，34岁。产后出现面部黄褐斑3年，近4个月加重，以双颧部为主，经前明显，深褐色，呈蝴蝶状。经服中西药物、外敷面膜及光子治疗等效果不佳，伴有月经推迟，经量少，色淡，神疲体倦，胃纳一般，大便偏稀，睡眠尚可，舌质淡胖边有齿痕，苔白，脉沉。曾在当地各大医院做妇科B超未发现异常。李子勇于患者面部采用挂针术，体穴选取曲池、血海、三阴交、足三里、关元、天枢针刺，进针得气后，留针30min。出针后于褐斑明显处实施直接灸，每穴3壮，每周2次。治疗1个疗程后，面部色斑明显变淡，精神状态好，月经恢复正常，纳可眠调。再治疗1个疗程，面部色斑基本消退，改每周治疗1次，巩固治疗4次，追踪观察1个月未见复发。

六、综合疗法 内外兼治

刘玉洁采用针灸配合中药治疗黄褐斑，效果满意。

中医辨证分型：肝郁气滞型，脾失统摄型，脾失健运型，肾阴虚型，肾阳虚型。

(1) 针灸治疗

毫针：主穴：肝俞（双）、肾俞（双）、风池（双）、阿是穴。辅穴：迎香（双）、太阳（双）、曲池（双）、血海（双）。

耳针：肺、内分泌、缘中、交感、皮质下、面颊。

加减配穴：肝郁气滞加太冲（双）、支沟（双），耳针配肝、神门、胆、胸；脾胃虚弱加足三里，耳针配心、脾、胃、三焦；肾阴不足加关元、气海、命门，耳针配肾、肾上腺；月经不调：配耳针子宫、附件、腹；神经衰弱配耳针心、神门、脾；慢性肝胆病配耳针胰、胆、脾。每日1次，留针20min，10次为1个疗程。

(2) 中药内服 内服基本方：柴胡10g，当归10g，赤芍、丹参

各 15g, 桃仁 6g, 红花 6g, 白芷 5g, 炙甘草 10g。肝郁气滞、肝阳上亢伴眩晕、耳鸣者, 加珍珠母、僵蚕、白菊花、夏枯草。脾胃虚弱伴纳呆、腹胀、便溏者, 用党参 10g, 茯苓 10g, 白术 10g, 陈皮 10g; 肾阳虚, 面色㿔白, 形寒肢冷, 腰膝酸软无力者, 加熟附片 6g, 桂枝 6g, 熟地 12g, 菟丝子 15g。每日 1 剂, 水煎分 2 次服, 2 个月为 1 个疗程。

(3) 中药外用

①祛斑膏: 大枫子仁、杏仁、核桃仁、红粉、樟脑各 30g, 研细加油调匀, 外搽, 每周 2 次。

②倒膜粉: 白术、白芷、白蔹、白及、白扁豆、当归、川芎、桃仁、三七粉、淀粉等分, 共研细为末备用。用祛斑膏外擦按摩后, 再取倒膜粉 20g, 加入医用石膏 200g, 加水调糊外用做硬膜倒膜。每周 1 次, 2 个月为 1 个疗程。

祖国医学认为, 黄褐斑多为肝、脾、肾三脏功能失调所致。肝失条达, 气机郁结, 郁久化火, 灼伤阴血, 血行不畅, 而致颜面气血失和; 若脾虚失摄, 则血不循常道而下溢亡失。若脾失健运, 水谷精微不能上输, 则气血不能润泽于颜面。肾阳不足, 阴寒内盛, 气血不得温煦而滞涩不畅, 脾失温煦水谷不得气化, 而生化乏源。肾阴不足, 虚火上炎, 肝失肾水滋养而肝失条达, 均可导致颜面发生黄褐斑。刘玉洁辨证论治以肝、肾、脾三脏为主, 可据色斑特点、位置、兼证及舌脉, 辨证用药及选穴。以上诸法针灸治疗黄褐斑可调节脏腑气血、疏通经络、活血化瘀, 促进色素沉着的消退; 中药内服治疗黄褐斑, 可以活血化瘀、消滞祛风; 中药外用可以调理经络气血, 分解黑色素, 并为面部补充水分及微量元素, 平衡皮肤的酸碱度, 消除黄褐斑, 达到美白保湿的效果。刘玉洁认为采用综合疗法治疗黄褐斑, 可取脏腑气血调畅、消斑容颜之功效。

七、走罐加局部围刺 调补五脏

黄褐斑是发于面部的淡褐色或淡黑色斑, 形状不规则, 对称分布于额眉颊鼻唇周等颜面皮肤, 表面光滑, 无脱屑, 有碍美容。史连俊采用背部走罐配合局部围刺治疗黄褐斑, 取得了较为满意的疗效。

取穴：面部黄褐斑处。

操作：选0.5寸不锈钢毫针，穴位常规消毒后快速刺入，每块黄褐斑中心先直刺1针，根据黄褐斑的面积，围绕黄褐斑向中心斜刺5~8针，留针30min。起针时摇大针孔，不按压，如针眼有出血，待其自止后即可。每日1次，10次为1个疗程。

走罐：取督脉（大椎~长强），足太阳膀胱经（大杼~白环俞），夹脊穴。患者取俯卧位，将液体石蜡广泛涂于背部经络分布处，根据患者的体质选用大号或中号的玻璃火罐，用闪火法将罐拔住，然后用右手握住罐子，上下往返推移。至所拔皮肤瘀血时，将罐起下。隔1天1次，10次为1个疗程。

《灵枢·邪气脏腑病形》曰：“十二经脉，三百六十五络，其血气皆上于面。”面色是脏腑气血的外荣。中医学认为，肝气郁结、肾阴亏虚、脾胃虚弱、冲任失调等均可导致气血失和，经脉阻滞，气滞血瘀，使气血不能上荣于面，故面部起黄褐斑。

循经走罐法是以十二经脉皮部与十二经脉、十二脏腑相通的理论为依据，背部为督脉和足太阳膀胱经分布循行之处，督脉为阳脉之海，总督人体阳气，位于膀胱经，可调补五脏，平衡阴阳，魄户、神堂、魂门、意舍、志室则善调人体五志。循督脉、膀胱经走罐既可调补五脏，补益先后天之本，平衡阴阳，又可调节人体五志，使精神情志活动趋于正常，故功效倍增。夹脊穴位于督脉和膀胱经之间，与后两经位邻相近，经气相通，兼有两经共同作用。

黄褐斑局部围刺泻法，可起到疏通面部经气、活血去瘀的作用，使脉络通畅，郁结之邪外出，气血上承于面，色斑消退。治疗期间嘱患者注意保持心情舒畅，生活规律，多食水果、蔬菜，外出时减少阳光的照射，不要使用劣质化妆品。

患者，女，35岁，已婚，8年前无明显诱因面部出现淡褐色斑，尤以近2年加重。曾外用祛斑霜、口服中成药无效，现鼻额、两颊有大小不等黄褐斑，边界不清，伴失眠、月经后期、量少色暗有瘀块、经前乳房胀痛、大便秘结、舌质暗红、苔少脉沉涩。诊断：黄褐斑。采用上述方法治疗1个疗程后，面部斑块明显变小。3个疗程后，患者面部黄褐斑全部消失，颜面皮肤红润光泽，伴随症状消失，治愈，随访1年未复发。

八、背俞穴 刺血拔罐

黄褐斑是一种色素沉着病，好发于面部，多见于中青年女性，俗称蝴蝶斑。属于中医学黧黑斑、面尘，多与妊娠、月经不调、内分泌功能改变、神经衰弱或日晒等诱发皮肤黑色素细胞功能亢进因素有关。王民集采用背俞穴刺血拔罐法治疗黄褐斑，取得较好疗效。

操作：背俞穴刺血拔罐，取大椎、肺俞、膈俞、肝俞、胃俞。将穴位常规消毒后，用一次性采血针点刺出血，然后用闪罐法拔罐，留罐6~10min，出血量1~2ml为宜。隔日治疗1次，10次为1个疗程。

黄褐斑为色素代谢失常所致，也有因日晒过多致皮肤灼伤，而内分泌失常是其根本因素。背俞穴点刺出血，取其“苑陈则除之”作用，起到舒肝解郁，促进代谢之效；大椎穴为诸阳之会，泄本穴可以除阳经之热；肺主皮毛，故取肺俞可以治疗皮肤病变；膈俞为血之会，刺血拔罐泄之，自然可以去除血之郁热；肝主疏泄，黄褐斑就是因体内疏泄失常所致，故取肝俞来调整肝之疏泄失常；本病好发于面颊及额头部，均为阳明经之分野，故取胃俞以泄阳明经之热。诸穴共用，加强调节内分泌功能，减少体内黑色素的分泌，逐步消退面部黄褐斑，以恢复正常肤色。

张某，女，33岁。主诉：于1994年3月面部出现蝶状褐色斑，鼻部及口唇部均有褐色素沉着。既往有月经不调病史。月经前褐色素沉着加深，月经后褐色素沉着变浅，无其他自觉症状。曾内服中药及维生素C等药物，效果不佳。体检：面颊、鼻部、眉上及口唇周围均呈深褐色蝶状斑。根据病史体征采用背俞穴刺血拔罐，第一个疗程的第三次治疗已明显见效。双侧面颊大部分已变浅褐色、鼻部及额部褐色素沉着也有所变浅。休息5天后，继续进行第二个疗程治疗，2个疗程后基本治愈。半年后随访已肤色如常，达到临床治愈。

九、辨证取背俞 推罐配按摩

黄褐斑以颜面出现淡褐色或褐色的色素沉着，皮损对称分布，面积大小不等，形状不规则，无自觉症状为临床特征。卜彤文根据

该病的病因病机，采用背俞穴推罐配合药敷加点穴按摩治疗该病，收到良效。

推罐：患者取俯卧位，选择其距后正中线 1.5 寸的膀胱经第一侧线上背俞穴（从大杼至膀胱俞之间）。将此部位暴露后选用罐口平滑的中号玻璃罐。先在背俞部涂抹一层凡士林，再将罐拔住，以手推罐。罐口前端向前推进的方法是微翘玻璃罐，沿着背俞部上下慢慢推移。先从上而下，至所选穴稍停，再回复向上，上下反复，慢慢推拉，直至皮肤充血为度。根据辨证选用背俞穴：①肝郁气滞：颜面出现黄褐色斑片，腰膝酸软，或急躁易怒，胸胁痛，舌质黯、苔薄白，脉沉细。将罐推至肝俞、膈俞、肺俞。②肝肾亏虚：颜面黄斑褐黑色，腰膝酸软，倦怠乏力，体弱羸瘦，舌红苔少，脉沉细。将罐推至肝俞、肾俞、脾俞、肺俞。③脾虚湿阻：颜面出现黄褐色斑片，神疲，纳呆，脘腹胀闷，或带下清稀，舌淡苔腻，脉弦缓。将罐推至脾俞、胃俞、肾俞、肺俞。

药膏按摩：制作药膏，选用白蔹、细辛、白芷、白术、茯苓、白附子、白扁豆各 30g，荆芥、防风、当归、川芎各 15g，研细后，放入 100ml 蜂蜜中调匀。在患者每次背部推罐完毕后施行面部药膏涂敷按摩。患者洁面后仰卧，术者将药膏均匀涂于其面部，双手拇指沾水，在面部美容的常规按摩基础上，重点按压印堂、阳白、太阳、四白、巨髎、颧髎、迎香、颊车、大迎、承浆、地仓、人中等穴；又于褐斑局部，即前额、两颊、鼻部、口周等处按压至发红发热为佳。每次 30min。

黄褐斑，中医称为黧黑斑，或肝斑。好发于成年女性。多为某一脏腑气血不足或运行失常，以致不能外荣于颜面。背俞穴是脏腑之气输注于背部的穴位。卜彤文根据辨证选用背俞穴拔罐，以调整脏腑功能，从而有利于气血运行复常，使黄褐斑消失。药膏按摩所用方，乃据《医宗金鉴》祛斑经验方玉容散加减而成。方中用药大部分为白色中药，能活血化瘀、通经活络、祛风润燥，有抑制色素沉着，嫩肤防衰老作用，故用之有效。

陈某某，女，31 岁，2002 年 4 月诊。患者两年前怀孕期间颜面出现蝴蝶斑，两外眼角下至颧骨分布淡褐色斑块，呈点片状。经血量少有块，腹痛，性情急躁。舌质黯，有瘀点，脉弦细。诊断为肝

郁气滞型黄褐斑。经背俞穴推罐配合药膏按摩治疗 25 次后，黄褐斑完全消失，面色光泽红润。随访至今未复发。

十、辨证取穴 药物注射

尚蓉采用背俞穴辨证穴位注射治疗黄褐斑，疗效较为满意。

辨证分型及选穴：将黄褐斑患者辨证分为 3 型，并分别选取背俞穴药物穴位注射。肝郁气滞型：面部色斑伴急躁易怒，经前或经期小腹或乳房胀痛，月经色黯，舌黯红，脉弦有力。选用双侧肝俞、膈俞，药用复方丹参注射液；脾虚血虚型：面部色斑伴面色黯淡、头晕眠差、月经色淡等，舌淡黯，脉细无力。选用双侧脾俞、膈俞，药用当归注射液加红花注射液；肾虚血瘀型：面部色斑伴面色晦黯，畏寒腰酸或手足心发热，月经色黯有块，舌黯有瘀斑或舌红少苔，脉沉细涩。选用双侧俞、膈俞，药用复方丹参注射液。

操作：辨证分型选穴选药后，待患者月经干净后 3 天开始，用 5ml 注射器 4 号注射针尖抽取药液 4ml，令患者俯卧或俯伏坐位，充分暴露欲注射穴位，常规消毒后针尖稍向脊柱方向刺入穴位，待患者有针感时将药液缓慢推入（每穴 1ml），隔日 1 次，10 次为 1 个疗程，经后 3 天开始第二疗程。

黄褐斑与祖国医学文献中记载的面尘、黧黑斑等相似，其发病多与肝肾有关，故又名肝斑，另外亦与脾胃关系密切。或因情志不遂、暴怒伤肝等使气机紊乱、气血悖逆不能上荣于面而生褐斑；或因脾胃虚弱气血生化不足不能上荣于面而生褐斑；或因肝肾不足、水亏火旺等致血瘀水亏、肾色外露而生褐斑。据其病因将黄褐斑患者辨证分为肝郁气滞、脾虚血虚和肾虚血瘀三型而分别论治。

背俞穴是脏腑经络之气输注于背部的特定穴，具有良性调节脏腑功能、调补脏腑气血功用；膈俞穴为血之会穴，具有养血活血之功，配以失调脏腑之相应背俞穴而起舒肝理气、健脾补血、补肾活血功用。丹参功善活血且能养血，配以理气祛瘀之降香而加强其活血养血祛瘀作用；当归长于补血又可活血，配以活血化瘀良药红花而加强其补血活血之力。

背俞穴辨证穴位注射是通过丹参、当归、红花等药物刺激与黄褐斑发病有关的相应穴位，加强相应脏腑气血的运行，治疗黄褐斑

的易患因素,使五脏六腑阴平阳秘、气血充盛而根治黄褐斑。临床资料分析显示黄褐斑病程越短疗效越好,黄褐斑早期又以肝郁气滞型居多而此型疗效最好,故黄褐斑患者应及早治疗以取得最佳疗效。

患者,35岁。主诉:面部黄褐斑2年。2年前因情绪不佳出现两颧部黄褐斑,斑形渐加宽、斑色渐加深,伴急躁易怒,经期两乳房胀痛,少腹、腰骶部胀痛,月经色黯红偶有块,经多种中西药物治疗无效来诊。查:两颧、两颊及眉间黄褐斑如蝶状,色较深,肝、脾、肾(-)。舌黯红,苔薄白,脉弦。诊为:黄褐斑(肝郁气滞型),选双膈俞、肝俞,用复方丹参注射液4ml依前法穴位注射。1个疗程后患者色斑明显缩小,色泽明显减淡。经后3天又行第二疗程治疗,疗程结束后患者面部色斑全部消退,面部色泽恢复正常,且经期两乳房胀痛、少腹、腰骶部胀痛等症状全部消失。

十一、刺络拔罐配耳压 辨证施治

刘丽通过刺络拔罐背俞穴为主,配合耳穴贴压治疗黄褐斑,收到良好效果。

取穴:主穴:肺俞、膈俞。配穴:肝郁气滞者加肝俞、胆俞。肾精亏虚者加肾俞、志室;脾虚湿阻者加脾俞、胃俞、大肠俞。

操作:所选穴位局部常规消毒后,三棱针点刺出血2~3滴,再在该穴上拔火罐10min,以上穴位均为双侧取穴,交替使用,隔日1次,10次为1个疗程,间隔7天继续下1个疗程。

耳穴贴压:取穴:主穴:内分泌、肾上腺、卵巢、面颊。配穴:肝郁气滞者加肝、胆;肾精亏虚者加肾;脾虚湿阻者加脾、胃、三焦。常规消毒后,用0.5cm×0.5cm胶布将王不留行籽贴在上述穴位,每3天换贴1次,两耳交替。嘱病人每天按压3~5次,每次2~3min,以耳廓微热、微痛为度。

中医学认为,黄褐斑的发病与机体脏腑功能失调有关,肝郁气滞、肾精亏虚、脾虚湿阻均可导致阴阳不调,气血失和,气滞血瘀,经脉不畅,气血不能上荣于面而致黄褐斑。背俞穴具有调节五脏气机,提高机体功能的作用,肺主皮毛,其华在面,点刺肺俞可使肺气得以宣发,津液润泽,温养肌肤皮毛而养颜;膈俞为八会穴之血会,它与背俞穴并用可起到气血兼调、阴阳兼顾的作用;刺络疗法

可消瘀去滞，通经活络，拔罐有激发经气，疏通脏腑经络的作用，二法合用，可使各经脉气血运行通畅，从而达到肾气平稳、肝脾调和的目的。“耳者，宗脉之所聚也”（《灵枢·口问》），十二经脉都直接或间接上达于耳，耳与脏腑不仅在生理功能上息息相关，而且在病理上也密不可分，选用相应的耳穴，并用具有活血化瘀，通经活络的中药王不留行籽进行贴压，可疏通和调节相应的脏腑经络功能，从而达到调和脾胃、疏肝理气、补益脾肾的目的，使各脏腑气血调和而病除。

李某，女，31岁，公务员，2002年6月28日就诊。两年前妊娠后面部出现黄褐斑，两边对称，分布于面颊，黄褐色，边缘清楚，伴心烦，急躁、易怒、失眠，月经不调，舌暗红，苔薄黄，脉弦。诊断为黄褐斑，证属肝气郁滞型，经用上述方法治疗3个疗程后，黄褐斑消失，面部光泽，半年后随访无复发。

十二、耳穴刺络 调理气血

李杰运用耳穴刺络法，在辨证论治的基础上治疗黄褐斑，疗效满意。

取穴：主穴为肺、内分泌、心、耳尖，每次必用。配穴根据病情不同，酌情选用。若月经不调、痛经者，加肾、卵巢；肝郁气滞者，加肝、胆、膈；便秘者，加大肠、三焦；失眠者，加神门、皮质下；有过敏史者，加风溪、耳背肺。每次选用5~7个穴位。

操作：先用碘伏消毒液，常规消毒耳廓表面。用一次性6号注射针头，依次在穴位皮肤络脉明显处，快速点刺，进针深度约0.1寸，令其出血，一般不需挤压，让血液自然流出，避免局部造成瘀血，影响吸收。若出血量不足，可用75%酒精棉球擦拭针眼，促使血液流出，一般出血每穴5~7滴。然后用消毒干棉球按压针孔，稍停自行去掉即可。每周1次，5次为1个疗程。休息7天，再行下1个疗程。

黄褐斑，中医称之为“肝斑”、“黧黑皮干暗”。好发于额、眉间、两颊、鼻部和下颏部，偶或发于颈部。一般为双侧分布，但不对称，多发于30~45岁的青壮年，女性发病率明显高于男性，有明显的季节性。常无自觉症状，但影响容颜，给患者造成心理负担。其发病

原因和机制尚不完全清楚，可能与内分泌失调及皮损区局部微生态失衡（菌群失调）有关。从中医的角度来看，本病虽然全身症状不甚明显，但与五脏六腑精气的盛衰调和有着密切的关系。正如《灵枢·邪气藏府病形篇》所云：“十二经脉三百六十五络，其气血皆上于面而走空窍。”无论六淫外袭、七情内伤、饮食劳倦等均能导致脏腑功能失调，气血不和，气机不畅，郁久化热，灼伤阴血，致使颜面气血失和而病。依据“血实宜决之，菀陈则除之”的原则，采用刺络法，即《灵枢·官针》“络刺者，刺小络之血脉”，浅刺耳穴体表瘀血的细小络脉使其出血的方法，达到疏通经络，调和气血的目的。取穴选用耳尖、肝、心、膈、风溪，有活血化瘀、疏肝解郁兼有抗过敏之功；肺、肾、大肠、三焦、卵巢、内分泌，有调整脏腑功能、调理气血之效。诸穴配伍有调节脏腑功能、改善肌肤营养、消除外界不良刺激，促使色素斑消退的作用。

患者，女，27岁，2003年3月18日就诊。面部色斑2年。自述平素除有痛经病史外，身体健康，2年前分娩后，逐渐面颊、前额部出现色素沉着，夏重冬轻，曾用美容、药物治疗效果不明显。检查患者前额、左侧面颊部各有3cm×4cm的深褐色色素斑块，表面平整，无隆起，边缘清楚。诊断为黄褐斑。经用上法治疗1个疗程后，自述额部皮损处出现脱皮现象。续治2个疗程后，皮损区色素颜色变浅，部分出现正常肤色，多年未愈的痛经也痊愈。又治1个疗程后，色素基本消退，仅面颊部还有隐约可见的色素斑。半年后随访，情况稳定，未复发。

十三、耳穴刺血配贴压 化瘀消斑

李晓泓在临床上采用耳穴刺血及压籽治疗黄褐斑，取得理想疗效。

耳穴刺血：在压籽前先揉按整个耳廓，使其发热，充血发红。然后常规消毒单侧耳穴，用三棱针点刺1~2针放血，放血量约可使3~7个干爽消毒棉球吸透（2~10ml）。应尽量挤净穴区余血，再压盖干净消毒棉球，防止感染。左右耳交替选用。

耳穴压籽：取双耳内分泌、肾上腺、子宫（男子为前列腺）、肝、肾5穴。大便干燥者加肺、大肠；失眠者加心、脾；痛经者在

经前加交感及卵巢。耳尖放血后，找出上述穴位最敏感处，将王不留行籽贴在 $0.5\text{cm} \times 0.5\text{cm}$ 胶布上，再贴压在敏感处。每3天1次，10次为1个疗程。每次贴压后由医生揉按耳穴5min左右，揉至耳廓红热胀痛为宜。以后可让病人每日按上法揉按耳穴3次，每次5min。

面部黄褐斑是全身疾病在局部的表现，是一种黑色素异常增多的皮肤病，多与妊娠、月经病、慢性肝病以及日晒有一定关系。发斑部位均在面部，以口唇周围、双面颊区为主，有些病人可兼见前额及鼻区。小者如茶末密布，大者满颊黑斑，呈对称蝶翼状。颜色多呈黄褐色，少数呈深褐及黯红色。中医理论认为，黄褐斑发病关键因素在于肝肾阴亏，阴血干枯不能上荣，或兼见郁热，久灼阴血，最终导致面颊失于气血濡养而发本病。西医认为，黄褐斑是一种内分泌失调的疾病。由于内分泌功能紊乱，使得面颊局部黑色素细胞功能亢进，黑色素生成量增多，沉积在面颊区而呈黄褐色斑片。

治疗时取耳尖充分放血在于激发整个脏腑经络，疏通气血，清泻郁热；取肝、肾在于调肝补肾，疏肝解郁，化瘀消斑；取内分泌、肾上腺、子宫（男子为前列腺）则可调节脑垂体及内分泌功能，促进脑垂体分泌抗黑色素细胞刺激素，进而减少黑色素的分泌。取上述5穴共奏滋肝益肾，活血通络，化瘀消斑之功。

由于本病是缓慢形成的，同样消退有形的斑片也要经历一个过程，因此该病的疗程较长，平均在2~3个月之间，有些症状严重的病人甚至需要半年时间才能使斑片消尽。随着内分泌功能的逐渐调整，黄褐斑由大变小、由深变浅、由晦变泽，渐渐露出正常的肤色，以至完全恢复光滑润泽的肤色。当然如果在治疗同时避免皮肤曝晒，并配合食用乌鸡、红花、丹皮等药膳，效果可更为快捷。

陈某，女，31岁，已婚，1993年5月初诊。主诉：怀孕后开始起黄褐色斑点，渐渐连接成片，现已3年。曾用过“祛斑灵”多瓶未效。查：双面颊满布黄褐色斑片，鼻柱中央布有深褐色斑条，呈明显蝶翼状。平素乏力纳差，腰膝酸软，月经先后不定期且伴痛经。舌暗，苔薄白，脉弦。诊断：黄褐斑（血虚血瘀型）。治疗：上法治疗1个疗程后，面颊处斑片明显发花，左颊处露出2片指甲盖大小的正常肤色，本月行经时痛经减轻，自诉排出很多紫黑血块，食纳转佳。继续2个疗程后，斑片全消，肤色正常，且光滑有泽，月经

准期，未发痛经，精神面貌焕然一新。半年后随访未犯。

十四、耳穴贴压 刺血拔罐

赵钧采用耳针配合刺血拔罐的方法治疗黄褐斑，取得了良好效果。

耳穴贴压：主穴：肺、心、内分泌、面颊。肝气郁结者加肝、胆、三焦；肾虚加肾、三焦、内生殖器；脾虚加脾、肾、胃。常规消毒耳部皮肤后，以王不留行贴于6mm×6mm的胶布上，对准穴位贴牢并按压，嘱患者每日按压3~4次，每次2~3min，以耳部微热、微痛为度。每周更换1次，双耳交替。

刺血拔罐：取穴：大椎、肺俞、心俞、膈俞、肝俞、肾俞、大肠俞，每次选取3~4穴。常规消毒后，用三棱针点刺出血2~3下，或用皮肤针叩刺到皮肤微微发红，再在此部位上拔罐5~10min，将瘀血拔出。以上穴位均双侧取穴，交替使用，隔日1次，10次为1个疗程。

现代医学认为黄褐斑的发生多与体内激素分泌水平及一些慢性疾病有关，如贫血、肝脏病变、肿瘤、性生殖系统炎症、肾上腺皮质功能低下等，此外服用避孕药、过度日晒可为诱因。中医学认为其病因与脏腑功能失调有关，脾胃虚弱，肝气郁滞，肾气亏虚，均可致气血失和，气滞血瘀，经脉不畅，气血不能上荣于面而致黄褐斑。临床可分为脾虚、肝郁、肾虚三型。

中医学认为“耳者宗脉所聚”，十二经都直接或间接上达于耳，通过耳穴贴压，可疏通相应经络，调节各脏腑的功能，从而达到调和脾胃，舒肝理气，补益肾气的目的，使各脏腑气血调和而病除。

《灵枢·九针十二原》说：“凡用针者，虚则实之，满则泄之，苑陈则除之……。”可见若气滞血瘀，闭阻经络，可用放血疗法以活血化瘀，故选取相关脏腑的背俞穴，以放血拔罐的方法，既能舒通经络，活血化瘀，调和气血，又能有效刺激穴位，激发人体的阳气，平衡阴阳，调理脏腑功能。多数患者在治疗黄褐斑的同时，所伴有的痛经、腰痛、失眠、便秘等症状也有好转。

王某，女，35岁，营业员，2000年10月28日就诊。8年前无明显诱因面部出现少量斑点，随年龄增大，斑点增多变大，曾用多

种美容品无明显效果。现症见：面色晦黯，双侧面颊布满黄褐斑，失眠，健忘，双肋部胀痛，心烦易怒，伴痛经，经色黯、有块，经前双乳胀痛，舌质黯，少苔，脉沉细涩。诊断为黄褐斑，证属肝气郁结，气滞血瘀。治以疏肝理气，活血化瘀。选取耳穴肺、内分泌、面颊，配穴肝、胆、三焦、子宫，每日按压，同时选取大椎、肺俞（双）、肝俞（双）、胆俞（双），以三棱针点刺拔罐，隔日1次，双侧穴位交替应用。治疗2个疗程后，面部斑块明显变浅，面积减小，继续治疗2个疗程后，面部黄褐斑基本消退，面色红润，半年后随访，未见复发。

十五、飞腾八法 配刺血拔罐

朴联友采用飞腾八法针法，配合刺血拔罐治疗黄褐斑，取得良好效果。

针刺方法：采用飞腾八法针法的即时开穴为主穴，以内关配公孙，外关配临泣，后溪配申脉，列缺配照海的八脉交会穴配穴法取配穴，以配穴为客穴，每日针1次，5次为1个疗程，疗程间休息3~5天，继续下1个疗程治疗。

刺血拔罐：取大椎、肺俞、膈俞、心俞、肝俞。每次选取1穴，进行皮肤常规消毒后，用三棱针点刺出血或用皮肤针叩刺至皮肤微微发红，再行拔火罐。以上穴位交替使用，体壮者每日治疗1次，体弱者2~3天治疗1次，5天为1个疗程，疗程间休息3~5天。

飞腾八法是传统医学中的时间针法之一，是古人以天人合一的观点，根据大自然变化规律，结合人体各经脉气血周流盛衰的情况，运用八卦学说，将天干纳入八卦内，并配以奇经八脉八穴，指导临床开穴的一种针法。《灵枢·岁露论》中说：“人与天地相参也，与日月相应也”。朱丹溪亦认为：“天上地下，人生其中，脏腑气血亦与天地相为流通”。天有四时十二月，应人之十二经脉，所以人的经脉气血周流随着时间的不同也有着盛衰开阖的变化。针灸的调整作用则取决于机体所处的特定功能状态。《素问·八正神明论》说：“凡刺之法，必候日月星辰，四时八正之气，气定乃刺之”。把握时间，按时取穴，可以获得良好效果。

中医对面部色素沉着统称为黧黑斑，认为因肝郁气滞，肾阴亏

虚，脾胃虚弱，冲任失调等，均可致气血失和，经脉不畅，瘀血阻滞，气血不能上荣于面，故面部起黄褐色斑。

朴联友用飞腾八法治疗黄褐斑，是根据不同时辰人体经脉气血周流的变化，按时选取一组八脉交会穴治疗，从而协调全身阴阳，调理脏腑经络，益气养血，调节冲任，活血化瘀，疏通经络，使气血得以上荣于面，达到治疗目的。

《灵枢·九针十二原》说：“凡用针者，虚则实之，满则泄之，苑陈者除之……”，指出了针灸治病，若气滞血瘀，闭阻经络时，采用放血疗法，以活血祛瘀。黄褐斑的主要病机为瘀血阻滞，气血不能上荣于面，所以治疗时，配合刺血拔罐疗法，起到疏通经络、活血祛瘀的作用，使脉络通畅，气血上承于面，色斑消退。

崔某，女，39岁，会计，2000年1月8日9时初诊。主诉：10年前无明显诱因，面颊及唇周出现淡褐色斑，并逐渐加重，尤以近4年明显。伴有失眠、偏头痛，重时头痛如针刺，月经先期，色黯有块，大便秘结3~7天一行。曾自做面部按摩，面膜美容等，口服中成药治疗，疗效不显。刻下见：面色灰黄，布满黄褐色斑，额部、眼周、双侧面颊及唇周颜色呈深褐色，失眠、健忘、疲乏无力，右侧头部刺痛，胁肋胀痛，心烦易怒，此次月经提前1周来潮，色黯有血块，大便秘结，舌质暗红、少苔，脉沉细涩。诊断：黄褐斑，证属肝气郁结，气滞血瘀。治以疏肝理气，活血化瘀。采用飞腾八法，即时开穴为后溪，配以申脉，取大椎穴，用三棱针点刺3针后拔火罐，出血约1ml，血色呈紫黑色。治疗3次后黄褐斑均变浅，面色由灰黄渐见红色。治疗1个疗程后，色斑明显变浅，面色较前红润。治疗2个疗程后，患者大部分色斑消退，尤以额部、眼周围消退明显，但口周色斑仍较明显，5个疗程后患者颜面皮肤红润光泽，黄褐斑完全消退而告痊愈；伴随偏头痛、失眠症状明显改善，心烦易怒症状消失，月经如时来潮，色红无血块。因患者久病阴虚耗伤，嘱患者口服六味地黄丸调养，并尽量避免夏日强烈日光照射。

十六、辨证分型 割耳敷药

赵昱割耳敷药法辨证治疗黄褐斑，获得满意疗效。

临床分型：①肝气郁滞型：可见颜面、鼻周、额头深浅散在斑

块或蝶翼状褐斑，境界相对清晰，伴有两胁胀痛，心烦易怒，月经先后不定期，经量少，经期腹痛，经色黯，舌红苔黄，脉弦数。②脾胃湿热型：多见前额、口周、鼻部、眉间等处，边界不清，向心性逐步加深之斑块，伴有身重易疲倦，胸闷，渴而不饮，月经先期，经期延长，量多，有血块，苔黄腻，脉滑数。③阴虚火旺型：色斑以鼻额、两颧、唇周较集中，大小不等，边界不清，点状或片状散在，色斑较灰黯，伴有头晕，耳鸣，消瘦，五心烦热，口干，月经不调，量少，脉沉细，舌红少苔。

取穴：神门、内分泌、三焦、皮质下、子宫、肾上腺、缘中（脑点）。肝气郁滞型加肝、胆、肾；脾胃湿热型加脾、胃、艇中、大肠；阴虚火旺型加心、肾、小肠。

操作：经严格常规消毒后，用15号刀片的刀尖，在应取的耳穴上，用刺、划、挑等手法，使其局部皮肤少量渗血或出血，敷以沾有药粉的干棉球，塞于耳腔起到止血消炎活血化瘀的作用，然后用胶布固定，保持24h。每周2次，10次为1个疗程。药粉为自制，主要成分为熊胆、三七、大黄、白及、冰片等量研为粉状。

注意事项：每年6、7、8月份停止治疗，因夏季高温，每天洗浴容易引发耳软骨感染。

面部黄褐斑病因与内分泌失调，自主神经功能紊乱有关。日晒、物理性刺激是发病诱因。中医认为，该病发病机制与肝气郁结，失其条达，郁久化热，灼伤阴血，营气阻遏，致使颜面气血不畅，肾气不足，肾水不能上承濡养颜面；脾虚生化无源，肌肤失于濡养，因而发病。

因此治疗上必须治病求本，以内养外，不能只着眼局部。中医理论取耳穴肝、心、肾。因肝藏血，肾藏精，心主血脉，其华在面，精血相生，气血相荣，荣养肌肤则色斑可消。取脾胃穴，因脾胃为后天之本，可活气血，又可清热祛湿。内分泌、皮质下、神门等穴为现代医学功能穴位，取之则功能调矣。

皮某，女，36岁，职员，已婚，1999年9月2日初诊。主诉：面部出现色斑2年。曾外用祛斑霜，口服营养液、中西药无效。现患者鼻额、两颧大小不等黄褐斑，边界不清，面色黯，形体消瘦，伴有头晕、耳鸣、眼花、口干、尿少色黄、月经不调，有时2个月1

次月经，出血量少，色泽红，脉细，舌红少苔。辨证：阴虚火旺。
治则：滋阴清热。取穴：心、肾、小肠、膀胱、神门、内分泌、三焦、子宫、皮质下、肾上腺，割穴后外敷药粉。经2个疗程治疗后色斑消失，月经恢复正常。

十七、体耳穴并用 埋线为主

卢文采用埋线加耳穴点刺治疗黄褐斑，取得较好疗效。

体穴埋线：将0号胶原蛋白铬制医用羊肠线按无菌操作方法剪成1~2cm线段，浸泡在75%酒精中3天，针具为北京任晓艳穴位埋线医学研究中心发明的一次性使用任氏穴位埋线针。分3组取穴：①肺俞、脾俞、天枢（或大横）、手三里、足三里；②肝俞、肾俞、带脉、曲池、血海；③心俞、膈俞、膻中、气海、支沟、三阴交。伴有月经不调者，先取②组穴，再取①、③组穴；伴有睡眠障碍（失眠、多寐）者，先取③组穴，再取①、②组穴；伴有大便异常（便秘或便溏）及以上3症皆有或皆无者，均按①、②、③顺序取穴。穴位用安尔碘常规消毒，按穴位深浅选取不同长度肠线，用无菌眼科镊将肠线装入埋线针前端，背部穴位针尖斜向脊柱方向刺入1~1.5寸，有针感后注入肠线，腹部穴位直刺达肌层注入肠线，四肢穴位直刺达穴位深度有酸胀重等针感后注入肠线，肠线不得露出皮肤，出针后用消毒干棉球压盖针孔，24h后去除干棉球，不影响日常生活。前3次每隔15天治疗1次，后3次每隔1月治疗1次。

面部埋线：第3次体穴埋线后半个月予面部埋线。采用北京任晓艳穴位埋线医学研究中心监制的纳米祛皱线，一次性使用任晓艳穴位埋线专用针。取穴：印堂、阳白、太阳、颧髻、下关、迎香、地仓、承浆、阿是穴等，按黄褐斑分布区选取10~20穴次。操作方法：面部覆消毒洞巾，整个面部、医生双手用安尔碘常规消毒，把线体装入埋线针前端，在距离穴位0.5寸处，将针平刺入穴位，进针1寸左右后，边退针边推针芯，将线体埋入穴位皮下组织内，出针后用消毒纱布按压针孔至不出血。全部穴位埋线后，用消毒棉签蘸金霉素眼药膏涂布针孔，3天内用湿毛巾擦脸后再用金霉素眼药膏涂布针孔，不用化妆品，半月内不做面部美容。

耳针：取穴为相应部位（如额、面颊区、口）、肝、脾、肾、

心、肺、内分泌、缘中，大便异常加大肠、三焦，睡眠障碍加神门、交感，月经不调加内生殖器，每次选取4~5个穴位。75%酒精常规消毒耳廓皮肤，一侧采用耳穴点刺法，用左手在耳廓背后固定相应部位穴区，右手持一次性采血针具点刺穴位，以刺破表皮、渗出血珠为度，酒精棉球擦拭至渗血停止。对侧相应耳穴贴压王不留行籽，每周1次。两耳交替点刺、贴压。

黄褐斑中医又称面尘、黧黑斑、肝斑等，以女性多见。虽然仅表现于面部，但其实是脏腑功能失调的外在表现，所谓“有诸内必形诸外”。多由情志不遂、暴怒伤肝、思虑伤脾、惊恐伤肾致气机逆乱，气血悖逆，不能上营于面而生褐斑。其病机主要与肝、脾、肾三脏关系密切，但肺主气，心主血，要使逆乱的气血回复正常，治疗亦离不开心肺。又所谓“无瘀不成斑”，膈俞乃活血化瘀要穴，因此治疗选取五脏俞加膈俞，以整体调整五脏功能；脾胃为后天之本，气血生化之源，阳明经又为多气多血之经，因此取曲池、足三里、手三里、天枢、血海以行气活血；气为血之帅，取气会膻中和气海，以达补气调血、气行血行作用；三阴交为肝脾肾三经之交会穴。诸穴合用，使气血调和，斑消症愈。耳穴作为人体的一个全息胚，具有整体调整全身各系统功能的作用。

埋线疗法治疗疾病的过程，初为机械刺激，后为生物学和化学刺激，具有短期速效和长期续效两种作用方式。针具刺激产生的针刺效应和埋线时渗血起的刺血效应，是短期速效作用；埋线时穴位处机体组织损伤的后作用，肠线在体内特殊的留针和埋针效应及其组织疗法效应，又可起到长期续效作用。人体上为阳下为阴，左为阳右为阴，后为阳前为阴，埋线疗法可以同时选取人体上下、左右、前后不同阴阳部位的腧穴，其配穴可以形成一种远近、上下、前后、左右的相互呼应的阵势，交通阴阳，沟通各经气血，来达到协调脏腑气血阴阳以治疗疾病的目的。

十八、局部刮痧为主 行气消斑

孔维枝运用刮痧加中药治疗面部黄褐斑取得了较好疗效。

操作：全息穴位循经刮痧法，身体的某一脏腑发生病变或失去平衡，在面上的某一部位就会发生变化。“脉三百六十五络，其气血

皆上注于面，而走空窍，其气血津液皆上薰于面”。刮痧治疗前先观察斑片的位置，对应特定的反射区，以三焦理论对应面部，中医将人的面部眼睛以上区域定为上焦，眼睛以下鼻以上定为中焦，鼻以下为下焦。此三焦“上、中、下”又对应人体三部分，上焦为心肺，中焦为脾胃，下焦为肝肾。上焦心肺对应于面部：眉中印堂一肺，鼻梁顶端一心。中焦对应于面部：鼻尖一脾，鼻翼一胃。下焦对应于面部：左侧面颊一肝，右侧面颊一胆，颧下一大肠，下颌一肾及泌尿系统。

遵循中医法则依据：“顺经为补，逆经为泻”的原则，因人而施用补法、泻法，平补平泻法手法，一般先从头开始，头部为诸阳之会，面部又是十二条经络中手足三阳经经过，并有督脉所主，先打通督脉，再进行面部刮痧，操作时先洗净面部，涂以中药制成的膏体，配以中草药离子喷雾，用玉板或牛角板均可，先中间路线：百会-上星-印堂-素髻。再刮两边路线三条：第一条线路，承浆-大迎-下关-太阳。第二条线路：地仓-颧髻-上关-太阳。第三条线路：人中-迎香-四白-听宫-太阳。以上经络均使用点、揉、挑、扭、刮、摩、托等手法，刮拭10~30min，初次面部会轻微出痧，2~3次后就不出了，毛孔张开后敷以中药加珍珠粉加蜂蜜调和的面膜40~50min后洗去。一般受术者感觉面部微热，个别敏感者会有眼周面颊、发际处感觉有轻微跳动或蚁行感，大多数在洗去面膜后恢复正常。每3天1次，12次为1个疗程，重症为2个疗程，视症状轻重加服中药，如复方丹参片、四物汤加减、逍遥散、六味地黄丸等。

黄褐斑系为气滞血瘀，肝肾功能失调所致。隋·巢元方认为“痰饮渍藏，或腠理受风，致血气不荣于皮肤而成”。明·陈实功在《外科正宗》中也有记载“黧黑斑者，水亏不能制火，血弱不能华肉，以致为燥结成斑黑”。清·王清任认为本病为血瘀证。

孔维枝根据久病入络的原理，施以刮痧通络，使体内瘀血得以清理，澄清经络，使之得以疏通，气血运行通畅。面部刮痧美容法，是根据刮痧治病的原理派生出来的一种新颖疗肤法。它根据面部生理结构，设计专用的刮痧板，如牛角板，优质玉材刮板等，由于这些刮具都可以入药，对人体有凉血解毒，活血化瘀，调整阴阳，舒

筋活络，排毒抗氧等作用。而介质是由多种中草药精练而成，用中医脏腑经络学说理论为指导，治疗部位则按中医经络原理，同时，面部经络受刮拭刺激而产生热效应，使颜面局部血容量和血流量增加，激活弱细胞，促使代谢产物交换排出，氧化、修复、更新而发挥正常作用，最终达到排毒养颜、行气消斑、活血除疮、抗氧嫩白、保肤健美的效果。

十九、辨证取穴 面部浅刺配闪罐

黄褐斑多呈对称性分布，又称为蝴蝶斑。常英采用面部浅刺配合闪罐法治疗黄褐斑，效果满意。

取穴：主穴据发斑部位：额部为阳白，鼻部为印堂、迎香，颧部为颧髎、四白，颊部为颊车，再取斑重部位阿是穴，每次取4~5主穴。配穴据辨证远端取穴：肝郁者加太冲、行间、肝俞，脾虚者加丰隆、三阴交、脾俞，肾阴亏虚者加太溪，气血不畅者加血海、膈俞。

操作：先用小号火罐在面部行闪罐20~30次，尤其是发斑较重的区域，然后用1寸毫针浅刺于面部皮下，远端穴位可适当深些，得气后留针25min出针。每日1次，10次为1个疗程。

祖国医学认为，黄褐斑的发生与脏腑功能失常，气血失调有密切关系。情志不舒，思虑伤脾，惊恐伤肾等使气血逆乱，不能上荣于面所致。治疗时既要着重改善面部的血液循环，增加其供血供氧，又要注重调理脏腑的气血功能。局部取穴可疏通面部经络，调和气血，促进病变部位的血液循环，促进表皮细胞的新陈代谢，减少色素沉着，而面部闪罐可激发经气，达到治标的目的。辨证取穴则有调整脏腑，疏通经络，消瘀散斑，达到治本的作用。针刺治疗以疏肝解郁，健脾补血，滋肾养阴为主。脾胃为气血生化之源故取脾经的三阴交，可调血气；面部为阳明经的循行之处，足三里为足阳明经合穴，而阳明经为多气多血之经，故二穴共奏行气活血之效。太冲有疏肝解郁的作用，脾俞为背俞穴，可调节脏腑气机。由于十二经脉都直接或间接地联系于面部，故可疏通脏腑经络，使各经脉气血运行通畅，减少色素沉着，以使皮肤恢复正常。

张某，女，50岁。2006年5月10日就诊。患者半年前面部出

现黄褐斑，两边对称分布于颧部，呈淡褐色，神疲面黄，舌淡脉细。自诉曾用美容品出现过敏现象，颜色逐渐加深。该患者就诊后，笔者采用本法，局部闪罐后取穴阳白、四白、太阳、颧髎、迎香、脾俞（快针）、合谷、足三里、三阴交、太冲，治疗10次后斑点变浅，中心露出正常肤色，30次后斑点逐渐淡化消失，随访半年未复发。

二十、远端取穴为主 辨证施治

王秀颖采用远端取穴针刺为主，配合局部围刺，治疗黄褐斑，效果满意。

取穴：远端取穴为主。主穴：太冲、通里、三阴交。配穴：肝郁型配肝俞、胆俞、期门、日月、膻中、行间；脾虚型配太白、百会、气海、足三里、脾俞、胃俞、内关；肾虚型配太溪、神门、心俞、肾俞、绝骨、关元。同时辅以黄褐斑局部围刺，按辨证分型，针刺面部主要交会穴及临近穴，如颧髎、下关、地仓、口禾髎、巨髎、四白、迎香等。

操作：针刺穴位常规消毒，面部针用直径0.30mm。每次治疗针刺主穴并选配穴2~3穴，针法以提插得气，再行提插补泻。黄褐斑围刺及面部穴位，禁忌提插捻转，黄褐斑围刺针距2cm左右，以达周围皮肤红晕为宜。留针20~40min，10次为1个疗程，一般隔日1次，对重度患者，首疗程每日1次。治疗期间，要求患者合理安排工作、生活，保持心情舒畅，面部忌厚涂擦化妆品，避免日晒。

王秀颖认为，黄褐斑应理清其病因病机，辨证施治，是取效满意的关键。中医学认为，本病多因情志失调，阴阳失衡，肝脾肾功能失调以及各种原因导致气滞血瘀，其病理过程多为肝气郁结，郁而化火。伤阴，虚火上扰，导致气血运行不畅，血瘀颜面成斑；或饮食不节，脾失健运，清阳不升，浊阴不降，以及房室不节，耗伤精血，导致精血不足，脉络空虚不能荣颜而成斑。治疗时以整体观念、辨证施治为指导思想，针对黄褐斑多发生于女性这一特点，采用远端取穴太冲、通里、三阴交为主穴针刺治疗。女子以血为本，肝藏血，又主疏泄，肝所藏之血，能够防止肝气上升太过，对保持肝疏泄功能正常，具有重要意义。而血之为用，全赖于气，气能生血、行血及摄血，若情志失调，肝失疏泄，则影响血液运行，女性

经血、胎产、哺乳等特殊生理过程，极易伤及肝血，同时女性又极易受心理、社会等因素影响，而导致情志失调，终致气血不畅而成斑。太冲，为足厥阴肝经原穴，又为输穴，具有疏肝理气、养血之功效；心主血脉，而藏神，通里为手少阴心经之络穴，具有通经活络、清心宁神之功效；三阴交，为足之三阴之交会穴，一穴三脏，具有健脾养血、调肝益肾、平和冲任之功效。三穴为主相伍，共奏疏肝健脾益肾、通经活络之功效，辅以配穴、局部取穴加围刺等，使气血调畅，而养颜祛斑，以内达外，内外合治，治标又治本，不仅祛除了黄褐斑，还具有美白肌肤、强身健体之效。

二十一、背部走罐 梅花针叩刺

李树香采用背部走罐加梅花针叩刺的方法治疗黄褐斑，疗效满意。

取穴：督脉（大椎～长强），足太阳膀胱经（大杼～白环俞）。

操作：患者取俯卧位，将液状石蜡涂于所取的经络上，根据患者的胖瘦、体质的强弱选用大号或中号的玻璃火罐，用闪火法把火罐拔在大椎穴或大杼穴上。用双手握住火罐循经由上而下缓缓用力走罐，每条经络走罐3～4次，直至皮肤红紫或出现紫红色瘀点为度，每次选瘀点比较大的5～7个，局部皮肤常规消毒后，用梅花针叩打。对痛觉敏感者，可用左手大拇指和食指将瘀点部捏起，改用三棱针快速点刺2～3下，出血部位拔罐5～10min，将瘀血拔出，瘀点将随着病情的好转而数量减少。隔日治疗1次，10次为1个疗程。

《灵枢·邪气脏腑病形》曰：“十二经脉，三百六十五络，其血气皆上于面。”面色是脏腑气血的外荣。李树香认为：黄褐斑是脏腑功能失调，气血不能运行于面的外在表现。治疗时，应重点调理脏腑气血功能，也可根据不同伴随症状，适当加服中药，整体调节，根治此病。

循经走罐是以十二经脉皮部与十二经脉、十二脏腑相通的理论为依据。采用督脉、足太阳膀胱经背部走罐的方法，有效地刺激穴位，可达到疏通经络，激发人体的阳气，平衡阴阳，调理脏腑的功能。皮下紫红色瘀点的放血拔罐，可鼓舞正气，以驱外邪，使气血调和。背部走罐加梅花针叩刺治疗黄褐斑的同时，患者的伴随症状

如月经不调、腰痛、腹泻、便秘、失眠等也一同好转或消失。

治疗期间嘱患者注意保持心情舒畅，生活作息有规律，多食水果蔬菜，外出时要避免阳光的照射，不要使用劣质的化妆品。

董某，女，38岁，干部，1998年3月18日就诊。主诉：面部黄褐斑6年，近1月加重。曾服中药和外用祛斑霜后减轻，一段时间后又复发。望诊：面部无光泽，双颊及额头部呈片状黄褐斑，边界清楚，伴有月经后期，量少色黯有瘀块，经前乳房胀痛。舌红，苔薄白，整舌上可见散在的瘀点，脉弦。诊断：黄褐斑。采用上述方法治疗1个疗程后，面部斑块明显变浅，面积变小，3个疗程后，面部黄褐斑全部消失，皮肤光洁健康，伴随症状消失，治愈。随访1年未复发。

二十二、针刺为主 神阙隔盐灸

老锦雄采用针刺加神阙隔盐灸治疗黄褐斑，取得较满意疗效。

取穴：主穴：颧髎、太阳、曲池、血海、三阴交、足三里、肺俞。配穴：肝郁气滞型加合谷、太冲、肝俞；胃肠积滞型加天枢、中脘、上巨虚；脾肾两虚型加关元、脾俞、肾俞；失眠加安眠、神门、照海。

操作：常规消毒后，面部穴选用0.5寸的毫针，其他部位选用1寸的毫针，直刺进针，得气后，留针30min。同时用纯净干燥的食盐填敷于脐部（神阙穴），使其与脐平上置艾炷，施灸3壮。每周治疗2次，8次为1个疗程。

《医林改错》认为本病是血瘀皮里而成，其病虽在外，实因内而发，治宜外病内治而求其本。故针刺治以疏肝解郁、行气活血、健脾消滞、滋肾养阴为主。脾胃为后天之本，气血生化之源，故取脾经之血海以调血补血；气为血之帅，肺俞与血海共奏补气理血之功；曲池、足三里分别为手足阳明经之合穴，阳明为多气多血之经，故两穴合用共奏行气活血之效；三阴交乃足三阴经之会穴，颧髎、太阳为面部气血所经，神阙是任脉穴，先天之本，诸穴合用，达到调整脏腑、疏通经络、调理气血、祛瘀生新的目的，使腠理得养，肤色光泽。艾叶味苦，性辛微温，入脾、肝、肾经，《别录》：艾叶“主灸百病”，《本草再新》：艾叶可“调经开郁，理气行血”，盐入

肾，隔盐灸产生的热量是一种有效并适应于机体治疗的物理因子，其近红外线具有较高的穿透力，被人体吸收，可促进血管扩张，改善局部血液循环。神阙穴隔盐灸既可以疏通任脉经气，调和阴阳、理气和血，又可以起到固本回阳、疏通局部经络的作用。

沈某，33岁，干部。患面部黄褐斑2年，近半年加重，以双颧、面颊部为甚，呈褐色。经药物面膜治疗效果不佳，伴有月经不定期，经行不畅，量少，色黯有血块，睡眠差，舌质淡黯，舌尖有瘀点，苔薄黄，脉弦。曾在当地各大医院做妇科B超未发现异常。选取颧髻、太阳、曲池、血海、三阴交、足三里、合谷、太冲针刺，进针得气后，留针30min，并配合神阙隔盐灸。治疗1个疗程后，面部色斑明显变淡，月经恢复正常，睡眠好。治疗2个疗程，面部色斑基本消退，改每周治疗1次，巩固治疗4次，追踪观察1个月未见复发。

二十三、耳穴贴压配刺血 祛瘀除斑

周志英采用耳穴贴压配合刺血疗法治疗黄褐斑，疗效显著。

(1) 刺血疗法

主穴：耳廓上相应色斑部位；配穴：耳尖、大椎、血海等。

操作：每次选1~2穴，进行皮肤常规消毒后，用三棱针点刺出血1~2滴。体壮者每日1次，体弱者3天1次。相应耳穴刺血后不做磁珠贴压。

(2) 耳穴贴压法

主穴：缘中、肾上腺、皮质下、内分泌、肾、肝、脾、肺。

配穴：月经不调者加取内生殖器、卵巢；再根据临床辨证（肝气郁结、气滞血瘀、脾虚湿热、肾气不足、肾阴虚等）所涉及的脏腑经络及黄褐斑具体的部位选取耳穴。

选用材料：耳贴磁珠。

操作：每次选一侧耳廓，两侧交替使用。常规消毒耳廓皮肤，根据所取耳穴，用自己制作的小棉签探测敏感点进行磁珠贴压，无敏感点按耳穴定位贴压。根据辨证每次选取耳穴5~8个，皮质下、内生殖器、内分泌可交替使用。同时嘱病人每天适度按压各穴3~4次，每次每穴2min左右。夏季每侧耳廓贴3天左右，其他季

节4~6天。

疗程：上述耳贴、刺血疗法同时进行，连续治疗1个月后休息7天，再进行下1个疗程的治疗。

黄褐斑主要为肝郁气滞，肾虚脾弱，冲任失调，导致气血失和，经脉不畅，瘀血阻滞，气血不能上荣于面所致。俗称蝴蝶斑、面尘、黎黑斑。

所取耳穴均针对病因，如：缘中、肾上腺、内分泌能调节脑垂体及内分泌的功能，促脑垂体分泌抗黑色素细胞刺激素，减少黑色素分泌，调节肌肤营养供应，促使色素斑消退。肾、肝、脾：有补肾益精、疏肝解郁、活血去瘀，改变面部黎黑之功。内生殖器、卵巢主治月经不调。相应部位点刺放血可激发经络感传，将治疗信息输入相应病变部位；放血疗法活血通络，祛瘀除斑。

张某某，女，43岁，教师，2002年5月19日初诊。自诉6年前无意中发现两颧部淡淡的色素沉着，因素体健康，未加重视。渐渐色斑颜色加深，面积扩大。就诊时见鼻梁、两侧面颊、口周围布满黄褐斑。并伴有失眠健忘，头痛乏力，胁肋胀满，月经不调，经行腹痛，色深夹有瘀块，常便秘，舌质黯，脉弦细。诊为黄褐斑，辨证为肝气郁结，气滞血瘀。取穴：面颊区、外鼻、大椎、血海交替刺血；缘中、肾上腺、皮质下、内分泌、肾、肝、脾、肺、内生殖器、卵巢等交替贴压磁珠。1个月治疗后色斑明显变浅；2个月后，色斑基本消退，只有两颧部隐隐可见，面色也显红润；4个月后，面部黄褐斑全部消退，颜面皮肤光洁润泽。伴随症状明显改善，精神饱满，月经正常。

参 考 文 献

- [1] 王萍，李荷英．背部走罐配合刺络放血治疗黄褐斑29例．甘肃中医，2007，20（10）：39~40
- [2] 肖平，孙远征，侯慧先．督脉埋针治疗女性黄褐斑的临床研究．针灸临床杂志，2005，21（6）：21~22
- [3] 刘剑梅，李慧珍．耳穴贴压磁珠治疗黄褐斑80例小结．甘肃中医，2000，（3）：43

- [4] 张学丽, 朴联友. 灵龟八法针法配合耳穴治疗黄褐斑 32 例. 针灸临床杂志, 2002, 18 (6): 33
- [5] 李子勇, 老锦雄. 面部挂针加直接灸治疗黄褐斑 68 例. 中国民间疗法, 2006, 14 (6): 17~18
- [6] 刘玉洁. 针灸配合中药治疗黄褐斑 65 例. 湖北中医杂志, 2006, 28 (9): 50
- [7] 史连俊. 背部走罐加局部围刺治疗黄褐斑 60 例. 北京中医, 2007, 26 (7): 427
- [8] 王民集, 杨东梅. 背俞穴刺血拔罐法治疗黄褐斑 80 例. 江西中医药, 2006, 37 (5): 45
- [9] 卜彤文, 田新乐, 张雅兰, 等. 背俞穴推罐配合药膏按摩治疗黄褐斑 40 例. 浙江中医杂志, 2003 (10): 435
- [10] 尚蓉. 背俞穴注射治疗黄褐斑 85 例. 贵阳医学院学报, 2001, 26 (3): 268~269
- [11] 刘丽, 李文丽, 满伟. 刺络拔罐配合耳穴贴压治疗黄褐斑的疗效观察. 河北中医药学报, 2006, 21 (2): 30~31
- [12] 李杰. 耳穴刺络法治疗黄褐斑 60 例. 中国民间疗法, 2006, 14 (7): 21~22
- [13] 李晓泓. 耳穴刺血及压籽治疗黄褐斑. 北京中医药大学学报, 1995, 18 (2): 62
- [14] 赵钧, 毕伟莲. 耳穴配合刺血拔罐治疗黄褐斑 40 例. 中国中医药信息杂志, 2002, 9 (3): 66
- [15] 朴联友, 郝广义, 段跃武, 等. 飞腾八法配合刺血拔罐治疗黄褐斑 30 例. 中国针灸, 2001, 21 (7): 415~416
- [16] 赵昱. 割耳敷药法治疗黄褐斑 40 例临床观察. 中国针灸, 2001, 21 (4): 215~216
- [17] 卢文, 斯维特娜·曼恩. 埋线为主治疗黄褐斑临床观察. 中国针灸, 2006, 26 (10): 713~715
- [18] 孔维枝, 周迎春. 面部刮痧加中药治疗黄褐斑 38 例. 河南中医, 2005, 25 (1): 50~51
- [19] 常英, 张娟, 何君君. 面部浅刺配合闪罐法治疗黄褐斑 49 例. 浙江中医杂志, 2007, 42 (8): 472
- [20] 王秀颖. 远端取穴为主治疗黄褐斑 50 例. 辽宁中医杂志, 2000, 27 (3): 139
- [21] 李树香. 背部走罐加梅花针叩刺治疗黄褐斑 66 例. 中国针灸, 2001, 21

(7): 436

- [22] 老锦雄, 李子勇. 针刺加神阙隔盐灸治疗黄褐斑 60 例疗效观察. 中国针灸, 2005, 25 (1): 35~36
- [23] 周志英. 耳穴贴压配合刺血疗法治疗黄褐斑 45 例. 针灸临床杂志, 2005, 21 (8): 43

【男性更年期综合征】

男性更年期综合征是男子从成年向老年过渡阶段出现的，以潮热出汗、情绪及性格异常、阳痿为主症的临床疾病，祖国医学虽无更年期之名，却有不少类似的记载。中医归属于阳痿、郁证、衰老等病。

男性更年期综合征的出现，中医认为与肝、肾、脾、心的关系密切，其中尤与肾气的虚衰有关。《内经》载：“丈夫……五八，肾气衰，发堕齿槁。六八，阳气衰竭于上，面焦，发鬓斑白。七八，肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾脏衰，形体皆极。八八齿发去。”肝藏血，主筋，主疏泄，肝气衰，肝血虚，则筋失所养，筋不能动，情志抑郁，孤独怪癖；肾藏精，主骨，肾气衰，精不足，天癸竭，情欲减退，骨节疼痛。本病属虚实夹杂，本虚而标实。肾气虚衰为其根本所在，痰瘀内阻为其标。治疗多采用疏肝解郁，滋阴潜阳，理气活血，补肾填精，温肾助阳等法。

该篇共收录了3位针灸医家的临床治验，有的采用耳压为主，配合心理治疗；有的采用针刺结合有氧运动，疏肝健脾；有的采用针推为主，综合治疗等，对该病的治疗均有不同的疗效。

一、耳压为主 配心理治疗

男性更年期综合征是男性从中年期过渡到老年期这一特定年龄阶段所出现的一种临床综合症状，其病因多样化，临床症状和体征繁多。患者主诉往往多而复杂，有的情绪不稳定。庄田畋采用耳穴贴压结合心理支持疗法治疗男性更年期综合征，疗效满意。

耳穴贴压：取穴神门、交感、心、肾、肝、脾、内生殖器、皮质下、内分泌。每次取一侧耳穴，以王不留行籽贴压，双耳交替，隔日换贴1次。每日按压所贴耳穴3~6次，每次5min，以耳廓微有胀、麻、痛或灼热感为度。15次为1个疗程。

心理支持治疗：耐心分析解释病情，让患者理解更年期是不以人的意志为转移的自然规律；鼓励患者努力提高自我控制能力，善于自我宽解，科学调理，消除紧张、焦虑等不良情绪；指导患者良好的生活习惯，避免过度劳累，从而达到最优的配合疗效。同时使用暗示疗法，在按压耳穴施以手法时，暗示患者症状即将或已经逐渐减轻。

祖国医学认为，天癸是主宰人生长壮老己的物质。而天癸竭则是导致男性更年期综合征的病机之根本。《素问·上古天真论》说：“丈夫……五八肾气衰，发堕齿槁；六八阳气衰竭于上，面焦，发鬓斑白；七八肝气衰，筋不能动，八八天癸竭，精少，肾脏衰，形体皆极，则齿发去。”《灵枢·天年篇》说：“五十岁，肝气始衰，……目始不明。六十岁，心气始衰……血气懈惰”。男性至更年期，由于肾气渐衰，天癸渐竭，精血日趋不足，导致阴阳平衡失调，脏腑功能紊乱，继而出现各种症状。因此，对本病的辨证治疗应重在肝肾，兼顾心脾，舒畅气血。现代医学认为，本病是由于机体逐渐衰老，内分泌功能尤其是性腺功能减退，男性激素调节紊乱而出现以生殖生理和自主神经系统功能紊乱为主的临床综合征。其中主要是由雄激素部分缺乏引起的男性更年期综合征又称为中老年男性部分雄激素缺乏综合征。

中医认为耳和全身五脏六腑都有密切联系，《灵枢·口问》篇云：“耳者，宗脉之所聚也”。有研究表明，耳穴贴压的作用机制在于对神经内分泌系统的整体调节，可调整自主神经系统，促使紊乱

的自主神经功能恢复正常,还可调整和改善中枢一下丘脑—垂体—性腺轴的功能状态,促使机体内分泌环境达到相对平衡的状态,从而纠正内分泌紊乱。选取肝、肾、心、神门、脾穴用以疏肝解郁,调节情志,滋补肾精,宁心安神,健脾运湿。取肾穴配内生殖器、内分泌以调节性激素水平,交感穴调节自主神经功能,皮质下穴补髓益脑,调整大脑皮层的兴奋与抑制。诸穴配合,标本兼治,调和气血,协调脏腑经络,平衡阴阳,使阴阳平复,疾患得愈。

二、针刺配有氧运动 疏肝健脾

男性更年期综合征是指发生在男性中年期过渡到老年期特定年龄阶段出现的更年期症状,又称中老年男性部分雄激素缺乏综合征。宋连柱采用传统针刺结合有氧运动治疗男性更年期综合征,疗效满意。

取穴:主穴取百会、上星、率谷(双)、水沟、外关(双)、阳陵泉(双)、三阴交。配穴取手三里(双)、足三里(双)、太溪(双)、太冲(双)。

操作:选用1.5寸毫针备用,穴位常规消毒,百会、上星、率谷(双)沿头皮针尖向后平刺1寸;水沟直刺0.2寸,施雀啄术,中等刺激强度,使患者眼球湿润为度;其余穴位直刺1寸,施以平补平泻手法,使针下得气即可,留针30min。每日1次,20次为1个疗程。疗程间休息2天。

有氧运动:根据患者身体状况及运动爱好。指导进行太极拳、健身跑、快走运动。20天为1个疗程,开始第1疗程隔日1次,每次30min。后2个疗程每日1次,每次30min以上,45min以下。患者运动前、中、后各测心率1次,控制心率增加不超过患者安静心率的20%。

男性更年期综合征是以男性体内激素水平和心理状态由盛而衰的转变为基础的过渡时期,如果表现得过于激烈,并表现出一定程度的身心异常的症状或体征时,则称为男性更年期综合征。

针刺百会、上星、率谷(双)、水沟、外关(双)、阳陵泉(双)、三阴交具有醒脑开窍、恢复脏腑阴阳平衡及人体内分泌的作用,配以针刺手三里(双)、足三里(双)、太溪(双)、太冲

(双),具有疏肝健脾、补益气血的作用,全面调整中老年男性身体状态及各脏腑之间的关系。结合适当的有氧运动,可改善神经系统的功能,维持中枢神经系统的紧张度,调节自主神经系统的兴奋性,从而使各系统器官的功能趋向正常;科学的运动还能使酶的活性增强,提高患者机体的代谢能力;参加运动可反射性地引起大脑皮层和丘脑包括下丘脑部位兴奋性提高,从而调节心脏活动、内分泌活动、体温、饮食和情绪等,产生良好、愉快的情绪,促进机体的康复。

三、针推为主 综合治疗

男性更年期,中医学称为男子脏躁,多因年老肾气渐衰,天癸将竭,脏腑功能失调而出现一系列症状。耿鹏采用针灸推拿配合心理疗法治疗本病,疗效满意。

推拿:患者俯卧位,医者用单手多指或双手多指拿揉颈项部,用双手多指揉枕骨下缘,然后双手食指或中指端自风府穴向两侧分别按压枕骨下缘,中指按揉风池、安眠等穴,操作3~6min;双手掌自上而下推抚背腰及下肢部,对揉背腰部,双手拇指交替按揉华佗夹脊穴胸腰段,重点刺激背腰部腧穴,握拿叩背腰部,单掌搓擦肾俞、八髎等,操作8~10min;拿揉叩下肢,重点按揉环跳、委中、承山、昆仑、太溪及跟腱、掌跟或鱼际,搓擦、按揉、叩涌泉及足底,操作3~5min。患者仰卧位,医者用双手掌推抚胸部,对揉对挤,搓擦肋部,拇指按揉膻中、期门、章门、云门等,操作3~5min;双手掌推摩、揉腕腹,拇指按揉中脘、关元、中极、曲骨等,操作4~6min;双手掌推、拿揉、叩四肢,双手拇指同取内关、神门、劳宫、足三里、三阴交、太冲等,操作4~6min。患者坐位,医者双手多指拿揉、推抖、敲击、抓打头部,拇指按揉印堂、头维、太阳、百会、四神聪,操作6~8min。

针灸:选取印堂、头维、太阳、百会、四神聪、风池、风府、安眠、肺俞、心俞、肝俞、肾俞、三阴交、足三里、太冲、太白、内关、合谷、神门、云门、章门、中脘、关元、中极等,分成三组,交替针刺,一般留针30min。

心理治疗:一般施以劝说开导法,调和患者情志;或施以暗示

解惑法，消除患者疑虑；或施以移情易性法，解除消极思想情绪；或施以情胜情法，调畅气机。

肾气虚是男性更年期综合征的主要病机，治疗上应补肾气，养肝阴，调脾胃，益神志。推拿背腰部，搓擦命门、肾俞、推揉、叩下肢部，针刺背腰部及下肢部腧穴，能调五脏，温肾阳，壮筋骨；推拿胁肋、胸腹及四肢，配合针刺相应部位的腧穴，能健脾和胃，疏肝理气，养血滋阴；推拿、针刺头颈部能除虚烦，安神志。治神就是心理疗法，其理论基础建立在形与神之间辨证关系上。推拿、针灸、心理治疗三管齐下，故疗效显著。

参 考 文 献

- [1] 庄田畋. 耳穴贴压结合心理疗法治疗男性更年期综合征 93 例. 陕西中医, 2006, 27 (7): 859 ~ 861
- [2] 宋连柱, 李辉, 葛建强, 等. 针刺结合有氧运动治疗男性更年期综合征临床观察. 辽宁中医杂志, 2005, 32 (5): 467
- [3] 耿鹏. 针灸推拿配合心理疗法治疗男性更年期综合征 68 例. 中国民间疗法, 2006, 14 (10): 52 ~ 53

【女性更年期综合征】

女性更年期综合征指妇女在绝经前后，出现一系列诸如月经紊乱、眩晕耳鸣、烘热汗出、面红潮热、烦躁易怒或面目肢体浮肿、腰膝酸软等症状。中医学虽无更年期综合征之病名，但在脏躁、绝经前后诸证、虚劳等篇中或见到有关此病的论述。如《内经》云“……七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子”，“年四十而阴气自半”，说明肾虚是本病的根本问题。

中医学认为，本病因肾气由盛渐衰，天癸由少渐至衰竭，冲任二脉也衰少，同时受素体阴阳偏胜偏衰，宿有痼疾，或家庭社会等环境改变而发病。病位主要在肾，病机要点为肾气渐衰，冲任亏虚，天癸将竭，阴阳平衡失调，脏腑功能紊乱。究其病性，在本为肾阴阳两虚，可累及心肝脾等多脏；在标为气滞。临证以扶正为主，兼以理气调肾以治本。

该篇共收录了 20 位针灸医家的临床治验，有的以电针为主，辨证施治；有的采用耳穴贴压；有的取五脏俞加膈俞，调理脏腑；有的采用穴位埋线，滋补肾气；有的采用上下配穴，针用补法；有的从整体入手，调理冲任；有的采用俞募配穴，协调阴阳；有的采用针药结合等，治法各异，疗效明显。

一、既病防变 电针配耳压

更年期是指人体由中年向老年过渡的生理时期，也是人体生理功能由旺盛走向衰退的转折点。随着现代社会的快速发展，工作与生活节奏日益加快，人们心理所要承受的竞争压力越来越大。更年期综合征的发病越来越普遍，尤其以女性知识分子为甚。现代医学对更年期综合征治疗颇为棘手，往往效果欠佳。中医重在“未病先防，既病防变”，在“既病防变”原则的指导下，陈贵珍运用电针结合耳压治疗女性更年期综合征。

取穴：主穴：取四神聪、内关、三阴交、气海；配穴：肝肾阴虚配太冲、太溪、肝俞、肾俞；脾肾阳虚配脾俞、肾俞；心肾不交配心俞、肾俞。耳穴：神门、交感、心、肝、肾、内分泌、三焦。

操作：常规消毒诸穴，四神聪选用 30 号 1.5 寸毫针平刺入 0.5 ~ 1 寸，接上海产 G6805 型电针仪，通以连续波，强度以患者能耐受为宜，局部以弱胀感或重压感为佳；内关、太冲、太溪、三阴交直刺 1 ~ 1.5 寸，得气后施平补平泻手法；气海直刺 1 ~ 1.5 寸，待针下产生感应后，退针至皮下平刺，使针尖朝下，针感缓缓传至会阴部；肝俞、肾俞、脾俞、心俞直刺 0.5 ~ 1.0 寸，施捻转补法，留针 30min，脾肾阳虚可重灸脾俞、肾俞，每日 1 次；同时用胶布将王不留行籽贴压于神门、交感、心、肝、肾、内分泌、三焦等耳穴，两耳交替进行，3 ~ 5 天换 1 次，每日按压刺激 3 ~ 4 次，每次每穴 1 ~ 2min，以轻刺激为宜。针刺及耳压均 5 天为 1 个疗程，每疗程间隔 2 天，待症状稳定后，仍予以耳穴贴压 1 ~ 2 个疗程。

更年期是人体由“壮”向“老”过渡的生理时期，此时，由于性腺发生退行性改变，加上人们往往对此期的生理、心理缺乏正确的认识，致使下丘脑—垂体—性腺轴之间的平衡制约关系失调，而导致一系列全身性的病理变化，临床以精神症状、自主神经功能紊乱、性格障碍等为其主要表现。

更年期综合征病因病机乃肾气衰，天癸竭，冲任亏虚致气血失调，机体阴阳失衡所致，针刺的目的在于行气血，调阴阳，使得“阴平阳秘，精神乃治”。四神聪穴位于百会穴前后左右各旁开一寸处；百会属督脉，督脉统诸阳，为阳脉之海，故刺之可引阳入阴，

使昼夜阴阳转运得以正常，同时该穴位于脑府，脑为元神之府，刺之还有壮阳气，益精髓，补脑养心，镇静安神之功，内关为心包之络穴，与四神聪相配，增强其宁心安神之效；气海穴为任脉之要穴，乃先天元气之海，刺之既可补气又可理气，三阴交为脾之络穴，又为足三阴经之会穴，二穴相伍，可健脾益气，调理冲任；肝俞、肾俞、太冲、太溪相配，有育阴潜阳之功，滋水涵木之效；选取耳穴神门、交感、内分泌、三焦、心、肝、肾乃遵循“辨病与辨证结合，治标与治本兼顾”的原则，共奏补肾气、益精血、调冲任、宁心神之功，使诸症皆消。

郑某，女，49岁，工人。初诊日期：2000年2月28日。主诉：头晕，寐差，月经周期紊乱年余，伴有恐惧，焦虑，恶风，每遇邪风劲吹则自觉头痛如针刺，全身乏力，四肢酸软，曾在本院以郁证行中药治疗，效果欠佳。现症见：头晕，心悸，恶风，头麻痛欲戴帽，全身酸麻，四肢乏力，心中烦乱，夜不成寐，咽中如有物梗，吞之不下，吐之不出，月经紊乱，先后不定期，口干，舌尖红，少苔，中有裂痕，脉细。头颅CT及脑电图检查均正常。拟诊为更年期综合征（绝经前后诸证），采用上述针刺方法，并在治疗时进行必要的心理疏导。经针刺5次，前述症状已有明显改善，头晕，恶风，头麻痛明显减轻，外出时已不用戴帽，但仍觉咽中如有物梗，夜寐欠安，口干，遂加合谷、神门，继续针刺10次后，患者自感肢麻、头麻痛感消失，咽中已无异物感，夜寐稍安，心悸症状减轻，仍继续治疗5次，共计4个疗程后，前述症状基本消失，月事、精神症状恢复正常，随访3个月无复发，临床治愈。

二、电针为主 辨证施治

刘蓉用电针为主辨证治疗更年期综合征，取得了较好疗效。

取穴：肾俞、三阴交、中极、足三里、悬钟，皆用补法针刺。随症配穴：肝肾阴虚、肝阳上亢型配针补太溪、志室，泻太冲，平补平泻肝俞；心肾不交型配针补太溪，泻劳宫，平补平泻心俞；脾肾阳虚型配合灸关元、命门、章门，针补脾俞；肾阴阳俱虚型配合针补太溪、志室，灸关元、命门。此外，无论何型，如兼有血瘀，可泻血海、气海。

操作：选用26~28号，1~1.5寸毫针，病人侧卧位（背俞穴宜斜刺、浅刺，以免伤及内部脏器），穴位常规消毒，运用提插和捻转相结合的手法，针刺得气后，将中极与肾俞、三阴交与足三里分别接G6805电针治疗仪的两对电极，选用连续波，电量以患者能耐受为度，每次通电30min。选灸的穴位用艾条温和灸：施灸时将艾条的一端点燃，对准应灸的腧穴部位，约距皮肤2~3cm左右，进行熏烤，使患者局部有温热感而无灼痛为宜，每穴灸10min左右至皮肤红晕为度。针灸每日1次，5次为1个疗程，

更年期综合征相当于祖国医学的“绝经前后诸证”，其病机为：肾气衰弱，冲任虚损，阴阳失调。治宜补肾，调理冲任，平衡阴阳。选肾俞、三阴交针用补法以补肾；中极为任脉、足三阴经的交会穴，用补法针之可调理冲任及肝、脾、肾功能；足三里为足阳明经合穴，补之可充盈冲任二脉；悬钟为髓会穴，髓充于骨而骨健，更年期多骨质疏松，用补法针之有益髓健骨作用；其配穴志室为膀胱经在腰部之穴，与肾经原穴太溪用补法针之有滋肾水的作用；命门为督脉在腰部之穴，关元为任脉、足三阴经交会穴，灸二者可助肾阳；太冲为肝经原穴，泻之可降肝气以平肝阳；劳宫为心包经之荥穴，泻之可清心热；章门为脾的募穴，灸之可振奋脾胃之阳。总之，主穴与配穴恰当配伍使用，能较好地辨证治疗更年期综合征。

三、耳穴贴压 平衡阴阳

烘热汗出是妇女更年期综合征的典型症状，是由于卵巢功能衰退，引起内分泌失调和自主神经功能紊乱所致。何玲应用耳穴贴压治疗，疗效满意。

取穴：主穴：神门、交感、心、肾、内分泌、卵巢、丘脑、缘中。配穴：心烦易怒，抑郁易哭者加肝；腹胀纳少，便溏者加脾；月经失调加内生殖器；心悸失眠加皮质下，并行耳尖放血。操作：首先耳廓常规消毒，待自然干燥后用耳穴探测仪在所选耳穴区域内寻找良导点或敏感点，取王不留行籽贴压于敏感点上，按压强度除缘中、丘脑用强刺激外，余穴以微痛为宜，嘱病人每日自行按压5次，每次每穴按压30~50次，每次贴一侧耳穴，每周治疗2次，左右耳交替，10次为1个疗程。不愈者，休息1周再行第二个疗程。

中医认为属绝经前后诸证的范畴，是由于这一时期的妇女因“天癸”将竭，肾中阴精不足，不能维系肾阳，虚阳浮越则烘热汗出。阴阳严重失调，还可影响到心、肝、脾诸脏功能失调而出现一系列临床症状。

对本病的治疗，首先以卵巢、内分泌、丘脑、缘中来调节丘脑、垂体、卵巢这一内分泌轴的平衡，其中卵巢、内分泌穴用弱刺激手法，有补益作用，可加强其功能；缘中、丘脑穴用强刺激手法，有泻的作用，可抑制丘脑、垂体的功能亢奋，起到中医平衡阴阳的作用。取心可安心神，滋心阴，降心火，敛心液，配合交感调节自主神经功能，而治疗烘热汗出。取神门、皮质下及耳尖放血能安神镇静，调节大脑皮层功能治疗心悸失眠。取内生殖器调理子宫功能，治疗月经不调。取肾、肝、脾以调节脏腑间功能失调。均施弱刺激手法，以穴位微痛为宜。注意按压穴位时，当垂直于耳廓皮肤，前后对压，或用食指尖点按，切忌揉按，因为揉按时王不留行籽易移动位置，偏离敏感点而降低疗效。

陈某，女，52岁。患者4年前开始出现烘热汗出，日达数10次，伴失眠，月经失调。2年前绝经，因丈夫突然去世，诸症未能缓解，反而加重，常悲痛欲哭，彻夜不眠，独自在家恐惧难安，坐卧不宁，不敢独自进入丈夫去世时的房间，有时整日不敢回家，常有自杀念头，故常由老母陪伴。述说病情时痛哭流涕。经中、西医多方治疗，效欠佳。经用耳穴贴压神门、交感、心、肾、肝、皮质下，缘中、丘脑、卵巢穴，1次获效，烘热汗出次数减少，夜间睡眠3个多小时，二诊时已情绪稳定，自述对治疗充满信心。1个疗程后烘热汗出症状完全消失，睡眠每夜可达6h以上，情绪稳定，心情愉快。嘱常去公园锻炼，多与人交流，后又治疗2周巩固疗效。随访1年未复发。

四、耳压配中药 清心平肝滋肾

更年期综合征属中医“经断前后诸证”、“绝经前后诸证”，最常见的有潮热汗出、心烦易怒、口干、失眠、心悸、抑郁等症。袁美琳根据中医辨证施治的原则，运用清心平肝滋肾法结合耳穴贴压进行治疗，取效满意。

耳穴贴压：主穴为内生殖器、卵巢、内分泌、神门、交感、皮质下、肾上腺，配穴为脾、心、肝、肾。每次取4~5穴，用0.3cm×0.3cm脱敏胶布将王不留行籽固定于上述耳穴，每穴每次按压50次，每日按压3~5次，要求有酸、麻、胀、发热感觉，3天换贴1次，左右交替。

中药：清心平肝滋肾汤组成：黄连3g，白芍9g，麦冬9g，石斛9g，白薇9g，丹参9g，炒枣仁9g，龙骨15g，珍珠母15g，鳖甲30g，女贞子9g，制首乌9g。每日1剂，水煎2次，早晚服。

连续服药及耳穴贴压1个月为1个疗程。

更年期综合征属心身疾病范畴。其发病不但有生理因素，而且与精神心理因素密切相关。临床上许多患者常常在情绪激动或紧张时症状就会频繁发作，而且有部分患者在其开始发病时常有家庭、生活或工作等因素引起情志不快或紧张等诱因。祖国医学认为，心主神明，肝主情志，心肝两脏在调节精神情志中起着主要作用；心属火，肝属木，火木之性皆易升发；汗为心液，心火内灼，迫液外泄，肝火上炎，故潮热汗出，且以上半身为主；肝肾阴虚，阴不敛阳，心肝火旺，扰乱神明则心悸心慌，心烦易怒，失眠。针对上述病机，根据中医辨证，从心肝肾论治该病，以清心平肝滋肾为法。内服方中黄连、珍珠母降心火，清肝热；白芍、麦冬、炒枣仁、白薇、丹参凉血益阴，补血柔肝，宁心安神，清虚热而敛汗；何首乌、石斛、女贞子养血益精，补肝滋肾，清肾中浮火，摄元气，除虚烦；生龙骨、鳖甲平肝潜阴，镇静安神而退热。诸药合用，结合耳穴贴压，共奏清心平肝滋肾之功，能明显改善临床症状，取效满意。

刘某，女，50岁，2005年4月12日初诊。自述两年前出现潮热汗出、心烦易怒、失眠、心悸，反复发作，自服更年康疗效不佳。刻诊：烘热面红、潮热汗出、心烦易怒、失眠、心悸、懊恼欲哭、抑郁、健忘、胸胁胀痛、腰膝酸软、闭经、食欲不振、二便调、舌红苔少、脉沉细略数。诊断为更年期综合征。证属肝肾阴虚，阴不敛阳，心肝火旺。治拟清心平肝滋肾法，方药：黄连3g，白芍、麦冬、石斛、白薇、丹参、炒枣仁、女贞子、制首乌各9g，龙骨15g，珍珠母15g，鳖甲30g，鸡内金6g。水煎服，每日1剂。耳穴贴压：主穴为内生殖器、卵巢、内分泌、神门、交感、皮质下、肾上腺，

配穴为脾、心、肝、肾，每次取4~5穴，每穴每次按压50次。3天换压1次，左右交替。上述综合治疗14天后，精神好转，主证均减，继以原法治疗30天，余症悉除，为巩固疗效，原方做丸继调月余，半年后随访无复发。

五、五脏俞加膈俞 调理脏腑

袁志太采用针刺五脏俞加膈俞治疗更年期综合征，取得理想疗效。

取穴：主穴选五脏俞加膈俞（心俞、肝俞、肺俞、肾俞、脾俞、膈俞），均双侧。肝阳上亢型配太冲、太溪；心血亏损型配内关、足三里、三阴交；脾胃虚弱型配足三里、上巨虚、下巨虚；痰气郁结型配内关、足三里、丰隆。亦可随症加减。

操作：先取俯卧位，针刺五脏俞加膈俞，手法以平补平泻为主，针感以酸麻胀为佳，中等强度刺激。针刺应严格掌握针刺深度及角度，以免发生意外，留针20min，中间行针1次，再根据配穴取舒适体位针刺，留针时间同前，每日1次，10次为1个疗程。

更年期综合征是妇女在绝经期前后常出现的一组症候群，这些证候往往轻重不一，参差出现，持续时间或长或短，短者一年半载，长者迁延数年，甚至影响生活和工作。肾主骨生髓，主生殖。妇女经血由肾精气化而来，与冲任二脉关系密切，二脉隶于肝肾。中年妇女，肾气渐惫，若再加七情所伤，久病失养，饮食不节，痰湿等外邪侵扰，导致脏腑功能失调，进一步损伤冲任经脉，出现月经紊乱或绝经，肾虚则髓窍失聪，出现头晕失眠。背俞穴是脏腑气血输注于背部的穴位。故背俞穴能调理脏腑功能，治疗脏腑疾病。五脏俞加膈俞是京城著名老中医王乐亭治疗中风后遗症、日久五脏虚损、气血两亏等虚弱证候的有效针灸处方。根据异病同治的理论，应用其治疗妇女更年期综合征，也取得很好的效果。膈俞为血之会穴，针刺膈俞可活血补血理血，与五脏俞相配，能调理脏腑功能，起到滋补肝肾，补益心脾，活血调血的作用。肾精充足则脑窍得充，头晕失眠症状消除，精神振奋，身体恢复健康。现代医学认为，背俞穴的分布与脊神经节段性分布大致相同，通过针刺背俞穴，起到刺激自主神经，达到调理脏腑功能的目的。

患者，女，48岁，干部，1997年6月3日初诊。患者3年前因与同事争吵，情志过激，随后出现头晕失眠，健忘，月经周期逐渐错后，月经量少色暗，有血块，曾服中、西药物后好转。6个月前停经，头晕失眠，伴有背痛，腹胀纳呆，口服阿普唑仑1.6mg方可入睡，遂来针灸科求诊。患者面色晦黯，无光泽，背部左侧T₃~T₁₂，有一条索状阳性反应物（相当于膀胱经第一侧线位置上，即背俞穴位置）。心肺腹未见异常，诊断为更年期综合征（肝郁气滞型）。按上法针刺五脏俞加膈俞穴，配太冲、太溪、足三里，每日1次，针刺2次后症状减轻，10次后主要症状消失，面色红润，精神振奋，身体康复。继针5次以巩固疗效，临床痊愈。半年后随访无复发。

六、穴位埋线 滋补肾气

姜守信运用羊肠线穴位埋植的方法治疗更年期综合征，疗效满意。

取穴：以膀胱经的背俞穴为主，配合任督经脉穴位，穴取大椎、心俞、肝俞、肾俞、脾俞、胃俞、志室、命门、膻中、中脘、气海、关元等。

操作：穴位皮肤经严格消毒后，一般勿须麻醉，特别紧张怕痛者以1%盐酸普鲁卡因做浸润局麻，每穴取1/0号医用羊肠线2cm，以特制埋线针，穿入穴位皮下，进针至线头进入0.5cm，随后把针退出，用棉球压迫针孔片刻，以防出血，然后用消毒纱布块盖敷保护针孔，根据病情及病人对肠线的吸收情况，每次取穴3~5个，2~4周埋线1次。

本病属中医学的“绝经前后诸证”范畴，其病因为妇女届绝经前后，肾气渐衰，冲任二脉虚衰，天癸将竭，精血不足，月经将断而至绝经，而出现肾气偏盛偏衰的现象，此乃正常生理变化，如不能适应，或劳力、劳心过度，营血暗耗，心血亏损，使阴阳二气不相平衡，脏腑气血不相协调，肾虚不能濡养和温煦其他脏器，因而诸证蜂起。

本病以肾虚为本，在治疗上应注重维护肾气，加强用滋补肾气之穴，如肾俞、命门、关元等穴。

在治疗过程中，应注意严格无菌操作，防止感染，皮肤局部有

感染或有溃疡时不宜埋线，并注意观察术后反应。

张某，女，49岁，1994年1月20日诊，患者自诉，月经时断时续，先后无定期，烘热汗出食欲超常，多食易饥，甚至夜里仍需起数次，体重半年内明显增加，时有情志失常，哭笑无常，经妇产科，内分泌等科确诊为更年期综合征，介绍至本科埋线治疗，穴取心俞（双）、肝俞（双）、脾俞（双）、脊中、中脘等穴，每次选用4穴，交替使用，共治3次，病人痊愈，1年后随访无复发。

七、穴位注射 配耳压

符少杨采用穴位注射配合耳穴贴压治疗妇女更年期综合征。

穴位注射：取穴：肾俞、肝俞、心俞、脾俞、心俞、三阴交、足三里、太溪、中极。药物：复方当归注射液。方法：常规消毒。用10ml注射器配6号针头，吸取复方当归注射液，选准穴位，右手持注射器垂直或斜刺穴位。深度在0.1~0.4寸不等，待出现酸、麻、胀感以后抽取无回血再缓慢将药液0.5~2ml推入穴位深部，拔出针后用酒精棉球压迫针口1~2min。每次取2对穴位，1对背俞穴配1对体穴，交替配穴，隔日1次，10次为1个疗程。

耳穴贴压：取穴：内生殖器、内分泌、缘中、肾、肝、卵巢、丘脑、交感。方法：患者端坐，选准穴位，耳廓常规消毒，用0.6cm×0.6cm的粘有王不留行籽的医用胶布固定于耳穴上，3天换1次，两耳交替。治疗期间每天按压3~4次，按压至耳廓发热或者烧灼感为止。10次为1个疗程。

中医认为更年期肾气渐衰，肾精不足是发病的主要机制，其次情志不遂，肝气郁结，气滞血瘀也是不容忽视的发病原因。现代医学认为：妇女进入更年期，由于卵巢功能减退，雌激素分泌减少，垂体反馈性分泌多量激素，引起甲状腺及肾上腺皮质功能亢进，内分泌失调，以自主神经系统功能紊乱，而产生各种临床症状。其病的严重程度可因人而异，轻者经几个月机体的自我调节，形成新的内分泌系统，严重者可影响生活和工作。给患者造成很大的痛苦。

穴位注射具有针刺和药物、经络（穴位）三者的协同作用。复方当归注射液有活血补血，通络止痛，补中有通。背俞穴（肝俞、肾俞、心俞、膈俞、脾俞），为五脏之气汇聚和转输部位；三阴交为

足太阴、足厥阴、足少阴之会；中极为足三阴与任脉交会穴，太溪为足太阴之输穴；足三里为足阳明之合穴，均为按经取穴，诸穴合用可促气机调畅，具有健脾、养肝、强肾，调理冲任、清心醒脑、养血安神、培正扶气的作用。

根据祖国医学“经穴——脏腑相关理论”，耳廓与全身经络脏腑有着密切的关系，故在耳穴施予针刺或按压，可达到疏通经络、调整脏腑、运行气血的功能。内生殖器，为相应部位取穴，配卵巢、内分泌、缘中、丘脑的调节卵巢功能，缓解因年老卵巢功能衰退所引起的紊乱而出现不适症状。月经与肝肾亏虚有关，配肝、肾穴以补肝肾、调阴阳。

由于更年期综合征是生理、心理、社会环境共同作用的结果，所以通过穴位注射、耳穴贴压治疗，同时配合心理治疗，有利于病变的康复。

治疗妇女更年期综合征时应注意：①手法宜轻；②患者主诉症状较多，应择主要症状治疗，短期内解除病人痛苦。

赵某，女，51岁，2000年3月5日初诊。2年来月经周期紊乱，半月或数月一潮。近1年来出现阵发性潮热、汗出，以上半身为主，每日发作数10次伴心烦易怒，急躁、焦虑，经常与家人吵闹，情绪低落，悲伤欲哭，心悸，失眠，舌苔薄白，脉弦。经过多项检查未发现异常。诊断：更年期综合征（肾阴亏虚）。治则：滋阴降火、疏肝宁心、调整阴阳。治法：穴位注射配合耳穴贴压。治疗2个疗程后，上述症状明显减轻，继治2个疗程，并配合心理治疗痊愈。

王某，女，45岁。就诊时间：2001年6月20日。病史：近一年多来精神不振，郁闷不乐，悲伤欲哭。近1个月来逐渐加重，悲观厌世，多次想自杀。见面色潮红，心悸多梦，失眠健忘，多疑善感，思绪不宁，五心烦热，盗汗，口咽干燥，舌红少津，脉细数。已绝经8个月。入院后各种理化检查均未见异常。诊断：更年期综合征（心阴亏虚）。治则：养心、滋阴补血。治法：穴位注射配合耳穴贴压。治疗2个疗程后，心悸多梦、失眠健忘、盗汗减轻，精神亦较前好转，但情绪时好时坏，每遇查房或家属探视时均伤心哭泣。继治2个疗程，并配合心理治疗，上述症状明显减轻，又治疗1个疗程，痊愈出院。

八、辨证配穴 针刺配耳压

杨瑾健采用针刺四关穴为主，根据证型辨证配穴，配合耳穴贴压治疗该综合征，效果满意。

针刺：以双侧合谷、太冲为主穴，根据证型，辨证取穴，随症加减。肝气郁结型：针泻气海、三阴交（双）。肝阳上亢型：针补太溪（双），针泻百会、风池（双）。痰热中阻型：针泻膻中、中脘、阴陵泉（双）、丰隆（双）。心肾不交型：针补心俞、脾俞、肾俞、三阴交（双）。心脾两虚型：针补心俞、脾俞、神门、足三里（双）、三阴交（双）。脾胃虚弱型：针补脾俞、胃俞、中脘、足三里（双）。肝肾亏损型：针补肝俞、肾俞、关元、足三里（双）、照海（双）。

主穴针刺得气后接 G6805 电针仪，采用连续波，频率 1.3 ~ 2.0Hz，强度以患者能耐受为宜。配穴每隔 5min 行针 1 次，行捻转提插泻法，留针 30min，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

耳穴贴压：耳穴：神门、内生殖点、肾、肝、心、内分泌、脑点。方法：一侧耳廓常规消毒，用 0.5cm × 0.5cm 的粘有木香顺气丸的胶布固定于耳穴上，两耳交替，每 3 天换 1 次，并嘱患者每日每穴揉按 4 ~ 5 次，按压至耳廓发热为止。

人到中年，肾气渐衰，天癸渐竭，冲任虚损，精血不足，阴阳失调，导致全身功能相对减弱是更年期综合征发生的内在条件。《针灸大成》曰：“四关、四穴。即两合谷、太冲是也。”合谷是手阳明经的原穴，泻之可清热泄火，补之可补气振羸。太冲是足厥阴经的原穴，泻之可疏肝理气，平肝熄风，补之可养肝血。针刺原穴能调整脏腑气血，通达三焦气机，改善内脏功能，从而发挥其扶正抗邪的作用。另外，太冲为冲脉之支别处，与冲脉、肾经气脉相应，故针刺太冲亦有调理冲脉、肾经之功。开四关穴结合辨证分型取穴，或补或泻，具有镇静安神、健脾养肝强肾、调理冲任，培正扶元的作用。根据“经穴-脏腑相关理论”，耳廓与全身经络脏腑有密切关系，故按压耳穴可达到疏通经络、调整脏腑、运行气血的功能。

患者，女，53 岁，于 2003 年 6 月 24 日初诊。诉近 2 年郁闷不乐，悲观厌世。见情绪抑郁，胸胁胀满，善太息，嗳气频频，烘热

汗出，心烦不寐，不思饮食。舌淡红，苔薄腻，脉弦。诊断：更年期综合征（肝气郁结型）。治则：疏肝解郁，理气和胃。治法：按上法辨证取穴，针刺四关穴为主配合耳穴贴压治疗，并结合心理治疗。1个疗程后痊愈。

九、五脏俞为主 针刺配火针

潘文字对更年期综合征患者进行针刺加火针法治疗，取得了理想临床疗效。

取穴：主穴：五脏俞穴、神门、三阴交。配穴：痰气郁结者配丰隆、膻中、太冲、阳陵泉；肝阳上亢者配太冲、行间、太溪、涌泉；心脾两虚者配内关、公孙、足三里；肾阴虚者配太溪、照海、复溜；肾阳虚者配百会、命门或关元、气海。

操作：①取仰卧位，选用28号1.5寸毫针，根据辨证。主穴加配穴针刺，在行针得气基础上运针以紧按慢提、小角度捻转后留针。留针期间每10min重复上述手法1次，留针30min后出针。隔日1次。②取俯卧位，以火针点刺背部五脏俞穴（每次依证型取4穴），每周2次。上述方法操作，8周为1个疗程。

更年期综合征与肝、脾、肾、心关系密切。尤与肾气渐衰，精血不足，冲任亏虚相关。盖因肾受五脏六腑之精而藏之，肾精不足，影响其他内脏，致体内阴阳关系失调，新的阴阳平衡不能很快建立，从而导致脏腑功能失常，故肾虚是致病之本。

《素问·痹论》中对治疗脏腑疾病时的取穴原则是五藏有俞。《素问·咳论》中更明确指出“治藏者治其俞”，这些都说明临床治五脏病变多以背俞穴为主。现代医学亦认为，背俞穴的分布与脊神经节段性分布大致相同，通过针灸背俞穴，可起到刺激自主神经，故临床上以五脏俞为主穴，藉以调整脏腑功能，调理冲任。《素问·灵兰秘典论》：“心者，君主之官，神明出焉”。心藏神，主神。更年期综合征的病人很多伴有心烦、心悸、失眠、健忘等神志病证，故取心经原穴神门。三阴交为肝、脾、肾三条阴经之交会穴，有补脾胃，理肝肾之功，其善行血分，而神门善走气分，二穴伍用，互相促进，有调气血，和阴阳，定神志之效。火针治疗能使衰弱之功能旺盛，对虚寒者能补，郁结者能散，故在五脏俞穴火针刺，以加

强机体免疫力,调节自主神经功能,调节肾上腺皮质功能,促进性腺功能,调整能量代谢,促使糖代谢合成加强等。所以,通过针刺加火针治疗,能调整脏腑气血功能,建立并适应新的阴阳平衡关系,有效地改善生活质量,使更年期患者尽快适应更年期的变化,顺利渡过更年期。

倪某,女,48岁,2000年7月10日就诊。主诉月经周期紊乱半年多。色淡,量忽多忽少,面色晦黯,头晕痛,夜寐不安,记忆力欠佳,腰疼阴坠,四肢厥冷,纳呆心悸,烦躁欲哭,胸中阻窒不舒,乏力,大便溏薄,尿失禁,舌淡苔薄,脉虚无力。曾服用阿米替林、黛安神、更年康、妇复春等药,并口服中药半年多,效果不佳。证属肾阳虚衰,脾阳不振。先用平补平泻法针刺百会、神门、足三里、三阴交,温针灸关元及气海,再配以火针刺肾俞、脾俞、心俞、命门,共治3个疗程,临床痊愈,半年后随访无复发。

十、辨证分型 针药并用

田华张运用针刺与中药联合治疗更年期综合征,颇有疗效。

取穴:主穴:三阴交、足三里、肝俞、脾俞、肾俞、关元、百会。配穴:①肾阴亏虚型配太溪、太冲、照海、内关;②肾阳亏虚型:配心俞、气海、命门。另外,失眠较重加安眠、神门、内关;兼潮热多汗者,加双侧合谷;心烦易怒、心悸者,加太冲、行间;眩晕、头昏头痛者,加风池。以上取穴双侧穴位的,两侧均取。

操作:各穴常规消毒,用长1.5寸毫针,进针后行小幅度提插捻转手法,以得气为度,平补平泻,留针30min,每隔10min行针1次。双侧穴位的均采取双手行针法。每天1次,7天为1个疗程。休息3天后,继续下1个疗程。

中药内服:肾阴亏虚型以左归丸合二至丸加味,肾阳亏虚型以右归丸加味,肾阴阳俱虚型以二仙汤合二至丸加味。每日1剂,水煎2次,混合后分3次服用。1个月为1个疗程,间隔5天行下1个疗程。

更年期综合征系肾气心血虚衰而致。其病机主要是妇女年近七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭而起。任脉之虚、太冲脉之衰少,根源又在于肾元渐衰,因为肾主藏精,肾虚则阴血不足,冲任二脉

也因气血充盈不足而致阴血衰少。《素问·上古天真论》言：“……七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。”妇女七七后因肾气虚衰月经停止，肾藏五脏六腑之精，肾之精血虚损则伤及五脏六腑，可出现诸多症状。故而肾虚为更年期综合征的基本病机，治疗中以肾为论治根本，而以补脾益肾、调理脏腑、平衡阴阳为总则。针刺主穴三阴交为足厥阴肝经、足少阴肾经、足太阴脾经的交会穴，取之可以健脾生血、补益肝肾、调补冲任；百会穴系督脉和手足三阳经之会穴，位居巅顶，“头为精明之府”，取之不仅可宁神定志，而且与三阴交相配更有调理阴阳、沟通上下之义。关元可培元固本，调冲任；足三里、三阴交健脾，足三里与肝俞、脾俞、肾俞三穴合用，可达健脾、疏肝、益肾之功。诸穴合用，可通调十二经脉，益肾补血而调神，通窍而不伤正。根据《素问·汤液醪醴论》所云“邪气时至，……必齐毒药攻其中，石、灸艾治其外也”的治疗原则，采用中药内服治其内，针灸外用治其外，共奏其效，调整脏腑阴阳的生理功能，以达佳效。

刘某某，女，49岁，于2005年5月16日初诊。主诉：阵发性潮热、心慌烦躁、盗汗、头晕耳鸣、失眠、腰膝酸软、肢体麻木、口干舌燥、纳差便干4月余，近2个月症状加重。患者已绝经半年，经多家医院妇科和心内科诊治，均未发现器质性病变，曾服用调节自主神经功能的药物和中药，效果不佳。经他人介绍来本科进一步治疗。查体：生命体征平稳，心电图、血尿常规等检查均正常，血压正常。舌质红，苔少，脉细数。西医诊断为更年期综合征，中医辨证为肾阴亏虚型。采用上述方法治疗2个疗程后，烘热汗出、情志异常等症状消除，且随访半年未复发。

十一、上下配穴 针用补法

女性更年期头痛多发于50岁左右的女性，中医认为发病的关键是冲任衰，天癸竭，机体内阴阳失衡，肝肾阴亏，冲任不足，精血乏源，在下为月经渐绝，在上则脑髓空虚，脉络失养而发生头痛。单赤军用针灸治疗本病以虚则补之为原则，治以滋补肝肾，调理冲任。

取穴：太溪、太冲、百会、风池、关元、三阴交。

操作：患者取俯伏坐位或俯卧位，皮肤常规消毒后，采用 28 号 1.5 寸毫针，进针得气后施以补法，留针 30min。每次选穴 3~5 穴，每天 1 次，10 次为 1 个疗程，每个疗程间休息 3 天。

太溪为足少阴肾经之原穴，太冲为足厥阴肝经原穴，二穴相配，前者益阴，后者平肝，功在平肝潜阳，增水涵木；百会、风池主治头目疼痛眩晕；关元属任脉通于胞宫，三阴交为足三阴之交会穴，二者同用，可补养冲任，补益精血，益气血生化之源。诸穴合用，共奏滋补肝肾，调理冲任之功。

赵某某，女，49 岁。主诉头痛反复发作半年，近年来月经量多，经期不规则，经常头部钝痛、头晕耳鸣，失眠多梦，心烦易怒，五心烦热，腰膝酸软，口干便结，尿少色黄，舌红少苔、脉细数。诊断：女性更年期综合征。中医辨证：头痛，证属肝肾阴虚型。用上述方法治疗 2 次后，症状明显减轻；治疗 1 个疗程后，以上症状完全消失，随访 1 年未复发。

十二、以肝为本，辨证取穴

董军杰以疏肝理气为主，根据病情，适当地选用清泻肝火，滋养肝阴之法治疗更年期综合征疗效很好。

取穴：主穴：神门、风池、关元、太阳、合谷、太冲、阳陵泉、太溪。配穴：烘热汗出，加曲池、阴谷；神疲乏力，加灸足三里；皮肤感觉异常，加蠡沟；精神不集中、失眠，加三阴交、照海；烦躁易怒者，加行间。

操作：嘱患者仰卧位，穴位作常规消毒，选用 1.5 寸毫针，用双手进针法刺入皮肤，然后调整进针深度，其中风池穴，向鼻尖或对侧口角刺入约 1.2 寸（仰卧时向风府穴刺入 1~1.2 寸），以局部感觉明显酸胀并向头顶或眼底放射为佳。其余穴位得气后行平补平泻手法，留针 30min。每天 1 次，2 周为 1 个疗程，连用 1~3 个疗程。

风池为胆经要穴，疏调肝胆，清利头目；太阳穴提神止痛效佳；合谷疏风止痛，太冲平肝清热，2 穴合用为“开四关”，可用于各种精神情志疾病；神门调气安神；关元补气理气；阳陵泉疏泄肝胆；太溪补肾降火；其他配穴对症治疗，共奏佳效。

十三、整体入手 调理冲任

女性更年期综合征，肝肾阴虚证是常见证型。张永刚认为针灸治疗应从调理冲、任二脉入手。用针刺治疗，疗效满意。

取穴：三阴交、关元、肝俞、肾俞、神门、血海、四神聪、太冲。

操作：针刺用1.5~2寸毫针，快速刺入，施以提插捻转补法。每天治疗1次，每次30min。留针期间行针3次。10天为1个疗程，休息1天行下1个疗程。

冲、任二脉下起胞宫，上连十二经脉，胞宫的生理功能与冲任二脉直接相关，在妇女生理过程中具有重要的地位。肾与胞宫有经络联系，即《素问·奇病论》所说“胞络者，系于肾”。肝脉与任脉交会于关元，与冲脉会于三阴交；三阴交为足三阴经之交会穴；关元为任脉经穴，可充元气、补益冲任；血海调理血分；肾俞培补肾气；肝俞、太冲疏肝解郁；心经原穴神门宁心安神；四神聪镇静安神。多穴合用，疗效显著。

十四、针药结合 滋阴潜阳

苏思杰认为肝为女子之先天，具有储藏血液和调节血液的作用，其藏血作用取决于肝的疏泄功能，肝气调达则血脉流通，经候如常；肝气失于疏泄，则冲任不调，导致月经不正常。

取穴：主穴：足三里、关元、三阴交、大椎。配穴：阴虚内热加合谷、太溪；精亏血枯加膈俞、中极；阴虚肝旺加太冲；肾虚肝郁加太冲、合谷；阴虚血燥加血海、鱼际、太溪；心肾不交加内关、心俞、脾俞、肾俞。

操作：取1~2寸毫针，常规针刺，得气后行平补平泻手法，留针20~30min。每天1次，10天为1个疗程。

中药：主方：六味地黄汤加减：熟地30g，山萸肉15g，山药15g，泽泻15g，丹皮15g，茯苓15g，龟板15g，枸杞15g。随证加减：①阴虚内热加黄柏15g，地骨皮15g，知母15g；②精亏血枯加制首乌15g，阿胶10g；③阴虚肝旺加菊花10g，白芍15g，夏枯草10g，鳖甲20g；④阴虚血燥加当归25g，防风10g，生首乌20g；⑤

肾虚肝郁：加炙柴胡 10g，郁金 15g，合欢皮 10g；⑥心肾不交加五味子 15g，枣仁 15g，茯神 15g，黄连 8g，莲子心 8g；⑦月经量多者加仙鹤草 25g，侧柏炭 15g。水煎服，每天 1 剂，早中晚各 1 次连续服用，10 天为 1 个疗程。

针灸治疗本病以扶助正气，调理冲任，疏肝理气为主要治则。选取经穴以冲任脉、肝、脾、肾经为主，诸穴均有滋阴潜阳，调整阴阳平衡的作用。六味地黄汤中熟地、山萸肉、枸杞益肝肾，补精血；山药、茯苓健脾和中，补后天以养先天；泽泻清泄肾火，并防熟地之滋腻；丹皮清泄肝火，亦制山萸肉之温；龟板补肾填精益血。各药合用滋阴补肾。

十五、针刺配穴位注射 补肾益气养血

龚东方认为更年期妇女以卵巢功能的衰退为主要特征。妇女在绝经期前后，肾气渐衰，冲任亏虚，天癸将竭，导致阴阳失衡，脏腑气血失调，功能紊乱而发病。可见，肾虚是本病发生的根本原因，而补肾当为治疗的第一要义。

取穴：主穴：取肾俞、太溪、足三里、三阴交、心俞、神门、肝俞、太冲。配穴：兼痰浊加丰隆、膻中、中脘；兼血瘀加膈俞、血海、间使。

操作：常规针刺，太冲、丰隆、膻中、中脘、膈俞、血海、间使采用平补平泻，其余均用补法。隔天 1 次，4 周 1 个疗程。

穴位注射：取肾俞、足三里、血海。用人胎盘组织注射液 2ml 穴位注射，每次取 2 穴，4 周为 1 个疗程。

针刺取穴以肾俞、太溪补肾；足三里、三阴交健脾；肝俞、太冲调肝；心俞、神门宁心。诸穴合用，同奏补肾宁心，健脾调肝之效。人胎盘组织液穴位注射以补肾填精，益气养血。临床中补肾虽为本病的主要治法，但须注意脾胃的变化，故取足三里、三阴交以保护后天生化之源。针药并用，协同作用，改善临床症状，使之顺利度过更年期。

十六、俞募配穴 协调阴阳

孙远征认为更年期综合征是指女性由生殖期至非生殖期的过渡

时期里出现月经紊乱以至绝经，并由此引起的头晕耳鸣、心悸失眠、烦躁易怒、烘热汗出、五心烦热、腰膝酸软、倦怠乏力等一组证候群。大约 50% 更年期妇女出现症状，这些证候往往轻重不一，参差出现，持续时间或长或短，短者一年半载，长者迁延数年，甚至影响生活和工作。故采用俞募配穴针法为主治疗本病，疗效显著。

取穴：肝俞、脾俞、肾俞、心俞、膈俞、关元、中极、百会、神门、三阴交。

操作：嘱患者先取俯卧位，取 1.5 寸毫针针刺背俞穴，手法以平补平泻为主，针感以酸麻胀为佳，中等强度刺激，留针 20min，留针期间行针 1 次。再嘱患者取仰卧位，针刺其他穴位，操作同前。每天 1 次，10 次为 1 个疗程，每疗程中间休息 2 天。

祖国医学对更年期综合征早有探讨。《素问·上古天真论》云：“七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通。”表明女子七七，肾气渐衰，冲任虚损，天癸将绝，精气不足，肾阴亏虚或肾阳不足至气血阴阳失衡，导致脏腑功能失调，遂发诸症。故中医学认为，本病与肾、心、肝、脾有关。肾虚为本。肝肾乙癸同源，肾阴不足，精亏不能化血，水不涵木，导致肝肾阴虚，肝失柔养，肝阳上亢。肾与心关系密切，《傅青主女科》记载“胞胎属于心肾之间，上系于心而下系于肾”，且心肾水火相济，若肾阴不足，不能上济心火，常使心火独亢，则出现心火亢盛证候。肾为先天之本，脾为后天之本，先后天相互充养，脾赖肾阳以温煦，先天之精亦靠后天之水谷以滋养。肾虚阳衰，火不暖土，又致脾肾阳虚证候。因此，本病的发病机制主要为脏腑气血功能失调，采用俞募配穴为主的方法，取心俞、肝俞、脾俞、肾俞。背俞穴是脏腑气血输注于背部的穴位，能调理脏腑功能，治疗脏腑疾病；膈俞为血之会穴，针刺膈俞可活血补血理血，与五脏俞相配能调理脏腑功能起到滋补肝肾、补益心脾、活血调血的作用。关元为任脉之要穴，亦为小肠募穴，具有补肾壮元、益气和血之功，取之则可益火壮水、调理冲任；中极为膀胱募穴，亦为足三阴经与任脉交会穴，取之可温阳利水、补肾调经。神门为手少阴心经之原穴，原穴为脏腑原气经过和留止的部位；三阴交为足三阴经之交会穴，足三阴与妇人生理功能、病理变化有密切联系，二穴可交通心肾、调理冲任；百会系督脉和手足三阳经之

会穴，位居巅顶，“头为精明之府”，取之不仅可宁神定志，而且与三阴交、神门相配更有协调阴阳、沟通上下之义。因此，俞募配穴针法对于治疗女性更年期综合征具有十分重要的临床意义，不失为一种安全有效的治疗方法，值得推广应用。

十七、针灸配耳穴疗法 补肾培元

唐碧漪认为治疗更年期综合征宜补肾培元，调理脏腑，平衡阴阳。以任脉、脾胃经穴及背俞穴为主，配合耳穴疗法，疗效满意。

取穴：主穴：关元、三阴交、肾俞、百会、神门、足三里。配穴：肝肾阴虚：太溪、肝俞、太冲；肾阳亏虚：脾俞、命门。

操作：嘱患者卧位，全身放松，常规消毒后，选用1.5寸毫针刺，运用提插与捻转相结合的手法，得气后行平补平泻，留针30min，隔日1次，10次为1个疗程。耳穴：主穴：肾、神门、交感、内分泌。配穴：肝肾阴虚配肝、皮质下；肾阳亏虚配心、脾、卵巢。常规消毒后，将粘有金属磁珠的胶布贴于所选耳穴，前后两面均贴，嘱患者对穴位前后对压，每日按4~5次，每次按压5~10min，使耳廓皮肤充血变红、发热、疼痛，以病人能忍受为度。隔日更换1次，两耳交替，10次为1个疗程。

关元为任脉之要穴，能补肾培元，调理冲任；三阴交为肝、脾、肾三阴经的交会穴，可健脾、疏肝、益肾；百会为督脉经穴，可宁神定志；神门为手少阴之原穴，能宁心安神；足三里有益气补虚，调理冲任的作用。太溪、肝俞、太冲以滋养肝肾，佐以潜阳；脾俞、命门以温肾扶阳，佐以健脾。耳与经络、脏腑关系密切，通过对耳穴的刺激，可以疏通脏腑之气，调和阴阳。本法具有一定的疗效，且无毒性及不良反应，是治疗妇女更年期综合征安全、有效的方法。

十八、三穴六针 平补平泻

陈成巧认为更年期综合征的病因乃天癸将竭，致肾阴亏而心阳亢，阴阳平衡失调。心肾阴阳互济即所谓心肾相交，又须赖脾土媾通。故治疗应以理脾为主，佐以滋肾清心。针刺选用“三穴六针”，操作简便，且疗效佳。

取穴：主穴：神门、足三里、三阴交（均取双侧）。配穴：头痛

加双侧太阳、合谷；胸胁痛加双侧内关；腕腹胀满加中脘、气海；腰腿酸痛加双侧肾俞、阳陵泉；便秘加双侧支沟；高血压加双侧涌泉。

操作：取双侧神门、足三里、三阴交（简称“三穴六针”），针刺顺序从上到下（先神门，再足三里，后三阴交）用平补平泻手法，进针后留针30min，每10min行针1次，留针期间行针亦同样由上至下。连续3天为1个疗程，间隔1天再做下1个疗程，2~5个疗程可以治愈。

李某，49岁，2002年9月14日就诊。头晕心烦已1年余，月经将绝，量少色黯，有白带，失眠多梦，面部烘热。经检查，诊断为更年期综合征。用多种中西药物治疗收效甚微。症见两颊黯红，眩晕心烦，失眠健忘，腰酸身疲，多愁善感，面目四肢肿胀，压唇无凹陷，舌质红，苔薄白，脉弦数。依次针刺双侧神门、足三里、三阴交，均施平补平泻手法，留针30min。针后当夜入睡安宁，头晕消失，精神愉快，继针3个疗程痊愈。

十九、针药结合 辨证分型

吴志强认为本病多见于中老年妇女，女子以血为本，中年后肾气渐虚，天癸将绝，冲任精血不足，不能濡养他脏，兼素有情志不舒，肝气郁结，气郁化火，上扰心神；或忧思劳倦，损伤心脾；或年轻时孕嗣过多，中年房事不节，损及肾元，阴亏于下，阳亢于上，心肾不交等因素导致脏腑功能紊乱，阴阳平衡失调。按中医分型施治，分别运用针药结合辨证治疗，同时辅以心理疏导，取得良好效果。

（1）肝气郁结型 精神抑郁，胸闷胁胀，心烦，善太息，多愁易怒善哭，失眠头晕，腕腹胀闷，纳呆，或月经不调，经行紊乱，舌黯，脉弦。

取穴：合谷、太冲、章门、膻中、神门。

操作：电针刺激合谷、太冲，选疏密波、以能耐受为度，并以针刺手法补膻中、泻章门。

中药：加味甘麦大枣汤：淮小麦、大枣、炙甘草、佛手、川楝子、北柴胡、当归、芍药、郁金。

(2) 气郁化火型 急躁易怒，胸闷胁胀，头晕目眩，口苦，心烦狂躁，失眠多梦，或月经不调，便秘，舌红苔黄，脉弦数。

取穴：合谷、太冲、三阴交、涌泉、百会。

操作：常规针刺，以合谷、太冲、三阴交、涌泉为主，行泻法。

中药：甘麦大枣汤加丹皮、栀子、龙胆草、川楝子、薄荷、泽泻、大黄。

(3) 心脾两虚型 善思多虑不解，胸闷心悸气短，悲伤欲哭，不能自主，虚烦不眠，健忘，精神恍惚，头晕眼花，神疲自汗，纳谷不香，便溏，或绝经前后，伴月经紊乱，经行淋漓不止，舌淡红，苔薄黄，脉细弱或细濡。

取穴：合谷、太冲、内关、中脘、三阴交、神门。

操作：常规针刺，以合谷、内关、神门为主，施以补法刺之；太冲、中脘行温针灸。

中药：甘麦大枣汤加党参、白术、当归、茯苓、酸枣仁、元肉、夜交藤、合欢花。

(4) 心肾不交型 心悸怔忡，心烦不宁，失眠多梦，腰膝酸软，健忘易惊，精神恍惚，或思维不连贯，或如痴如呆，见于绝经前后妇女，或伴月经紊乱，经期前后不定，经血渐少，舌红，苔少，脉沉、弦、细或细涩。

取穴：合谷、太冲、心俞、太渊、涌泉、照海、肾俞、百会。

操作：常规针刺，以合谷、太冲、太渊、照海为主，施以平补平泻法；心俞、肾俞、涌泉、百会悬灸三壮。

中药：甘麦大枣汤加黄精、茯神、玄参、龟板、熟地、酸枣仁、麦冬、柏子仁、远志。

中医心理疗法：

(1) 言语疏导 根据“人之情，莫不恶死而乐生，告之以其败，语之以其善，导之以其所便，开之以其所苦”的原则，对不同病人情志特征和病理变化，用言语开导、劝说安慰的方法，动之以情，晓之以理，启发诱导，说服指导，端正认识，树立信心，配合治疗。

(2) 移精变气 通过语言交谈，转移患者对疾病的注意力，排遣情思，改易心志，移易精气，变利气血，形成精神内守的正常

状态。

(3) 顺情从欲 对病人需顺其情，从其意，如使隐情曲意，舒达其衷，欲从愿遂，则心顺神宁，心身康复。

更年期乃人体生理必须经历的一个过程，运用中医辨证施治，协调脏腑阴阳，和其情志，顺应人体生理变化。针刺治疗，以合谷、太冲为主，辅以辨证选穴。合谷、内关为四总穴之一，合谷为气关，太冲为血关，双侧同刺，有起闭解郁、宁心安神之功效，配合辨证选穴，以调理脏腑、平和阴阳气血。中药选取经方甘麦大枣汤主之，方中小麦养心安神，炙甘草和中缓急，大枣甘润补中，坚志除烦，合用有养心安神、甘润缓急之效。主方随证化裁，肝郁者加柴胡、川楝子、佛手、郁金等以疏肝理气；气郁化火者加丹皮、栀子、大黄、龙胆草清泻肝火；心脾两虚加党参、白术、枣仁、茯苓、夜交藤补益心脾、宁心安神；心肾不交者加黄精、玄参、龟板、熟地、麦冬、远志以滋水济火，养心安神。针药并用，随证施治而效。如张仲景《金匮要略》所云：“妇人病……审脉阴阳，虚实紧弦，行其针药，治危得安”。针药结合治疗的同时，辅以心理疏导，而取得良好疗效。

二十、针药配合 疏肝解郁

妇人脏躁属于心因性疾病，其临床表现类似神经官能症，是一组大脑功能活动暂时性失调发生疾病的总称，好发于中青年妇女，是妇科常见的杂病之一。虽患者有多种躯体自觉不适感，但无相应的器质性损害。薛聆采用针灸配合中药治疗本病，取得满意疗效。

取穴：主穴：内关、三阴交；配穴：印堂、膻中、中脘、足三里、百会。

操作：嘱患者取仰卧位，穴位常规消毒后，用28号1.5~2.5寸不锈钢毫针直刺内关、三阴交、中脘、足三里；用0.5~1寸毫针，平刺百会、印堂、膻中。得气后留针30min，留针期间每隔10min行针1次，行平补平泻法。每天1次，7次为1个疗程。

中药：柴胡疏肝散合甘麦大枣汤：柴胡10g，白芍10g，香附10g，当归10g，枳壳10g，白术10g，川芎6g，栀子10g，黄芩10g，党参12g，生地15g，小麦3g，炙甘草6g，大枣8枚。每天1剂，早

晚温服，7 天为 1 个疗程。

脏躁与患者的体质因素有关，如素多抑郁忧愁思虑，或肝气郁结，郁久化火，或劳倦伤脾，心脾受伤，化源不足，精血内亏。内关穴为手厥阴心包经络穴，别走手少阳三焦经，又为八脉交会穴之一，通于阴维脉，有清心胸郁热、宽胸理气、和胃降逆、清心安神之功，治疗心悸怔忡、妇人脏躁；三阴交为足太阴脾经的腧穴，又为足三阴经之交会穴，能补脾肾、益肝肾、调气补血，为治疗妇科病的常用穴，两穴为治疗本病的主穴。配百会、印堂治疗失眠、健忘；中脘、足三里健运脾胃；膻中可宽胸理气。再以中药，疏肝解郁、养心安神。针刺与中药配合应用，共奏奇效。本病的发生与精神有关，除针药治疗外，还可进行心理治疗，使患者思想豁达，树立战胜疾病的信心，对治愈本病亦可起到辅助作用。

参 考 文 献

- [1] 陈贵珍，许云祥．电针结合耳压治疗更年期综合征疗效观察．中国自然医学杂志，2003，5（3）：137～138
- [2] 刘蓉．电针为主辨证治疗更年期综合征 36 例．中国针灸，2000，（8）：488
- [3] 何玲，刘智斌．耳穴贴压治疗更年期烘热汗出 32 例．陕西中医，2002，23（11）：1022～1023
- [4] 袁美琳，柳玉林．清心平肝滋肾法结合耳穴贴压治疗更年期综合征 49 例疗效观察．四川中医，2006，24（9）：64～65
- [5] 袁志太．五脏俞加膈俞针刺治疗更年期综合征．上海针灸杂志，1999，18（6）：19
- [6] 姜守信．穴位埋线治疗妇女更年期综合症 60 例临床观察．针灸临床杂志，2000，16（7）：46～47
- [7] 符少杨，陈洁．穴位注射配合耳穴贴压治疗妇女更年期综合征临床研究．中医学刊，2006，24（6）：1147～1148
- [8] 杨瑾健，蓝毓营．针刺配合耳穴贴压治疗更年期综合征 32 例．广西中医药，2004，27（5）：22
- [9] 潘文字，林国华．针刺配合火针治疗更年期综合征 103 例．针灸临床杂志，2005，21（2）：20～21
- [10] 田华张，张春燕．针药合用治疗更年期综合征 63 例临床观察．四川中医，

2006, 24 (6): 101 ~ 102

- [11] 单赤军. 针刺治疗女性更年期头痛 73 例. 湖南中医杂志, 2001, 17 (1): 30
- [12] 董军杰. 针刺治疗更年期综合征 50 例疗效观察. 山西中医, 2001, 17 (1): 42
- [13] 张永刚, 李瓦里, 李庆云, 等. 针刺治疗女性更年期综合征肝肾阴虚证 65 例临床观察. 针灸临床杂志, 2002, 18 (11): 42
- [14] 苏思杰. 六味地黄汤配合针刺治疗更年期综合征 50 例疗效观察. 云南中医中药杂志, 2003, 24 (4): 46 ~ 47
- [15] 龚东方, 杨海燕, 李月梅. 针刺与穴位注射并用治疗更年期综合征 35 例疗效观察. 新中医, 2004, 36 (6): 46
- [16] 孙远征, 崔淑子, 郭淑颖, 等. 俞募配穴为主治疗更年期综合征. 中国针灸, 2004, 24 (2): 85 ~ 86
- [17] 唐碧漪. 针刺加耳穴贴压治疗妇女更年期综合征 47 例临床观察. 江苏中医药, 2004, 25 (7): 42 ~ 43
- [18] 陈成巧, 桑雅清. 三穴六针治疗更年期综合征 33 例. 浙江中西医结合杂志, 2005, 15 (4): 249 ~ 250
- [19] 吴志强, 罗苑媚, 于海波. 针刺合谷、太冲穴为主结合甘麦大枣汤化裁治疗脏燥证 256 例疗效观察. 医药产业资讯, 2006, 3 (14): 274 ~ 275
- [20] 薛聆, 王维峰. 针药配合治疗妇人脏躁 38 例. 山西中医学院学报, 2002, 3 (3): 38 ~ 39

【经前期紧张综合征】

经前期紧张综合征为现代医学病名，是指月经前期部分妇女伴有生理上、精神上及行为上的改变，如烦躁、忧郁、嗜睡、乳房胀痛、健忘、头痛等，影响正常工作。其发生的原因尚不清楚，中医学虽无此病名，但有关该病的论述散见于各医籍中，如经前便血、经前发热、经前泄水、经前烦躁等，称之为月经前后诸证。

本病病因中医认为与肝、脾、肾有关，亦可因外感而来而责之于肺。多由情志不畅、肝郁气滞而发，日久肝郁化火，伤及肾阴，而成心肾不交；亦可因贪食生冷，伤及脾肾，阳虚不化，水湿停滞。本病辨证多为虚实夹杂，治疗亦应标本兼顾，扶正祛邪。

该篇共收录了8位针灸医家的临床治验，有的以头针为主，虚补实泻；有的采用穴位注射配合体针；有的针药并用，行气活血；有的采用辨证取穴，耳穴贴压；有的采用辨证施治，调肝及胞宫等，虽治疗方法各异，但疗效均佳。

一、头针为主 虚补实泻

经前期紧张综合征是发生在月经来潮前的证候群，影响育龄妇女日常生活和工作。洪钰芳采用头皮针为主治疗本病。

取穴：主穴：额中线、顶中线。配穴：根

据不同症状选取相应的穴位。如有心悸怔忡、失眠多梦、发热等上焦症状配额旁1线；乳房胀痛、胸胁作胀、腹泻等中焦症状配额旁2线；肌肤浮肿、腹痛等下焦症状配额旁3线。

操作：常规消毒后，在所选腧穴上，用1寸不锈钢毫针沿皮下斜刺，将针体推至帽状腱膜下层。根据辨证，施用提插补泻手法，虚证施以补法，实证施以泻法，然后用G6805型电针治疗仪连接到主穴上，电量以患者感到舒适为度，频率为80~100次/min。留针1h，每周3次。治疗以1个月经周期为1个疗程。经后休息5天。

中医认为本病与经期气血盈虚变化以及患者素体禀赋有关，多因肝郁、肾虚、血瘀、冲任失调导致血海蓄溢失常所致，与肝、脾、肾三脏密切相关，其中尤以肝为主，故治疗上常以调肝、柔肝、舒肝等为治疗大法。

额中线和顶中线各在督脉循行路线上，相当于神庭、前顶、百会诸穴所在部位，有理气行滞、疏肝调经、安神定志和调冲任之功效。实验证明，电针刺激额中线和顶中线，可以提高大脑皮层的兴奋性，调节自主神经，使混乱的功能得以恢复。根据症状，选取额旁1，2，3线，以达调节上、中、下三焦的功能，使脏腑的功能恢复，气血阴阳得以平衡。

二、穴位注射配体针 调理冲任

经前期紧张综合征是妇女在经前出现的一系列精神和躯体症状，可随月经来潮而消失的一种疾病。徐天舒采用穴位注射结合体针治疗，取得理想疗效。

取穴：合谷、太冲、关元、气海、风池、太阳。

操作：穴区常规消毒后，选取直径1~1.5寸一次性毫针刺入穴位至适当深度，施以提插捻转手法，使产生轻微针感，之后留针40min。

穴位注射：采用黄芪注射液，穴取足三里、三阴交，选择5ml一次性注射器及5号针头，穴区常规消毒，进针到适当深度，施捻转手法使产生轻微酸胀重感，回抽无回血，缓慢注射药液1ml左右，足三里可适当多注入些药液；之后快速出针，局部按压1~2min。

穴位注射结合体针治疗于每次月经前10天开始，每3天治疗1

次，月经来潮后停止治疗。

经前期紧张综合征包括在中医的经行发热、经行头痛、经行身痛、经行泄泻、经行浮肿、经行眩晕、经行口糜、经行风疹、经行乳房胀痛、经行情志异常等病证中。《女科百问》中有“经水欲行，先身体疼痛”的记载；《叶氏女科证治》云：“经来遍身浮肿，此乃脾土不能克水，变为肿”。中医认为本病的形成与经前血注冲任血海，全身阴血相对不足，阴阳失调，脏腑功能紊乱有关。

由于本病病因及发病机制尚不清楚，目前还缺乏特异的、规范的治疗方法，主要是对症治疗，如心理治疗；药物治疗方面，有人应用调整中枢神经系统神经介质活性药物，以消退心理、情绪障碍，或应用激素抑制排卵以消除乳房胀痛等严重经前期紧张综合征症状。

徐天舒采用穴位注射结合体针方法，黄芪注射液具有补气活血、健脾消肿功效，足三里、三阴交分属足阳明胃经、足太阴脾经，可调理脾胃功能、益气养阴；穴位注射疗法可同时发挥药物及经络、腧穴的双重作用，且针感持久。体针取关元、气海通调冲任，且可改善下焦不适症状；合谷、太冲理气解郁、镇静止痛；太阳、风池宁心安神、减轻头部症状。6穴合用，补泻兼施，以健脾化湿，疏肝理气，调节阴阳气血，使经前期紧张综合征患者肝脾肾三脏功能正常，气血阴阳平衡，冲任和调。

三、针药并用 行气活血

经行头痛在现代医学上属经前紧张综合征的一个类型，是指女性每逢经期或行经前后，出现以头痛为主要临床表现的病证，廖小七采用针灸中药并用的方法治疗经行头痛，取得可喜疗效。

取穴：太阳、曲鬓、头维、三阴交、太冲、合谷、外关。血虚配足三里；肝郁配期门；血瘀配取血海。

操作：太阳、曲鬓、头维用1寸毫针，常规进针斜刺0.5寸，以患者有舒适针感为度，太冲、合谷、外关、期门、血海用平补平泻行气手法，以得气为度，血虚者足三里行捻转提插补法，留针30min，隔10min进针1次。每日1次，于下次月经来潮前3~5天开始治疗，至月经结束为1个疗程。

中药：血虚型用八珍汤加减；肝郁型用柴胡疏肝散加减；血瘀

型用通窍活血汤加减。每日1剂。

经行头痛属于现代医学的经前期紧张综合征的范畴，目前西医治疗经行头痛以镇痛为主，疗效不佳，药物不良反应大。中医学将经行头痛归属月经前后诸证的范畴。本病主要是气血为病，常因素体血虚，血不上荣，或因情志不畅，肝气郁滞，血行不畅，瘀血内阻，络脉不通所致。因此治法为疏肝理气，养血益气，行气活血。针刺选穴主要以行气活血，通络止痛为主；中药以养血益气为主。针药结合，功效相得益彰。

四、调脏腑 理冲任 平阴阳

郭淑颖采用针刺疗法为主治疗经前期综合征，获理想疗效。

取穴：主穴取百会、膻中、关元、三阴交、内关、太冲。配穴取肝俞、脾俞、肾俞、膈俞。

操作：所选腧穴常规消毒后，选用1.5寸毫针。先令患者俯卧位，直刺各背俞穴深约1寸，采用平补平泻法，进针得气后，迅速出针；然后再嘱患者仰卧位，百会穴沿头皮向后平刺，将针体推进帽状腱膜下约8分；膻中平行于胸骨向下平刺约1寸，关元、三阴交直刺约1寸，内关、太冲直刺约5分，以上穴位均采用平补平泻法，得气后留针30min，其间每5min行针1次。每日治疗1次，10次为1个疗程，经前14天开始治疗，行经期停针。

经前期紧张综合征是指少数妇女在月经期以前出现的一系列异常征象，其特点是周期性发作与经期密切相关，现代医学对本病的发病机制迄今不明，目前认为可能与精神社会因素、卵巢自体激素比例失常、神经内分泌系统平衡失常、催乳素排出量增多、维生素B₆缺陷等有关。

中医学认为妇女以血为本，以气为用，历经经、孕、产、乳，屡伤于血，故使妇女处于阴常不足、阳常有余的状态，此为发病发生的内在条件。经前血海满盈，冲任二脉之气盛实；行经血海溢泻，由盈而虚，则全身阴血更显不足。个体禀赋不同，阴阳盛衰及疾病、产、乳各异，经前、经期冲任气血的急剧变化，则引起脏腑功能失常，气血阴阳失调；至经净，阴血渐复，气血调和，脏腑功能恢复平衡，诸症随之消失。临床常以肝脏功能失调为主，并累及肾、脾、

心，治疗当以调理冲任、补肝肾、调肝脾为主。

背俞为经气转输于背部之腧穴，为动，属阳；募为经气汇集于胸腹之腧穴，为静，属阴。两者可以互相影响。滑寿曾说：“阴阳经络，气相交贯，脏腑腹背，气相通应。”郭淑颖采用俞、募穴相配，通以百会、三阴交等穴，从而达到调脏腑，理冲任，平阴阳的作用。百会位于头部，为诸阳之会，属督脉，有醒脑开窍，宁心安神之功。三阴交为足三阴之交会穴，有益肾调血，补养冲任的作用，关元为足三阴、冲、任之会，两穴合用可和肝补肾，调理冲任。内关可益心安神，宽胸利膈。太冲、膻中、肝俞共奏疏肝解郁、调理气血之用。脾俞、肾俞温补脾肾。膈俞为血会，与肝俞、脾俞共奏健脾统血、和营补血之功。诸穴合用益其源，调其流，使气血充盈，脏腑功能恢复，阴阳得以平衡。

五、针刺配推拿 通调冲任

王君认为按摩和针刺结合治疗能通调冲任，以达养心安神、舒肝理气、化痰解郁之功，从而平衡阴阳，调节全身功能。

1. 针刺

取穴及操作：太阳、风池、百会、印堂、曲池、合谷、足三里、三阴交。辨证加减：①心血不足：加血海、神门、气海、关元；②肝郁气滞：加行间、太冲、太陵；③痰浊郁结：加天突、丰隆。推拿后进行针刺，留针 15 ~ 30min。（除任、督二脉均为双侧取穴）。

2. 推拿

（1）头部手法 患者仰卧位，术者端坐于患者头前。

①两手拇指交替从印堂至百会直推 10 ~ 20 遍，然后两手拇指分推从印堂、鱼腰至太阳 10 ~ 20 遍；

②大鱼际揉头面部 5min；

③指揉百会、太阳、睛明、风池各 30s；

④拿头部五经 3 ~ 5 遍；

⑤头部啄法 1min；

⑥头部擦法（小指尺侧叩击法）1min。

（2）腰背部手法 患者俯卧位，术者立于一侧。

①用手掌或掌根直推两侧膀胱经和督脉各 3 ~ 5 遍；

②腰骶部和背部滚法 5~10min;

③腰骶部和背部拍打法 1~2min;

④患者仰卧位,术者作双下肢盘法,双侧内外盘各 5~10 次。

(3) 手法辨证加减

①心血不足:指揉双侧心俞、肝俞、脾俞、胃俞和肾俞各 30s,小鱼际横擦腰骶部 1min。

②肝郁气滞:掌搓两侧胁肋 1min,指揉肝俞、太冲和三阴交各 30s。

③痰浊郁结:摩腹 3min,指揉丰隆、阴陵泉和天突各 30s。

按摩与针刺的配合,可调节自主神经及内分泌的紊乱与失调,缓解各种症状和不适。恰当的功能锻炼及劳逸结合对本病的治疗有一定的帮助。同时患者还需注意调整饮食结构,补充维生素、矿物质,并且保持良好的情绪。

六、辨证取穴 耳穴贴压

冉金丽采用王不留行籽贴压耳穴治疗经前紧张综合征,疗效满意。

取穴:主穴:主穴为肝、肾、心、脾、内分泌、内生殖器(子宫、卵巢)、交感、皮质下、神门、垂体。配穴:肝郁气滞型加耳迷根、交感、肝阳;肝肾阴虚型加肾;脾肾阳虚型加肾、肾上腺、耳迷根。伴头痛者根据头痛部位选相应穴位。如:枕、顶、额、颞;伴眩晕者加脑干、眩晕点;伴呕吐者加胃、交感。

操作:在选取的穴区内通过视诊及触诊找出敏感点,将医用胶布剪成约 0.7cm×0.7cm 方型,常规消毒后将王不留行籽一粒置于剪好的胶布中央贴于上述耳穴,嘱患者每天自行按压 5~10 次,每次 3~5min,按压强度以病人能忍受为宜。每次贴压一侧耳穴,两耳交替,隔 3 天换贴 1 次,连续治疗 3 个月经周期。经前、经期、经后均不间断治疗。

郭某,37 岁,干部。1993 年 5 月初就诊。患者近两年来每于月经前 5 天出现前头顶及双颞胀痛刺痛,急躁易怒,两乳胀痛,胸胁满闷,腰及少腹坠痛,月经周期正常,月经量中等,血色紫黯挟黑色血块。饮食尚可,睡眠多梦,二便调,舌质暗、苔薄黄,脉弦。

中医辨证属肝郁气滞。用耳穴贴压疗法治疗后，第一个月经周期头痛症状明显减轻，第二个月经周期乳痛消失，经血中无血块，治疗至第三个月经周期症状完全消失。随访一年无复发。

七、针刺配心理治疗 强调情志

安玉兰认为月经前后诸证的发生是由于全身阴血不足，冲任失养，造成脏腑功能或气血失调。临床上采用针刺配合心理疗法治疗该病，疗效显著。

取穴：主穴：中极、关元、足三里、三阴交。配穴：腹寒伴痛经者针灸并用；头痛头晕者加印堂、百会、合谷；易激动失眠者加神门、内关；胸闷乳房胀痛者加乳根、期门；浮肿加气海、水分；泄泻加中脘、天枢；发热加大椎、曲池。

操作：选用1.5~3寸毫针。采用平补平泻法，进针得气后，留针20~30min，每于行经前3~4天进行针刺治疗，连针2个月经周期。

心理疗法：治疗中以高度关心和同情的态度与患者建立良好的医患关系，并通过交谈的方式加强医患间的理解和沟通，知道患者的内心体验，对患者进行有效的生殖生理知识干预，使患者充分了解女性生理功能特点，明白经前期紧张综合征周期性发作的原因及治疗方面有关的知识，同时积极调整月经前的活动，有效合理地安排自己的学习、工作及生活，适当运用自我心理调节方法，正确地对待自身的特殊生理功能。

合理的饮食：从经前1~2周起，应吃低盐饮食，以减少水盐潴留；多吃蔬菜，多喝水，尤其应多吃些苦味食品，如苦瓜、苦菜、绿茶等可以使紧张的心理放松弛，且有助于大脑皮层消除疲劳，具有良好的调节神经、醒脑提神的作用。此外，咖啡因能增加焦虑、紧张、抑郁及易怒，因此患者应避免或减少咖啡因的摄入。

针刺中极、关元，通调冲任，补益气血；足三里健脾化湿，益气通路；三阴交是三阴经交会穴，能调整足三阴经的平衡，有补益肝肾，调经止带作用；百会、印堂同属督脉，有醒脑开窍、宁心安神之功；神门、内关安神；期门配乳根疏肝解郁、理气消胀；中脘、天枢调理脾胃；曲池、大椎泄热。各穴配合能够调节自主神经及内

分泌的紊乱和失调，从而缓解各种症状和不适。

八、辨证施治 调肝与胞宫

中医学认为妇女月经前或经期诸证的发生是阴血由冲任二脉下注胞宫，血海充盈，而全身阴血不足，使某些脏腑功能或气血失调。尤亚芳认为其发病与个人体质有关，以精神症状为主的病人病机以肝脏功能失调为主，常累及肾、脾、心，在治疗中以调肝为主。

辨证取穴：①肝气郁结：主穴：太冲、太溪、气海、肝俞、膻中、三阴交；配穴：发热加大椎、曲池，头痛加太阳、百会，失眠重者加神门、内关，乳房胀痛加乳根、期门。②脾肾阳虚：主穴：足三里、脾俞、肾俞、太溪、三阴交、关元（灸）；配穴：泄泻加中脘、天枢，浮肿加水分、气海（灸）。

操作：穴位常规消毒，选用28~30号1.5~2.0寸毫针刺入穴位，得气后留针30min。其间每5min行针1次，肝气郁结型用泻法，脾肾阳虚型施补法。艾灸穴位5min。每天1次，10次为1个疗程。月经来潮前10天开始治疗，其余时间停针休息。

太冲为足厥阴原穴，配膻中、肝俞重在舒肝解郁、调理气血；气海、三阴交，共奏调理冲任之效；太溪功在增水涵木。以水盐潴留症状为主的病人，多因脾肾阳虚、气化不利、水湿不运，治疗宜健脾温肾。关元、三阴交二穴主调理冲任；脾俞、肾俞补脾温肾；足三里健脾化湿，气海助阳化气。

李某，30岁，已婚，1993年7月5日就诊。患者经前烦躁、乳痛2年余。自1991年起月经后期，40余天一行，经量少，伴有瘀块，经期3天。每次行经前2~3天乳胀、胸闷胁痛、烦躁易怒、不思饮食，苔薄腻、脉弦细。一般在行经1~2天后以上症状消失，于下次行经前又复发，每月如此，已成规律，辨证为肝郁之象。针刺取太冲、足三里、膻中、神门、内关、乳根、三阴交，施泻法，留针30min，共3个疗程治愈。半年后随访，诸症未复发。

参考文献

- [1] 洪钰芳. 头皮针治疗经前期紧张综合征临床疗效观察. 中国针灸, 2002, 22 (9): 597 ~ 598
- [2] 徐天舒. 穴位注射合体针治疗经前期紧张综合征疗效观察. 中国针灸, 2005, 25 (4): 253 ~ 254
- [3] 廖小七. 针药并用治疗经行头痛 57 例. 上海针灸杂志, 2007, 26 (9): 31
- [4] 郭淑颖, 孙远征. 经前期综合征 35 例针药对比观察. 上海针灸杂志, 2004, 23 (1): 5 ~ 6
- [5] 王君, 王鹰雷, 等. 按摩与针刺结合治疗经前期紧张综合征. 中日友好医学院学报, 2003, 17 (4): 251
- [6] 冉金丽. 耳穴贴压治疗经前期紧张综合征 37 例. 中国针灸, 1996, 2: 434
- [7] 安玉兰, 毛德新, 等. 针刺配合心理疗法治疗经前期紧张综合征. 上海针灸杂志, 2005, 24 (8): 19 ~ 20
- [8] 尤亚芳. 针灸治疗经前期紧张综合征 56 例. 中国针灸, 1997, 3: 171

【痛 风】

古代中医古籍中也有相同的病名，但中医所言痛风系指痛痹久不愈而言，二者在概念上有差别。现代痛风应属中医痹证范畴，其病机主要为外邪痹阻于肢体经络，使气血运行失畅所致。病初邪实为主，以热痹为主要表现，多是由于感受风热湿邪或寒湿邪郁而化热，形成热痹。病久邪留正虚，虚实夹杂，病情反复发作，缠绵日久，正虚邪恋，而出现肝肾气血不足之证。本病病位在肌表经络，久则深及筋骨，甚者及肾。痰浊血瘀凝聚精髓，殃及脏腑，湿浊内蕴，煎熬尿液，可见尿血石淋。浊毒久稽，损伤脾肾，寒热错杂，壅塞三焦，以至“关格”尿闭，险恶之象环生。

该篇共收录了 20 位针灸医家的临床治验，有的采用刺络拔罐，活血止痛；有的以刺血为主，辅以中药；有的采用随证取穴，针灸并用；有的根据通则不痛的理论采用浮针疗法；有的以腹针为主，配合中药；有的采用局部取穴，火针点刺放血；有的以痛为腧，梅花针叩刺等，治疗方法各有特色，但对急性期均有较好疗效。

一、刺络拔罐 活血止痛

原发性痛风是长期嘌呤代谢障碍、血尿酸增高致组织损伤的一组疾病，其临床特点是高

血尿酸血症，急性关节炎反复发作，痛风石形成等，属中医痹证范畴。其急性关节炎发作时多呈红、肿、热、痛，应属“湿热痹”范畴，陈雷采用刺络拔罐法治疗急性痛风，疗效显著。

操作：患者采用仰卧位或端坐位，选受累关节局部为施术部位，常规消毒，梅花针重叩刺至局部出血，选不同型号玻璃火罐，用闪火法在叩刺局部拔罐 10~15min，观察充血、出血状况，每罐出血量在 10~15ml，若因跖趾关节等部位过小，玻璃罐闪火法难以施行者，可用神罐代之。每日 1 次，3 次为 1 个疗程。

本病的发生主要是湿热阻络，有反复发作倾向，常由过食肥甘及饮酒而发，以致湿热浊瘀互结，流注经脉，痹阻关节。根据急性关节炎湿热浊瘀的特点，治拟清热解毒，利湿退肿，活血止痛。

陈雷选用刺络拔罐法，源于《内经》“血实者决之”“宛陈则除之者，去血脉也”的刺血原则。《医学源流》亦说：“凡血络有邪者，必尽去之。”故施治时，出血量较多，刺络出血对解除痛风之急性关节炎的临床症状疗效特别满意，且具见效迅速特点。

患者，男，52 岁，1995 年 6 月 27 日初诊。反复骨节疼痛 7 年，又发 2 天。多家医院确诊为“痛风”。本次由饮酒诱发，右踝及第一跖趾关节红肿热痛，伴身热，溲赤短，检查见体温 38.2℃，右足第一跖趾关节、踝关节外侧肿胀压痛，皮色潮红，触之灼手，舌尖偏红，苔薄黄腻，脉滑数而有力。遂予刺络拔罐法治疗，共治疗 2 次，临床症状消失，第 4 天实验室复查结果，血沉、血尿酸均恢复正常。

二、刺络放血 泻热解毒

痛风性关节炎是由于长期嘌呤代谢紊乱所致的疾病，为高尿酸血症。李扬缜采用刺络治疗该病，疗效满意。

取穴：照海、太冲、丘墟、地五会、足临泣、解溪、委中、阿是穴及足背部瘀阻比较明显的络脉。

操作：皮肤常规消毒，在红肿周围上下寻找上述穴位暴露于皮肤浅表之脉络。每次选 2~3 穴用三棱针快速点刺约 0.1 寸深度，出血约 5~20ml 不等，若出血量小于 3ml，针后加拔罐，并留罐 15min。治疗后的针孔消毒，敷以消毒纱布固定，3 天刺络 1 次，5 次为 1 个疗程，如不愈者，休息 1 周后进行下 1 个疗程。若出血量

多，大于 30ml 可用酒精棉球按压止血。严密消毒防止感染。

痛风性关节炎属中医热痹、历节范畴，病机在于湿热瘀阻，火热凝聚，滞留关节，经络失和，气血失畅。

刺络治疗痛风性关节炎，其主要治则是，泻热解毒，清热利湿，调和气血，疏通经络。选用照海、太冲、丘墟、地五会、足临泣、解溪、委中及足背部瘀阻比较明显的经络，诸穴具有出血泻热、活血消肿、疏通经络脏腑之气、调整机体气血的功用。瘀血痰浊随血而出，使临床症状迅速控制。本疗法对患者的嘌呤代谢有调节作用，故取得较好疗效。

凡精神紧张、畏惧刺络者应缓刺，下肢及足跗有重度静脉曲张者慎刺。亦可在曲张静脉之稍远处选小静脉刺络，但应注意控制出血量。凡严重贫血、血小板减少性紫癜、血友病、低血压、体弱者慎用本疗法。皮肤溃烂者，局部禁刺，应在稍远处取穴避让。此外危重患者伴痛风性关节炎者禁刺。

三、刺血为主 辅以中药

痛风是一组因嘌呤代谢紊乱所致的疾病。急性痛风性关节炎是原发性痛风的首发症状，临床以起病急骤，关节红肿热痛，且疼痛激烈为其特点。潘红玲采用刺血疗法加中药治疗急性痛风性关节炎，取得了一定的疗效。

刺血方法：患者取卧位，将其关节红肿疼痛处常规消毒，用梅花针重叩至皮肤出血（红肿处全部叩遍），立即加拔火罐（小关节处可用青霉素瓶去掉瓶底制成的小罐，用抽气法拔罐），等瘀血出净，取罐，用干棉球擦去瘀血。嘱患者刺血处当日不可见水，以免感染。每处每次宜拔出瘀血 5~10ml 为度。每周放血 2 次，4 次为 1 个疗程。

中药：以独活寄生汤合四妙丸化裁，药物组成：独活 15g，桑寄生 15g，秦艽 12g，防风 12g，当归 12g，赤白芍各 12g，川芎 9g，生地黄 15g，川牛膝 15g，茯苓 12g，苍术 15g，黄柏 15g，薏苡仁 30g。随症加减：发热甚者，加生石膏 30g，知母 15g；红肿甚者，加赤芍 15g，忍冬藤 15g，赤小豆 15g；痛甚者，加姜黄 9g，炮穿山甲 9g，制乳香 9g，没药 9g；肝肾亏虚者，加枸杞子 15g，杜仲 15g；大便秘干

结者，加生大黄 9g（后下）。每日 1 剂，水煎服，早晚各 1 次，14 剂为 1 个疗程。

急性痛风性关节炎属于祖国医学的痹证，潘红玲认为本病系由饮食不节，恣食酒醴肥甘，引起脏腑功能失调，湿浊内生，闭阻经络，气血运行不畅，日久瘀血湿浊痹阻关节所致。其发病以脾肾两虚为本，湿浊、热毒、血瘀为标，属正虚邪实之证。根据《灵枢·九针十二原》“宛陈则除之”的治疗原则，在其痛处采用刺血疗法，意在疏通经络，使气滞血瘀的病理变化恢复正常，达到消肿止痛的目的；中药则以独活寄生汤合四妙丸化裁，健脾益肾、清热利湿、活血通络，从而使气血运行畅通，湿热之邪随之排出体外。局部刺血加整体辨证用药，共奏标本同治之功效。

现代医学认为，痛风是由体内嘌呤代谢障碍，血尿酸增高而致尿酸钠盐在关节和关节周围组织以结晶形式沉积，而引起的急性炎性反应。尿酸生成增多、增速或排泄减少、减慢，均可使血液中尿酸浓度增高，成为痛风发病的主要环节，因此，降低血尿酸浓度为治疗痛风病的关键所在。潘红玲认为，采用刺血疗法有直接促进血尿酸排泄的作用，而中药方剂清热除湿又可抑制尿酸的合成，从而降低关节组织中尿酸钠盐的含量，达到消除患者关节红肿热痛的目的。

四、随证取穴 针灸并用

陈英采用电针加艾条温和灸治疗急性痛风性关节炎，疗效满意。

取穴：主穴取患侧足三里、三阴交、阳陵泉、公孙、八风、阿是穴。湿热内阻证配曲池（双）、阴陵泉（双）；瘀热内郁证配血海（双）、合谷（双）；肝肾阴虚证配肾俞（双）、太溪（双）。

操作：患者取仰卧位，所取主配穴、所用针具及医者手指经常规消毒，将针刺入穴位得气后，再将针柄与 G6805 型治疗仪导线连接，选连续波，用中频率，电流以患者能耐受为度，留针 30min 出针并泻八风穴。出针后点燃纯艾条 1 支，分别在上述施针穴位上施温和灸，每穴 10min，艾火距穴位约 1 寸左右，以施灸部位局部潮红又不产生灼痛为度。上述治疗每天 1 次，10 天为 1 个疗程。

痛风性关节炎是因体内嘌呤代谢障碍和血尿酸持续升高引起的以关节红、肿、热、痛为主，甚则僵硬、畸形为特征的关节炎。多因过食膏粱厚味，以致湿热内蕴，浸渍于肌肉关节，又兼外感湿邪，侵袭经络而致气血不通，瘀血凝滞，阻塞经脉，而使气血运行不畅，从而引起关节红肿疼痛。其病机关键为湿热瘀血阻滞经脉。足三里是足阳明胃经合穴，三阴交是足三阴经之交会穴，两穴相配可加强健脾和胃、扶正培元、疏风化湿、通经活络之功；阳陵泉既是足少阳胆经合穴又是筋之会穴，公孙既是足太阴脾经络穴又是八脉交会穴之一，两特定穴相配更能健脾胃、调冲任、清肝胆、舒筋利节。合谷、曲池、阴陵泉、血海以助清热、祛湿、舒筋、蠲痹之功。三组穴合用，相得益彰，加强了健脾和胃、清利湿热、化瘀利浊、通络止痛的作用。电针镇痛可调整机体各系统功能，增加机体的防御免疫作用。艾条温和灸清利湿热、活血祛瘀、疏通经络、健脾治本，并有助于血尿酸的溶解，协同作用，从而使筋脉通畅，气血调和则痹痛可蠲。

李某，男，38岁，于2000年3月26日入院。因左足第一跖趾关节红肿疼痛3天入院。查：见左足第一跖趾关节红肿灼热，拒按，压痛明显，活动受限。体温38.5℃，口渴，心烦，溲黄，舌红，苔黄腻，脉滑数。西医诊断为痛风性关节炎，中医证属湿热痹阻。即采用针刺左侧足三里、三阴交、阳陵泉、阿是穴配曲池（双）、阴陵泉（双）得气后将针柄与G6805-1治疗仪导线连接，留针30min，出针后针泻八风穴。后同时点燃2支艾条依次选曲池、足三里、阴陵泉、阳陵泉、三阴交与阿是穴施温和灸每穴10min，1次治疗后疼痛消失，但红肿未见消退，2次电针加艾条温和灸后红肿消失，关节功能恢复正常，共经7次治疗，复查血尿酸正常，血沉正常而出院。随访2年无复发。

五、电针配穴位注射 消肿止痛

原发性痛风性关节炎是嘌呤代谢紊乱所引起的疾患，各种年龄均可发病，但中年以上者较多，尤以中年男性为多见。本病起病急骤，多数于半夜或清晨发作，初期常为单侧第1趾关节剧痛，常累及足跟、指、趾关节及其他小关节，有红、肿、热、痛，血液尿酸

浓度高于 $400\mu\text{mol/L}$ 。张静采用电针加穴位注射治疗原发性急性痛风性关节炎，疗效较佳。

取穴：患侧隐白、大敦、太冲、三阴交、阳陵泉、阴陵泉。

操作：穴位常规消毒后，针刺穴位使之得气，再用青岛产 G6805 电针治疗仪，选用连续波，电流强度以病人能耐受为度，通电 30min。

穴位注射：取患侧足三里。穴位常规消毒后，用 5ml 一次性注射器套上 7 号针头，吸入复方丹参注射液 2ml，将针刺入穴位，得气后注入药液。

以上治法每日 1 次，10 天为 1 个疗程，每疗程间隔 5 天。

中医学认为，原发性痛风性关节炎属于痹证、历节风等范畴，常因湿热内蕴，兼感风寒，内侵经络，郁而化热致使气血失和，瘀血阻滞所致，治以清热除湿，疏风散寒，通经活络。根据急则治其标的原则，选用足厥阴井穴大敦，足太阴井穴隐白，清泻经脉热毒，达到清热、凉血、消肿、止痛；太冲、三阴交泻肝脾湿热；阴陵泉能化湿通络；阳陵泉为筋会，有通络利关节的作用，使用电针可加强刺激。足三里能清利湿热，又是强壮穴之一，具有调理气血和调节人体阴阳平衡的作用。丹参具有活血化瘀，通络止痛之功，复方丹参注射液现代医学表明是改善血液循环的首选药，将其注射于穴位，即可产生双重效应，从而达到疏通经脉，活血化瘀，消肿止痛的目的。在治疗期间，嘱患者饮食宜清淡，禁止吃高嘌呤食物。

毛某，男，60 岁，工人。1993 年 5 月 10 日初诊。主诉：右足跖趾突然红肿胀痛 3 天，曾用抗风湿药和消炎药治疗，未见好转。检查：右足第 1 趾关节红肿胀痛，紫红而发亮，触之灼痛，按之剧痛，行走困难，化验：血尿酸 $485\mu\text{mol/L}$ 。诊断：原发性急性痛风性关节炎。遂按上法治疗，1 个疗程后症状体征全部消除，功能恢复正常，血尿酸 $390\mu\text{mol/L}$ ，随访 1 年后未复发。

六、浮针疗法 通则不痛

李昌生采用浮针法治疗急性痛风性关节炎，取得显著疗效。

操作：病人仰卧位，在其病变痛点处作记号，采用中号浮针在痛点旁开 6 ~ 10cm 处（已用 75% 酒精棉球拭擦消毒）与皮肤成

15°~25°角快速刺入皮下（针尖向痛点），然后运针，单用右手沿皮下向前缓慢推进，可作扫散动作（即以进针点为心，针尖划弧线运动），操作应柔和，不致引起强烈刺激，当痛点疼痛消失或减轻后抽出针芯，用胶布固定皮下的软套管，留至24h后拔出，隔日1次，5次为1个疗程，第1疗程结束后，休息2天，继续下1个疗程。

湿热痹证，关于其病因病机，《针灸大成》谓：“病有三因，皆从气血”；《千金方》认为：“热毒气从脏腑出，攻于手足，手足则热、赤、肿、疼痛也”；朱丹溪在《格致余论》中指出痛风是“血中有热，再受风寒，热血得寒，痰浊凝涩引起”，均说明了急性痛风性关节炎与血中瘀热有关。

浮针的作用机制是在皮下针刺，与皮肤关系密切，肺合皮毛且肺朝百脉，肺气通过宣发功能把卫气和津液输布于体表，故浮针能使经脉气血运行，将体内的病邪从皮肤驱除。《素问·汤液醪醴论篇》曰“天病之始生也，极精极微，必先结于皮肤。”所以皮肤是人体的门户，也是疾病发生发展的重要路径，故浮针作用于皮下可疏通经脉经气、解表清热、行气活血、消肿止痛。

七、腹针为主 配合中药

卓鹰以腹针加中药治疗痛风，取得满意的疗效。

取穴：主穴：引气归元（即中脘、下脘、气海、关元、中极）；辨证加减：急性期：加腹四关、水分、上风湿点（双侧），肿胀可加局部刺络放血。慢性期：加气旁（双穴）、气穴（双穴）、足部及踝关节疼痛加下风湿下点。膝关节疼痛加下风湿点，手指和肘等部位取上风湿外点。

操作：根据体型胖瘦采用30号1~1.5寸一次性不锈钢毫针针刺，进针后不行针，每日1次，留针30min。每周连续治疗6天后休息1天。

中药：白鲜皮、青风藤、黄芪各30g，虎杖根、秦艽、鸡血藤、汉防己、白花蛇舌草、生地各15g，制马钱子0.6g（研末冲服），每日1剂，水煎分2次服。

腹腔内集中了人体许多重要的内脏器官，人体生命活动的许多功能均是在这些重要的器官的正常生理活动下得以运转，同时腹部

还分布了大量的经脉，为气血向全身输布、内联外达提供了较广泛的途径。薄氏腹针理论提出神阙调控系统，认为以神阙为轴心的腹部不仅有一个已知的与全身气血运行相关的循环系统，而且还拥有一个全身高级调控系统，腹针就是通过刺激腹部穴位调节脏腑失衡来治疗疾病。

痛风应归属中医学痹证、历节等范畴，主要缘于机体内在功能失调、湿热痰瘀之邪由内而生，其病机可概括本虚标实。既有先天不足之肾虚，还有后天失养造成脾肾两虚。由于肥甘饮酒、风寒湿邪、疲劳紧张而致湿、痰、瘀，进而造成肢体关节经络气血阻滞是其标实，不通则痛，因此关节红、肿、热、痛，本病迁延日久应可见肝肾两虚。故腹针治疗主穴是引气归元，气海、关元均属任脉，气海为气之海，关元为小肠募穴，有培肾固本补气之功效，故二穴合用具有调畅任督二脉兼补肾气之功，水分、上风湿点具有清热解毒之功，气海、关元、水分具有消肿、利水之功，共同消除充血水肿的炎症改变，腹四关疏通四肢气血，可起到活血化瘀作用，通则不痛。诸穴合用可缓解疼痛，改善症状。

八、局部取穴 火针点刺放血

胡丰村采用火针点刺放血治疗痛风，取得一定疗效。

操作：患者取坐位，双足垂地，穴位常规消毒。针刺前给病人解释火针的感应，消除其恐惧心理。选取患病关节局部高度肿胀、充盈、青紫的络脉上，用12号一次性注射针头在酒精灯上烧至通红时对准部位速刺疾出，深度为0.3~1.0寸。务必点刺准确，一针到位。每次治疗总出血量控制在50ml以内。关节局部肿胀明显者，可在患部散刺1~3针，使炎性渗出物排出。轻症每周1次，重症2天1次，一般1~2次症状可迅速得到控制，以2次为1个疗程。

急性痛风性关节炎是一种异质性疾病，遗传性或获得性引起尿酸排泄下降或嘌呤代谢障碍，导致血尿酸浓度过高而沉积于人体四肢关节引发红、肿、热、痛为主要表现的急性炎症，随着人们生活水平的提高，在中老年中发病率呈上升趋势。西医治疗主要以对症止痛、抑制血尿酸生成或促进其排泄。急性痛风性关节炎属于中医痹证、白虎历节的范畴。多为湿热浊毒瘀滞经络，不通则痛，治宜

清热利湿，化痰泻浊通络。

火针疗法治疗痛风具有以下三种作用：①借火助阳，温通经络。火针疗法通过加热的针体，通过腧穴将火热直接导入人体，直接激发经气，鼓舞血气运行，温壮脏腑阳气。火针借火热之力，亦起到艾灸之功，共同达到温通经络的作用，使气血畅通，通则不痛。②开门去邪，散寒除湿。开门祛邪，即通过灼烙人体腧穴腠理而开启经脉脉络之外门，给贼邪出路，火针可达到事半功倍之效。③以热引热，行气散毒。火针借助火力强开外门，将热邪引出体外，明·龚居中《红炉点雪》云：“热病得火而解者，犹如暑极反凉，乃火郁发之之义也”，故火针不仅对于风寒湿引起的痹证和寒证有效，同时对热证也卓有成效。热证由于局部血气壅滞，火郁而毒生，往往出现红肿热痛等多种表现。使用火针，可以温通经络，行气活血，借火力强开其门，引动火热毒邪直接外泻，从而使热毒毒解，同时可以使血管扩张，血流加速，腠理宣通。《圣济总录》云：“肿内热气，被火夺之，随火而出”，指出因为火针速入疾出，使热外泄，起到以热引热之效。此外，通过局部放血排毒，迅速快捷地排放高黏度、含有大量尿酸盐之高压血液，可消除血管张力，降低血管阻力，直接改善血液循环，降低毛细血管通透性，降低胶体渗透压，减少局部炎性刺激，从而达到活血化瘀、疏经通络、消肿止痛的良好效应。

九、随症配穴 火针点刺

痛风是一组因嘌呤代谢紊乱所致的疾病。文绍敦应用火针点刺放血治疗各类痛风病，近期及远期疗效满意。

取穴：主穴为行间、太冲、内庭、陷谷。配穴：湿热蕴结加丘墟、大都、太白；瘀热阻滞加血海、隔俞；痰浊阻滞加丰隆、脾俞；肝肾阴虚加太溪、三阴交。均取患侧穴。

操作：足部腧穴用粗火针，踝关节以上腧穴用细火针。患者取直立位或坐位，双足垂地。穴位常规消毒后，将火针在酒精灯上烧至由通红转白亮时对准穴位速刺疾出，深度为0.3~1寸。每穴1~3针，足部腧穴以出血为度。每次治疗总出血量控制在100ml以内，每周治疗1次。术后，嘱患者在48h内保持针孔清洁干燥。

注意事项：①对痛风性关节炎急性发作，可在红肿的患部散刺数针，使炎性渗出物排出。②出血初为暗红色，待血色由暗转淡时会自行止血。若出血不止者，可加压止血。③对血友病等凝血机制障碍的患者，禁用此法。

痛风病药物治疗周期长，毒性及不良反应大，且费用较高，一般人难以承受。用本法治疗痛风病，旨在从非药物疗法上寻找一个方便、有效的方法。所选主穴行间、内庭为荥穴，荥主身热；太冲、陷谷为输穴，输主体重节痛。本病系由湿浊瘀阻，留滞关节经络、气血不畅所致。苑陈则除之，采用火针放血，意在温经通络，活血祛瘀，止痛消肿，化湿除痹。并且，火针对腧穴的刺激时间长，刺激量大，能持久地产生治疗作用。

王某，男，59岁。初诊日期：1994年6月5日。主诉：痛风3年。3年前，因右足第一趾环关节处突然红肿、疼痛，被某省级医院诊断为痛风病。经服用秋水仙碱、别嘌醇等药物症状缓解之后，每隔2~3个月该处肿痛发作1次。查体：右足第一趾环关节及足背红肿、发热、拒按，伴发热口渴，心烦不安，溲黄，舌红、苔黄腻，脉滑数。查血尿酸为 $580\mu\text{mol/L}$ 。诊断：痛风（湿热蕴结型）。遂在患侧行间、太冲、内庭、陷谷、大都、太白处用粗火针如上述之法点刺放血，6穴总计出血量为85ml，红肿即时见消，患者自觉轻松；第二天肿痛全消，1次而愈。3个月后查血尿酸为 $340\mu\text{mol/L}$ ，随访1年未复发。

十、以痛为腧 梅花针叩刺

痛风是因嘌呤代谢紊乱所致的疾病。成娅丽采用梅花针叩刺治疗痛风，疗效满意。

操作：针具选用牛角柄梅花针，患者取坐位，手、足放松，自然平放或垂地，手足下垫纸。用75%酒精局部常规消毒，随之用梅花针在患处反复叩打，中度刺激，故局部皮肤明显发红，并有轻微渗血，同时可用左手拇指或食指的指尖在患者被叩打部位旁侧进行揉按，以减轻局部肌肉痉挛疼痛，如视其发病部位辅以拔罐，疗效则更好。隔日1次，术后嘱患者保持局部干燥，注意休息及禁食刺激类食物。

痛风病多因患者平素过食膏粱厚味，以致湿热内蕴，兼因外感风邪，侵袭经络，气血不能畅通，致局部红肿灼热、疼痛、功能障碍。治疗痛风的药物疗程较长，且费用贵，令患者难以承受。用本法治疗痛风安全简便、疗效可靠，且治疗后不易复发，患者乐于接受。采用该治法治疗痛风本着血实宜决之、菀陈则除之的治疗原则，以及病证情况，用梅花针刺络放血，通过皮部—孙脉—络脉—经脉，起到调脏腑虚实，通经活络，平衡阴阳之作用。同时通过刺络放血改善了微血管的血道、流态、瘀点、流速，改进了组织缺氧状态，从而达到了疏散凝滞、祛邪通瘀、活血止痛、消肿的效果。

张某，男，48岁，初诊日期：1993年5月17日，主诉：痛风2年。2年前左足内侧第一跖趾关节突发性红肿、疼痛、活动受限。化验血尿酸8mg/dl，被某医院诊为“痛风”，经服用秋水仙碱、别嘌醇、丙磺舒等药物症状得以缓解。但此后每半年该患处发作1~2次。查：左足内侧第一跖趾关节及足背红肿灼热，疼痛拒按，不能行走，由他人扶助活动。化验血尿酸9mg/dl，诊断：痛风、继用梅花针在患处反复叩刺，致皮肤发红渗血，在足背处辅以火罐拔之瘀血，第二天红肿疼痛减轻，再行叩刺，3天后患处肿痛消失，行走自如，半月后查血尿酸6mg/dl，1年后随访无复发。

十一、梅花针配中药 分期治疗

李种泰采用梅花针结合中药治疗痛风，疗效显著。

梅花针：患者取卧位，选阿是穴（疼痛局部）、五输穴常规消毒（2%碘酒常规消毒，再用75%酒精脱碘），医者右手持消毒好的梅花针以腕力进行叩刺（直接经过患处的经脉及其表里经脉的五输穴重点叩刺）至点状出血；同时左手揉按叩刺部位旁侧皮肤，以减轻局部肌肉的痉挛疼痛和促进瘀血的排除。梅花针叩刺治疗隔日1次。急性期关节红肿热痛主症基本消失后、慢性期和间歇期，每周2次。10次为1个疗程。痛风急性期和发作期次日取金黄膏用醋或蜂蜜调和外敷患处，隔日换药。

中药：急性期和发作期用自拟祛风蠲痹止痛汤：萆薢15g，赤小豆20g，马齿苋20g，土茯苓15g，豨莶草15g，防己10g，威灵仙15g，车前草10g，金钱草20g，海金沙15g，生薏苡仁12g，泽兰

10g, 秦艽 10g。每日 1 剂, 水煎早晚服。慢性期和间歇期用自拟祛风蠲痹止痛汤加济生肾气丸: 萆薢 10g, 赤小豆 12g, 马齿苋 12g, 土茯苓 10g, 豨莶草 10g, 防己 8g, 威灵仙 10g, 车前草 12g, 金钱草 12g, 海金沙 10g, 熟地 15g, 炒山药 10g, 山茱萸 10g, 泽泻 10g, 白茯苓 10g, 丹皮 10g, 肉桂 6g, 炮附子 3g, 牛膝 8g。每日 1 剂, 水煎早晚服。中药治疗 15 天为 1 个疗程。

中医学认为痛风属“痹证”、“历节风”范畴, 由于先天禀赋不足, 或年老体弱, 脏腑功能失调, 尤以脾肾二脏功能紊乱, 脾失健运, 升降降浊无权, 肾阳不足, 膀胱的气化功能下降, 湿浊排泄减少, 加上平素嗜食膏粱厚味, 以致湿热内生, 湿热之邪流注经络, 舍于关节, 气血津液运行受阻, 郁化热毒, 壅遏血气致关节红肿热痛。日久则由于热毒煎熬, 结成砂石。其病机为本虚标实, 脾肾阳虚为本, 风湿痰瘀为标。故治疗根据急则治其标, 缓则治其本的原则, 急性期和发作期以清热解毒、疏通经络、消肿散结, 慢性期和间歇期以补益脾肾、化湿散热、利尿排石为治疗大法。根据《难经·六十八难》“输主体重节痛”, 选择五输穴梅花针叩刺放血, 有很好的泻火解毒、疏通经络、行气活血、消瘀散肿作用。中药治疗自拟祛风蠲痹止痛汤有清热解毒、利湿消肿之功效, 其中金钱草、海金沙、车前草清热利湿, 利尿排石; 马齿苋、土茯苓、萆薢、赤小豆清热解毒利湿, 消炎退肿; 生薏苡仁利湿消肿, 活血止痛; 泽兰活血化瘀, 行水消肿; 豨莶草、防己、威灵仙、秦艽祛风湿, 清湿热, 止痹痛。慢性期和间歇期加济生肾气丸取温补脾肾、利水消肿之意, 其中肉桂、炮附子补下焦之阳, 以鼓脾肾阳气; 熟地滋补肾阴; 山药滋肾补脾; 山茱萸滋肾益肝; 牛膝、车前子利水以温补脾肾, 化气行水; 泽泻利湿泻浊, 可防熟地之滋腻; 白茯苓渗利脾湿, 可助山药之健脾; 丹皮清热凉血, 活血化瘀。因此, 梅花针结合中药治疗痛风性关节炎, 可祛邪治标以化痰瘀, 扶正治本以调理脾肾。

金某, 男, 56 岁, 干部, 2004 年 7 月 19 日就诊。主诉左踝关节、左第 1 跖趾关节反复疼痛 15 年, 加重 1 天。症见面色苍白, 呻吟不已, 呈急性痛苦面容。检查见左踝关节及全足背部明显红肿, 左踝及左第 1 跖趾关节皮肤红肿灼热, 疼痛剧烈不能触碰。血尿酸 780.7mmol/L。诊断为痛风性关节炎急性发作期。梅花针叩刺结合自

拟祛风蠲痹止痛汤治疗1次,第2天局部红肿、疼痛明显减轻。3天后红肿、疼痛等症状全部消失,复查血尿酸恢复正常。为了预防发作,每周梅花针叩刺2次,并结合自拟祛风蠲痹止痛汤加济生肾气丸,共治疗15天。同时嘱患者不食或少食高嘌呤食物,忌烟酒,多饮水。随访1年未复发,临床治愈。

十二、局部取穴 齐刺加隔姜灸

痛风是临床上的常见病,其特点是起病急骤,受累关节红、肿、热、痛,活动受限;初起为单侧关节发炎,多数为第一趾关节,其次是腕、足跟、指、趾及其他关节。张谨采用齐刺出针让穴位流出淡黄色液体或血液,再用隔姜灸治疗痛风,取得较满意效果。

取穴:以痛点为主,选用压痛最明显的地方为齐刺点,配合邻近取穴和循经远取俞穴。

操作:选取好合适的姿势,局部消毒后,用毫针在最疼痛的地方直刺1针,然后在其左右再各刺1针,可配合邻近穴和俞穴,在痛点处接G6805治疗机,用连续波30min,以病人耐受刺激量为准。取针时齐刺处摇大针孔不按针孔,稍挤压使其流出淡黄色液体或血液,如果患部能拔火罐就多拔些血水出来,再在患处隔姜灸,每日1次,10次为1个疗程。

痛风属中医的痹证范畴,痹证是指气血为风、寒、湿邪阻闭所致,不通则痛。根据《内经·十二刺》曰:“齐刺者,直入一,傍入二,以治寒气小深者。”出针用泻法,使其苑陈则除之;再用隔姜灸祛除寒湿,温通经络,从而达到经络疏通,阴阳平衡,肿消痛止的功效。

刘某,男,70岁,1998年11月10日就诊。主诉:右腕肿痛,活动受限2天,腕部肿胀,稍红,压痛(++)有痛风病史,查血尿酸高。在最痛点齐刺,配外关和液门穴,接G6805治疗仪,取针时用泻法,使针眼流出淡黄色液体,再用小火罐拔痛处,使其多流出血水。然后隔姜灸,针1次后,疼痛大减,肿胀减退,8次痊愈。

十三、温针灸 清热泄火

丁锋采用温针灸治疗急性痛风性跖趾关节炎,获理想疗效。

操作：患者取坐位，在第一跖趾关节处取太冲（或行间）、大都、太白、公孙；在第二跖趾关节处取内庭（或陷谷）以及触痛最敏感点的阿是穴。75%酒精消毒后，用28号1.5寸不锈钢针灸针针刺上穴。阿是穴以《灵枢·官针》篇的“正内一，傍内四”的扬刺法针刺。针刺得气后留针。然后在针柄上插入已点燃的长1.5cm的艾卷，燃烧面朝下，一般灸2~3次后出针。出针时摇大针孔，在针孔处流出暗红色血液。一天治疗1次。

急性痛风性跖趾关节炎的临床表现属中医热痹范畴。其性质为热性、实证，病变在肝、脾、胃三经。所取行间为足厥阴肝经荥穴，太冲为输穴；内庭为足阳明胃经荥穴，陷谷为输穴，大都为足太阳脾经荥穴，太白为输穴。《难经·六十八难》指出：“荥主身热，俞主体重节痛”。所以跖趾关节炎取肝、脾、胃三经之荥、输穴又能起到清热泄火，利湿消肿、行气止痛的作用。

《灵枢·九针十二原》指出：“凡用针者，满者泄之，苑陈则除之，实则泻之。”为此，在出针时摇大其针孔，让暗红色血液自针孔流出，达到活血消肿的治疗作用。

传统的中医艾灸具有行气活血，温经通络，消肿散结和强壮保健的作用。经实验测定，艾绒在燃烧时的辐射能谱不仅具有远红外辐射，而且还具有近红外辐射。红外线辐射治疗炎症时可增强细胞的吞噬功能，引起主动脉性充血，改善血液循环，降低神经的兴奋性，具有镇痛消肿作用。在艾灸疗法过程中，近红外辐射作用于人体时，其具有较高的穿透能力，是一种有利于刺激穴位的信息照射，在产生受激共振的基础上，借助反馈调节机制，纠正病理状态下能量或信息代谢的紊乱功能，调控和提高机体的免疫能力。从以上传统的中医艾灸作用和现代科学实验研究艾灸疗法的作用机制充分说明温针灸治急性痛风性跖趾关节炎的原理。

温针灸疗法治疗急性痛风性跖趾关节炎，融针刺、放血、艾灸于一体的治疗方法，共奏清热泄火、行气活血、消肿止痛，调节人体嘌呤代谢紊乱功能的治疗作用。

胡某，男，61岁，退休干部。初诊日期，1992年3月7日。患者3月7日凌晨突感右第一跖趾关节红肿疼痛，不能下地行走。其子背来本科就诊。刻诊：第一跖趾关节焮红热痛，肿胀明显，触痛

剧烈。体形肥胖，有嗜酒史。血沉 15mm/h，类风湿因子阴性，血尿酸 $0.57\mu\text{mol/L}$ （本院血尿酸正常值为 $0.12\sim 0.42\mu\text{mol/L}$ ）。诊断为急性痛风性跖趾关节炎。行上法治疗后，翌日红肿消退，疼痛明显减轻，能自行走路。复诊时再行上法治疗，2 次后疼痛消失，行动自如。

十四、针刺配刺络拔罐 清热解毒

痛风是由于长期嘌呤代谢紊乱所致的疾病，临床上以高尿酸血症、急性关节炎反复发作、痛风石沉积和关节畸形为特点。临床表现为关节红、肿、热、痛反复发作，关节活动受限，可伴有发热、寒战、厌食、倦怠、头痛等症状。黄桂英采用针刺配合刺络拔罐方法治疗痛风，取得较为满意的疗效。

针刺：取患侧太白、大都、足三里、三阴交、丰隆、太冲、曲池，如合并其他关节痛者再取局部阿是穴。皮肤常规消毒针刺，急性期进针后提插捻转泻法，每日 1 次，每次留针 30min 后起针。10 次为 1 个疗程。

刺络拔罐：常规皮肤消毒后用三棱针在疼痛最明显处垂直刺入 0.1 寸，每个痛点刺 3~5 个点，随后用抽气式拔罐法，拔出 3~5ml 血液，10min 取罐，擦去血迹，消毒针孔，用无菌小纱布块包扎，隔日 1 次，每 5 次为 1 个疗程。

痛风属于中医学痹证范畴，多由风湿热邪痰瘀痹阻经络，不通则痛。针对病机取足太阴脾经原穴太白、足阳明胃经的合穴足三里，健运脾胃，清热化湿、蠲痹通络；结合病变的部位，取肝之原穴太冲、荣穴大都，手阳明大肠经合穴曲池，诸穴相配，能清泻血中之热毒，使湿热清除，痰化络通，则痹宣痛除。中医认为气行血，血载气，气行则血行，气滞则血瘀，瘀滞不通则痛。疼痛最明显处即为邪气最旺之处，在此进行刺血，放出恶血邪气，自然症状缓解，用刺血疗法可疏通气血，又可给邪气出路，通过刺络拔罐，使之随血直接排出体外，从而达到迅速消炎、止痛的目的。

男，45 岁。左侧第一跖趾关节痛 2 天，查局部发热、胀痛、压痛明显，左足不能下地行走，夜间痛甚，不能入睡，血尿酸 $510\mu\text{mol/L}$ ，尿酸 6.8mmol/L ，类风湿因子阴性，抗链球菌溶血素 $O < 200\text{U}$ ，

X线检查,关节肿胀,无痛风石沉积,既往有类似的发作病史,每次口服秋水仙碱后胃肠反应明显。西医诊断:痛风性关节炎。中医诊断为痹证。治则:宜痹化湿,清热止痛取左侧太白、大都、三阴交、丰隆、足三里、曲池,用提插捻转泻法,留针30min。皮肤消毒后用三棱针在第一跖趾关节垂直刺入,刺3~5点,用抽气式拔罐法拔出血液3~5ml,10min后取罐,擦去血迹,消毒点刺处皮肤,用无菌小纱布块包扎,经过2次治疗后疼痛明显减轻,停用刺络拔罐,用针刺疗法1个疗程痊愈。

十五、针药合用,清热利湿

钱志伟采用针刺配合中药内服外敷治疗痛风性关节炎,取得了满意疗效。

针刺:取足三里、商丘、太白、大都、太冲、行间、隐白等。除隐白穴外,其余穴位均以毫针刺入后留针15~20min,取针后再于隐白穴用毫针点刺放血。

中药:内服方选二妙散合五味消毒饮加减,即黄柏、苍术、野菊花、泽泻各12g,银花、丹皮各20g,紫花地丁、车前草、蒲公英各30g,木通15g。并根据患者情况辨证加减。每日1剂,分3次服用。外用金黄膏(成药)敷患处,每日一换。另嘱患者回家后注意休息,抬高患肢,禁食肥甘辛辣,禁饮酒。

中医学认为本病多与膏粱厚味,湿热阻滞有关,如《张氏医通·痛风》中提出“肥人肢节疼,多是风湿痰饮流注”。故肥胖及饮食条件优良者较易发病。根据痛风性关节炎的发病特点,钱志伟用清热利湿的二妙散和清热解毒的五味消毒饮合方为基本方,加入木通、泽泻、车前草、丹皮等利尿通络之品,以帮助排泄,祛除湿热,消炎止痛。外以金黄膏外敷以清热散结,活血消肿。针刺疗法能疏通经络,祛瘀逐邪,所选穴位又有健脾除湿、通经止痛之效。尤以隐白穴点刺放血,可增强活血通络,泻热利湿止痛之效。尤其是本病急性阶段,先以针刺为治,可明显的减轻症状。

王某,男,50岁,1998年2月25日初诊。诉近年来连续多次吃了海鲜后突发右足跖趾及足背处红肿发热,疼痛难忍,足不能着地,曾到本市某医院查血诊为痛风,经吃药无效。查患者右跖趾跖

关节内上方红肿明显，右足背偏内侧处红肿，压痛明显，皮温高，脉弦数，舌质红、苔黄厚腻。遂诊为痛风性关节炎，证为湿热壅滞，痹阻经脉，治以清热利湿，通络宣痹。即以上述方法治疗，3天后患者肿痛已基本消失，已能下地行走，再以中药内服外敷3天，其足已恢复正常。

十六、随症选穴 针药并施

叶梅惠采用针刺配合中药治疗原发性痛风性关节炎急性发作，取得较好的疗效。

针刺：取穴阿是穴、三阴交穴，阴陵泉穴、足三里穴、肝俞穴、肾俞穴，发于第一跖趾关节者加刺大都穴，太白穴、行间穴、太冲穴，累及内踝关节者加刺太溪穴、照海穴、中封穴，累及外踝关节者加刺昆仑穴、申脉穴，丘墟穴，发于膝关节者加刺阳陵泉穴、血海穴、梁丘穴，发于腕关节者加刺阳池穴、外关穴、阳溪穴、腕骨穴等。操作：穴区局部常规消毒后，视针刺部位不同选用1~1.5寸长的毫针针刺，得气后行平补平泻法，留针30min，期间可接KWD-808Ⅱ全能脉冲电疗仪，采用疏密波。取针时阿是穴应摇大针孔出针，尽量使其出血。每日针刺1次，7天为1个疗程。

中药：内服四妙丸加味：黄柏15g，苍术10g，牛膝10g，苡仁15g，当归12g，赤芍10g，泽泻10g，茯苓15g，威灵仙15g，桑寄生10g，杜仲10g，防己10g，丹皮10g，桂枝6g，甘草3g。以上诸药加水300ml，煎取法200ml，每日服3次，每次服200ml，日服1剂。7天为1个疗程。

《景岳全书》中云：“历节风痛是气血本虚，或因饮酒腠理开汗出当风所致；或因劳倦调护不谨，以致三气之邪偏历关节，与气血相搏而疼痛非常，或如虎之咬，故有白虎历节之名”。《金匱翼》云“脏腑经络，先有蓄热而遇风寒湿气客之，热为寒郁，气不得通，久之寒亦化热，则痹然而闷也。”所以叶梅惠认为正气不足，脏腑经络蓄热是患病的内在因素，为本。感受风寒湿邪是患病的外在因素，为标。根据其病因病机则采用清热凉血，利湿通络，益气养血，兼补肝肾之法标本同治，使正气得补，蓄热得解，达到消肿止痛的目的。治法中阿是穴及其周围腧穴清热活血，消肿止痛，阴陵泉清热

利湿，足三里健脾益气，肝俞、肾俞补益肝肾，三阴交调理肝脾肾脏腑之气。四妙丸（黄柏、苡仁、苍术、牛膝）清热利湿，泽泻、茯苓、甘草健脾益气利湿，当归养血活血，赤芍、丹皮凉血活血，杜仲、桑寄生、牛膝补益肝肾、强筋骨，威灵仙、防己、桂枝祛风湿利关节通络。针药并用相辅相成，标本同治提高疗效。此外，患者在起居、饮食、劳倦等方面的调护对本病的治疗也起到积极的作用。

十七、内外合治 针药并用

文绍敦采用火针放血外治和自制的痛风舒胶囊内服，针药并用治疗痛风，取得了很好的临床疗效。

（一）病因病机

痛风是一组因嘌呤代谢紊乱所致的疾病，高尿酸血症是其重要的生化基础。属于中医痹证、历节范畴。文绍敦教授认为痛风是由于湿浊瘀阻，留滞关节经络，若遇外因触动，如局部关节损伤、穿紧鞋、走路多、饱餐、饮酒、过度劳累、感受风寒湿邪等，引发内伏血分之浊毒，浊毒阻滞脉络，气血运行不畅，不通则痛。浊毒浸渍于关节肌肉，致痛风反复发作。痛风根据其临床表现不同分为急性期和间歇期。

（二）治疗方法

1. 急性期

多为湿热浊毒瘀滞经络，不通则痛。治宜清热利湿，化瘀泻浊通络。文教授采用火针放血疗法，并结合痛风舒胶囊内服，治疗痛风性关节炎急性发作。

火针放血：主穴为行间、太冲、内庭、陷谷，配穴以阿是穴为主，均取患侧穴。患者取坐位，双足垂地，穴位常规消毒后，将火针在酒精灯上烧至由通红转白亮时对准穴位速刺疾出，深度为0.3~1寸。每次治疗总出血量控制在100ml以内，每周1次。关节局部肿胀明显者，可在患部散刺数针，使炎性渗出物排出。

痛风舒胶囊：药物组成：大黄、泽泻、车前子、川牛膝、汉防

己（由青海绿色药物研究所制备，每粒相当于生药 1g）。服法：每次 2 粒，每日 3 次，饭后 30min 时服，20 天为 1 个疗程。

2. 间歇期

多为痛风反复发作，致肝肾脾虚，湿浊瘀阻，气血不畅。患者尿酸值高于正常。治宜补肝肾脾、祛湿泻浊，化瘀通络。文教授在饮食、一般治疗的同时，采用痛风舒胶囊内服治疗，取得较好疗效。

火针放血疗法取主穴行间、内庭为荥穴，荥主身热；太冲、陷谷为输穴，输主体重节痛。本病系由湿浊瘀阻，留滞关节经络，气血运行不畅所致。苑陈则除之，采用火针放血，意在温通经络、活血化瘀、消肿止痛、化湿除痹，并且火针对腧穴的刺激时间长，刺激量大，能持续的产生治疗作用。足部腧穴用火针点刺后，出血量多（每穴出血量最多不要超过 30ml）者疗效好。如出血量少或针后未出血者疗效差，需经多次治疗方能见效。

中药方中大黄为泻下药，具有攻积导滞、泻火凉血、活血祛瘀之功效；泽泻、车前子为利水渗湿药，具有利水渗湿、利尿通淋、清热祛湿之功效；川牛膝为活血化瘀药，具有活血祛瘀、引血下行、补肝肾、通淋涩之功效；汉防己为祛风湿药，具有祛风湿、止痛、利水之功效。诸药合用，既有活血祛瘀、利水渗湿、消肿止痛之功，又有降低尿酸之效。在治疗中用药剂量宜小，每日服生药 3g 者（生药 1 日剂量可达 9g）更有利于降低尿酸，用药剂量过大可导致关节内尿酸盐结晶迅速析出、沉积，致使急性关节炎反复发作，患者误认为降尿酸药无效而停药或换服其他药物。

陈某，男，52 岁。因右踝关节、右足第一跖趾关节红、肿、热、痛及活动受限 2 日，2001 年 10 月 7 日初诊。患者自诉已有 5 年的痛风反复发作史，曾确诊为痛风。此次于 2 日前夜间突然发作，右踝关节、右第一跖趾关节肿胀、疼痛、活动受限，服用秋水仙碱 0.5mg，每天 4 次，出现恶心呕吐、腹痛，不能耐受，即停用。查体：右踝关节、右足第一跖趾关节肿胀，皮色发红，局部皮温高，有压痛，右耳轮见 2cm × 2cm 大小的痛风石结节，无破溃，查尿酸 692 μ mol/L，诊断为急性痛风性关节炎。予以痛风舒胶囊口服，2 粒，每日 3 次。火针放血外治，在患侧行间、太冲、内庭、陷谷及

关节红肿处用火针如前述之法点刺放血，总出血量为 85ml，红肿即时减退，患者自觉轻松，治疗 3 天后，疼痛逐渐缓解，肿胀消退，关节活动改善。继续服药 2 周，症状完全消失，查血尿酸为 $410\mu\text{mol/L}$ ，随访 1 年未见复发。

马某，男，58 岁。因反复发作的右足跖趾关节疼痛肿胀 3 年，近 6 个月内加重，2002 年 11 月 10 日初诊。患者自诉 3 年前夜间突发右足第一跖趾关节疼痛，在当地县医院查血尿酸增高（具体不详），诊断为痛风，经服用秋水仙碱后缓解。此后每遇寒冷、劳累后发作，自服秋水仙碱可缓解，平素未服用任何药物治疗。近 6 个月内，疼痛间歇期逐渐缩短，疼痛时间延长，服用秋水仙碱疗效不佳，且恶心呕吐严重，伴头痛，故来就诊。查体：右第一跖趾关节红肿，局部皮温高，有压痛，活动受限，未发现痛风结节。查血压 160/90mmHg，血尿酸 $730\mu\text{mol/L}$ ，血甘油三酯 4.9mmol/L 。确诊为痛风伴高血压。治疗以痛风舒胶囊 2 粒，每日 3 次，并辅以波依定和血脂康胶囊口服，嘱患者禁止食用动物内脏、海鲜等高嘌呤饮食，忌服酒类，多饮水。2 周后，疼痛肿胀较前缓解，查血压 130/80mmHg，血尿酸 $628\mu\text{mol/L}$ ，血甘油三酯 3.77mmol/L 。继续服药至 1 月后复查，症状消失，血压 130/75 mmHg，血尿酸 $398\mu\text{mol/L}$ ，血甘油三酯 $2.27\mu\text{mol/L}$ 。随访 1 年，患者无急性痛风性关节炎发作。

十八、病分急慢 刺络拔罐为主

刺络亦称放血疗法，是刺破身体某一部位的小血管，放出少量血液的治疗方法。吴延斌采用该法治疗痛风性关节炎，疗效的确满意。

根据病情分急性发作与慢性发作两种：①发病在 7 天以内，关节剧痛难以忍受，局部有明显红肿，痛处发热处拒按，而且血尿酸有显著升高者为急性发作；②发病在 7 天以上，关节有酸胀痛但疼痛能忍受，局部微有肿胀，按之痛甚，血尿酸较正常值增高者为慢性发作。

具体：①拔罐法选用大小不等的小口药瓶，瓶口保留铝盖和橡皮塞完整，将瓶底用砂轮磨掉，边缘磨光滑备用；②刺络局部皮肤和三棱针均需用碘酒、酒精棉球严格消毒，然后用三棱针正对治疗

点刺入，使血液流出，随即用磨好的药瓶叩在刺入点上，用注射器抽去瓶内的部分空气，使之造成吸着皮肤，出血量以3~5ml为宜；③疼痛剧烈难以忍受者，刺络放血后可局部用0.2%利多卡因2ml+醋酸泼尼松龙25ml痛点注射。

中医学理论认为：局部红肿疼痛为气血瘀阻，凝结不散，凝则脉不能，不通则痛。古人对刺络放血也非常重视：《素问·血气形志篇》注“凡治病必去其血”。《灵枢·九针十二原》篇中还提出了“苑陈则除之”的治疗原则。因此刺络法在临床上具有通经活络、开窍泻热、消肿止痛的作用。

现代医学认为：其致病因素主要为尿酸沉着在关节，关节周围及关节外组织中的物理学改变，形成组织中的尿酸结石，另外即尿酸存在于组织中的化学反应变化而导致代谢失调。刺络拔罐法能改善局部血液微循环，缓解血管痉挛，从而达到了消肿止痛之目的。

刺络拔罐法消肿止痛疗效迅速，但在临床上有些患者远期疗效不巩固。为了避免该病的复发，在日常生活中应避免食用嘌呤含量过高的食物和忌饮啤酒。刺络操作不可用力过猛和刺入太深，以防出血过多、伤口过大造成不必要的周围组织损伤。

刘某，男，55岁，高级工程师，左跖趾骨关节胀痛3天，因工作劳累加之饮酒后导致疼痛明显加剧，行走活动不能，疼痛日轻夜重。查体：体温38.6℃，表情痛苦，左跖趾明显红肿，局部压痛(+++)。查血尿酸报告提示460mmol/L。诊为痛风性关节炎。经按本文介绍的刺络拔罐法治疗1次后，患者自感疼痛基本消失，红肿明显减退，体温下降。第三天复诊时诸症皆除。

姚某某，男，33岁，工人，体胖，无任何诱因，自感右膝关节内侧红肿痛1周，症状呈进行性加重，因疼痛难忍，站立行走不能，被他人抬入门诊就医。查体：痛苦面容，呻吟不止，右侧膝关节髌骨下缘处明显红肿，局部拒按，触之疼痛难以忍受。仍按本文介绍的刺络拔罐法治疗完毕后局部用0.2%利多卡因+醋酸泼尼松龙25ml痛点注射后，患者即感疼痛明显缓解且能自行走路。次日查血尿酸提示为438mmol/L，按原方法治疗2次而愈。

十九、泄浊祛邪 泻热化瘀

李岩以泄浊祛邪、泻热化瘀为治疗原则，采用火针治疗，疗效显著。

取穴：主穴：肝俞、行间、太冲、内庭、陷谷、阿是穴；随证取穴：湿热蕴结加脾俞、太白；瘀热阻滞加血海、膈俞；痰浊阻滞加丰隆、足三里；肝肾阴虚加太溪、照海。

操作：选择所刺穴位，体位固定，充分暴露其处，用75%的医用酒精棉球充分消毒，同时在针刺前，要给病人解释火针的感应，消除患者的恐惧心理。针刺时，要求火针在酒精灯上加热至通红，然后施针于患处。本病证一般采取快针法。针刺后，用干棉球迅速按压针孔，以减轻疼痛，出血勿止。嘱患者不要搔抓患处；一天内不要洗澡；不要污染局部；如局部微红，高起于皮肤为火针后正常反应，2天后可自行消退；火针治疗期间忌食生冷；针后半小时之内勿饮水。

中医常将痛风列入痹证范畴，但其又具有独特的表现，如文献中述：“走痛于四肢关节如虎咬之状”；“夜则痛甚，疼痛如掣”；“痛有常处，多为赤肿灼热……足附肿甚……稍有触动其痛非常”，这些描述均相似于现代痛风的临床表现，中医痛风一词是金元医家李东垣、朱丹溪最早提出的。李东垣在《兰室秘藏》中认为痛风的主要病因在于气血虚弱。朱丹溪亦曾指出“痛风者，四肢百节走痛，谓之白虎历节风证是也”。

在病因病机方面，指出“痛风者浊毒滞留血中不得泄利，渐积日久愈滞愈甚，或偶逢外邪相合终必瘀结为害，或闭阻经络，突发骨节剧痛，或兼加凝痰，变生痛风结节，久之痰浊瘀腐则溃流脂浊，痰瘀胶固，以致骨节僵肿畸形”。《万病回春》中云：“一切痛风肢节痛者，病属火，肿属湿”，“所以膏粱之人，多食煎炒酒食热物蒸脏腑，所以患痛风、恶疮痈疽者最多”。《张氏医通·痛风》指出“痛风一证〈灵枢〉谓之贼风，《素问》谓之痹，《金匱》名曰历节，后世更名曰历节，多由风寒湿气，乘虚袭于经络，气血相凝滞所致”。《外台秘要》中指出：“白虎病者，大多是风寒暑湿之毒”。以上论述都明确指出痛风之为病主要是瘀浊郁热凝滞不得泄利，闭阻

关节所致。因此在治疗时应以泄浊祛邪、泻热化瘀为主，并且要审证权变、标本同治。

火针疗法治疗痛风具有以下三种作用：

（1）借火助阳，温通经络

火针疗法通过加热的针体，通过腧穴将火热直接导入人体，直接激发经气，鼓舞血气运行，温壮脏腑阳气。火针借火热之力，亦起到艾灸之功，共同达到温通经络的作用，使气血畅通，通则不痛。

（2）开门去邪，散寒除湿

开门祛邪，即通过灼烙人体腧穴腠理而开启经脉脉络之外门，给贼邪出路。《东医宝鉴》和《针灸集成》也对开门祛邪之说有所比喻，其云：“譬如盗入人家，必开门逐之使出，万一门不开而无所出，必伤生乃已”。痹证日久，必然在体内产生一些诸如瘀血、水湿等致病性病理产物，一旦形成，就会停滞于局部经脉、关节，火针可达到事半功倍之效。

（3）以热引热，行气散毒

火针借助火力强开外门，将热邪引出体外，明·龚居中《红炉点雪》云：“热病得火而解者，犹如暑极反凉，乃火郁发之之义也”，故火针不仅对于风寒湿引起的痹证和寒证有效，同时对热症也卓有成效。张景岳《类经》中曾对此解释曰：“因其势而解之、散之、升之、扬之，如开其窗，如揭其被，皆谓之发”。热症由于局部血气壅滞，火郁而毒生，往往出现红肿热痛等多种表现。使用火针，正可以温通经络，行气活血，借火力强开其门，引动火热毒邪直接外泻，从而使热清毒解，同时可以使血管扩张，血流加速，腠理宣通。《圣济总录》云：“肿内热气，被火夺之，随火而出”，指出因为火针速入疾出，使热外泄，起到以热引热之效。

张某，男，38岁，干部。2001年12月11日就诊。1999年起右足第一趾关节红肿疼痛，被某医院确诊为痛风。曾服用秋水仙碱、别嘌吟等药物治疗后，症状好转，但主诉胃肠道不良反应很大。后每隔3~4个月急性发作1次，患者痛苦不堪。2001年12月8日突起右足第一趾关节疼痛剧烈，行走不利，自行采用麝香关节膏贴敷，2天后关节疼痛加剧，红肿蔓延至足背，以致右足不能触地，步履艰难，遂来就诊。查体发现患者面部轻微浮肿，右足第一趾关节红肿

疼痛，拒按，伴发热口渴，心烦不安，溲黄，舌红苔黄腻，脉滑数。实验室检查血尿酸为 $590\mu\text{mol/L}$ 。诊断为急性痛风性关节炎。遂在患者右足部以中粗火针于肝俞、行间、太冲、内庭、陷谷、太白及疼痛剧烈处（多为痛风石沉积处）点刺出血。针刺后即刻患者感觉疼痛明显减轻。以后隔日针刺1次，治疗3次后，疼痛全消。嘱其继续巩固治疗，5次为1个疗程。3个月后查血尿酸为 $350\mu\text{mol/L}$ ，随访1年未复发。

二十、针药并用 急慢性治法各异

张吉采用针药并用治疗痛风性关节炎，针灸清热祛湿，活血通络，消肿止痛；中药利湿分清化浊。内通外达，逐邪外出，对痛风性关节炎起到标本兼治的作用。

（1）对病因病机的认识及治则

正如张景岳《景岳全书》所曰：“外是阴寒水湿，令湿邪袭人皮肉筋脉；内由平素肥甘过度，湿壅下焦，寒与湿邪相结郁而化热，停留肌肤……病变部位红肿潮热，久则骨蚀。”张吉认为痛风性关节炎的病因主要由于两个方面：外因为感受风寒水湿，寒湿之邪侵入机体皮肉筋骨和关节；内因为平素过食肥甘厚味，或饮酒无度，或多食乳酪，脾胃运化失常，湿热内生而致病。而痛风性关节炎的发病与后者关系更为密切。

张吉认为痛风性关节炎其本在脾肾，其标在湿浊。脾虚运化失司，湿浊内生；肾虚二便失司，湿浊内聚；湿浊内盛，郁而化热。湿热流注关节、肌肉、筋骨，闭阻经脉，即出现关节红肿热痛。故张吉治疗痛风性关节炎的急性期以利湿清热、通络止痛为主；慢性期以健脾补肾、养血和营。针药并用，针灸多取脾肾二经之穴；中药重在利湿热分清化浊，内通外达，逐邪外出，肿消痛止而病愈。

（2）针灸治疗痛风本于脾肾二经

张吉认为痛风性关节炎属于足太阴脾经病，痛风性关节炎的发病与脾肾二经的关系密切，尤其与足太阴脾经关系最为密切。如临床上痛风性关节炎患者常常出现从第一跖趾关节开始的循足太阴经的刺痛。故在临床上张吉治疗痛风性关节炎多取脾肾二经的穴位。常以行间、大椎、解溪、太白、太溪、丘墟、三阴交、阴陵泉为主

穴。主穴中行间、大椎、解溪配太白、丘墟，清泻湿热，通经止痛；三阴交、太溪、阴陵泉，活血化瘀，利湿消肿。诸穴共奏清热祛湿、活血通络、消肿止痛之功。

在主穴的基础上，还要注意随症加减，如第一跖趾关节肿痛可配隐白、大都、太冲等；踝关节肿痛者加绝骨、昆仑、商丘、足三里等；膝关节肿痛加血海、犊鼻、鹤顶、梁丘等；肘关节肿痛加曲池、尺泽、少泽、手三里、合谷等。累及腕关节者加刺阳池、外关、阳溪、腕骨等。张吉用针灸治疗痛风性关节炎一般用泻法，隔日1次，每次留针30min。

(3) 中药治疗重在利湿热分清化浊

张吉治疗痛风性关节炎一般采用自拟经验方，经验方组成为萆薢、瞿麦、萹蓄、酒大黄、泽泻、茯苓、猪苓、车前子、制黄芪、香附、郁金、元胡、炙甘草。经验方中萆薢、萹蓄利湿热分清化浊；酒大黄活血逐瘀通经；泽泻、茯苓、猪苓、车前子利水渗湿消肿；制黄芪、瞿麦益气补血除热；香附、郁金、元胡疏肝解郁，行气活血止痛；炙甘草调和诸药。诸药共奏利湿热分清化浊，行气活血止痛消肿之功。

临床上还要注意随症灵活加减，如反复发作，局部色黯，夜间痛重，瘀毒为甚者，张吉一般重用酒大黄加赤芍、牡丹皮、虎杖、鸡血藤等；肿胀明显，酒食诱发，苔厚腻，脉滑者，湿毒偏重，重用萆薢加土茯苓、黄柏、防己等；疼痛剧烈加制川乌、草乌等；痰毒为著，关节畸形、结石者，加白芥子、皂角刺、夏枯草、牡蛎等。湿甚纳呆者加苍术、砂仁等；夹瘀、肌肤甲错加泽兰、丹皮、川牛膝等；局部色红灼热，舌红，脉数，热毒明显者，加金银花、蒲公英、紫花地丁、漏芦、山慈菇、白花蛇舌草等。张吉用自拟经验方加减治疗痛风性关节炎一般采用中药水煎服，每日1剂，每剂分2次服。

范某某，男，42岁，门诊病例。2004年11月4日初诊。三天前因大量饮酒，夜间突发右足第一跖趾关节红肿热痛，疼痛剧烈。既往有急性痛风性关节炎病史2年。现症：右足跖趾关节、足背及踝关节处黯紫肿大，皮肤灼热，压痛明显，行走困难。伴口干、大便干燥、尿黄，舌红、苔黄腻，脉弦数。查血尿酸 $510\mu\text{mol/L}$ 。诊

断：①西医：急性痛风性关节炎；②中医：热痹，证属湿热浊毒痹阻经络。治法：清热利湿，化浊通络。①针刺：取行间、大椎、解溪、太白、太溪、隐白、大都、太冲、丘墟、三阴交、阴陵泉，针刺隔日1次，采用泻法，每次留针30min。②中药：萆薢15g，瞿麦15g，篇蓄12g，酒大黄6g，泽泻12g，茯苓12g，猪苓12g，车前子12g，制黄芪15g，香附12g，郁金12g，元胡12g，炙甘草6g，每日1剂，水煎服，1剂分2次早晚服。针药并用治疗1周后，上述症状明显减轻，关节红肿热痛消失，活动正常，复查血尿酸 $325\mu\text{mol/L}$ 。继守上处方，针药并用治疗15天后，诸症状消失痊愈。随访1年，未见复发。

参考文献

- [1] 陈雷. 刺络拔罐法治疗急性痛风39例. 上海针灸杂志, 1999, 18 (5): 30
- [2] 李扬缜. 刺络治疗痛风性关节炎32例. 中国针灸, 2006, 26 (2): 150
- [3] 潘红玲, 许天兵. 刺血疗法加中药治疗急性痛风性关节炎50例. 中医研究, 2007, 20 (1): 49~50
- [4] 陈英. 电针加艾条温和灸治疗急性痛风性关节炎43例. 四川中医, 2007, 25 (1): 105~106
- [5] 张静, 沈宏家. 电针加穴位注射治疗原发性急性痛风性关节炎76例. 针灸临床杂志, 2005, 21 (11): 32~33
- [6] 李昌生. 浮针疗法治疗急性痛风性关节炎疗效观察. 辽宁中医杂志, 2005, 32 (10): 1069
- [7] 卓鹰, 惠华强, 方立, 等. 腹针加中药治疗痛风30例临床分析. 新疆医科大学学报, 2006, 29 (11): 1042
- [8] 胡丰村, 陈飞, 郑润杰, 等. 火针点刺放血疗法治疗急性痛风临床观察. 中医正骨, 2007, 19 (1): 9~12
- [9] 文绍敦, 赵国梁. 火针放血治疗痛风105例疗效观察. 中国针灸, 1996, (3): 23~24
- [10] 成娅丽, 吴延林. 梅花针叩刺治疗痛风23例. 针灸临床杂志, 1999, 15 (10): 33~34
- [11] 李种泰, 杨文波. 梅花针结合中药治疗痛风性关节炎37例. 四川中医, 2005, 23 (9): 105~106

- [12] 张谨. 齐刺加隔姜灸治疗痛风. 针灸临床杂志, 2000, 16 (8): 47
- [13] 丁锋. 温针灸治疗急性痛风性跖趾关节炎 31 例. 针灸临床杂志, 1997, 13 (5): 70
- [14] 黄桂英. 针刺配合刺络拔罐治疗痛风性关节炎 32 例. 山东中医杂志, 2006, 25 (7): 467~468
- [15] 钱志伟, 王永渝. 针药合治痛风性关节炎 37 例. 实用中医药杂志, 2001, 17 (9): 13
- [16] 叶梅惠. 针药治疗原发性痛风性关节炎 25 例临床观察. 云南中医中药杂志, 2002, 23 (2): 37~38
- [17] 申海莉, 王玉凤. 文绍敦教授内外合治、针药并用治疗痛风经验. 河北中医, 2004, 26 (11): 806~807
- [18] 吴延斌, 宋群英. 刺络拔罐法治疗痛风性关节炎 25 例. 针灸临床杂志, 2003, 19 (12): 8
- [19] 李岩, 周震. 火针疗法治疗痛风临症举隅. 针灸临床杂志, 2003, 19 (7): 35~36
- [20] 何庆勇. 张吉教授针药并用治疗痛风性关节炎的经验. 四川中医, 2006, 24 (9): 4

【月经不调】

月经不调是以月经周期异常为主症的月经病，临床有月经先期、月经后期和月经先后无定期几种情况。西医学的排卵型功能失调性子宫出血、生殖器炎症或肿瘤引起的阴道异常出血等疾病可参照本节治疗。

月经先期又称经早或经期超前。主要因于气虚不固或热扰冲任。气虚则统摄无权，冲任失固；血热是流行散溢，以致月经提前而至。月经后期又称经迟或经期错后，有实有虚。实者或因寒凝血瘀、冲任不畅，或因气郁血滞、冲任受阻，致使经期延后；虚者或因营血亏损，或因阳气虚衰，以致血源不足，血海不能按时满溢。月经先后无定期又称经乱，主要责之于冲任气血不调，血海蓄溢失常，多由肝气郁滞或肾气虚衰所致。本病与肾、肝、脾三脏及冲、任二脉关系密切。

该篇收录了10位针灸医家的临床治验，有的辨证取穴，腹针为主；有的注重手法，采用阴中隐阳；有的独取神阙穴，药物贴敷；有的针灸并用，益气补血；有的独取隐白，子午流注施灸；有的采用穴位注射，益气摄血等，针灸对功能性月经不调有较好的疗效，但治疗时应把握好治疗时机，一般多在月经来潮前5~7天开始治疗，行经期间停针。

一、辨证取穴 腹针为主

月经不调是妇女月经病中最常见的疾病，凡是月经在周期、经量、经色、经质等方面的改变，同时伴有其他方面不适者叫月经不调。黄丽采用以腹针为主治疗月经不调。取得满意疗效。

取穴：主穴：中极、关元、中脘配穴：气门、外四满、经中。辨证加减：血虚者，加血海、三阴交；气虚者，加足三里、脾俞；血寒者，加命门、归来、三阴交；血热者，加行间、太溪；肝郁气滞者，加中脘、期门、内关；肾虚者，加肾俞、水泉。

操作：选用华佗牌一次性针灸针，规格为32号1.5寸毫针，按腹针的标准化取穴，刺主穴时将针进入地部，病人可无针刺反应或略有胀感，配穴将针刺入人部。虚证、寒证者可在主穴温针灸，或在神阙穴艾箱灸。

中医认为月经不调主要机制是肾阴阳在月经周期演变中的失衡。《校注妇人良方》引王子亭所说：“经者，常候也。为候其一身之阴阳衍状……阳太过则先期而至，阴不及则后时而来，其有乍多乍少，断绝不行，崩漏不止，皆由阴阳衰盛所至。”阴阳源于肾，故月经不调与肾之关系尤为密切。又有妇女以血为主之说，故在行经前后出现的有关病证，无不与子宫、冲、任、肝、脾有关。

腹针疗法是通过刺激腹部腧穴和一些特定的穴位来调节相关脏腑和经络失衡而达到治疗全身疾病的目的。腹针以它独特的处方标准化、操作规范化、辨证条理化来调节五脏六腑，更好的治疗脏腑病和一些慢性病。月经不调的治法应该以调经为主以治其本，本法以中极、关元为主穴，因二穴有培肾固本、补气回阳之功，中脘、关元为腹针之天地针，两穴合用具有补脾肾之功用。气门、外四满、经中穴均为腹针治疗月经不调的经外奇穴。艾箱灸神阙穴，具有温通脾肾、壮元阳、散寒湿之功效。根据辨证使用相应的处方，对治疗月经不调有独特的优势，通过腹针调气血、和脾胃、养肝肾，还可以调节内分泌，保持健康的肤色，延缓衰老。

患者杨某，女，36岁，2004年7月初诊。经水先后无定期，本次推迟一月未行，精力下降，胸胁胀闷不舒，烦躁易怒，面部黄褐斑增多，忽冷忽热，纳差，睡眠欠佳。妇检正常，雌性激素全套检

查正常，全身酸楚，头昏痛，舌苔薄白，脉弦细。证属肝郁脾虚，气血失调。治宜理气解郁，培土养血。取穴为：引气归元：中脘、下脘、气海、关元、阴交、气穴、太溪。每日1次，留针30min，治疗第5次，患者月经来潮，但量少色暗红，继续治疗10次停针。治疗后患者月水如期来至，量适中，精神好。

二、主穴三个 阴中隐阳

月经不调是妇科常见内分泌功能异常的疾病。陈美仁采用阴中隐阳针刺方法治疗本病，疗效满意。

取穴：主穴：关元、肾俞、三阴交。随证配穴：月经先期配行间、中封；月经后期配气海、足三里；月经先后不定期配期门、肝俞；倒经配气海、血海。

操作：主穴均运用阴中隐阳针法，阴中隐阳针法为先泻后补之法。根据穴位的可刺深度，分浅（5分）、深（1寸）两层操作，进针后先深层行泻法，紧提慢按6数，再退针到浅层行补法，紧按慢提9数。均不留针，可行数度。每日1次，10天为1个疗程，一般采用每个月治疗1个疗程，连续治疗至少3个月以上。根据辨证后选用的配穴则采用一般的平补平泻手法。

月经不调是妇科常见多发病。其病因病机为气血失调，冲任不固，经血不能按期而致。《傅青主女科》云：“夫同是先期而来，何以分虚实之异？……先期者火气之冲，多寡者水气之验。故先期而来多者，火热而水有余也；先期而来少者，火热而水不足也。倘一见先期之来，俱以为有余之热，但泄火而不补水，或水火两泄之，有不更增其病者乎！”故治疗采用阴中隐阳的先泻后补的针刺手法，先泻其有余之热，再补其不足之阴，并辨证论治取用行间配中封之妙穴，共收疏肝理气、清热调经之功。

三、独取神阙 药物贴敷

庞保珍采用药敷法治疗月经先期，疗效满意。

取穴：神阙。

操作：神功经先散（自拟）：人参、五味子、山萸肉各20g，麦冬50g，鹿茸15g，麝香1g。上药除麝香外，共研细末，瓶贮密封备

用。临用时先取麝香末 0.1g。纳入脐中，再取药末 10g，加入适量醋调和成团，涂于神阙穴，外以纱布盖上，胶布固定，3 天换药 1 次，10 次为 1 个疗程。

神阙穴是任脉的一个重要穴位，它能与全身经络相通，与脏腑相连，通过脐部受药物的刺激和吸收，激发经络之气，以疏通经络，调和气血，调整脏腑的阴阳平衡。神功经先散中人参、麦冬、五味子为生脉散，益气生精；山萸肉补益肝肾，固经止血；鹿茸补肾阳，益精血；麝香活血通经达络，有利于药物吸收，诸药合用，有补益肾气，固冲任，调经血之功。神阙穴贴敷，具有穴位刺激，激发经络之气作用，而且特定药物在特定部位吸收，发挥明显的药理作用。本法对脾气虚弱、肾气不固之月经先期，疗效较好。

四、调泌穴针刺 平衡内分泌

韩华明采用调泌穴为主治疗月经先期，疗效独特。

取穴：①调泌穴：肾腺 2（第二腰椎棘突下，旁开 2 寸）、胸腺（胸部正中线中间长约 1 寸）、松果（神垂下 1 寸）、垂体（神垂下 1 寸）。

②常规穴：实热型：关元、气海、太冲、曲池、隐白；虚热型：三阴交、足三里、脾俞、关元俞；郁热型：肝俞、大椎、内关、太冲、地机、曲池、阳陵泉。

操作：上穴可交替使用。实热型：多用泻法，施以提捻术，重刺激；虚热型：多用补法，加以艾灸，施以捻转术、搓针术，中等刺激，不留针；郁热型：多用泻法，施提捻术，中等刺激，不留针或留针 30min。

患者，徐某，女性，42 岁，职工。因月经不调 3 年，于 2000 年 4 月 25 日初诊。病史：患者 3 年前不明原因出现月经提前来潮 1 周以上，经量少，经色正常。饮食二便正常，余无不适。诊见：患者发育正常，营养佳，面呈常色，四肢活动自如，肌肤润泽，弹性好，自述每月经来提前 7~8 天，经量少，经色红，质稠黏，手足心热，舌红苔少，脉细数。诊断：经早，属虚热型。施治方法如前文虚热型所述。疗效：每天针 1 次。针 3 次后，月经来潮比上月推迟了 2 天，减少了 5 天，行经 4 天。后随访，自针后行经正常，未再提前

来潮。

五、针灸并用 益气补血

月经后期是妇科常见病，中医辨证其病因主要为气滞、寒凝、气血亏虚。徐云虹针灸并用治疗本病疗效明显。

取穴：三阴交、足三里、太冲、合谷（均为双侧取穴）。艾条灸至阴穴（双侧取穴）。

操作：患者仰卧位，三阴交、足三里、太冲、合谷，常规消毒，针刺得气后，施行提插捻转，留针 30min；针刺后患者可取坐位，用艾条灸至阴穴，取小趾甲根外侧角 1 分许，施灸艾条距穴位约 3~5cm，每侧灸 15min 左右。隔日针灸 1 次，连续 3 次为 1 个疗程。

三阴交属足太阴脾经，是脾、肾、肝三阴经之交会穴，月经失调常与肝气郁滞、脾虚生化不足、肾气亏虚相关，三阴交是妇科常用穴；足三里为足阳明胃经之合穴，与足太阴脾经相表里，为补益气血强壮之要穴。合谷为手阳明大肠经之原穴，具有行气引血下行、催产作用；太冲为足厥阴肝经之原穴，肝主藏血、主疏泄气机，血病多从肝治，针刺太冲具有疏肝理气、理血通络功效。至阴穴属足太阳膀胱经之井穴，是催产导胎之经验穴，《本草从新》指出“艾叶苦辛，生温熟热，纯阳之性，能回垂绝之元阳，通十二经，走三阴，理气逐寒湿，暖子宫”，故用艾条熏灸至阴，能温通经脉、催产导胎、引血下达。诸穴合用、针灸并举，有通调气血、行气活血作用。

胡某，女，35 岁，已婚，干部。1998 年 7 月 2 日初诊。述经期多延后，常间月 1 次，本次月经已延期 1 月未至。经 B 超、尿妊娠试验检查，排除早孕。患者面色晦滞，颜面有黄褐斑，少腹时有胀痛感，舌质暗红边有瘀点，苔薄白，脉略弦。诊断为月经后期，证属气滞血瘀、阴血亏虚。按上述方法治疗，针灸后第 3 天月经来潮。此后随访一年半，月经基本正常。

六、随证取穴 耳穴压豆

胡明珠以耳穴压豆治疗气滞型月经后期，疗效满意。

取穴：主穴：肝、神门、脾、子宫、卵巢、内分泌。随症取穴：

伴肾虚腰膝酸软者加肾，腰痛者加腹，头晕失眠者加神经衰弱点、额及枕。

操作：75%酒精常规消毒耳穴皮肤，然后用0.5cm×0.5cm胶布将王不留行籽固定于耳穴上，按压每天6次，每次2~3min，双耳交替贴压，隔日1次，15次为1个疗程。

《灵枢·口问》云：“耳者，宗脉之所聚也”，在十二经循行中，经脉都直接或间接与耳有联系，故刺激耳穴能够调节十二经脉及与其有联系的脏腑器官的功能。气滞型月经后期病在肝，当以治气为主，佐以养血活血。耳穴肝、神门疏肝理气调神；脾以养血扶脾；子宫调理子宫气血，行气活血。内分泌、卵巢，能调节月经，加强治疗作用。

患者，26岁，已婚，1993年3月6日就诊。月经延后2年，量少有块，颜色紫黯，小腹胀痛，且平素郁郁不乐，胁腹窜痛，舌质暗红苔白，脉弦，诊为肝郁气滞型月经后期。用上述方法治疗1个疗程，月经周期基本正常，伴随症状明显减轻，又治疗1个疗程，月经周期完全恢复正常，伴随症状消失而痊愈，半年后随访未复发。

七、药针并用，疏肝补肾

月经先后无定期在于气血失调而导致血海蓄溢失常，多由肝气郁滞或肾气虚衰所致。《景岳全书·妇人规》曰：“凡欲念不遂，沉思积郁，心脾气结，致伤冲任之源，而肾气日消，轻则或早或退，重则渐成枯闭。”冯梦阳采用针药并用治疗本病，疗效显著。

取穴：气海、脾俞、三阴交、足三里。

操作：平补平泻手法，留针10~15min，每天1次。连续治疗15天为1个疗程。如服药期间月经来潮，则停用针药，月经净后第三天，再行下1个疗程。

中药：定经汤加减：当归、柴胡、郁金、白芍、白术、菟丝子、熟地。随症加减：胸胁、乳房及少腹胀痛者，加川楝子；腹胀纳差者，加砂仁、焦三仙；头晕耳鸣者，加杜仲、川断；心悸失眠者，加龙眼肉、远志；腰骶疼痛者，加桑寄生；四肢关节疼痛者，加秦艽、防己。于月经净后3天开始服药，每天1剂，水煎服。

方中当归、白芍柔肝养血调经，柴胡、香附、郁金疏肝解郁，

白术健脾和中，菟丝子、熟地补肾而益精血。气海为任脉经穴，可疏肝健脾，脾气旺盛则血有所统；足三里、脾俞扶助中焦而资气血生化之源。针药结合，共奏疏肝健脾、补肾调经之功，临床用之效果显著。

黄某，25岁，1996年6月初诊。经来无规律半年余。上次月经延迟11日，量少，无腹痛，3天而止。隔2周月经复行，伴胸闷，两胁不适，腹胀纳差，脉虚细而弦，舌淡红，苔薄白。妇科检查无器质性病变，子宫及双侧附件B超检查未见异常。生育史：孕4产1人流3。证属肝郁脾虚，气血不调。治以舒肝解郁，健脾调经。方用基础方加砂仁、焦三仙，配针气海、脾俞、三阴交、足三里。治疗15天，停药1周后月经来潮，量偏多，质红色淡，伴纳差，五心烦热，舌质红，苔薄黄，脉虚细而数。复诊时认为患者因多产伤肾，水不涵木，肝郁化火，阴虚内热。故治以固肾舒肝理气，健脾养血清热。药用当归、柴胡、香附、郁金、白芍、菟丝子、山萸肉、青蒿、玄参，针灸配穴同上。第二疗程后月经如期而至，伴随症状消失，又巩固治疗10天停药。后经随访，无特殊不适。

八、取隐白 子午流注施灸

黄琦芬用子午流注灸法治疗月经过多，疗效满意。

取穴：隐白。

操作：施灸时间定于巳时（上午9~11点）进行。施灸前，先用75%酒精棉球消毒后，涂上凡士林软膏，然后置放米粒大的塔形艾炷，连续点燃5壮为一次量，3次为1个疗程。

《素问·八正神明》指出：“法天则地，合以天光，凡刺之法，必候日月星辰，四时八正之气……是以因天时而调气血也。”说明针刺需把人的气血与日月四季气候的关系直接联系起来。用时间疗法，选择最佳时机，在巳时灸治，乃脾经主时，正当气血流注至脾经旺盛之时，以利促进脾气旺盛而统血，月经调和，则病痊愈。施用温热灸，符合久病多虚，阴盛阳虚，阳气衰微，气不足以摄血，导致血离经妄行，气为血帅、脾气虚则不统血，血不归经则外溢，灸法可振奋脾气而统血，血统而经自调。取脾经的井穴，脾是生血统血之脏器。张景岳说：“血者水谷之精气也，源源而来，而实生于脾。”

脾的功能失调，统血无权，致使血不归经外溢，故采用灸脾经井穴（隐白）以统血，血得统月经自然调和。

九、针刺调冲任 补肝肾

祖国医学认为：冲为血海，任主胞胎，脾统血，肝藏血，肾主生殖发育，凡此种与月经生理系统相关者均可影响正常月经。月经血量过多属标；肝、脾、肾三脏功能失常及冲、任二脉功能失调为本。故治疗本病重在经期治疗，从补肾、健脾、疏肝、调理冲任入手，以治其本。由于肾系胞宫，内寓天癸，因此治肾尤为重要。张鷟采用针刺疗法治疗本病，疗效满意。

取穴：气虚型：以足少阴肾经经穴、背俞穴、任脉经穴为主，如太溪、命门、肾俞、关元、气海等，毫针刺用补法；血热型：①实证型：以手阳明大肠经及足太阴脾经经穴为主，常用穴有曲池、血海、膈俞等，毫针刺用泻法。②虚证型：加太溪、太冲、三阴交；气滞血瘀型：以足厥阴肝经经穴为主，取太冲、血海、中极等，用泻法。

操作：针刺手法采取提插补泻、捻转补泻方法，下腹部要求针感达会阴部。针刺每天1次，10天为1个疗程，于行经第五天开始治疗。

行经期间月经量多者，以急则治其标的原则以止血为先，取肝、脾、肾三经的郄穴及三阴交、膈俞等；经间期反复出血，淋漓不断者，重在益肾固精，疏肝理气；伴有明显的贫血体征者配以足阳明胃经经穴，因脾胃为后天之本，气血生化之源。

十、穴位注射 益气摄血

月经的产生和肾气、肾精的充盛，肝的疏泄与调节，脾的生化与统摄功能有密切关系。月经失调多由肝脾肾三脏功能失常，尤以脾之升提固涩、益气摄血功能失常为主。张继采用穴注治疗本病，疗效明显。

取穴：血海、三阴交（双侧）。

操作：嘱患者取坐位或卧位，取血海、三阴交。常规消毒，用2ml注射器，6号针头，抽取止血敏注射液2ml（0.25g），穴位进针

后小幅度提插得气，得气后针感向上传导，以传至会阴部效果更好。血海穴注射 0.5ml，三阴交穴注射 1.5ml，快速出针，压迫针孔片刻。每天 1 次，次日取对侧穴位。连续治疗 3 次为 1 个疗程，一般治疗 1~2 个疗程。

出血过多可导致脱证，需急用塞流之法，故选用足太阴脾经穴位，血海穴可调血泻热，主治月经不调；三阴交穴为足三阴经交会穴，能益气健脾、疏肝补肾。二穴合用具有肝脾肾三脏同治之功。止血敏为常用止血药，穴位注射能发挥针刺、药物双重作用，提高疗效，故能取得满意的止血效果。待病势缓和，再辨证运用澄源、复旧之法以固根本。

参 考 文 献

- [1] 黄丽, 卢琰. 腹针治疗月经不调 78 例. 光明中医, 2005, 20 (6): 55
- [2] 陈美仁. 阴中隐阳针法治疗月经不调 120 例. 湖南中医杂志, 2005, 21 (1): 46~47
- [3] 庞保珍, 赵焕云. 神功经先散贴脐治疗月经先期 126 例. 陕西中医, 1997, 18 (6): 269
- [4] 韩华明, 韩增平, 韩兰平. 针刺调节内分泌治各科疾病. 中国科技技术大学出版社, 2004, 3: 266~267
- [5] 徐云虹. 针灸治疗月经后期 36 例. 四川中医, 2001, 19 (5): 72
- [6] 胡明珠. 耳穴压豆治疗气滞型月经后期 100 例. 山东中医杂志, 1997, 16 (3): 118~119
- [7] 冯梦阳, 任永忠, 等. 针药并用治疗月经先后无定期 74 例. 国医论坛, 2000, 15 (5): 35
- [8] 黄琦芬, 黄建章. 子午流注灸治月经过多 25 例. 上海针灸杂志, 2005, 24 (11): 5
- [9] 张鸥, 吴兆利, 张丽. 针刺对置宫内节育器妇女月经血量的调整作用, 辽宁中医药, 1997, 24 (12): 563~564
- [10] 张继, 龚建明. 穴位注射止血敏治疗月经过多 30 例. 上海针灸杂志, 1997, 13 (5): 32

【子宫内膜异位症】

子宫内膜异位症是妇科的一种常见病、多发病，以渐进性痛经、不孕、月经失调及局部结节或包块为主要表现。本病在祖国医学中大抵属于痛经、不孕等疾病范畴。

子宫内膜异位症之痛经、盆腔肿块、月经异常三大主要症状与中医痛经、癥瘕密切相关。本病形成多因经期或产后性生活不节，导致冲任损伤及胞宫的藏泻功能异常。月经期经血虽有所泻，但不循常道而行，部分经血不能正常排出体外而逆行，以致离经之血蓄积，流注经脉、脏腑，形成子宫内膜异位症。本病辨证实证多见，多由气滞、血瘀、寒凝、热伤所致。治疗则据其证而治之，或行气活血，或散寒温通，或清热通经。

该篇共收录了3位针灸医家的临床治验，有的采用七厘散敷贴，活血化瘀；有的采用药饼灸结合水针；有的采有针药并用，调补冲任等，对该病均有一定的缓解作用。

一、七厘散敷贴 活血化瘀

子宫内膜异位症是子宫内膜组织生长在子宫内膜功能层以外的部位，以剧烈痛经、腰骶痛、排便痛，并有月经不调、不孕及盆腔包块为特征。汪慧敏选用七厘散用于人体神阙穴，

并加艾条灸，治疗临床分型为 I 期的子宫内膜异位症患者，疗效理想。

操作：取七厘散 1g 用少量黄酒调和，敷贴于患者神阙穴，用艾条灸 20min，用麝香止痛膏外贴（皮肤敏感者用肤疾宁外贴），48h 更换 1 次，3 次治疗后让患者自己操作治疗。每次月经干净后第十天开始治疗，到第二次月经干净时结束，治疗 2 个月为 1 个疗程。

子宫内膜异位证属于中医的血瘀证，故活血化瘀是其治疗大法。中成药七厘散出自清代《良方集腋》，由血竭、没药、乳香、红花、儿茶、朱砂、麝香（本治疗中不用，该药除去）、冰片组成，为临床活血化瘀、止痛消肿卓有成效的著名方剂；广泛用于跌仆外伤和妇科血瘀等证。本方药物多属树脂类，具有量少而效著之特点，着重活血止痛。

药物经皮肤进入体内的主要屏障即表皮中的角质层，神阙穴在脐中央，为腹壁的最后闭合处，此处皮肤与全身皮肤结构相比较而言，其表皮角质层最薄，屏障功能最弱，药物易于穿透；而且通过穴位刺激可发挥激发经气，调节脏腑气血功能，从两个途径产生治疗作用。

二、药饼灸配水针 温通经络

阮继源采用隔药饼灸配合水针治疗子宫内膜异位症，有较好的临床效果。

隔药饼灸：附子、肉桂、鹿角霜、乳香、五灵脂按一定比例混合打成细粉，用时用黄酒调和，制成厚 0.4cm，直径 2cm 的药饼，置艾绒于药饼上，再放在关元、次髂、子宫穴上，每次灸其中 1 个穴位。隔天灸 1 次，每次灸 3 壮。

水针治疗：取足三里、血海、次髂、三阴交两组穴位，隔天交替一组一侧穴位，每穴注射复方丹参注射液 2ml，共 4ml。

以上均以 2 个月为 1 个疗程，观察 2~5 个疗程。

子宫内膜异位症病变位置基本局限在盆腔，是盆腔瘀血阻滞所致。故改善盆腔血液循环是治疗本病的关键。灸能温通经络、气血，活血化瘀，并能提高免疫功能，改善内分泌功能。隔药饼灸除具备一般灸的作用外，还能通过皮肤组织对药物吸收发挥药理效应。本

疗法用药均为温阳活血化瘀类药。能促进盆腔血液循环。关元、子宫深部为子宫位置所在，次髂为第二骶后孔，骶骨前面为盆腔，这些穴位均接近盆腔。隔药饼灸时热力透过药饼传导到穴位上皮肤及深部组织，使局部温度升高。血液循环加速，故直接改善了盆腔血液循环。这种局部作用的效果是一般活血化瘀药物所无法达到的。关元、次髂等穴能治疗泌尿生殖系统疾病，通过穴位刺激及经络调整达到治疗作用；此外，丹参注射液活血化瘀，足三里、三阴交、血海、次髂协调肝、脾、肾，正切合子宫内膜异位症瘀阻胞宫之病机。

三、补肾化浊 针药并用

付于在临床上应用针灸加中药治疗子宫内膜异位症，临床疗效理想。

取穴：三角灸、中极、八髂、三阴交（双）。

操作：三角灸用清艾条施行温和灸 20 ~ 30min，热力以患者能耐受为度；中极直刺 1.5 ~ 2.5 寸，施捻转泻法，留针 15 ~ 20min，每隔 5min 运针 1min；八髂穴先用温灸盒罩在穴区上施灸 20 ~ 30min，然后用梅花针中等力度点叩穴区，使局部皮肤针孔有少量出血；三阴交直刺 1.5 ~ 2 寸，行捻转补法，留针 15 ~ 20min，每隔 5min 运针 1min。每于月经前 9 天开始针灸，经期停针。

中药：柴胡、白芍、皂刺、鳖甲、五灵脂、当归、桃仁、肉苁蓉、黄精、香附各 10g，鸡血藤 30g，小茴香、艾叶各 5g。中药连续服用 3 个月经周期，经期去鸡血藤继续服用。

子宫内膜异位症是指具有生长功能的子宫内膜组织出现在子宫腔被覆黏膜以外的身体其他部位。中医学无此病名，多将其归属为痛经、不孕等范畴。其病机以气滞血瘀为主。付于以温阳活血、调补冲任为治疗大法。治疗中针药并用，其中肉苁蓉、小茴香、艾叶温经止痛；鸡血藤、五灵脂、皂刺、鳖甲活血化瘀，软坚散结；柴胡、白芍、当归、桃仁、黄精、香附调补冲任，理气止痛。同时运用针灸治疗，以三角灸为主穴，运用灸法温经暖宫，破瘀止痛；中极、八髂、三阴交（双）为辅穴，散瘀通经，调补冲任。针药并用，共奏温阳活血，调补冲任之功。

参考文献

- [1] 汪慧敏, 王幸儿. 七厘散穴位敷贴治疗子宫内膜异位症的临床观察. 上海针灸杂志, 2003, 22 (4): 24~25
- [2] 阮继源, 汪慧敏. 隔药饼灸配合穴位注射治疗子宫内膜异位症 46 例. 实用中医药杂志, 2001, 17 (3): 19
- [3] 付于, 夏天. 针药并用治疗子宫内膜异位症的临床观察. 上海针灸杂志, 2005, 24 (3): 3~5

【内分泌失调性不孕症】

不孕症是指夫妻同居2年，排除避孕因素及男性因素而未生育的疾病。中医历代对之颇为重视，有关论述很多。如《内经》云：“女子七岁，肾气盛，齿更发长；二七天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。”指出女子孕育与肾气充盛有关。

中医认为不孕之原因主要为肾、肝、脾虚损及气滞血瘀、痰湿阻滞、寒凝胞脉等，可单独为患，也可相兼为病，如肾虚肝郁、寒凝血瘀、湿热内阻等。其病理变化大多表现为月经不调，故有调经种子之说。总之，女性不孕，注重肾气，又侧重于血。其治疗亦应治本为主，兼以治标。在补肾气、养血调和的基础上酌情论治，气滞血瘀者行气活血，痰湿阻滞者健脾化痰。

该篇共收录了20位针灸医家的临床治验，有的采用针药结合，调理肝脾肾；有的针刺配合中药分期治疗；有的采用穴位注射，标本兼顾；有的采用雷火灸，活血化瘀、通络；有的独取子宫穴，温针灸；有的采用针、药、罐、灸，综合治疗等，其临床疗效理想。

一、针药结合 调理肝脾肾

谢珍运用《傅青主女科》保产催生的保产

无忧散加入补肾药物配合针刺治疗卵泡发育不良而致不孕者，效果颇为满意。

取穴：关元、中极、三阴交（双侧）、子宫（双侧）、太溪、太冲穴。

操作：在B超监测下卵泡已达到成熟标准未破裂时针刺，每日1次，连续4天。针刺腹部穴位时针尖斜向下，穴位局部出现酸、麻、胀、重感后中强刺激留针20min。

中药：酒炒当归25g，厚朴10g，羌活6g，川贝母10g，赤芍15g，荆芥穗10g，川芎10g，艾叶10g，枳壳12g，黄芪20g，菟丝子25g，枸杞子12g，女贞子12g，淫羊藿12g，甘草6g。每日1剂，水煎分早晚2次服，连服20天。月经周期第五天开始服用（闭经或月经周期紊乱者，在用中药或黄体酮治疗后，从阴道出血第五天开始服用，3个月经周期为1个疗程。

不孕症是临床常见病，影响因素颇多，其中因无排卵而致不孕者占27.0%。祖国医学认为冲任二脉为经络之海，元气之所由生，真息之所由起，而女子尤赖此任养，若非任脉盛，则冲脉血不旺难以有孕。肾为冲任之本，肾精与冲任气血息息相关，只有肾的精气足才能任通冲盛，方可有子。故在治疗上用菟丝子补肾益精，佐枸杞子、女贞子、淫羊藿以增强补肝肾精血之力，配当归、赤芍、川芎养血活血，以黄芪、甘草补气，选荆芥、羌活泻肝经气血之郁以治滞，艾叶暖胞宫以治寒，虚极者可加人参以治虚。诸药合用共奏气血双补、温中散寒、通郁开滞、冲盛任通之效。配针刺肝、脾、肾、任脉穴以补肝肾、调冲任、健脾阳、温胞宫、疏通经脉，使肝脾肾脏腑气血功能正常，增强摄精受孕之功能。

二、针刺配中药 分期治疗

多囊卵巢综合征是育龄妇女常见的内分泌紊乱性疾病，其临床症状主要表现为月经紊乱（稀发或闭经）、不孕、多毛、肥胖等。患者往往因月经不调、不孕就医。王珍萍采用补肾化痰中药和针灸治疗，疗效较好。

取穴：膈俞、脾俞、肝俞、肾俞、中脘、气海、关元、子宫、大赫、归来、血海、足三里、三阴交。

操作：膈俞、脾俞、肝俞、肾俞、中脘、气海、关元针刺用补法；关元、子宫加灸。其余穴位用平补平泻法。每个穴位留针30min，每10min行针1次。每日1次，6次为1个疗程，疗程间休息1天后再进行下1个疗程。

中药：基本方：补肾化痰方由菟丝子、川断、巴戟天、仙灵脾、石菖蒲、半夏、胆南星、夏枯草、当归、川芎、丹参、益母草等组成。

经后期（月经5~10天）以滋补肾阴、调补冲任为主，方中酌加二至丸、首乌等滋阴补血之品。

排卵期（月经11~14天）方中酌加助阳调气活血之品，如香附、赤药、鸡血藤等。

排卵后期（月经15~24天），酌加补阳之品，如艾叶、小茴、桂枝等。

经前期（月经25~30天），以通经引血下行为主，方中加活血调经之品，如桃仁、泽兰、红花、牛膝等。

根据该病的临床表现多归属于中医的月经不调、闭经、不孕、癥瘕的范畴。中医认为，女子月经与肾密切相关。《素问·上古天真论》指出：“女子七岁肾气盛，齿更发长，二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下……”。说明月经的产生是肾气—天癸—冲任—胞宫协同作用的结果。肾为先天之本，元气之根，藏精、主生殖，开窍于二阴。月经出现周期性藏泻，是肾阴阳、气血盈亏与变化的结果。经后期血海空虚，肾阴增长，阴中有阳，表现为藏而不泻；经间期，是肾阴精发展到由阴转阳的转化时期；经前期，是肾阳增长，阳中有阴，阴阳平衡中肾阳的功能渐趋充旺；行经期，是重阳则开阶段，在阳气的转化中推动经血的排出，子宫表现为泻而不藏，除旧生新。

同时肾为水脏，主管一身之癸水。若肾气不足，气化失司，水液代谢失常，湿聚成痰，痰浊阻滞冲任脉络，故而产生月经失调、闭经、肥胖等症。故治疗多以补肾化痰祛瘀为法。而补肾是最关键的，通过补肾，可调节生殖的功能，促使经血调顺，冲任血海蓄出有度。同时，肾的功能正常可使水液代谢调畅，湿去痰化，气血和顺，使肾—天癸—冲任—胞宫间的阴阳趋于平衡。

本病除肾虚外，常兼有痰阻血瘀之象。所以，治疗时必须配合化痰祛瘀之法。王珍萍所拟基本方中，菟丝子、川断、巴戟天、仙灵脾补肾固本，调节冲任；石菖蒲、半夏、胆南星、夏枯草化痰散结；当归、川芎、丹参、益母草活血化瘀。配合针灸治疗，能激活全身经气，良性调节患者的神经内分泌功能。与中药配合，相得益彰，故而效果满意。

三、补肾化浊 药针并用

不孕症中约 20% 与免疫因素有关，目前治疗本病尚无令人满意的方法。张继红采用补肾化浊法药针并用进行治疗，疗效满意。

取穴：肾俞、关元、命门、三阴交、足三里、丰隆、阴陵泉。

操作：常规消毒穴位皮肤，肾俞用 1.5~2 寸毫针，呈 45° 角向督脉方向斜刺，针深约 1~1.5 寸，施捻转补法；命门视病人胖瘦，可选长度 1.5~3 寸的毫针，直刺或稍向上斜刺，针深约 1.5~3 寸不等，施捻转补法；关元用 1.5~2 寸毫针，垂直进针约 2 寸，施提插或捻转补法，患者自觉小腹部有酸胀感或热感；三阴交、足三里用 1.5 寸毫针直刺约 1 寸，施平补平泻；丰隆、阴陵泉用 1.5 寸毫针直刺约 1 寸，施提插或捻转泻法。治疗每日 1 次，10 天为 1 个疗程，疗程间休息 23 天。1 个月为 1 个疗程。

中药：用菟丝子、枸杞子、淫羊藿、泽泻、金银花、紫花地丁、丹皮、牛膝各 10g，薏苡仁 20g，车前子 30g，黄柏 5g。用法：每日 1 剂，水煎 2 次，取汁 300~500ml，分 2 次服。经期停服。

免疫功能异常增高为肾精亏虚，免疫性不孕为免疫异常增高所致。肾精亏虚为本，湿热浊邪为标，方中菟丝子、枸杞子、淫羊藿甘润补肾；薏苡仁、泽泻、黄柏泄肾燥湿而坚阴；车前子甘寒滑窍；金银花、紫花地丁清热解毒；丹皮、牛膝疏利冲任。肾俞、关元、命门三穴合用，可滋养先天，补益肾气，扶正培元，调动机体的抗病能力，提高机体的免疫能力；三阴交为足三阴经交会穴，可调理阴血；足三里补益气血，为强壮要穴；丰隆、阴陵泉化湿泻浊，标本兼治。

四、辨证分型 针药合用

无排卵不孕症是女性不孕的主要原因之一，占女性不孕症的25%~30%。这类患者大多表现为久不受孕，月经延后、稀发，多毛，肥胖，甚至闭经。李文英自拟补肾排卵汤为主加电针治疗无排卵不孕症，疗效较好。

(1) 辨证分型

肾虚肝郁型：月经延后，或先后不定，经行不畅，量少，色紫黑，有血块，经来腹痛，经前烦躁，腰膝酸软，舌黯淡有紫点，脉弦。

肾虚脾弱型：经行量多，或淋漓不尽，色淡，全身倦怠，乏力，失眠多梦，腰膝酸软，便溏，舌淡胖嫩，脉沉无力。

肾虚宫寒型：婚久不孕，月经延后，量少，或月经稀发，闭经，体胖，腰酸腿软，性欲淡漠，面色晦黯，畏寒肢冷，蜷卧，舌淡苔白，脉沉细。

(2) 电针治疗

取中极、关元、子宫（双）、三阴交（双），采用音频电疗机，于月经第12天起每日电针1次，共5天，刺激强度频率3Hz，电流5mA以内，连续30min平补平泻。3个月为1个疗程。

(3) 中药

基本方：鹿茸（冲服）2g，淫羊藿10g，女贞子15g，墨旱莲15g，枸杞子15g，菟丝子15g，山药30g，丹参30g，制龟版（冲服）6g等。

肾虚肝郁型：补肾排卵汤加川楝子10g，制香附15g，当归30g，川芎12g。若双乳胀甚加柴胡10g，橘核10g；小腹胀加小茴香10g，失笑散。每日1剂，水煎分2次服。若月经延迟或闭经者，除外早孕，月经来潮可服用。

肾虚脾弱型：补肾排卵汤加党参30g，黄芪15g，黄精10g，熟地黄10g，枸杞子12g。经量多加仙鹤草15g，炒地榆10g，海螵蛸10g；失眠多梦加夜交藤15g，茯苓30g，灯心草6g；便溏加炒扁豆10g，木香5g；纳呆加鸡内金30g，焦山楂15g。每日1剂，水煎分2次服。

肾虚宫寒型：此型患者多数未行经，除外早孕。方用补肾排卵汤加紫石英 6g，附子（先煎）6g，当归 30g，艾叶 6g。经量少加红花 15g，桃仁 10g，益母草 30g；畏寒较甚加吴茱萸 10g，肉桂 6g。日 1 剂，水煎分 2 次服。

受孕是一个比较复杂的生理过程，而排卵是生育的必要条件。中医学认为，无排卵性不孕症与肾虚有关。肾为先天之本，元气之根，藏精主胞胎主生殖。禀赋不足，肾气亏损，冲任虚寒，胞脉失养，不能摄精成孕。补肾排卵汤中鹿茸、淫羊藿、菟丝子以补肾阳，益精血为主；女贞子、墨旱莲、枸杞子、龟板以滋补肾阴、清热为主；山药加强补肾之功，并能益气健脾；丹参活血化瘀，善调妇女经脉不均，真正遵循了“善补阳者，必阴中求阳，阳得阴助则生化无穷。善补阴者，必阳中求阴，阴得阳助则泉源不竭”。故诸药合用起到补肾而不膩之功效，有补肾益精，促进排卵之作用。排卵期配合针刺，更能增加补肾精、调冲任、养胞宫之功能，以达调整机体阴阳气血平衡，使天癸及冲任功能正常，恢复正常排卵，与中药促排卵有协调作用。

五、穴位注射 标本兼顾

李莲华根据中医理论，采用当归、黄芪及胎盘组织液穴位疗法治疗女性不孕症，疗效显著。

取穴：治疗穴：子宫、关元、气海、八髎。扶正：肝俞、肾俞、脾俞、足三里、阴陵泉、三阴交、太溪。

药物：当归、黄芪、胎盘组织液。

操作：治疗穴用胎盘组织液 4ml 穴位注射，扶正穴用当归、黄芪各 2ml 穴位注射，治疗穴与扶正穴交替注射，每日 1 次，按月经周期为 1 个疗程。

当归性温，味甘、辛，能补血活血、调经止痛、润燥滑肠。当归有促进子宫增生作用。黄芪性微温，味甘，能补气固表，有强心、利尿、降血压、止汗及促性激素作用。用当归、黄芪穴位注射旨在鼓舞正气，提高机体的免疫功能，活血化瘀、补气通络，改善盆腔供血。胎盘组织液是从人体胎盘中提取的一种有效成分，它有调节内分泌的作用，促进子宫和卵巢发育，使子宫和卵巢的功能正常，

以至于卵泡发育成熟，正常排卵，同时还有调节黄体功能的作用。

肝俞藏血，肾俞造血，脾俞统血，足三里是全身强壮穴，阴陵泉、三阴交和太溪是平衡穴，关元、气海为任脉穴，任脉穴能调节诸阴经之气，有保养胎儿的作用，八髋、子宫为治疗女性生殖系统疾病的经验穴。诸穴合用通过针刺和药液对穴位刺激及药理作用达到治疗的作用。

六、主穴三个 电针治疗

韦伟采用电针法促使已发育成熟的卵泡破裂至排卵，疗效较好。

取穴：主穴取关元、中极、子宫。配穴取三阴交，肥胖加次髋，肾虚加肾俞。

操作：患者平卧位，选用30号2~2.5寸毫针刺入关元、中极、子宫（针尖斜向内下方），根据患者体质及肥胖程度进针0.8~1.5寸，提插捻转手法，使针感下传向外阴部放散，得气后接上D-8605电针仪30min，用断续波，电流强度尽量加大至患者能忍受刺激量为宜。三阴交针尖稍向上刺，使针感上传，得气后留针30min。次髋行快针，强刺激不留针，如能次髋透中下髋效果更佳。肾俞直刺，强刺激不留针，每日1次或每日2次。针后数小时行B超检查见已排卵即停。

中医认为不孕与肾关系密切，并与冲任两经病变或脏腑气血不和影响胞脉功能有关，电针取穴以下腹部和骶骨部接近盆腔脏器穴位为主，以泻法，活血祛瘀，疏通经脉，调理冲任为治疗原则，穴中关元，中极都是任脉要穴，而冲脉起于关元之下，任脉又起于中极之下，针刺此两穴可启动或加速冲任两脉之气血运行。另外此两穴又是任脉与肝脾肾足三阴之交会，故针之可调补肝脾肾三经气血，并将其引入冲任脉。子宫穴为经外奇穴，主治妇人久无子嗣。三阴交为足三阴之交会，是妇科常用穴，有理气化瘀之功，与上诸穴相配可温补下元真气，调和肝脾肾三脏。下元固，脏气和，则冲任通调，故能摄精成孕。电针促排卵不受年龄限制，也不受不孕是原发或继发的影响，故用电针促排卵并在B超动态观察下了解排卵，实为治疗不孕症之重要辅助手段。

张某，32岁，1996年5月29日来诊。诊断：继发性不孕8年。

当时月经周期 14 天。患者于月经期 13 天在生殖健康科病房已肌内注射促排卵激素 1000U，目的是让卵泡破裂排卵，准备行人工受精，但至今用药已 27h，尚未排卵。B 超检查见：左右卵巢各有 $1.7\text{cm} \times 2.0\text{cm}$ 和 $1.8\text{cm} \times 2.2\text{cm}$ 发育成熟完整卵泡。给予电针关元、中极、子宫 30min，并强刺激三阴交、次髂透下髂。针后病人感腰腹酸胀，3h 后行 B 超检查发现左右卵泡已破裂排卵。

龚某，29 岁，1996 年 5 月 2 日下午就诊。妇科诊断：原发性不孕症 5 年。患者一向月经正常，但婚后 5 年未孕，来诊时正值月经第 13 天，B 超检查提示右侧卵巢见 $1.6\text{cm} \times 2.0\text{cm}$ 卵泡，要求针灸排卵。电针关元、中极、子宫 30min，强刺激三阴交、次髂、肾俞；次日上午再针 1 次后 B 超复查见卵泡破裂排卵。1 月后诉已怀孕。

七、雷火灸 活血化瘀通络

输卵管炎症性阻塞，是导致女性不孕主要原因之一。陈英秋采用雷火灸为主治疗输卵管炎症性阻塞，取得一定疗效。

取穴：主穴取神阙、关元、中极及两侧少腹部（也就是附件相应皮表部位），肾虚加肾俞，肝虚加肝俞、次髂、下髂、三阴交、太溪、输卵管足部反射区，病情严重配合四逆散加味。

操作：点燃雷火灸药顶端，对准应灸部位，距离皮肤 1 寸左右，施以回旋灸法，灸至皮肤发红，深部组织发热为度（避免烫伤），随时吹掉药灰，保持红火。主穴每穴灸 15min，两侧少腹部加用啄式灸法和按揉手法，配穴每穴灸 5min。每日 1 次，每次 1 支雷火灸药，经期停灸，1 个月为 1 个疗程。

输卵管炎症性阻塞的病人大多兼有经前乳房胀痛，精神抑郁，烦躁易怒，妇科检查附件明显增厚。此症相当于中医学的“胞脉闭阻”之证。治疗比较困难，治法常以行气活血，化瘀通络。雷火灸药力峻猛，渗透力强，具有活血化瘀，通络镇痛等功效，具有避免打针，开刀之痛苦，无不良反应的优点。因此，采用雷火灸治疗输卵管炎症阻塞，尤其患处相应体表部位以啄式灸法和按揉手法，能促进气血运行，使新陈代谢旺盛，有利组织吸收，从而加快炎症的吸收，加强治愈能力。

患者，30 岁，1998 年 4 月 14 日初诊。结婚 6 年习惯性流产 2 次

后不孕。月经周期规律4~5天/30天，血量中，偶见血块，腰部酸痛。碘油造影提示双侧输卵管通而不畅，不孕门诊诊断其继发不孕。采用上法治疗35次患者告知已经怀孕。

患者，25岁，会计，1998年9月4日初诊。结婚3年人工流产1次后不孕。月经周期5~7天/28天，痛经，经前乳房胀痛。碘油造影提示双侧输卵管伞端炎症粘连，通畅困难。患者饮食、二便正常，舌质暗红，舌苔薄白，脉弦细。治拟行气活血，化瘀通络。以雷火灸为主配合四逆散加味，共治68次告知怀孕了。预产期1999年8月8日。

八、灵龟八法配温和灸 通调任脉

赵彩娇运用灵龟八法治疗不孕症，获效满意。

灵龟八法：选用八脉交会穴中的照海穴，按灵龟八法定时开穴针刺。在每日开照海穴时进行治疗，并配用列缺穴。治疗时先针开穴，后针配穴，用1寸毫针快速进针，捻转得气后，留针30min，每10min行针1次。每日治疗1次，每周治疗5次，每月共治疗20次，2个月经周期为1个疗程。

温和灸：在患者留针的过程中配合温和灸。以关元穴为主，将点燃的艾条对准穴位，约距皮肤2~3cm，进行灸烤，以患者感觉温热舒适为宜，每次施灸时间约20min。每日治疗1次，每周治疗5次，每月共治疗20次，2个月经周期为1个疗程。施灸时要注意避风，否则适得其反。

同时注重精神调护，多跟患者沟通，增强患者信心，使其对医生有高度的信任感。

灵龟八法是针灸学的重要组成部分，又名奇经纳卦法，是运用古代的九宫八卦学说，结合人体奇经八脉气血的会合，取十二经脉与奇经八脉相通的八脉交会穴，按照日时干支的推演做出按时取穴的一种针刺疗法，是人天观、整体观在针灸学上的具体运用，是因时制宜原则的范例。本治疗中选用八脉交会穴中的照海穴为主穴，按灵龟八法定时开穴针刺，并配用列缺穴。

照海穴通阴跷脉，是阴跷脉气始发之处，阴跷脉在人体经脉中具有十分重要的作用，李时珍在《奇经八脉考》中说：“凡人有此

八脉，俱属阴神，闭而不开，惟神仙以阳气冲开，故能得道。八脉者，先天大道之根，一炁之祖，采之惟在阴跷为先。此脉才动，诸脉皆通”。可见，阴跷脉为奇经之总源，在照海穴开穴的时候针刺，通调了阴跷脉，从而实现了对其他奇经八脉的调节，而奇经八脉又对十二正经起着蓄灌调节的作用，故此经一调，则诸经皆通，达到对全身阴阳气血动态平衡的调节作用。同时照海又属足少阴肾经腧穴，肾藏精，主生殖。针刺照海穴还有直接调整足少阴肾经的作用，肾阳得补，使肾发挥其正常的功能，肾气盛，天癸至，则为受孕打下了基础。

列缺穴通任脉，任脉起于胞中，出于会阴，有任主胞胎之称，女子妊娠有赖其濡养，胚胎的正常发育有赖其充盈和坚固。故配用列缺穴针针刺通调了任脉的气血，有助于受孕。

同时，关元穴为任脉上的腧穴，温和灸关元穴可起到温补气血，通调任脉的作用。

因此，运用灵龟八法定时开照海配列缺穴针刺，并配合温和灸关元穴治疗肾阳虚型不孕症（排卵障碍），可获满意疗效。

刘某，女，29岁，于1999年9月29日初诊。诉1995年11月做药流致流产不全，12月再行清宫术，而后月经后期，每月推迟10余天，注射孕酮后稍好转，近1年来病情加重；月经间月而至，甚见3个月一行，经中药治疗未效，经期伴见经色黯红，有血块，腰腹冷痛。流产至今近4年夫妇正常同房未有怀孕。平素见畏寒，手脚冰凉，夜尿2~3次，体倦乏力，阴道欠湿润，性欲不强等。曾到区妇幼保健院就诊，经妇科检查、B超（子宫、附件）、子宫输卵管造影均未见明显异常，连续自测基础体温3个月，呈单相曲线，并经B超监测未见排卵。末次月经为1999年7月29日。舌淡胖，边有齿印，脉沉。诊断为继发性不孕（排卵障碍），证属肾阳虚型。拟温补肾阳、通调任脉为法。予灵龟八法定时开照海配列缺穴针刺，配合温和灸关元穴治疗。治疗20天后月经来潮，量、色均正常，无血块，伴腰酸冷感。再治疗1个月后月经按期而至，腰酸冷感明显减轻。畏寒、手脚冰凉、乏力、夜尿等症明显好转，阴道渐湿润，性欲好转。3个月经周期后临床症状基本消失，予每周治疗3次，再治2周共6次，放寒假暂停治疗。2000年2月中旬患者来电告之已

怀孕，嘱其注意保养，2000年11月剖腹产下一健康男婴。

凌某，女，35岁，于2005年6月9日初诊。诉结婚6年余，婚后前4年曾先后怀孕3次，但每次均在怀孕40余天时自然流产，最后1次流产时间为2002年10月。两年多来夫妇正常同居未避孕，但一直未再怀孕。并出现月经量逐渐减少，色黯，月经后期。平素见四肢冰凉，畏寒，腰酸腿软，神疲体乏，阴道干涩，分泌少，性欲淡漠等症。到省中西医结合医院就诊，经妇科检查、B超（子宫、附件）、子宫输卵管造影均未见明显异常，连续测量基础体温3个月，呈单相曲线并经B超监测未见排卵。末次月经时间为2005年6月3日。舌淡胖，苔白，脉沉。诊断为继发性不孕（排卵障碍），证属肾阳虚型。拟温补肾阳、通调任脉为法。予灵龟八法定时开照海配列缺穴针刺，配合温和灸关元穴等治疗。治疗10天后患者即感腰酸腿软、神疲体乏等症消失，四肢冰凉、畏寒等症明显好转，阴道分泌物接近正常，白带有黏性，性欲增强，自测量基础体温呈双相曲线趋势，指导夫妻掌握时机同房。2005年7月11日查尿HCG阳性。因患者曾有习惯性流产病史，故继续予上方治疗3个月。现怀孕6个月，随访患者胎儿发育正常。

九、内外结合 活血化瘀通络

输卵管阻塞是女性不孕症的重要发病原因之一。张梅香采用中西医结合方法治疗，效果颇佳。

穴位注射：取穴：归来穴，耻骨联合上缘1寸，前正中线旁开2寸（左右两穴）。药物：生理盐水20ml，盐酸洁霉素注射液1.2g（或注射用青霉素320万U），2%利多卡因2.5ml，醋酸泼尼松龙注射液适量。方法：嘱患者排空膀胱，仰卧，取穴后直刺，快速进针，待患者有针感后，回抽无血，将药物缓慢注入。每天1次，7~10天为1个疗程，每月治疗1个疗程。

中药内服：基本方：当归10g，川芎9g，赤芍12g，桃仁9g，红花9g，急性子9g，穿山甲10g，王不留行12g，路路通12g，白芷6g。随症加减：血瘀明显加制乳没各5g；肾虚加仙茅10g，仙灵脾10g；邪毒感染，腹痛拒按加虎杖12g，败酱草30g；附件增厚加昆布9g，海藻9g。10天为1个疗程。经期停服。

中药外敷：千年健 12g，钻地风 12g，透骨草 50g，当归 25g，川芎 12g，赤芍药 25g，血竭 12g，制乳香、制没药各 12g，白芷 25g，艾叶 100g，路路通 12g，羌独活各 12g，川断 12g，川椒 12g。共研粗末，加醋半斤拌匀，装入布袋，上笼干蒸 15min，趁热外敷下腹部，至药物不热为止。每日 1~2 次，10 天为 1 个疗程。经期停敷。

输卵管阻塞不孕约占女性不孕症的 70%~80%，其主要病因是慢性输卵管炎症。因炎症可导致输卵管管壁水肿、增厚，炎性渗出致管壁粘连，从而影响输卵管的通畅，妨碍精卵的正常运行，阻止了精卵结合以致不孕。

中医学中无输卵管阻塞病名，按其临床表现，散见于无子、癥瘕、带下等论述中，属少腹瘀血症。其主要病机是少腹瘀血阻滞胞宫，冲任不畅，胞络不通，而致不孕。故治疗应以活血化瘀通络为要。归来穴近子宫，善治女子疾患，可调气血，通经闭，使气血旺盛，子宫复原。张梅香以活血化瘀中药为主组方，内服兼以外用，以促进血行，消散瘀血；再兼以归来穴注射抗生素封闭，抗菌消炎，减少渗出，缓解粘连。同时，药液留于穴位局部，可刺激穴位，激发经气，起到消炎和针刺的双重作用。如此，中西结合，内外并治，使输卵管瘀血水肿得以消散，粘连得以缓解，胞络通畅，精卵运行无阻，自然结合而受孕。

十、三法同用 取长补短

李世玲采用中药内服外用，针灸及穴位注射，子宫输卵管通液三者相结合的疗法治疗输卵管阻塞性不孕症，取得了较满意的效果。

针灸：取天枢、水道、归来、气冲、大赫、横骨、志室、子宫、冲门。以上穴位若双侧输卵管不通取双侧穴位，若单侧不通取患侧穴位。手法均采用平补平泻法，得气后留针 30min。每日 1 次，10 次为 1 个疗程。若输卵管伞端粘连，取子宫穴用胎盘组织液或灯盏花注射液做穴位注射，每次每穴注射 1ml，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。每个月经周期可治疗 1~2 个疗程。

中药：柴胡 10g，赤白芍各 10g，穿山甲 10g_{冲服}，皂角刺 12g，路路通 15g，三棱 15g，莪术 20g，土鳖虫 10g，红藤 30g，败酱草 30g。附件增厚明显有炎性包块者加夏枯草 30g，牡蛎 30g；伴子宫内

膜异位症者加全蝎 10g_{冲服}，蜈蚣 3 条_{冲服}，黄芪 15g，知母 10g；输卵管积水加猪苓 10g，冬葵子 12g，泽泻 10g；输卵管结核加杏仁 10g，白及 15g，黑芝麻 15g；宫外孕术后加白头翁 30g。以上方剂每日 1 剂，分早晚水煎口服，第二煎余 50ml，晚间保留灌肠，10 剂为 1 个疗程。每个月经周期可治疗 1~2 个疗程。

通液：月经干净 3 天后行子宫输卵管通液。通液用药：脉络宁 20ml 加生理盐水 20ml 或复方丹参注射液 20ml 加生理盐水 20ml，每日 1 次，5 次为 1 个疗程，如通液时阴道有少量出血可口服止血药。

《内经》云：“女子二七天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子”。此中的任脉通可能与现代医学的输卵管通畅有关。故选方用药原则应是：理气、活血、化瘀、通脉。采用口服与灌肠相结合的给药方式，使药力直达病所。

输卵管炎症性阻塞是女性不孕的重要因素，约占女性不孕症的 29.7%。炎症不但可引起输卵管阻塞，还可引起输卵管与周围组织粘连、输卵管壁僵硬、输卵管疤痕挛缩使输卵管蠕动受影响，此时即使输卵管通畅，仍可影响精卵的结合和受精卵的输送。针灸可疏通经络，松解局部粘连，促使输卵管蠕动，促进精卵结合，进一步可防止宫外孕的发生。输卵管通液能起到药物和机械双重作用。

不孕症由于病程的特殊性，治疗过程往往漫长，患者容易产生急躁情绪。以上三种治疗方法相结合，能取长补短，更快更有效地发挥治疗作用，所以疗效较好。

陈某，29 岁，1993 年 3 月以结婚 2 年同居未避孕未孕为主诉入院，月经基本规律，但色黯、痛经。妇科检查：阴道通畅，有黄色分泌物；宫颈光滑；宫体前位，正常大小；附件：双侧增厚，压痛。经抗炎治疗后同年 4 月作子宫输卵管碘油造影提示双侧输卵管不通。入院后经用上述三联法治疗 3 个疗程后作输卵管通液时向宫腔注药 40ml，无返流，无阻力。6 月 15 日再次作输卵管碘油造影提示双侧输卵管通畅，痊愈出院。8 月份来诊时停经 43 天，尿妊娠试验阳性，于 1994 年 4 月 25 日足月顺产一健康男婴。

十一、独取子宫 温针灸

许淑琴试用温针灸子宫穴的办法，治疗女性不孕症，疗效

满意。

取穴：“子宫穴”的位置在中极穴旁开3寸，归来穴外1寸处。

施治时间：于月经干净后即可施术。

操作：取二侧子宫穴，直刺进针，深度为1.5~2寸。手法：平补平泻，待得气后（针感到达阴部为最佳效果）将事前准备好的艾条（2厘米为1炷），用镊子或直接用手，插在针柄上，用火柴点燃施灸。第一炷燃尽之后，用同样手法换第二炷至第三炷（阳虚宫冷、阴寒证盛者可至五炷），待艾条燃尽后除去灰烬，将针取出。每日1次，3天为1个疗程。第一疗程后观察3~6个月。无效时，可进行第二疗程。

用针灸子宫穴来治疗女性不孕症，理论基础可见于内经。在内经《素问·上古天真论》中就有“女子……二七天葵至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子……”的记载。也就是说，任脉通畅，气血充盛，月事应时而下是妇女受妊有子的三个基本要素。子宫穴虽是经外奇穴，但就古人立此穴并命名为子宫穴的意义上来看，实为胞宫的主要穴位，任脉又主胞胎，由此可断定“子宫穴”是任脉的主要经外奇穴。

针灸的治疗原理是通经络、导气血、调气机、因此温针灸子宫穴就是促使任脉的经气得以疏通，使气血宣畅、气机调达，进而收到任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故能有子的最佳效果。

杜某，女性，30岁。结婚后3年不孕，经矿某医院妇科检查子宫后倾，1991年6月就诊，月经基本正常，经温针灸子宫穴3次后受孕，生育1男婴。

王某，女性，24岁，售货员。婚后2年不孕。在家属催促下，于1993年5月就诊，患者自述，月经错后，量少有块，腹痛伴手足凉，小腹冷，白带多。经温针灸子宫穴，重灸（艾炷用至五炷）3次，于第二年夏，生育1女婴。

十二、分期取穴 药饼灸

不孕症是妇科常见病之一，王寿椿总结施延庆的临床经验，从肾入手，并结合月经周期气血阴阳的变化规律，采用药饼灸的方法治疗，获得满意的疗效。

经后期（增殖期）：约月经周期的5~14天，此期血海空虚，阴血亏损，卵泡正处于发育阶段，基础体温低温相在36.5℃左右，治疗着重滋肾养阴为主，促其血海逐渐充盈。取穴：关元、气海、肝俞、肾俞、三阴交。具体方法：药饼灸药料用肉桂、细辛、延胡索、白芥子，按10:6:8:6的比例研末，每次30g，用老姜汁调糊，做成五分硬币大、厚0.3cm的药饼，敷贴在穴位上，外用塑料薄膜覆盖，四周用胶布固定，敷贴1h后取掉薄膜、胶布，在药饼上用塔型艾炷（底圆直径1cm，高1.3cm）灸5壮，以少腹部有温热舒适感为度，如施灸时局部有烧灼感，用镊子提起药饼少许，灸毕后，局部涂少量绿药膏以防起泡。一般在月经干净后第二天开始治疗，腹、腰分两日施治1次。（方法下同）

经间期（排卵期）：正常排卵约在月经周期的14天左右，此期血海充盈，阴精盛而化阳，故此时带下偏多，以时有心烦、情绪易激动为特征，基础体温由低温相上升至高温相37℃左右。治疗以补肾助阳，促其排卵为重点。取穴：关元、子宫、肾俞、腰阳关、关元俞、三阴交。在本期开始前一天施治。

经前期（分泌期）：约在月经周期的15~28天，此期肾中阴阳相对平衡，排卵后的基础体温较前上升0.3~0.5℃。治疗当中滋阴护阳、暖宫待孕。在经间期治疗后的第七天施治，若经间期治疗1周内基础体温出现双相，取穴：气海、足三里。若基础体温仍单相，则仍按经间期取穴治疗。

经期（月经期）：约在月经周期的1~5天。此时胞宫冲任阴血充盈，满则溢下，此期一般不作治疗。如有痛经患者，可针刺气海、血海、次髎、三阴交，以活血调经止痛。

施延庆认为女子以血为用，冲任为血海，任主胞胎，冲任之本在于肾，肾气不足，冲任空虚，故难受孕，正如《圣济总录》曰：“妇人所以无子，由于冲任不足，肾气虚寒故也”。所以在治疗上将补肾暖宫贯穿整个过程，促使肾精充盛冲任相资而受孕。

关元为任脉与足三阴经之交会穴，气海为生气之海，有益肾填精，通调冲任之功，主“女子绝嗣无子”，“多灸令人生子”，肾俞为肾脉经气转输之处，与腰阳关、关元俞相合，增强补肾扶阳之力；子宫为奇穴，“妇人无子，灸三七壮”，为治不孕症之经验要穴，能

促使输卵管通畅；足三里为足阳明经之合穴；三阴交为足三阴经之交会穴，以补脾益肾，助生化气血之源。

肉桂、细辛、延胡索、白芥子研末敷贴，借助温阳走窜之性，药穴合用，加之艾灸温热的刺激，加速其药性的渗透，共奏滋益肾精，暖宫调经，促排卵受孕的功用。

袁某，女，36岁，工人。1991年5月10日就诊。病史：结婚8年未孕。患者形体瘦小，月经数月一行或不行，常用黄体酮等激素催经，月经量少，色淡，有少许血块，少腹冷痛，腰酸膝软。性欲淡漠，基础体温呈单相，舌淡体瘦，脉细小。妇科检查：子宫发育不良呈三棱形。右卵巢囊肿，两侧输卵管通而不畅。诊为原发性不孕，经中西医多方治疗未孕，证属先天不足，肾气亏损，冲任空虚。按上述分期治疗。经第一个月经周期治疗后，月经按月来汛，基础体温仍单相。第2月经周期治疗后，基础体温现双相，月经逾期末转。尿妊娠试验阳性。妇科检查诊断为怀孕。后足月顺产一女婴，随访女孩发育健康。

十三、针刺配穴位敷药 通胞宫

输卵管阻塞是妇科常见病、多发病，往往因急、慢性输卵管炎、盆腔炎、输卵管结核，或手术后盆腔附件粘连等引起，由此可出现输卵管的器质性阻塞、使精卵细胞结合及宫腔内着床无法实现，最终导致不孕症的产生。王麦绒运用针刺配合中药穴位贴敷的方法治疗输卵管阻塞性不孕症，收到良好效果。

取穴：中极、归来、三阴交、子宫、关元。临症配穴：情绪消沉、抑郁、胸闷心烦者加膻中、支沟；少腹发凉、胀满者加气海、命门；行经腹痛者加石关、外关；经色黯红挟有血块者加血海；经量多而延期者加行间、阴谷；经量少或闭经者加志室、交信；体胖嗜卧者加足三里、丰隆；带下量多清稀者加带脉、白环俞；带下色黄有味者加蠡沟、照海、曲泉；腰部酸困，性欲冷淡者加命门、四海；小便清长，夜尿增多者加肾俞、阴陵泉；眩晕耳鸣者加百会、率谷；脘痞纳差者加中脘、阴都；心悸失眠多梦者加心俞、神门；伴有炎性肿块者加三阴交、八髎；输卵管积水者加足三里、至阴；子宫后位者加阳池；黄体功能不健全者加腰俞；基础体温不升或双

相体温不稳定者加肾俞、水泉。

操作：子宫、中极、归来进针3~4寸，三阴交进针2寸，均施提插捻转平补平泻法，中等刺激，每穴提插捻转30s，关元针感下行，三阴交针感上行，分别放散到会阴部，使腹部及会阴皆有针感，其他各穴得气即可。留针15min，月经来潮第一天开始针刺，每日1次，连针15次，休息半月，下次经来再针。3个月为1个疗程。

药物贴敷：①肝郁气滞型：月经先后无定期，色紫夹块，经前乳房及小腹胀痛，胸胁不舒，烦躁易怒或抑郁寡言，舌黯红，苔薄白，脉弦涩。外用方：将桃仁10g，皂角刺20g，败酱草30g，三药配制成浓缩液，进行局部穴位（关元、次髂）热敷，以加速瘀积消散。经来第一天放置，每日1次，连放15天。3个月为1个疗程。②脾肾阳虚型：月经后期或闭经，经色淡红，经质稀薄，腰膝酸痛，下腹冷，精神不振，肢体虚胖，疲乏无力，面色苍白晦黯，性欲淡漠，夜尿多，大便溏，舌淡嫩，苔薄白，脉沉迟或滑。外用方：细辛、花椒、羌活各5g，共研粉，加白酒调成浆糊状，制成圆饼，睡前洗脐门后，把药饼平放脐门上，用艾条灸15min，经来第一天开始，每晚1次，连用15天。3个月为1个疗程。③肝肾阴虚型：月经量少或后期，经色鲜红，五心烦热，盗汗口干，形体消瘦，腰膝酸软，舌嫩红，少苔或无苔，脉细弱或略数。外用方：透骨草、丹参、吴茱萸、小茴香各50g，路路通、淫羊藿各30g，细辛20g，将上述药物研粉，用白酒浸透、拌匀，置于关元穴上，热敷15min，以下腹部微微汗出为佳。经来第一天开始，每晚1次，连用15天，3个月为1个疗程。④邪毒内侵型：月经先期或闭经，经量多或淋漓不净，平时少腹、小腹热痛或辣痛，带下量多，色白黄相兼而质稠秽，阴道瘙痒而灼痛，苔白黄而腻，舌质偏红，脉象滑数。外用方：红藤、败酱草各30g，透骨草20g，乌药、木香各10g，加水煎至100ml，取汁，肠道排空后，用灌肠器缓慢注入肠道内并应保留30min，月经干净后，每日1剂，连用15剂。3个月为1个疗程。

输卵管不通常由气机不畅，血脉凝滞；或由寒邪阻于胞宫；或因湿痰内阻，阻碍血行所致。今取子宫、中极，意在行血气、通胞宫，且兼中极是任脉、足三阴之会，可以补肝肾以调任脉，任脉通则月经按时而下，增加受孕机会；用归来行血去瘀，佐三阴交调和

足三阴经的经气，兼补脾益血，旺盛血行，故能消除瘀阻，而能怀孕。刺穴方中关元、归来、三阴交可温肾通络、化滞消肿、活血养血、调冲通任、助孕生子。配合中药穴位外敷，能通达冲任之胞络，峻补下焦之元阳，具有软坚散结、消癥除痞、活血通络与加速瘀积消散和炎性组织吸收之功。

十四、针灸配耳压 调理冲任

李晓宁采用针灸配合耳穴贴压治疗不孕症，疗效满意。

取穴：主穴：取关元、气海、中极、四满、子宫、神阙、三阴交、命门。配穴肾虚加太溪、肾俞；肝郁加合谷；气血亏虚加血海、膈俞。

操作：每次选6~8穴。手法均用补法，其中神阙穴只灸不针，针刺关元、中极、子宫时，针尖斜向内下方，进针1~2寸左右，要求使针感下传至会阴部，每日1次，留针1h，10天为1个疗程。

耳穴贴压：取肝、肾、神门、内生殖器（子宫）、卵巢、肾上腺、皮质下、内分泌，用王不留行进行耳穴贴压，每日按压3~5次，每次5~10min，双耳交替，3日换贴1次或隔日换1次。

祖国医学认为不孕与肝、肾关系密切，并与冲任两经病变或脏腑气血不和影响胞脉功能有关，故体针多选以下腹部和骶骨部接近盆腔脏器穴位为主，采用疏通经脉，调理冲任为治疗原则，并配合调和肝脾、补肾活血的三阴交、肾俞等穴。另外，耳为宗脉之所聚，与五脏六腑关系密切，贴敷肝、肾、内分泌、皮质下等耳穴，与现代医学可以调节下丘脑—垂体—卵巢性腺轴密切相关，可见体针与耳穴贴敷合用可以调节垂体功能，提高雌激素水平，促进排卵而受孕。

王某，29岁。1996年7月10日就诊。主诉：结婚3年未孕，月经周期正常，量中等。经妇科确诊为原发性不孕。治疗：体针取穴1组：关元、神阙、中极、三阴交、合谷；2组：命门、子宫、气海、膈俞，二组交替使用，同时配合耳穴贴压子宫、皮质下、肾上腺、内分泌、肝、肾。按上法治疗3个月，受孕，随访足月产一女婴。

十五、针灸治疗 生血充精

郑士立采用针灸治疗排卵障碍性不孕症，疗效比较理想。

取穴：神阙、中极、关元、子宫（双）、足三里（双）、三阴交（双）。

操作：针刺前嘱患者排空小便，中极、关元、子宫（双）、足三里（双）、三阴交（双），分别选用30号1.5寸不锈钢针，常规消毒后直刺1.2寸左右，得气后大幅度提插捻转9数，中极、关元、子宫（双）的针感向会阴放射为佳。每隔10min捻针1次，留针30min。神阙、三阴交（双）分别用艾条悬灸30min，以局部潮红为度。

祖国医学认为女子以血为本，血足则子宫易于容物，女子受孕主要是肾气充盛，天癸至，任冲通盛，气血调和，适时交媾，摄精受孕。《素问·上古天真论》曰：“女子七岁，肾气盛，二七而天癸至，任脉通月事以时下，故有子”。排卵障碍性不孕主要是由于肾虚精亏、血海亏虚、气滞血瘀引起肾气-天癸-任冲-胞宫性系统出现紊乱致使卵泡发育不良，卵泡周期长等障碍而不孕。

《针灸大成》云：“关元主月经不通，绝嗣不生”，关元为足三阴经、任脉之会，又为小肠之募，主藏魂魄，此乃男子藏精、女子蓄血之处，此穴能调整足三阴经、冲任二脉，并主血主胞之疾；《针灸资生经》云：“中极治妇人断绪，失精绝子”。中极为肾肝脾、任脉之会，膀胱之募，主阴血，与关元同为妇人断绪最要穴。“子宫治妇人久无子嗣”（《针灸大成》），三穴同用充精生血，且局部直接作用于子宫、卵巢等女子生殖器官，促进子宫、卵巢等女子生殖器官的血供，有利于卵泡细胞的成熟、排放。《医学源始》云：“脐者，肾间动气也，气通百脉，布五脏六腑，内专脏腑经络，使百脉和畅，毛窍通达，上至泥丸，下至涌泉”，神阙穴位居腹部中央，系血脉之蒂，为精气神血往来之要，并与冲脉有密切联系，为人体上下左右交会之中心，乃生气所系，内通五脏而关系于肾。艾灸神阙穴能激发丹田的元气能量，从而升降气机，调和百脉。和关元、中极相配，具有培元固本、补益脾胃，使阴血、精血生化有源而充盛。辅以足三里可温补先天与后天之原气；配三阴交可通利瘀滞。诸穴合用生

血充精、调和百脉、通利除瘀使肾气 - 天癸 - 任冲 - 胞宫性系统功能和谐而易于受孕。

十六、辨证分型 因证施治

不孕症是一种常见病，临床治疗颇为棘手。周晋丽采用针药并用进行治疗，疗效较好。

(1) 肾阳虚型

主症：久婚不孕，月经后期，量少色淡，少腹冷痛，腰酸腿软，性欲淡漠，舌淡苔白，脉沉迟。治法温肾助阳，暖宫散寒。方药：熟地 12g，当归 10g，白芍 12g，川芎 10g，菟丝子 10g，杜仲 10g，肉苁蓉 10g，巴戟天 10g，紫河车 12g，香附 10g，肉桂 6g，甘草 10g。水煎服。

针刺取穴：命门、肾俞、关元、足三里、大赫。命门属督，督脉总督一身之阳经，故取命门以补其阳，肾俞为肾之背俞穴，大赫为肾经穴，二穴有温壮肾阳之功，关元属任脉经穴，可暖下焦而温养冲经，更取足三里补脾胃而益气血，气血充足，胞脉得养，冲经脉气自调。每次取穴 3~5 个，隔日 1 次，10 次为 1 个疗程，交替进行，针后加艾条温和灸。

(2) 气滞血瘀型

主症：久婚不孕，月经先后不定期，量少色紫黯伴血块，经行少腹胀痛下坠，乳房胀痛，腰酸胀痛，带下色青，舌质黯，苔薄润，脉弦滑。治法活血化瘀，佐以行气通络。方药：桂枝茯苓丸加穿山甲 10g，路路通 10g，王不留行 10g，生蒲黄 10g，水蛭 6g，橘子核 6g，香附 6g。水煎服。

针刺取穴：中极、合谷、血海、三阴交、行间。中极属任脉经穴，可通调冲任脉气，血海为足太阴脾经穴，行间属足厥阴肝经穴，二穴能通调肝脾之气，奏行瘀化滞之功，合谷三阴交可使气血下行而达通经目的。每次取穴 3~5 个，隔日 1 次，10 次为 1 个疗程，交替进行。

(3) 脾虚型

主症：久婚不孕，月经量多似崩，色淡红，经后小腹隐痛，头晕身倦，面色萎黄，腰膝酸软，面浮肢肿，脉沉细，舌质淡有齿痕，

苔薄白。治法健脾益气，固摄冲任，方药：党参 15g，炙黄芪 15g，炒白术 10g，怀山药 12g，炒白芍 10g，黑荆芥 10g，熟地炭 15g，炙地榆 10g，海螵蛸 12g，煅龙骨、煅牡蛎各 15g，炙甘草 6g。水煎服。

针刺取穴：关元、三阴交、隐白。关元为足三阴，冲任之会，可以调补冲脉，任脉之气，以增固摄，制约经血妄行，三阴交为足三阴经之交会穴，有补脾统血之作用；隐白为脾经之井穴，常用治崩漏，气虚明显加足三里，脾俞以培补中气，使气充而能摄血。每次取穴 2~3 个，隔日 1 次，10 次为 1 个疗程，交替进行，针后加艾条温和灸。

肾为先天之本，精气藏于肾，肾精充则能化血，精血同生，乙癸同源，胞脉至于肾，而胞宫为孕育生命之地，藏精气，又通血事，“其间又持一点命门之火为主宰”，治疗不孕症，历来医家都重视肝肾。肾主生殖，冲任之本在肾。先天禀赋不足，肾气不充，或后天房事不节，或久病伤及肾阳，或因经期涉水感寒，寒宫胞宫，胞脉失温煦均致宫寒不能摄精成孕。或情志不舒，肝气郁结，疏泄失常，血气不和，瘀阻胞宫、胞脉，冲任不通，不能摄精成孕。或素体脾虚，统摄无权，冲任失固，不能摄精成孕。在治疗过程中，针对各型的特点进行分型治疗，肾阳虚以温肾助阳，暖宫散寒为主，方中当归、熟地、白芍、川芎补血，香附理气调经，菟丝子、杜仲、肉苁蓉、巴戟天、紫河车补肾助阳而益精血，肉桂温肾助阳，全方共奏温肾助阳，填精助孕之效。气滞血瘀型，主方桂枝茯苓丸活血化瘀为主，血瘀日久，聚而成癥者加穿山甲、路路通、王不留行、水蛭等以散结癥。脾虚型，脾虚以黄芪、党参、白术益气以摄血，山药、白芍益肾养血，龙骨、牡蛎固摄冲任，全方共奏健脾益气，固冲止血之效。总之，中药以温补脾肾，调理气血，兼以活血化瘀为主，运用针刺运行气血，调和阴阳，二者有机结合治疗不孕是比较有效的方法。

婚后不孕易产生忧虑、恐惧的悲观情绪，这些不利因素应及时消除，才能提高效果。在治疗前调整患者心态，保持心情舒畅，帮助患者掌握性知识，进行性知识和受孕知识教育，使双方有规律和谐的性生活。这也是治疗不孕症的一个非常重要环节。

十七、针药配合 补肾益精

宋鸿雁运用口服中药配合针灸进行辨证施治，疗效满意。

(1) 针灸治疗

主穴：气海、三阴交、中极；配穴：辨证取穴，月经先期：太冲；月经后期：血海、归来；月经紊乱：肾俞、脾俞；痛经：次髎、地机；经闭：合谷、足三里；功能性子宫出血：关元、脾俞。方法：用1~1.5寸毫针，快速进针，捻转得气后，留针30min，每10min行针1次，每日治疗1次。从月经周期的第七天开始治疗，每月连续治疗10次，3个月经周期为1个疗程。

(2) 口服中药

基本方药：六味地黄汤合五子衍宗汤化裁。药如：熟地24g，山药12g，山茱萸12g，丹皮10g，茯苓10g，泽泻10g，枸杞子15g，菟丝子15g，覆盆子12g，五味子10g，车前子10g_{另包}。辨证加减：气血虚弱加人参、阿胶；肾阳虚加紫石英、仙茅；痰湿中阻加半夏、苍术；腰困腰痛加续断、杜仲。用法：每日一剂，水煎服，于月经周期第七天开始服用，每月服中药10剂，连用3个月经周期为1个疗程。

祖国医学认为肾主生殖。不孕与肾的关系密切，并与天癸、冲任、子宫的功能失调或脏腑气血不和，影响胞脉络绝功能有关。肾气盛实，促使天癸成熟，任通冲盛，月事以时下。这是受孕的基础。天癸，男女皆有，是影响人体生长、发育和生殖的阴精。所以治疗现代医学认为的排卵障碍性不孕，应以滋补肾阴为要。六味地黄汤以滋补肾阴为主，三补三泻，补中有泻，阴中求阳，阴阳并补；五子衍宗汤见于《丹溪心法》，以补肾益精见著，常用于男性病，宋鸿雁在临床将其用于妇科以促排卵，收效显著。两方合用，共收补肾益精之功效。

妇女的生理、病理与经络奇经八脉之冲、任、督、带联系密切。王冰说：“冲为血海”、“任主胞胎”，只有冲任脉通调，才能促使月经的来潮和孕育的正常。气海为任脉经穴，可调一身元气，以气为血帅，气充则能统血；三阴交为足太阴、手少阴、厥阴经交会穴，归脾经，脾气旺则血有所统；中极调理冲任，疏调下焦。配穴依辨

证取穴，与主穴共奏通调冲任，理气和血之功。

杨某，女，29岁。于2000年4月5日初诊。结婚3年余，一直同居未避孕，但未孕。平素月经周期紊乱，先后无定期，经期下腹坠胀不舒，量少，色红；形体消瘦，腰酸腿软，神疲体乏，性欲淡漠，性情急躁，心烦易怒。舌红，苔少，脉细数。其爱人精液常规检查正常。经妇科检查、B超（子宫、附件）、子宫输卵管造影均未见明显异常，连续测量基础体温3个月，呈单相曲线并经B超监测未见排卵。诊断：原发性不孕（排卵障碍），证属肾虚型，治宜补肾益精。处方：口服中药用基本方加续断10g，杜仲10g，人参20g。每日1剂，水煎服。针灸处方：主穴：气海、三阴交、中极；配穴：肾俞、脾俞、地机、足三里。每日治疗1次。针药配合，连续治疗3个疗程。第一疗程患者月经周期逐渐规律，第二疗程3个月中有一次排卵（BBT测量），第三疗程3个月中有2次排卵。完成第三疗程后2个月，于2001年6月尿HCG阳性，次年足月分娩健康女婴。

十八、针药罐灸 综合治疗

输卵管阻塞性不孕症是不孕症中最常见的病证，李艳梅运用中药、温针灸治疗该病，取得了较好的疗效。

（1）辨证分型

气滞血瘀型：表现为经期延迟或经前乳房胸胁胀满疼痛或伴小腹胀痛，烦躁易怒，精神抑郁，月经量少色黑有块，舌质淡紫有瘀斑、苔薄白或薄黄，脉沉细而弦。

湿热瘀阻型：表现为少腹有压痛，经期提前，量多有块，口干多饮，舌质红、苔黄而腻，脉濡数。

痰瘀互结型：表现为体形较胖，月经量少色紫有块，少腹两侧有压痛，舌质或淡或紫、苔黄腻或白腻，脉沉细。

肾虚血瘀型：表现为倦怠乏力，腰膝酸软，或畏寒肢冷，或头晕耳鸣，五心烦热，月经量少，色或淡或紫，经期延迟，少腹两侧有压痛，舌质淡胖有瘀点或舌质红有瘀点，脉沉细。

（2）温针灸

主穴取气海、中极、子宫、合谷、三阴交。辨证取穴：气滞血瘀型加太冲；湿热瘀阻型加行间、阴陵泉；痰瘀互结型加丰隆、中

腕；肾虚血瘀型加肾俞、太溪。

操作：用2寸毫针针刺，先取主穴气海、中极、合谷、三阴交，再取子宫穴。取子宫穴时在该穴处或周围循按，以压痛点或按压有阳性反应处为针刺点，采用捻转进针法，使针感传至阴部最佳。气海、中极、合谷用补法，三阴交及子宫穴用平补平泻法，然后再根据辨证配伍其他穴位。

灸法：将艾条切成长约1.5cm的艾段，用牙签在横截面中央插一小孔，然后穿到主穴已针好的毫针柄上，配穴不用灸法。每穴连续施灸3壮。对于阳虚者配合神阙施隔盐艾炷灸治疗。

起针后在背部肝俞、脾俞、肾俞及腰骶部走罐5min，隔日治疗1次，月经期停止治疗。1个月经周期为1个疗程。

(3) 中药治疗：主方用通管汤。

药物组成：炮山甲10g、皂角刺15g、三棱12g、莪术12g、制乳没各12g、昆布12g、海藻12g、赤芍9g、益母草12g、路路通12g、夏枯草9g。气滞血瘀型加柴胡10g、香附10g；湿热瘀阻型加土茯苓30g、薏苡仁30g；痰瘀互结型加清半夏、白芥子、陈皮各10g。肾虚血瘀型加生熟地各12g，丹参、桃仁各10g；如畏寒明显则去生熟地加熟附子、肉桂、小茴香各6g。水煎服每日1剂。月经期停止服用，1个月经周期为1个疗程。月经干净第三天开始服用，至月经来前2天停药。

《内经》云：“任主胞胎，任脉通太冲脉盛，月事以时下，故有子。”即不孕症与任脉关系密切。明代《景岳全书·妇人规·子嗣类》引朱丹溪之言曰：“阴阳交媾，胎孕乃凝，所藏之处，名曰子宫，一系在下，上有两歧，中分为二，形如合钵，一达于左，一达于右。”在这里所说的两歧就是现代医学所指的输卵管。输卵管阻塞不通的临床表现主要为腹痛、不孕、白带量增多，总的病机为胞络瘀阻。《内经》云：“病在脉，调之血。”涩者宜行宜疏，闭者宜攻宜通，总的治疗原则在通，故活血化瘀为其治疗大法。可因血瘀成因不同，随证加减，或佐以疏肝理气，或佐以温经散寒，或佐以清热利湿，或佐以理气化痰，再加通络之品。常用活血化瘀药物有丹参、桃仁、赤芍、红花等。但是输卵管阻塞属于器质性病变，瘀血积久程度较重，故取活血化瘀之重品，如炮山甲、皂角刺、三棱、

莪术之类再辅以散结通络之品，如昆布、海藻、路路通等，然后再根据辨证随证加减。在内服中药的同时，配合温针灸，穴取气海、中极、子宫、合谷、三阴交。气海、中极为任脉穴位，任主胞胎故治不孕症取任脉穴为首选。从穴性上讲气海可壮元气；中极为任脉与三阴经之交会穴，既可培元固本又可清热利湿。温针灸既可固元气又可活血化瘀。子宫穴位于中极旁开3寸，取该穴时要上下循按，找到压痛点或阳性反应物针刺，其深部正当输卵管，必刺到病位，并配合灸法，起到活血化瘀、通经活络的作用。合谷为大肠经原穴，阳明大肠经多气多血，取合谷可调和气血，三阴交为肝脾肾三经交会穴具有补益肝肾、活血化瘀、滋阴养血的作用，为治不孕症之要穴，且输卵管所在位置是肝经所循行的部位，针刺三阴交使气至病所并配以温针灸可通经脉之瘀滞。总之，诸穴相配可使任脉得通，胞脉得养，而为孕育胚胎打好基础。

吴某，28岁，东营人，于2003年2月17日来诊。已结婚3年余，于2000年5月流产1次，以后未再怀孕。其丈夫精液常规及免疫学检查均属正常范围。纳眠可，二便调，月经规律， (28 ± 2) 天一行，持续3~5天，量少色黑有块，经期伴小腹坠痛，畏寒，舌质淡紫、苔薄白，脉沉细。妇科检查示双侧附件有条索状结节伴压痛。行子宫输卵管造影示双侧输卵管不通。右侧输卵管迂曲伞端粘连。中医诊断为：无子（肾虚血瘀型），西医诊断为：不孕症（双侧输卵管不通）。遂给予通管汤加熟附子6g（先煎），小茴香9g，肉桂6g后入，每日2剂，月经干净第3天服用，至月经来前2天停药。针灸取穴气海、中极、子宫、合谷、三阴交、太溪，并配神灯隔盐艾炷施灸。炷如半个枣核大小，不拘壮数。针刺子宫穴时取压痛最明显处，使针感向下扩散，并与其他主穴配合温针灸。起针后在背部的肝俞、脾俞、膈俞、肾俞及八髎穴走罐，以皮肤潮红为度。隔日1次，月经期间停止治疗。1个疗程后，月经来潮已不腹痛，畏寒症状亦有好转，经后第4天，行子宫输卵管造影示双侧输卵管已通，并于次月怀孕，2004年3月足月顺产健康男婴。

十九、针药并举 调理冲任

女子婚后，配偶生殖功能正常，夫妇同居2年以上未避孕而未

怀孕者，称为原发性不孕；曾孕育过，并未采取避孕措施，又间隔2年以上未再孕，称为继发性不孕；统称不孕症。张风华应用针药结合治疗不孕症，疗效满意。

取穴：任脉、三阴经及阳明经为主。主穴：中极、关元、气穴、子宫。配穴：足三里、三阴交、太冲、合谷。辨证配穴：肾虚取肾俞、太溪；肝郁取太冲；痰湿取风隆、阴陵泉；血瘀取膈俞、归来。

操作：以补法为主，兼用泻法。中极向下斜刺，施提插泻法，以针感向会阴部传导为佳；关元向下斜刺，施提插捻转补法，以针感向会阴部传导为佳；气穴、归来、子宫穴直刺，施捻转补法；足三里、三阴交施提插补法。每次月经行经后2周治疗。连续治疗10次为1个疗程，每月治疗1个疗程。

中药：以养精种玉汤加味。熟地、吴茱萸、白芍、当归。肾阳虚加菟丝子、巴戟天；肾阴虚加丹皮；肝郁加香附、柴胡；痰湿型加茯苓、山药、陈皮、半夏；血瘀加丹参、红花。于经后12天服药，连服10天。

祖国医学认为，不孕症是脏腑功能失调，冲任病变，胞宫不能摄精所致。脏腑功能失调多与肝脾肾有关。故中药以调补肝肾之养精种玉为主方，随症加味以达调补肝肾。针刺取穴以任冲二脉为主，因冲为血海，任主胞胎。关元、中极为任脉和足三阴的交会穴，有补益精血的作用；足三里、三阴交、气穴、归来有调补气血之功能。针对不同的证型，采用不同的治疗法则。肾经虚损，治以补肾益气；肝郁气滞，治以疏肝解郁；痰湿阻滞，治以祛湿化痰；血瘀胞脉，治以活血化瘀。经后半月正值排卵期，故经后两周针药结合，以补肾通络，促进排卵。治疗总则调理冲任，养血通经。

二十、补益肝肾 佐以活血化瘀

马佩莲认为原发性不孕，多因无排卵或黄体功能不健全，出现肾虚证候；继发性不孕症，多因输卵管阻塞所致，有肝郁证候。鉴此采用疏肝补肾法进行治疗。

原发性不孕（肾虚精血不足）：月经周期紊乱，经量多或少、色淡红，或淋漓不易净，腰膝酸软，性欲淡漠，小便清长，舌淡红、苔薄白润，脉沉细，尤尺脉为甚。治拟补肾益气，疏肝养血。方选

毓麟珠加减：党参、白术、茯苓、当归、白芍、熟地、菟丝子、巴戟天、柴胡各 15g，淮山 20g，川芎 6g，青皮 5g。子宫发育不良（稍小）者，加紫河车、仙灵脾；小腹冷痛者，加小茴香；经量少而不畅者加泽兰；量多者，加失笑散；无排卵或黄体功能不健全者，加丹参、桃仁。并用针刺排卵法，于月经周期第 12 天开始，每天 1 组穴，每次留针 30 min，连用 3 天。第一组为阴交、关元、地机、水道，第二组为归来、大赫、曲骨、三阴交，第三组为中极、归来、水道、三阴交。另还用复方丹参注射液 2ml，取以上 5 个穴位注射，每周 2~3 次，连用 10 次为 1 个疗程。经期停用。

继发性不孕（肝郁肾虚）：经前乳房、少腹、胸胁胀痛，烦躁易怒，胸闷喜叹，月经前后无定期，量时多时少，色紫黯夹血块，腰酸痛，舌紫黯、苔薄白，脉弦。治拟疏肝理气，补肾调经。方选逍遥散加减：当归、白芍、柴胡、白术、茯苓、丹参、菟丝子、巴戟天、红藤、延胡各 15g，香附 10g，青皮 6g。乳房胀痛有肿块者，加橘核、橘络、鸡内金；附件有肿块者加穿山甲、蒲公英、路路通。另每晚中药保留灌肠（经期停用），以红藤、紫花地丁、野菊花、蒲公英、天葵子各 20g，三棱、莪术、元胡各 15g，煎水两次浓缩 100ml，连用 10 天为 1 个疗程，并结合用复方丹参注射液 2ml 穴位注射，取以下（原发性不孕）针刺排卵法 3 组穴中任意 5 个穴，每周 2~3 次，连用 10 次为 1 个疗程。

肾主生殖，肾是藏精之处，施精之所，天癸之源，冲任之本，肾又系胞养肝，肝藏血，肝肾同源，精血同源，相互滋生，精充血旺，血海充盈。肝主疏泄，肾主闭藏，一开一合，血海蓄溢正常，冲任脉通盛，两脉相资才能两神相搏合而成形。因此在治疗当中，始终补益肝肾，佐以活血化瘀，方取得较好的疗效。

原发性不孕症：秦某，女，26 岁，已婚，1993 年 3 月 13 日初诊。结婚 2 年余未孕，15 岁初潮，月经周期提前 7~8 天，量少，色紫黯夹小血块，2 天干净，经前乳房少腹胀痛，经期腰酸，形寒肢冷，舌红、苔薄白，脉弦细。末次月经 1993 年 3 月 1 日，妇科检查：外阴已婚未产式，宫颈单糜 1/3，白色分泌物量中（常规 II 度），宫体前倾正常大、质中、活动无压痛，双附件未触及肿物。内分泌测定：雌激素低于排卵期水平，孕激素 < 6mg/ml，基础体温呈

单相。提示卵巢功能不足，无排卵。诊断：肾虚肝郁不孕症。治法：补肾益气，疏肝养血。以毓麟珠加减：当归、白芍、熟地、党参、白术、巴戟天、菟丝子、泽兰、柴胡各 15g，淮山 20g，香附 10g，川芎、青皮各 6g。每天 1 剂，连服 17 剂。1993 年 4 月 5 日，服药后诸症好转，末次月经 1993 年 3 月 29 日，量中色紫红无血块，3 天净，舌体胖、质红、苔薄白，脉弦细。守上方 5 剂后，嘱月经周期第 12 天针刺排卵，连刺 3 天。月经周期第 11 天以桃红四物汤加减：当归、白芍、菟丝子、枸杞、淮山、桃仁、山茱萸、巴戟天各 15g，红花、川芎各 6g。5 剂。1993 年 5 月 24 日：停经 55 天，恶心欲吐，头晕乏力，腰酸，舌红、苔薄白，脉滑细。尿检 HCG 阳性，诊断：早孕。以补肾益气安胎为主，拟寿胎丸加味：川断、菟丝子、桑寄生、阿胶、黄芩、党参、白术各 15g，淮山 20g，砂仁、甘草各 6g。5 剂。

继发性不孕症、附件炎性肿块：李某，女，30 岁，已婚，1994 年 10 月 22 日初诊。人流术后 5 年未孕，于 1989 年 10 月受孕 56 天行人流术，术后月经量减少，色紫黯，夹小血块，淋漓不净，持续 10~15 天，月经周期 25~30 天，经前乳房胀痛，经期少腹坠胀，带下量多色黄，烦躁易怒，舌紫黯、苔薄白，脉弦。末次月经 1994 年 9 月 28 日。妇检：外阴已婚未产式，宫颈光滑，黄色分泌物量多，宫体前倾前屈，正常大小，质中，活动，左侧附件有鸽蛋大肿物质硬，不活动，压痛明显，右侧附件增厚轻度压痛。白带常规Ⅲ度，B 超子宫左侧探及一个约 3.8cm×3.5cm 肿块，低回声区边界清，毛糙。输卵管通水试验不通畅。诊断：肝郁肾虚不孕症、癥瘕。治法：疏肝补肾，活血软坚。处方：当归、白芍、柴胡、白术、茯苓、丹参、红藤、菟丝子、巴戟天、元胡、穿山甲各 15g，香附 10g，青皮 6g。每天 1 剂，每月服 20 剂，经期停药。另以上述中药保留灌肠，每天 1 剂，连用 10 天为 1 个疗程。1995 年 1 月 10 日诊：服药 65 剂，灌肠 2 个疗程后经前乳胀消失，经期无腹痛，末次月经 1995 年 12 月 27 日，量中等，色红无血块，5 天干净，舌淡红、苔薄白，脉细。妇检：子宫前倾前屈，正常大小、质中，双附件未触及肿块，无压痛。B 超子宫双附件未见异常。继以疏肝补肾法，守上方 20 剂。1995 年 4 月 10 日诊：停经 43 天，末次月经 1995 年 2 月 27 日，

头晕乏力,腰酸畏寒,舌质淡红、苔薄白,脉细滑。尿检 HCG 阳性,诊断早孕。拟补肾益气安胎:川断、桑寄生、阿胶、菟丝子、党参、白术、黄芩、补骨脂各 15g,砂仁、苏叶各 6g。7 剂。

参 考 文 献

- [1] 谢珍. 保产无忧散加味配合针刺促排卵疗效观察. 现代中西医结合杂志, 2003, 12 (24): 2651
- [2] 王珍萍. 补肾化痰法加针灸治疗多囊卵巢综合征 25 例. 湖北中医杂志, 2007, 29 (6): 31
- [3] 张继红, 张慧岭, 赵藏朵, 等. 补肾化痰法药针并用治疗免疫性不孕 23 例. 陕西中医, 2005, 26 (10): 1024 ~ 1025
- [4] 李文英. 补肾排卵汤加减合电针治疗无排卵不孕症 68 例. 河北中医, 2002, 24 (8): 571 ~ 572
- [5] 李莲华, 张一, 王宝芝. 当归、黄芪及胎盘组织液穴位疗法治疗女性不孕症. 贵阳中医学院学报, 2001, 23 (3): 36 ~ 37
- [6] 韦伟. 电针促排卵 106 例临床观察. 中国针灸, 1998, (9): 541 ~ 542
- [7] 陈英秋, 张丽. 雷火灸为主治疗输卵管炎症性阻塞 54 例. 上海针灸杂志, 1999, 18 (6): 16
- [8] 赵彩娇, 谢感共, 卢献群. 灵龟八法治疗不孕症体会. 辽宁中医杂志, 2006, 33 (9): 1174 ~ 1175
- [9] 张梅香. 内外结合治疗输卵管阻塞性不孕 56 例. 上海中医药杂志, 2003, (8): 42 ~ 43
- [10] 李世玲. 三法联合治疗输卵管阻塞性不孕症. 河南中医, 1999, 19 (4): 51 ~ 52
- [11] 许淑琴, 李亚菊, 李丽俭. 温针灸“子宫穴”治疗女性不孕症 48 例. 针灸临床杂志, 1999, 15 (3): 51 ~ 52
- [12] 王寿椿. 药饼灸治疗不孕症 15 例. 中国针灸, 1994, 增刊: 104 ~ 105
- [13] 王麦绒, 张鹏天. 针刺与药物贴敷治疗输卵管阻塞性不孕症 96 例. 辽宁中医杂志, 2005, 32 (12): 1283 ~ 1284
- [14] 李晓宁, 姚凤楨, 陶波. 针灸配合耳穴贴压治疗不孕症 28 例. 针灸临床杂志, 1999, 15 (2): 10 ~ 11
- [15] 郑士立, 宋丰军, 马大正. 针灸治疗排卵障碍性不孕症的临床疗效评价. 针灸临床杂志, 2007, 23 (1): 9 ~ 11

- [16] 周晋丽. 针药并用治疗不孕症临床观察. 长治医学院学报, 2006, 20 (4): 304 ~ 305
- [17] 宋鸿雁, 薛建堂, 曹利萍. 中药配合针灸治疗排卵障碍性不孕 77 例. 现代中医药, 2003, (5): 41 ~ 42
- [18] 李艳梅, 宋立中, 姜豪杰. 中药温针灸合用治疗输卵管阻塞性不孕症 50 例. 中国针灸, 2005, 25 (4): 259 ~ 260
- [19] 张风华, 张相知. 针药结合治疗内分泌失调性不孕症 23 例. 内蒙古中医药, 2006, (6): 29
- [20] 马佩莲. 针药治疗不孕症 36 例临床观察. 江西中医药, 1997, 28 (4): 35 ~ 36

【功能性子宫出血】

功能性子宫出血，是由于调节生殖的神经内分泌机制失常引起的异常子宫出血，以经血非时而来，或多或少，腹痛、不孕等为主症的疾病。属中医学崩漏的范畴，在医籍中有较多论述，《素问·阴阳别论》有“阴虚阳搏谓之崩”的记载，《济生方》曰：“崩漏之病，本乎一证，轻者谓之漏下，甚者谓之崩中。”

中医学认为本病的原因有血热、肾虚、脾虚、血瘀等。久病阴伤，虚热内生，热扰冲任，迫血妄行；或中气不足，血失所统，冲任不固，离经妄行；或脾肾阳虚，血不归经，郁怒伤脾，木贼土虚，肝脾不和，冲任失调；或瘀血阻于冲任，血海蓄溢失常，迫血妄行等，均可导致本病。总而言之，其病机为冲任不固，不能制约经血。究其病性，在本为脾肾亏虚，属虚；在标为实热，瘀血。临床治疗宜标本兼治，扶正祛邪并重。治本以补肾调经、健脾益气为主；治标以活血化瘀、清热凉血止血为要。

本篇共收录了 13 位针灸医家的临床治验，有的独取关元，隔姜灸；有的采用定宫丹填脐灸，滋阴调经；有的采用随症选穴，耳穴贴压；有的采用穴位注射为主，配中药内服；有的根据临床症状分型分期治疗；有的采用壮医药线灸，调摄冲任等，治法多样。

一、独取关元 隔姜灸

徐玉英采用艾灸关元穴治疗功能性子宫出血，取得较好疗效。

药物制作：取艾绒 50g，捏紧呈球状。鲜姜片，直径较艾绒球大约 3cm，中间用针刺数孔备用。

操作：患者取平卧位，选准关元穴（脐正中直下 3 寸）。将备好的鲜姜片放于关元穴上，再将艾绒球置于姜片中点燃。当患者感到灼痛，达到灸处皮肤红润为度。每天灸 1 次。

中医学认为，本病属崩漏范畴。多因脾虚统摄无权，冲任不固；或因情志所伤，冲任郁滞，血不归经；或因肾虚，封藏失职，冲任不固；亦有因素体阴虚血亏，冲任虚损所致。艾叶性温，具有温经止血、散寒止痛之功。艾绒灸能使热气内注，具有温煦气血、透达经络的作用。采用隔姜灸关元穴，可使冲、任、督三经并调，温通诸经，振奋脏腑的气化功能，激发机体阳气，以达扶正止血之功。应用艾灸治疗功能性子宫出血，不仅对虚寒型疗效好，而且对阴虚有热者疗效亦佳。徐玉英认为灸能助阳气，以达阳生阴长之目的。另外，灸法对机体具双向调节作用。因此，对虚寒型、阴虚型均有效。

王某，女，32 岁，1997 年 10 月 17 日初诊。2 个月以来，经血时多时少，淋漓不止，血色鲜红，伴有倦怠乏力，心烦，手足心热，口干。查体：面色无华，苔薄白，脉细数。曾用黄体酮及止血药治疗，效果不明显。用隔姜灸关元穴治疗 2 次血止而愈，随访半年未复发。

二、定宫丹填脐灸 滋阴调经

赵焕云以自拟定宫丹填脐灸治疗功能失调性子宫出血，取得较好疗效。

定宫丹（自拟）：山茱萸 30g，熟地黄 30g，山药 30g，阿胶珠 30g，女贞子 30g，菟丝子 30g，马齿苋 35g，益母草 30g。食盐末适量，艾炷如黄豆大适量。

操作：上药除食盐、艾炷均研细末，瓶装备用。用时嘱患者仰卧床上，将食盐填满患者脐窝略高 1~2cm，取艾炷放在盐上点燃灸

之。连续灸7壮之后，把脐中食盐去掉，再取上药末填满脐孔，上铺生姜片，姜片上放艾炷点燃灸14壮。然后将姜片去掉，外盖纱布，胶布固定。每隔3天灸治1次，7次为1个疗程。

定宫丹中熟地黄、山药、阿胶珠、女贞子滋补肾阴；马齿苋、益母草祛瘀止血，使血止而无留瘀之弊；菟丝子甘辛微温，既可补阳，又可益阴，具有温而不燥、补而不滞的特点，为平补肝、脾、肾之良药；山茱萸补益肝肾，固经止血，既可滋阴，又可补阳，为肝肾不足之要药。诸药共奏滋阴调经之效。

神阙穴与全身经络相通，与脏腑相连，脐部贴药既有激发经络之气的作用，又可通过特定药物在特定部位的吸收，发挥明显的药效。验之临床，该方对肾阴虚型功能失调性子宫出血疗效较好，且未发现毒性及不良反应。

三、随症选穴 耳穴贴压

朱玲采用耳压法治疗子宫功能性出血，^①收到较为满意的疗效。

取穴：主穴取子宫、内分泌、卵巢、脾。随症取穴：经色鲜红，属血热者，配肝，加耳尖三棱针点刺放血；经色黯红有血块，属血瘀者，配皮质下、交感；经色淡红属气血虚者，配肾、脑点。操作：以75%酒精常规消毒穴位后，用王不留行籽贴压耳穴，每次取主穴、配穴共5~6处，压至耳廓发热、胀、酸痛，每日压3次，每次2~3min。1周更换2次，左右交替取穴。加耳尖放血者每周放血1次。2个月为1个疗程。

功能性子宫出血是指由于卵巢功能失调而引起的子宫异常出血。临床上表现为月经周期紊乱，出血时间延长，经量增多甚至大量出血或淋漓不止，属中医学的崩漏范畴。中医认为其发生机制主要与冲任不调及肝脾肾三脏有关。本病好发于青春期及更年期，青春期因天癸初至，肾气初盛，冲任未充；更年期则由于肾气渐衰，冲任气虚。根据肝主藏血、脾主统血的理论，朱玲取子宫、卵巢、内分泌、脾为主穴，血热者加肝，耳尖放血以清热泻火凉血；血瘀者加交感、皮质下以通络活血；气血虚者加肾、脑点以益气培本。耳穴刺激通过经络的传导起到调节内脏功能（即卵巢功能）而阴阳调，气血和，冲任自充，经至正常。

陈某，女性，16岁，1993年11月5日初诊。患者2年来月经周期不准，或前或后，经来量多如潮涌，色淡，行经持续2~3周，面色少华，肢软乏力，无腹痛。舌质淡，苔白，脉细弱。考虑为先天不足，肾气稚弱，冲任未盛，肾阴阳之气不足，不能固摄所致。取穴子宫、卵巢、内分泌、脾、肾、脑点等穴，两侧交替取用，每周2次用王不留行籽贴耳。经治疗2个疗程，经量减少，行经1周内净，周期恢复正常，面色转红润，随访半年未复发。

四、穴位注射为主 配中药内服

修显红自拟举元固冲汤配合水针治疗少女血崩，效果显著。

举元固冲汤：升麻4g，党参15g，白术、菟丝子各10g，狗脊15g，续断、黑杜仲、阿胶（冲）、白芍各10g，炙甘草3g，金樱子10g。

取穴：右阴谷、左三阴交。耳穴：左肝、右脾。

药物：安咯血或维生素K₃注射液。

操作：先急施水针治疗，按水针操作常规，体穴垂直进针约0.5~1.2寸，得气后注药0.8ml；耳穴皮下注射药液0.2ml。再施举元固冲汤，每日1~2剂，水煎服。血止后可再服5~10剂，以巩固疗效，有利病后恢复。

青春少女，若天癸不充，肾气不足，或逢学习紧张，劳心伤脾累肝，动火均可致冲脉失摄，胞中之血遂走而崩。因此，少女血崩，肾虚是根本。又因先天不足，气虚失摄，或它因所致血崩失血，血为气母，伤血必及于气，血亏则气亦虚，因而气虚又为血崩的结果。冲为血海，任主胞胎，崩漏发病机制的最后环节，当责之于冲脉不固，因此，固冲止血为标，举元健脾补肾为本。举元即升举脾肾之元气，固冲为固冲脉养血止血之意。方中以升麻、党参、白术、炙甘草健脾升元，气旺则血有所依；狗脊、续断、菟丝子、黑杜仲、金樱子补肾培元固冲；阿胶养阴血而止血；白芍养血佐柔浮阳。诸药共使气血协调，补中有敛，温润而不燥烈，举元阳又固元阴，标本兼治，故临证效佳。

水针因其具备中西医治病之长，适应证广，奏效迅速，经济实用，简便易行，对人体阴阳、经络、脏腑及营卫气血有迅速持久的

综合作用，故而发挥其独具的治疗效果。方中取穴左右原理是根据人体左属血，右属气的理论。阴谷为少阴之合穴，具有益肾兴阳，调理前阴之功，故取右侧；三阴交为足三阴之交会穴，具有统血固经安神之功，故取左侧。而耳穴取肝脾仍因肝藏血，脾统血之故。从现代医学观点来看，水针对神经、神经一体液系统、免疫反应等，均有调整作用。另应重视血崩的预防为先及善后调理，调理月经周期，注意劳逸结合等，方可确保安康。

童某，女，13岁。1992年2月10日就诊。1990年10月经初潮，经期先后不定时，常行经淋漓不净，需服药而止。本次月经漏而不止有半月，近5天经量大增，曾至某院西医妇科就诊，服乙烯雌酚及肌内注射孕酮，效果不佳，血崩如注，经色淡红，无血块，伴头晕欲仆，口稍干，小腹隐痛，面浮肢肿，舌质淡红苔白，脉沉细。治疗按前法，当即施水针，继予举元固冲汤3剂。治疗当夜血崩量大减，次晚血崩已止。继服5剂，巩固疗效。1年后随访，该患经上法调治后月经周期已基本正常，无再发崩漏。

五、中极为主 深刺

功能性子宫出血属中医学崩漏范畴。阎政谋采用深刺中极穴加灸法治疗本病，疗效满意。

取穴：中极，三阴交。

操作：针刺前嘱病人排空大小便，取仰卧位，以27号2.5~4寸毫针直刺中极穴，视病人胖瘦垂直进针2~3.5寸，轻轻捻转（不提插，以免刺伤小肠）至有酸胀感，留针20min并用清艾条施温和灸至局部潮红为度。配刺双侧三阴交穴，平补平泻法。每日1次，10次为1个疗程，疗程间休息3天。

马某，女，18岁，学生。于1994年8月12日初诊。主诉：阴道流血，淋漓不断3年。缘于15岁初潮第2年3月份因生气停经，遂到省某医院就诊，给予孕酮人工周期疗法，停药后流血仍不能停止，又给1个周期治疗，停药仍如前，经多方治疗均无效而来诊。查体：精神不振，贫血貌，肛诊子宫位置、形态正常。血红蛋白70g/L，红细胞 $2.5 \times 10^{12}/L$ ，子宫及附件B超检查未见异常，舌质淡、苔薄白，脉沉细数。诊断：中医：崩漏（气血虚型）；西医：功

能性子宫出血。遂用本法治疗3次后流血明显减少，2个疗程后流血停止，1月后来月经，量、色、经期正常。随访1年无复发，贫血貌已纠正。

六、温针配服中药 调和温补冲任

青春期功能失调性子宫出血系由神经内分泌系统功能障碍及中枢神经成熟缺陷所致，是妇科的常见病之一。徐明采用温针和口服中药的方法治疗青春期功血，疗效满意。

温针：取关元、隐白（双侧）。28号2寸毫针直刺关元1.5寸，经提插、捻转使针感向会阴部放射，将事先剪好的2cm长的药艾条插在针柄上；28号0.5寸毫针直刺隐白，抵达骨膜，把1cm长的艾条插在针柄上施灸。取面积适当大小的锡箔纸，剪一裂隙套在针身上，使贴近皮肤，以防火炭落下烫伤皮肤。每次灸3~5壮，每日治疗1次，10次为1个疗程。

口服加味少腹逐瘀汤：元胡6g，干姜3g（炒），当归9g，蒲黄10g（炒），川芎6g，肉桂3g，赤芍6g，五灵脂6g（炒），没药6g（炒），小茴香3g（炒），黄芪60g，地榆炭30g，贯仲炭20g，赤石脂30g。水煎服，每日1剂，饭前分次服。

青春期功能失调性子宫出血属祖国医学崩漏的范畴，其主要发病机制为冲任损伤，不能固摄经血所致。关元穴为足三阴、冲任之会，可培肾固本，补益元气；隐白乃脾经井穴，犹如水的源头，是经气所出的部位。取此二穴进行温针治疗，可发挥针刺和艾灸的双重作用。既能调和温补冲任二脉之气，加强固摄，约制经血妄行，又可温通足太阴经，补中益气，促进脾恢复正常的统血功能，以奏固崩止漏之效。此外，崩漏与情志变化、风冷寒凉、饮食劳倦等因素密不可分，故少腹逐瘀汤中小茴香、干姜、肉桂温经散寒，通达下焦；元胡、没药利气散瘀；当归、川芎乃血中之气药，配合赤芍以活血行气，散滞调经，若出血过多时，用此二药宜慎重或减量，以防出血增加；炒灵脂、炒蒲黄、赤石脂都有止血作用；地榆炭、贯仲炭善治血崩；黄芪、当归补气生血，利于疾病早期康复。

陈某某，女，17岁，未婚。1996年5月28日初诊。诉月经周期紊乱2年，经血持续量多3周。患者于15岁月经初潮后，周期紊

乱，经期长短不一，出血量时多时少，自今年3月初始，连续停经周余，于5月7日月经又行，流血量较前增多，持续近2周。经当地妇科检查，诊断为青春期功能失调性子宫出血，口服中西药物治疗无效而来诊。经温针及内服中药治疗5天后出血停止，为巩固疗效又继续治疗5天而愈，随访半年未复发。

七、中药内服外用 补肾活血兼施

王敬善采用内服引血归经汤外用妇贴灵治疗功能性子宫出血，取得了满意效果。

内服引血归经汤：菟丝子30g，枸杞子15g，生地黄10g，白芍10g，当归10g，川芎3g，红花3g，日1剂，水煎300ml，早晚饭后分服。于出血期前、后各服8天。出血期上方加仙鹤草30g。

外用妇贴灵：药物组成：女贞子15g，五灵脂15g（炒），烘干共研为末，瓶装密封备用。用法：取患者关元穴（脐下3寸），用75%的乙醇擦净，取上药3g，食醋、姜汁各1ml调和成糊剂，摊涂于关元穴，直径2cm，然后外用纱布覆盖，胶布固定。每日换药1次，出血期贴敷。

功能性子宫出血西医多采用激素治疗，虽然有效，但用药方法复杂，停药后常易复发。此病属中医崩漏范畴，病人多为40~50岁中老年人，肾气渐衰，冲任二脉虚损，不能制约经血，经血非时而下，故肾虚为本病病理变化基础。久崩多虚，久漏多瘀，肾虚血瘀为本病病机，本病虚实并存，但补虚瘀不去，但化瘀肾愈虚，故宜补肾活血兼施。汤剂中菟丝子、枸杞子为君，重在补肾；生地黄、当归、白芍、川芎、红花补血活血，使肾阴足，瘀血化，血自止。同时采用妇贴灵外敷关元穴，方中女贞子、五灵脂补肝肾，调冲任，活血止血；食醋性味酸苦微温，取其收敛止血之功，另外，醋是一种有机溶剂，可有效溶解药物，使药物通过穴位渗透，经经脉传导而发挥作用；生姜为芳香性药物，含挥发油，其主要成分为姜醇、姜烯等，能促进药物经皮肤吸收而发挥作用。关元穴为任脉之要穴，同时为足三阴经及冲任二脉之汇，贴敷此穴可以调补冲任二脉之气，加强其固摄、制经血妄行的作用。

八、证分三型 治分两期

青春期功能失调性子宫出血是妇科常见病之一，严重影响少女的学习和生活。余春燕对出血期采用辨证分型施治，非出血期以自拟补肾调经汤配合针灸，治疗青春期功能失调性子宫出血，疗效较为满意。

(1) 中医辨证分型

脾气虚弱型：症见经血非时而至，崩中，继而淋漓不止，血色淡而质薄，伴气短神疲，面色白，食少纳呆，手足不温，大便溏薄，舌质淡，苔薄白，脉缓弱。

肝脾不调血瘀型：症见经血非时而下，出血量多如冲，或时多时少，或淋漓不尽，经色紫黑有块，精神烦闷易怒，胸胁乳房胀痛，小腹胀痛拒按，舌紫黯，苔薄白，脉涩或弦紧。

肾阳虚型：症见经来无定期，出血量多，或淋漓不尽，色淡质清，伴精神萎靡不振，畏寒肢冷，腰膝酸软，溲频便溏，舌淡苔薄润，脉沉弱。

(2) 出血期治疗

采用中药配合针灸辨证施治以止血。脾气虚弱型，治以健脾益气止血。方用固本止崩汤加减：熟地 20g，白术 20g，党参 15g，黄芪 15g，怀山药 15g，蛇床子 9g，三七 6g，炮姜 6g。出血多者加海螵蛸 15g，茜草 15g；血虚者，加阿胶 12g。竹圈盐姜灸关元、足三里、隐白、断红穴。肝脾不调血瘀型，治以调肝化瘀止血。方用逐瘀止血汤加减：生地 15g，三七 9g，柴胡 9g，炙龟板 12g，当归 9g，赤芍 9g，丹参 9g，香附 9g，桃仁 6g，枳壳 6g。胁痛腹胀者，加川楝子 9g；有血块者，加蒲黄 9g，五灵脂 9g。针刺太冲、大敦、隐白，毫针浅刺，行泻法。肾阳虚型，治以温肾固冲止血。方用右归饮加减：熟地 12g，菟丝子 12g，鹿角霜 12g，紫石英 12g，黑附片 9g，山茱萸 9g，巴戟天 9g，杜仲 9g，三七 6g，炮姜 6g。气虚者，加黄芪 15g；腰酸者，加淫羊藿 9g。竹圈盐姜灸命门、肾俞、关元、隐白。

(3) 非出血期治疗

崩漏以肾虚为主，治则以补肾调经为要。非出血期不分证型，用自拟补肾调经汤：紫石英 30g，鹿角霜 30g，菟丝子 15g，枸杞子

15g, 淫羊藿 15g, 女贞子 15g, 熟地 12g, 当归 12g, 肉苁蓉 12g, 续断 12g, 香附 9g。血止后 5 天服用, 每日 1 剂, 连服 7 天为 1 个疗程。下次月经来潮有周期者, 于经后 5~7 天服 3 剂, 巩固 2 个周期。并配合竹圈盐姜灸三阴交(双)、足三里(双)、关元、气海、子宫(双)。每日 1 次, 每次 30~40min, 连续 7 天。全部病例均以 1 个月经周期为 1 个疗程。治疗最短 2 个疗程, 最长 5 个疗程。

竹圈盐姜灸: 取干燥的竹圈 1 个, 直径 8~9cm, 高约 4.5~5cm。使用前底部用 3 层纱布包绕, 圈边用橡皮筋扎紧, 取细食盐 2 份, 碎生姜 1 份, 混合均匀填入竹圈内约 1cm 厚, 然后装进艾绒呈锥柱状, 自尖端点燃, 让其燃烧 3~5min, 用手测试圈底纱布有微热就可将其放置在选定穴位上施灸, 以皮肤潮湿红润为度, 1 圈可燃 30~40min, 穴位轮番施灸。

现代医学认为, 功能失调性子宫出血, 其出血原因多受外界环境的影响, 如生活环境不安定, 精神过度紧张, 情绪不稳定, 干扰了下丘脑-垂体-卵巢轴的相互调节, 性轴调节功能发生紊乱, 致使激素分泌紊乱, 产生无排卵型功血; 或因厌食挑食导致营养不良, 代谢紊乱, 通过神经-体液途径, 影响性轴的调节, 使激素分泌紊乱而致功血。本病属崩漏范畴。中医认为青春期少女因肾气不足, 天癸初至不充, 肾气稚弱, 冲任未盛, 不能调摄经期, 制约经血, 可致室女崩漏。

因崩漏病因复杂, 在治疗时应根据病情的轻重缓急, 采用急则治其标, 缓则治其本的原则, 灵活应用塞流、澄源、复旧三法。余春燕在治疗过程中, 重视体内瘀血存在的因素, 各型均应用三七活血化瘀, 止血调经。现代药理研究表明, 三七有止血和活血双向调节作用, 能促进凝血过程, 缩短凝血时间, 促进凝血酶的生成, 增加血小板数而产生止血作用。所以, 三七是治疗崩漏必用之药。

青春期崩漏多属肾虚, 先天禀赋不足。西医认为青春期 90% 以上为无排卵型功血。肾气充盛是卵巢功能正常的基础, 故血止之后, 应补益肾气, 调养冲任, 复旧固本。补肾可逐渐恢复性腺轴的功能, 使月经正常。余春燕自拟补肾调经汤乃据此而设。方中紫石英温补肝肾; 鹿角霜补肾助阳, 益精养血; 女贞子、枸杞子滋补肝肾; 当归、熟地补血养阴; 菟丝子、淫羊藿、肉苁蓉补肾壮阳; 香附调理

气机，调和气血。诸药合用，补肾调经，调理冲任。

张某某，女，16岁，学生。以阴道大量出血5天，淋漓不尽1周为主诉，于1998年5月13日就诊。患者14岁月经初潮，周期先后不定期，短则10天，长则3个多月来潮，经期4~12天不等，经量时多时少，色淡有血块。面色苍白，神疲气短，手足不温，纳少便溏，苔薄白，脉细弱。证属脾气虚弱，冲任失固。治以健脾益气摄血。固本止崩汤加三七、生茜草。每日1剂，共3剂。配竹圈盐姜灸关元、足三里、隐白、断红穴3次。二诊：经量明显减少，续服3剂，月经即净。复诊时诉仍神疲乏力，腰脊酸软，大便溏。给予补肾调经汤，每日1剂，连服7天。配合竹圈盐姜灸三阴交（双）、关元、子宫（双）。连续治疗3个周期后，月经如期而至，5天即净，量中等，至今未复发。

九、穴分两组 轮流注射

徐强华采用黄芪穴位注射治疗崩漏，疗效显著。

取穴：关元、三阴交和肾俞、足三里。

药物：黄芪注射液4ml，内含药4g。

操作：用5ml 1次性注射器，抽取黄芪注射液4ml，按水针操作常规，得气后，每穴注射1~1.5ml药液，每天1次，两组穴位交替，5次为1个疗程。

功能性子宫出血是妇科常见病，大多为气虚、肾亏、血瘀之证。中医认为是由于冲任失固，与肝、肾、脾三脏功能失调有关，特别与肾关系最为密切。因肾为冲任之本，经血之源。少女天癸刚至，肾气不足；而更年期妇女，则肾气渐衰，天癸将绝，所以临床以少女和更年期为多见。取肾俞益肾气，调冲任；关元穴是足三阴和冲任之会，能培元固本，约经妄行；三阴交可健脾疏肝益肾，为主治妇科要穴；足三里补气健脾，是强壮穴之一。配合具有补气摄血功效的中药黄芪穴位注射，加强了经穴与药物的协同作用，对气不摄血的功能性子宫出血确有明显疗效。

余某，女，50岁，退休工人，1993年11月17日初诊。患者形体肥胖，有高血压史4余年。月经素不正常，去年曾发生经期延长，数天后自愈，妇科检查无明显器质性病变。近20多天来经血淋漓不

断，略感腰酸，舌胖苔薄白，脉虚细。此为更年已至，肾气渐衰，冲任亏虚，以致气不摄血。通过第一次穴位注射黄芪后出血明显减少。经第二次治疗后即止。半年后随访经期正常。

王某，女，16岁，学生，1994年5月8日就诊。患者自月经初潮以来，经期不规则，行经量或多或少，拖日难净，经色鲜红质稀。末次月经已1个多月，经多方治疗至今未净。患者面色无华，倦怠乏力，舌质胖边有齿印，脉虚细缓。血常规检查见白血球 $3.1 \times 10^9/L$ ，血色素6g，证属冲任未固，肾气不足，而致气不摄血。经3次治疗经血渐止，共针5次而愈。

唐某，女，26岁，农民，1994年8月3日就诊。患者剖腹产已2个多月，至今出血不净，经服中西药物，效果不理想。症见面色苍白，经色淡红，苔白舌边有齿印，脉细缓。此证为产时失血耗气，冲任受损，脾肾两虚，导致气不摄血。通过2次穴位注射后出血已止，转黄色液体，3次治疗痊愈。

十、太阳灸 冲任督三经并调

郑玉兰采用太阳灸治疗功能性子宫出血，疗效较佳。

药物制作：取艾绒50g，捏紧呈球状。鲜生姜100g，捣烂与面粉调和，捏成约1.2cm厚度圆饼，直径较艾绒球大3cm备用。

操作：将棉纸（卫生纸亦可）1.5cm厚，铺于脐下小腹部，将姜面饼隔纸置于关元穴上，再将艾绒球置于姜面饼正中点燃，约1.5h左右燃尽。每隔1天灸1次。

中医学认为，本病属崩漏范畴。多因脾虚统摄无权，冲任不固；或因情志所伤，冲任郁滞，血不归经；或因肾虚，封藏失职，冲任不固；亦有因素体阴虚血亏，冲任虚损所致。艾叶性温，具有温经止血、散寒止痛之功。艾绒灸能使热气内注，具有温煦气血、透达经络的作用。郑玉兰认为采用太阳灸关元穴，可使冲、任、督三经并调，温通诸经，振奋脏腑的气化功能，激发机体阳气，以达扶正止血之功。应用太阳灸治疗功能性子宫出血，不仅对虚寒型疗效好，而且对阴虚有热者疗效亦佳。郑玉兰体会灸能助阳气，以达阳生阴长之目的。另外，灸法对机体具有双向调节作用。因此，对虚寒型、阴虚型均有效。

赵某，女，30岁。1987年10月17日初诊。2个月以来，经血时多时少，淋漓不止，血色鲜红，伴有倦怠乏力，心烦，手足心热，口干。查体：面色无华，苔薄微黄，脉细数。曾用孕酮及止血药治疗，效果不明显。用太阳灸治疗1次血止而愈。随访半年未复发。

十一、针药并用 标本兼治

功能失调性子宫出血，是指经血非时而下，属中医学崩漏的范畴。赵昌基采用针药并用治疗该病，疗效显著。

针灸：内分泌、安眠、内关、合谷、血海、足三里、三阴交、阴交、气海、石门、关元、功血、中极、天枢、府舍、冲门、脾俞、胃俞、肾俞，针刺每天1次，每次选穴3~4个，交替选穴，中刺激手法，边补边泻，得气后留针20min，中间隔10min左右，加强1次针感。7天为1个疗程。

中药：基本方：当归、续断各10g，鹿角霜、益母草、侧柏炭各15g，生地、地榆炭各20g，旱莲草30g，每天1剂，水煎服，每天3次。加减：血热者加黄芩、栀子、丹皮；血瘀者加茜草、桃仁、延胡索；脾虚者加白术、山药、茯苓；肾虚者加熟地、附片。

凡无妊娠、肿瘤、炎症、外伤及全身出血性疾病，而由内分泌失调引起的子宫出血，称为功能性子宫出血。

患者因青春期卵巢尚未发育成熟，或更年期卵巢功能渐趋衰退，或精神因素、营养状况、其他内分泌腺体功能紊乱等，使得丘脑下部-垂体-卵巢之间功能协调障碍，而致腺体分泌之促卵泡素与黄体生成素比例失调，卵巢内仅有不同发育程度的卵泡而无排卵和黄体形成，因而无孕激素分泌，体内存在大量雌激素堆积或少量雌激素长期刺激，使子宫内膜增生过长而出血。部分病人排卵正常，但黄体功能不全，造成子宫内膜不规则剥脱而出血。

根据子宫内膜组织形态，卵巢功能检查及临床表现等，一般将宫血分为无排卵型和有排卵型子宫出血两类，临床上以无排卵型子宫出血为多见。

功能失调性子宫出血患者中，月经量多，势急如山之崩者，称崩中；血量不多，而淋漓不断如屋漏者，称漏下。在发病过程中，崩与漏的病因病机基本相似，症状又相互转化，所谓崩为漏基，漏

为崩所致。均因冲任受损，不能固摄经血所致。

导致冲任受损的主要原因为血热、血瘀、脾虚、肾虚等，故治疗崩漏的原则为：急则治标，缓则治本。采用塞流、澄源、复旧三步治法。塞流以治其标，止血又救脱；澄源以治其本，调理脾肾以复其旧。从而巩固疗效，达到治愈的目的。

赵昌基经验方中，鹿角胶、续断补肾治其本；当归、益母草补血活血调经，标本兼治；生地、地榆炭、旱莲草、侧柏叶炭凉血止血，兼有收敛之功，以治其标。配合针灸，可刺激人体经络、穴位，调节内分泌及脏腑功能。以上临床观察表明，针药并用治疗功能性子宫出血疗效满意。

王某，女，20岁，1990年9月15日初诊。患者初潮每次7/30天，1986年9月下旬因学习紧张出现月经失调，经用中西医治疗稍有好转。1987年2月再次出现阴道不规则出血，淋漓不止，因用止血药效果不明显，而来就诊。症见阴道出血，血色紫红，头晕、心慌伴心烦易怒，睡眠差，饮食不佳。刻诊：发育营养中等，痛苦表情，贫血面容，脉细弱，舌淡，苔薄白，妇科会诊盆检：外阴有血迹，阴道有血块，宫颈光滑，宫体稍增大，双侧附件（-）。诊断：①青春期功能失调性子宫出血；②贫血（中度）。经上法治疗3天后止血，连续治疗14天。第二个月月经周期为25天，于第14天行针刺促排卵，治疗5天。于第三个月月经来潮时服中药3天，以治疗痛经。随访2年未见复发。

十二、中药并灸法 培元气止崩漏

围绝经期功能失调性子宫出血是由于调节生殖的神经内分泌机制失常所致，而没有全身及生殖器官器质性病变。主要表现为月经周期、经期、经量的异常，是妇科常见病，属中医崩漏范畴。宋永强采用中药与灸法联合治疗本症，取得了满意的临床疗效。

中药：出血期以固涩止血为主，选用方剂：茜草10g，海螵蛸15g，煅龙骨30g，煅牡蛎30g，棕榈炭10g，三七粉15g（冲服）。热迫血妄行加桑叶、丹皮，气虚者加黄芪、白术。非出血期以活血化瘀，固本澄源为主。选用方剂：当归10g，川芎10g，鸡血藤30g，党参10g，赤芍10g，生地15g，益母草15g，三七粉10g（冲服），

甘草 10g。内热者加丹皮、茜草、地榆，肾虚者加菟丝子、枸杞、鹿角胶，气虚加黄芪、白术。

灸法：选关元、隐白，根据病情艾条悬灸每穴 30 ~ 45min，每日 2 次，血止停灸。用药 20 天为 1 个疗程，

围绝经期妇女，天癸将绝，脾肾虚衰，冲任失约，经血失于固摄而发生崩漏，日久气血耗伤，血不归经阴血离经，虚热内生。瘀热等因素又可反果为因，加重病情。中药合灸法治疗该病安全有效，出血期与非出血期选用不同方剂，贯彻了急则治其标，缓则治其本的原则。出血期应以塞流为要，但止血注意勿留瘀。茜草与海螵蛸相伍共同作为君药以收涩固崩，正如张锡所说：“彼但知茜草、海螵蛸能通经血……，不知二药大能固涩下焦，为治崩之主药也”。龙骨与煅牡蛎同用收涩力增强，为治女子崩带佳品。三七既善止血，又可化瘀滞，为治疗本病要药，《医学衷中参西录》言其“善化瘀血，又善止血妄行……，为理血妙品”。然此药止血时非重用不能建功，须根据病情及患者体质加减用药剂量，用棕榈炭以收涩止血。血止后的治疗应以澄源培本为主，在扶正补虚同时，化瘀治疗亦为必须，否则宿血不去，血流不循常道，病不能愈，正如唐容川所云：“失血何根，瘀血即其根也……，瘀血不去，新血断无生理”。当归、川芎、鸡血藤、益母草相配，活血通络，去瘀生新，党参、生地益气滋阴，甘草调和诸药。如此则正气得复，瘀滞消散，血行归经复其常道。关元又称丹田，温灸关元，可温阳固本，收摄止血，隐白为脾经井穴，是治崩要穴，二穴同灸，共奏培元气，止崩漏之功。

患者，48 岁，2005 年 3 月 20 日初诊。月经量多且行经日久 2 年余，被某院妇科诊为功能失调性子宫出血，给予抗孕酮口服治疗。今年 1 月份因停服西药出现阴道大量出血，遂于门诊行诊刮治疗。病理诊断为子宫内膜大部区域增生密集，后月经闭止。两周前阴道出血淋漓不止，经色紫黯有块，患者面色苍白，口唇色淡，神疲微言，大便稀软，舌质淡，苔薄白，脉沉弱无力，辨证为脾虚不足，冲任失固，治宜健脾益气，安冲固崩。先给予隐白、关元穴温灸各 40min，灸至皮肤发红，小腹内有温热感，日 2 次。处方：茜草 12g，海螵蛸 15g，煅龙牡各 15g，山萸肉 15g，白术 30g，棕榈炭 10g，三七粉 15g（冲服），白芍 15g，炙甘草 10g。三剂，水煎服，每日 1

剂。治疗3天后，出血量大大减少，又治疗两天血止，遂停灸，并将处方易为：白术20g，茜草10g，川芎15g，当归15g，鸡血藤30g，益母草30g，丹参15g，生山药30g，三七粉10g（冲服）、炙甘草10g，水煎服。共服用20剂后月经来潮，量中等，色淡红，无其他不适感，行经6天，经期末予治疗。如前法继续治疗2个疗程，病情稳定。后6个月随访，月经量稀少，周期如常，其他未诉不适。

十三、壮医药线灸 调摄冲任

功能性子宫出血简称功血，更年期功血是以卵巢功能减退引起下丘脑-垂体-性腺轴功能失调为主要原因，属中医崩漏范畴。叶运英应用壮医药线灸治疗，取得满意疗效。

取穴：百会、脐周四穴、梁丘、阳陵泉、涌泉。

操作：采用广西中医学院提供的2号药线，食指、拇指持线的一端，并露出线头1~2cm，将露出的线端在酒精灯上点燃（如有火焰必须扑灭，只需线头有火星即可），将有火星线端对准穴位，顺应腕和拇指屈曲动作，拇指指腹稳重而敏捷地将有火星线点直接点按于穴位上，一按火灭即起为一壮。为增强疗效，采用梅花形灸法（即取穴位及距穴位5mm处等距各取四穴）。每日1次，10次为1个疗程，休息2天，再进行第二疗程。

更年期功能性子宫出血原因很复杂，但多由于肾气衰退，阴阳失调，封藏不固所致。应用壮医药线灸治疗本病，就是以穴位灸治的局部刺激，通过经络的传导，使气血归于平衡，肾之阴阳亏虚得到纠正，达到止血之功。百会位于巅顶，属督脉，统督诸阳，上络于脑，下络于肾，为升阳之要穴，取之下病上取之意，其又与任脉相通循环而阴阳交通，故能治阴阳失和之变症。涌泉为足少阴肾经之井穴，可引上越之浮阳归根。百会与涌泉，一上一下，阴阳相偶，两穴相合，配合脐周四穴、梁丘、阳陵泉，共奏调和阴阳之功。达调摄冲任、补肾养肝之目的，从而促进正常月经周期的恢复，减少出血量，提高临床疗效。

刘某，52岁，1993年6月10日就诊。患者诉1991年4月始，月经期前5天量多，5天后阴道流血淋漓不尽，长达20余日方尽。经市医院妇产科刮宫病检，诊为子宫内膜增殖，经西药治疗好转。

近3月上症再发,西药治疗无缓解,阴道流血淋漓不尽,色淡红,量不多,伴腰膝酸软,面色苍白,倦怠乏力,小便清长,舌淡,苔薄白,脉细无力。证属肾气亏虚,冲任功能失常,治宜温肾健脾,益气摄血。经上法治疗2次出血减,6次血止,治疗满1个疗程,间隔2天,巩固治疗1个疗程,随访3月未再复发。

参 考 文 献

- [1] 徐玉英,徐凤云.艾灸关元穴治疗功能性子宫出血63例体会.甘肃中医,2001,14(5):55~56
- [2] 赵焕云,庞保珍.定宫丹填脐灸治疗功能失调性子宫出血.甘肃中医学院学报,2004,21(1):46
- [3] 朱玲,陈玲.耳穴贴压法治疗子宫功能性出血34例.中国民间疗法,2001,9(3):10~11
- [4] 修显红.举元固冲汤配水针治少女血崩30例.辽宁中医杂志,1997,24(2):79
- [5] 阎政谋,孙永浩.深刺中机穴加灸治疗功能性子宫出血134例.中国针灸,1997,(1):16
- [6] 徐明,徐红梅.温针配合中药治疗青春期功能失调性子宫出血30例.中国民间疗法,1998,(6):31
- [7] 王敬善,孙素玲,刘爱玲,等.引血归经汤合妇贴灵治疗功能性子宫出血的临床研究.山东中医杂志,2001,20(3):139~140
- [8] 余春燕.针药并治青春期功能失调性子宫出血77例.福建中医学院学报,2002,12(2):18~19
- [9] 徐强华.黄芪穴位注射治疗功能性子宫出血38例.上海针灸杂志,1996,15(3):282~283
- [10] 郑玉兰,王荔华,刘凤兰,等.太阳灸治疗功能性子宫出血68例.新中医,2000,(1):25
- [11] 曾祥法.赵昌基针药并用治疗功能失调性子宫出血.湖北中医杂志,2004,26(3):19~20
- [12] 宋永强,王汝琴,李丽霞,等.中药并灸法治疗围绝经期功能失调性子宫出血39例.中国保健,2006,14(18):129
- [13] 叶运英.壮医药线灸治疗更年期功能性子宫出血66例.中国针灸,2000,(4):244

封面
书名
版权
前言
目录

单纯性肥胖症

电针配耳压	补虚泻实
证分四型	辨证用穴
耳穴贴压	随症选穴
肥三针为主	化脂降浊
群针疗法	调理经脉
刃针割治	消肥散积
透刺闪罐耳压	三法并用
随证取穴	穴位埋线
电针为主	综合治疗
针刺为主	配中药内服
脐周八针	随症加减
针刺配食疗	调和营卫
辨证施针	调整脏腑
整体与局部并重	随证取穴
针刺走罐埋线	三法并用
针药并用	清胃热
多法并用	整体调理
局部取穴	苍龟探穴
腹部取穴为主	电针
快速针刺为主	配合推拿
辨证分型	体耳针并用
电针为主	综合治疗

高脂血症

背俞穴埋线	结合耳针
立足于脾胃	化痰降脂
针刺配耳压	健脾祛痰除湿
三阴交为主	辨证施治

骨质疏松症

百会长留针	背俞穴速刺
理据肾主骨 - 生髓	行耳压治疗
腹针疗法	标本兼治
骨肽注射液	穴位注射
独取神阙	隔药灸
针推罐	三法并用
补肾为主	温针灸

证分两型	针刺配火针
足三里 - 三阴交	针药并用
背俞穴为主	重手法
针刺穴数	健脾补肾
督脉穴为主	针灸并用
温针为主	配西药口服
精神分裂症	
穴分两组	水电针并用
辨证分型	电针治疗
耳针治疗	镇静安神
头皮电针为主	配合穴位注射
针刺配药物	醒脑安神
辨证取穴	镇静安神
针药结合	泻火祛痰
穴位埋鬃	随证选穴
独取膻中	刺血拔罐
糖尿病及其并发症	
电针为主	配经穴按摩
揠针配体针	补虚泻实
独取胰俞	埋药线
背俞穴为主	针刺降血糖
针药并用	治肾为主
浅刺任督	配药物治疗
针药并施	益气养阴
电针配艾灸	神经源性膀胱
动眼神经麻痹	辨证施针
视网膜病变	针药并用
针药结合	治动眼神经麻痹
糖尿病胃轻瘫	芒针为主
背俞穴	辨证治胃轻瘫
附：糖尿病并发末梢神经炎	
刺络放血	除陈出新
电针耳压	祛风止痒
针药并用	养血活血
络脉扣刺	泻血攻下
辨证分型	针药并治
头针为主	配合簇针
头针为主	配穴位注射
穴位注射	益气养血
针药穴位注射	综合治疗
针药结合	活血化瘀通络

	穴位注射	健脾益肾固本
甲状腺功能亢进及其并发症	肝俞 - 心俞	埋线治疗
	挑筋割脂埋线	化瘀散结
	穴位埋线	标本兼治
	针刺为主	配神经节阻滞
	辨证分型	针药并用
	药线点灸	配中药施治
	壮医挑刺	调气解毒补虚
	穴位埋线配中药	标本兼治
	远近配穴	针药并用
	疏肝理气解郁	针药并用
	针药并施	消瘦散结
甲状腺肿大	针挑为主	软坚散结
	主穴三个	重刺法
	火针为主	标本兼治
黄褐斑	取经为主	走罐配刺络放血
	督脉埋针	调理诸经
	耳压磁珠	调节全身
	灵龟八法	按时开穴
	随证取穴	挂针配直接灸
	综合疗法	内外兼治
	走罐加局部围刺	调补五脏
	背俞穴	刺血拔罐
	辨证取背俞	推罐配按摩
	辨证取穴	药物注射
	刺络拔罐配耳压	辨证施治
	耳穴刺络	调理气血
	耳穴刺血配贴压	化瘀消斑
	耳穴贴压	刺血拔罐
	飞腾八法	配刺血拔罐
	辨证分型	割耳敷药
	体耳穴并用	埋线为主
	局部刮痧为主	行气消斑
	辨证取穴	面部浅刺配闪罐
	远端取穴为主	辨证施治
	背部走罐	梅花针叩刺
	针刺为主	神阙隔盐灸
	耳穴贴压配刺血	祛瘀除斑

男性更年期综合征

耳压为主 配心理治疗
针刺配有氧运动 疏肝健脾
针推为主 综合治疗

女性更年期综合征

既病防变 电针配耳压
电针为主 辨证施治
耳穴贴压 平衡阴阳
耳压配中药 清心平肝滋肾
五脏俞加膈俞 调理脏腑
穴位埋线 滋补肾气
穴位注射 配耳压
辨证配穴 针刺配耳压
五脏俞为主 针刺配火针
辨证分型 针药并用
上下配穴 针用补法
以肝为本 辨证取穴
整体入手 调理冲任
针药结合 滋阴潜阳
针刺配穴位注射 补肾益气养血
俞募配穴 协调阴阳
针灸配耳穴疗法 补肾培元
三穴六针 平补平泻
针药结合 辨证分型
针药配合疏肝解郁

经前期紧张综合征

头针为主 虚补实泻
穴位注射配体针 调理冲任
针药并用 行气活血
调脏腑 理冲任 平阴阳
针刺配推拿 通调冲任
辨证取穴 耳穴贴压
针刺配心理治疗 强调情志
辨证施治 调肝与胞宫

痛风

刺络拔罐 活血止痛
刺络放血 泻热解毒
刺血为主 辅以中药
随证取穴 针灸并用
电针配穴位注射 消肿止痛
浮针疗法 通则不痛

腹针为主	配合中药
局部取穴	火针点刺放血
随症配穴	火针点刺
以痛为腧	梅花针叩刺
梅花针配中药	分期治疗
局部取穴	齐刺加隔姜灸
温针灸	清热泄火
针刺配刺络拔罐	清热解毒
针药合用	清热利湿
随症选穴	针药并施
内外合治	针药并用
病分急慢	刺络拔罐为主
泄浊祛邪	泻热化瘀
针药并用	急慢性治法各异

月经不调

辨证取穴	腹针为主
主穴三个	阴中隐阳
独取神阙	药物贴敷
调泌穴针刺	平衡内分泌
针灸并用	益气补血
随证取穴	耳穴压豆
药针并用	疏肝补肾
取隐白	子午流注施灸
针刺调冲任	补肝肾
穴位注射	益气摄血

子宫内膜异位症

七厘散敷贴	活血化瘀
药饼灸配水针	温通经络
补肾化浊	针药并用

内分泌失调性不孕症

针药结合	调理肝脾肾
针刺配中药	分期治疗
补肾化浊	药针并用
辨证分型	针药合用
穴位注射	标本兼顾
主穴三个	电针治疗
雷火灸	活血化瘀通络
灵龟八法	配温和灸 通调任脉
内外结合	活血化瘀通络
三法同用	取长补短
独取子宫	温针灸

分期取穴	药饼灸
针刺配穴位敷药	通胞宫
针灸配耳压	调理冲任
针灸治疗	生血充精
辨证分型	因证施治
针药配合	补肾益精
针药罐灸	综合治疗
针药并举	调理冲任
补益肝肾	佐以活血化瘀

功能性子宫出血

独取关元	隔姜灸
定宫丹填脐灸	滋阴调经
随症选穴	耳穴贴压
穴位注射为主	配中药内服
中极为主	深刺
温针配服中药	调和温补冲任
中药内服外用	补肾活血兼施
证分三型	治分两期
穴分两组	轮流注射
太阳灸	冲任督三经并调
针药并用	标本兼治
中药并灸法	培元气止崩漏
壮医药线灸	调摄冲任